



RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JUNI  
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG  
2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang  
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874  
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com  
[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... i

Bab I Pendahuluan ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan ..... 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang ..... 2

2.1 Visi ..... 2

2.2 Misi ..... 2

2.3 Motto ..... 2

2.4 7 Nilai Budi Utama ..... 2

2.5 Struktur Organisasi ..... 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan ..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) ..... 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO ..... 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO ..... 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut ..... 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan ..... 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada ..... 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan ..... 10

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik ..... 10

3.3.2 Rawat Inap ..... 12

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) ..... 19

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) ..... 20

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO) ..... 21

3.4 Kinerja Bidang Penunjang ..... 22

3.4.1 Instalasi Farmasi ..... 22

3.4.2 Laboratorium ..... 27

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran ..... 29

3.4.4 Radiologi ..... 31

3.4.5 Gizi ..... 34

3.4.6 CSSD - Laundry ..... 36

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan ..... 39

3.5.1 SDM ..... 39

3.5.2 MFK dan K3RS ..... 44

3.5.3 Security ..... 49

3.5.4 Parkir ..... 51

3.5.5 Humas Marketing ..... 52

3.5.6 Penjaminan ..... 55

3.5.7 PIPP – MOD - MPP ..... 56

3.5.8 *Cleaning Service* ..... 65

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum ..... 67

3.6 Komite dan Tim ..... 69

3.6.1 Komite Mutu ..... 69

3.6.2 Komite PPI ..... 97

3.6.3 Tim PKRS ..... 106

3.6.4 Tim Prognas ..... 108

3.6.5 Tim PPRA ..... 146

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT ..... 152

3.7 Permasalahan Rumah Sakit ..... 153

3.8 Profil SDM ..... 158

Bab IV Kesimpulan dan Saran ..... 162

Bab V Penutup ..... 163

LAMPIRAN ..... 165

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

#### **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG**

#### **2.1 VISI**

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

#### **2.2 MISI**

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

#### **2.3 MOTTO**

Sahabat Menuju Sehat

#### **2.4 7 NILAI BUDI UTAMA**

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

## 2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



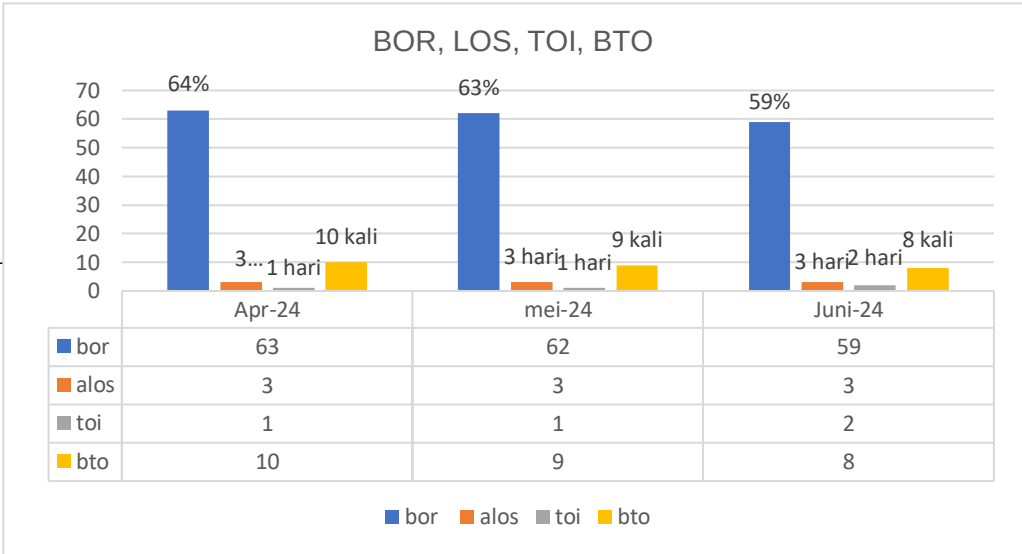
BAB III  
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

| NO | INDIKATOR | APRIL | MEI | JUNI |
|----|-----------|-------|-----|------|
| 1  | BOR       | 63    | 62  | 59   |
| 2  | ALOS      | 3     | 3   | 3    |
| 3  | TOI       | 1     | 1   | 2    |
| 4  | BTO       | 10    | 9   | 8    |

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



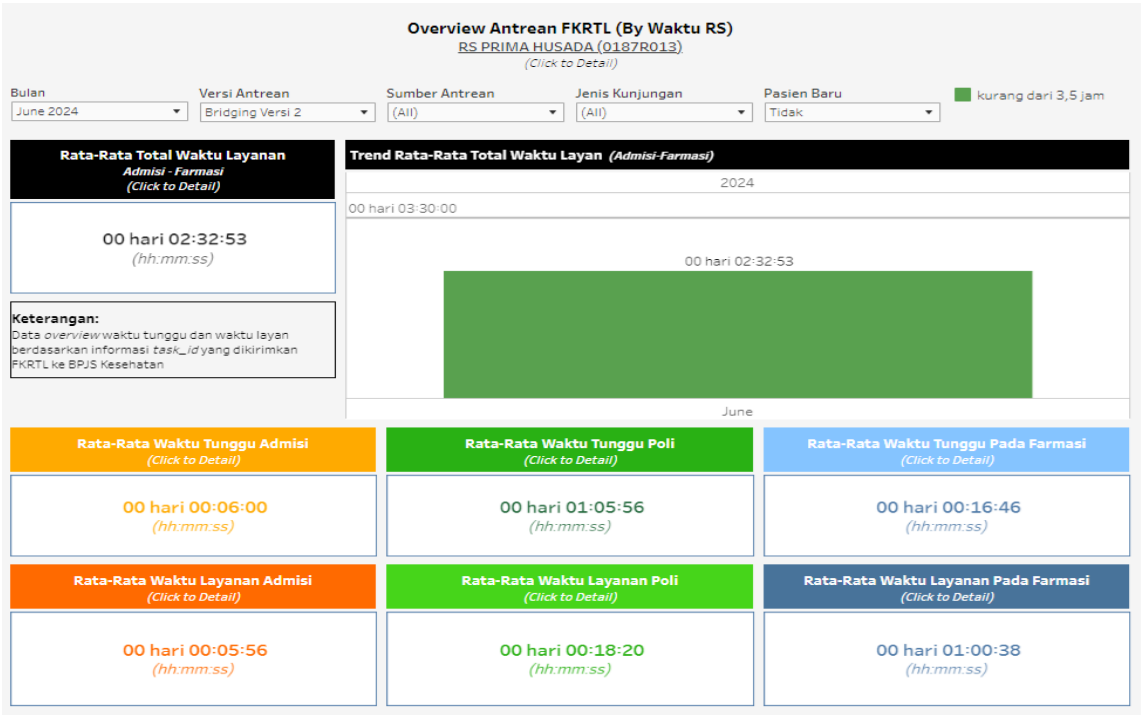
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Terdapat penurunan BOR menjadi di bawah standar (60%) sebesar 4,8% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan kunjungan IGD maupun poliklinik.

ALOS tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI meningkat dibanding sebelumnya dan masih di batas standard, peningkatan ini dapat terjadi karena adanya penurunan kunjungan pasien. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada delapan kal sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4   Terkait BPJS Kesehatan



| NO | JENIS                                                      | TARGET | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 |
|----|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Sumber antrian melalui mobile JKN                          | >30%   | 36.34%  | 34.86%  | 37.2%   | 34.88%  |
| 2  | Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN) | >90%   | 96.21%  | 94.57%  | 96.2%   | 94.62%  |

**Analisis :**  
Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan

|        |                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan   | Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya                                                                                                                      |
| Do     | Sosialisasi ke unit terkait                                                                                                                                                                         |
| Study  | Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki                                                                                                                           |
| Action | 1. Memanfaatkan aplikasi <a href="https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/">https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/</a> untuk monitoring<br>2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i><br>3. Supervisi kabit |

### 3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

| NO                               | UNIT              | PENGEMBANGAN PELAYANAN         | PROGRESS PENGEMBANGAN                                         | KENDALA                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN |                   |                                |                                                               |                                                                                           |
| 1                                | IRNA              | Bimbingan Doa pada pasien IRNA | Sudah berjalan rutin 1 minggu 3x. Sudah ada SOP               | Kendala pengembangan ini jika di ruangan crowded tidak ada yang menemani pendampingan doa |
| 2                                | IRNA              | Senam hamil                    | Sudah berjalan rutin                                          | -                                                                                         |
| 3                                | IRNA              | Foto bayi                      | Sudah berjalan dengan baik, respon keluarga pasien juga baik  | -                                                                                         |
| 4                                | IRJA              | Poli Eksekutif                 | Sudah berjalan di 3 poliklinik yaitu Obgyn, Anak dan Saraf    | Reservasi masih sedikit                                                                   |
| 5                                | IRJA              | Poli Estetik                   | Progres 20% masih proses penyusunan TOR                       | Belum ada daftar harga BMHP dari Pengadaan Farmasi                                        |
| BIDANG UMUM DAN KEUANGAN         |                   |                                |                                                               |                                                                                           |
| 1                                | Humas & Marketing | MCU                            | Bertahap dalam setiap bulan mengunjungi perusahaan untuk deal | 1. Belum memiliki kontak seluruh perusahaan<br>2. Kunjungan belum rutin                   |

|   |          |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                           |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |                                                                                 |                                                                                                                | 3. Tarif MCU masih tinggi dibanding kompetitor                                            |
|   |          | 1. Digital Marketing                                                            | Upgrading jenis konten setiap bulan                                                                            | Belum ada skill khusus tentang digital marketing                                          |
| 2 | SDM      | 1. Konseling                                                                    | Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target                                                                | Konseling dilakukan terbatas sesuai tingkatan                                             |
|   |          | 2. Supervisi                                                                    | Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target                                                                | Belum dijadwalkan rutin                                                                   |
|   |          | 3. Penegakan Tata Tertib                                                        | Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target                                                                | Waktu pelaksanaan masih bertabrakan dengan pekerjaan lain (penyesuaian SDM baru)          |
| 3 | CS       | 1. Penambahan trolley kerja Cleaning Service                                    | Belum terealisasi                                                                                              | Di pengadaan                                                                              |
|   |          | 2. Pengajuan ruang penyimpanan matras tiap area                                 | Sudah terealisasi                                                                                              | -                                                                                         |
|   |          | 3. Pengajuan bursak matras yang tidak layak dan potong menjadi 1 ukuran         | Sudah terealisasi                                                                                              | -                                                                                         |
|   |          | 4. Pengajuan ruang penyimpanan inventaris hall (kursi,meja,taplak,sarung kursi) | Sudah terealisasi                                                                                              | -                                                                                         |
|   |          | 5. Pengajuan alat pembersih kaca magnet                                         | Sudah terealisasi                                                                                              | -                                                                                         |
|   |          | 6. Penambahan tong sampah non medis                                             | Belum terealisasi                                                                                              | Masih di ajukan untuk penambahan                                                          |
| 4 | Security | 1. Penertiban Jam Berkunjung Pasien                                             | Terealisasi dengan adanya tambahan personel memudahkan untuk patrol dan adanya pengumuman dengan rekaman suara | Anak-anak dibawah usia 12 tahun masih ada yang masuk ke ruang irna karena alasan tertentu |
|   |          | 2. Kartu Tanda Penunggu Pasien                                                  | Sudah diajukan                                                                                                 | Dalam proses. Tidak ada kendala                                                           |
| 5 | IT SIMRS | 1. Peremajaan Komputer di Unit                                                  | Sudah dilakukan bertahap                                                                                       | Tidak ada kendala. Menunggu                                                               |

|                         |                |                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                |                                                                               |                                                                                                                                                                | instruksi pengadaan                                                                                                                          |
|                         |                | 2. Instalasi ruang server baru dan server backup                              | Sudah terealisasi                                                                                                                                              | Tidak ada kendala                                                                                                                            |
| <b>BIDANG PENUNJANG</b> |                |                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| 1                       | Depo Farmasi   | 1. Website Primantara                                                         | Proses penyelesaian oleh Programmer PT                                                                                                                         | Dalam proses                                                                                                                                 |
|                         |                | 2. Open Recruitmen Admin Primantara                                           | Sudah mendapatkan admin, bergabung mulai tanggal 01 Juli 2024.                                                                                                 | -                                                                                                                                            |
|                         |                | 3. TTD elektronik semua pasien rawat jalan, baik pasien IGD maupun rawat inap | Follow up programmer                                                                                                                                           | Dalam antrian programmer.                                                                                                                    |
|                         |                | 4. Fitur Iterisasi pada SIMRS                                                 | Fitur sudah tersedia di SIMRS, SPO disosialisasikan.                                                                                                           | Target ITER 1000/tahun.<br>Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan untuk pencapaian target (sosialisasi dengan DPJP).                              |
|                         |                | 5. Pendistribusian obat ke ruangan.                                           | Tetap menggunakan system UDD dengan penyiapan obat di malam hari.<br>Obat UDD tidak terlambat terdistribusi ke ruang perawatan.                                | -.                                                                                                                                           |
| 2                       | Gudang Farmasi | Repack sediaan farmasi sharing dose                                           | Repack sudah berjalan, tarif repack sudah ada.                                                                                                                 | -                                                                                                                                            |
| 3                       | Rekam Medis    | 1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA)                                       | Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA.<br>Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024.<br>IRNA dalam proses memasukan form kedalam aplikasi SIMRS. | Kurang sinkron antara future perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. |
|                         |                | 2. Serah terima DRM menggunakan sistem digital.                               | Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan)                                                                                                          | Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                      |

|   |              |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                         |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | 3. Permintaan form menggunakan sistem digital.                                   | Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.                  | Monitoring dan Evaluasi.                                                                                                |
| 4 | Radiologi    | Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil radiograf dapat diakses. | Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.                                      | Dalam antrian programmer.                                                                                               |
| 5 | Laboratorium | 1. Pengadaan LIS                                                                 | 1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium.<br>2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor. | Dalam antrian programmer                                                                                                |
|   |              | 2. Pengadaan BDRS                                                                | 1. Proses pembuatan FS BDRS oleh Kabid Penunjang Medis.<br>2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS.  | Dalam Proses.                                                                                                           |
| 6 | Gizi         | 1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan                                          | Kolaborasi dengan Humas & Marketing.                                                                      | Monitoring dan evaluasi setiap bulan                                                                                    |
|   |              | 2. MCU Gizi                                                                      | Rencana diajukan review tarif ke Keuangan PT                                                              | Dalam Proses                                                                                                            |
|   |              | 3. <i>Prima Healthy Meal</i>                                                     | Sudah pengajuan TOR ke PT                                                                                 | Menunggu ACC                                                                                                            |
| 7 | CSSD         | 1. Mengajukan mesin sterilitor (steam plasma)                                    | Belum terealisasi                                                                                         | Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf. |
|   |              | 2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.                              | Belum terealisasi                                                                                         | Proses dibuatkan alur dan digital form, target Juli berjalan.                                                           |
| 8 | Laundry      | Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas                                  | Belum terealisasi                                                                                         | Monitoring dan                                                                                                          |

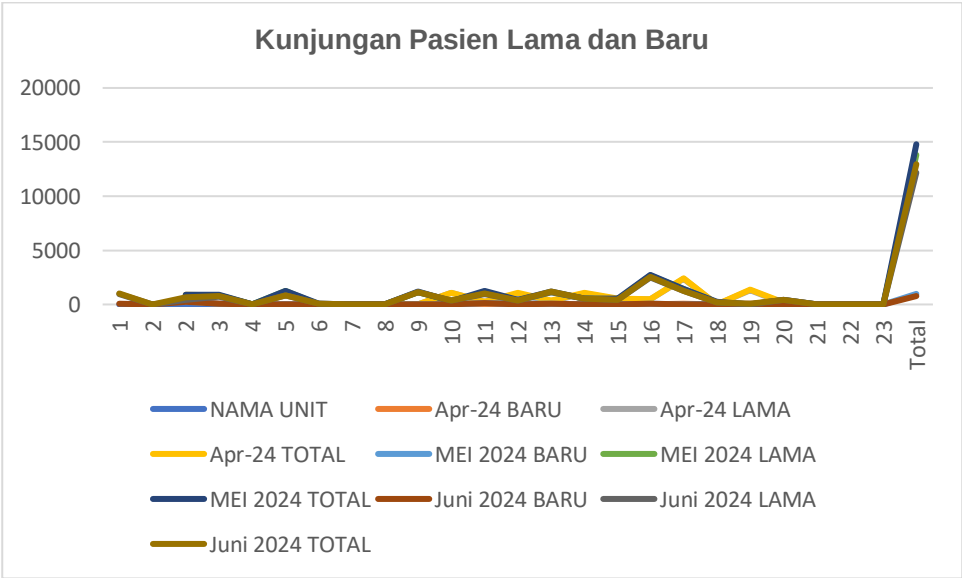
|  |  |      |  |                                                        |
|--|--|------|--|--------------------------------------------------------|
|  |  | 30kg |  | evaluasi<br>penggunaan<br>mesin cuci<br>industry utama |
|--|--|------|--|--------------------------------------------------------|

### 3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

#### 3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

##### 3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

| NO    | NAMA UNIT                | APRIL 2024 |       |       | MEI 2024 |       |       | Juni 2024 |       |       |
|-------|--------------------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|       |                          | BARU       | LAMA  | TOTAL | BARU     | LAMA  | TOTAL | BARU      | LAMA  | TOTAL |
| 1     | Klinik Anak              | 76         | 1095  | 1171  | 92       | 1214  | 1306  | 46        | 961   | 1007  |
| 2     | Anak sakura              |            |       |       |          |       |       | 0         | 1     | 1     |
| 2     | IGD                      | 317        | 599   | 916   | 246      | 645   | 891   | 236       | 435   | 671   |
| 3     | Klinik Bedah             | 48         | 786   | 834   | 54       | 823   | 877   | 54        | 735   | 792   |
| 4     | Klinik Bedah Plastik     | 1          | 20    | 21    | 4        | 31    | 35    | 0         | 19    | 19    |
| 5     | Klinik Fisioterapi       | 4          | 1027  | 1031  | 3        | 1273  | 1276  | 5         | 848   | 853   |
| 6     | Klinik Gigi Periodonti   | 3          | 16    | 19    | 8        | 39    | 47    | 0         | 42    | 42    |
| 7     | Klinik Gigi Spesialis    | 8          | 13    | 21    | 7        | 22    | 29    | 0         | 12    | 12    |
| 8     | Klinik Ibu dan Anak      | 0          | 0     | 0     | 0        | 14    | 14    | 0         | 9     | 9     |
| 9     | Klinik Jantung           | 1          | 13    | 14    | 22       | 1145  | 1167  | 13        | 1106  | 1119  |
| 10    | Klinik Jiwa              | 15         | 1074  | 1089  | 10       | 310   | 320   | 10        | 337   | 347   |
| 11    | Klinik Kandungan         | 7          | 261   | 268   | 146      | 1091  | 1237  | 108       | 928   | 1036  |
| 12    | Klinik Kulit dan Kelamin | 104        | 965   | 1069  | 56       | 382   | 438   | 24        | 341   | 365   |
| 13    | Klinik Mata              | 37         | 306   | 343   | 82       | 1132  | 1214  | 55        | 1116  | 1171  |
| 14    | Klinik Orthopedi         | 48         | 1010  | 1058  | 16       | 541   | 557   | 34        | 528   | 562   |
| 15    | Klinik Paru              | 15         | 505   | 520   | 23       | 504   | 527   | 6         | 442   | 428   |
| 16    | Klinik Penyakit Dalam    | 14         | 481   | 495   | 58       | 2663  | 2721  | 53        | 2498  | 2551  |
| 17    | Klinik Syaraf            | 48         | 2369  | 2417  | 38       | 1409  | 1447  | 29        | 1229  | 1258  |
| 18    | Klinik THT               | 0          | 0     | 0     | 51       | 183   | 234   | 39        | 178   | 217   |
| 19    | Klinik Umum              | 32         | 1315  | 1347  | 25       | 12    | 37    | 46        | 10    | 56    |
| 20    | Klinik Urologi           | 55         | 158   | 213   | 35       | 381   | 416   | 13        | 405   | 418   |
| 21    | Klinik gigi anak         |            |       |       | 1        | 0     | 1     | 2         | 6     | 8     |
| 22    | Gizi                     |            |       |       | 0        | 0     | 0     | 2         | 3     | 5     |
| 23    | Bedah Saraf              |            |       |       | 0        | 8     | 8     | 0         | 5     | 5     |
| Total |                          | 900        | 12358 | 13258 | 977      | 13822 | 14799 | 777       | 12180 | 12957 |



Analisis :

- 1. Kunjungan 3 bulan terakhir masih naik turun terlebih lagi pada bulan juni 2024 ini mengalami penurunan 12,4% sebanyak 1842 pasien karena bulan juni banyak tanggal merah dan libur idul adha sehingga rawat jalan mengalami penurunan pasien
- 2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2551 pasien. Kunjungan tersebut penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 2721 pasien, karena dokter penyakit dalam ada libur tanggal merah banyak
- 3. Kunjungan terendah adalah poli sakura hanya 1 pasien

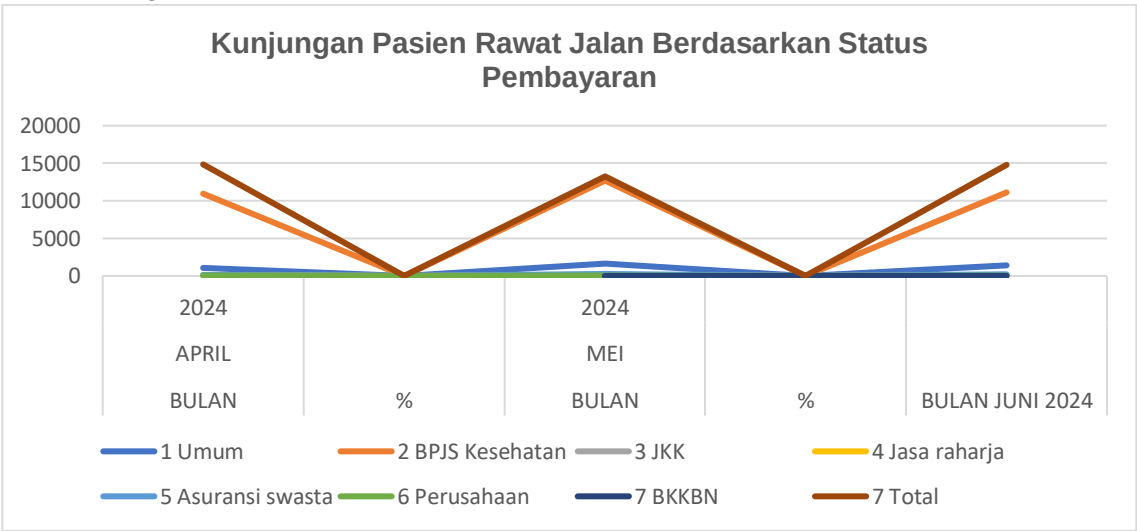
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Membuat video tentang poli sakura, edukasi mulai dari sosial media dan lewat pendaftaran untuk menjaring pasien untuk bulan depanya
- 2. Koordinasi dengan PKRS agar diupload di sosial media
- 3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk menjaring pasien lewat bidan jejaring dan praktek dokter yang ada di sekitar malang utara
- 4. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di Rumah Sakit Prima Husada

3.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

| NO | STATUS PEMBAYARAN | BULAN APRIL 2024 | %      | BULAN MEI 2024 | %      | BULAN JUNI 2024 | %      |
|----|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1  | Umum              | 1098             | 8,1%   | 1640           | 11,08% | 1435            | 11,07% |
| 2  | BPJS Kesehatan    | 10970            | 82,47% | 12689          | 85,73% | 11121           | 85,82% |
| 3  | JKK               | 95               | 0,7%   | 147            | 0,99%  | 128             | 0,99%  |
| 4  | Jasa raharja      | 17               | 0,01%  | 10             | 0,07%  | 22              | 0,17%  |
| 5  | Asuransi swasta   | 136              | 1,02%  | 264            | 1,78%  | 226             | 0,03%  |
| 6  | Perusahaan        | 34               | 0,20%  | 49             | 0,33%  | 22              | 0,17%  |
| 7  | BKKBN             |                  |        | 2              | 0,01%  | 0               | 0%     |
|    | Total             | 13266            | 100%   | 14799          | 100%   | 12957           | 100%   |

3.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien selama 3 bulan terakhir berdasarkan cara bayar masih naik turun dan belum stabil terlebih untuk bulan juni 2024 untuk pasien asuransi dan pasien dari perusahaan sangat menurun

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan berkoordinasi dengan marketing untuk Melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura, gigi anak dan berkoordinasi juga dengan pkrs untuk selalu di upload di sosial media

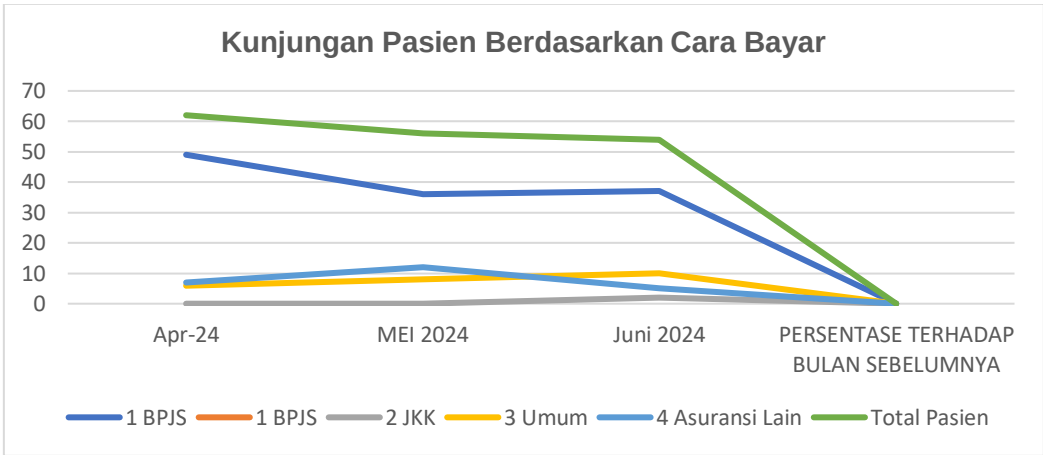
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April –Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 49         | 36       | 37        | ↑2,70%                               |
| 2            | JKK           | 0          | 0        | 2         | ↑100%                                |
| 3            | Umum          | 6          | 8        | 10        | ↑20%                                 |
| 4            | Asuransi Lain | 7          | 12       | 5         | ↓66,6%                               |
| Total Pasien |               | 62         | 56       | 54        | ↓3,7%                                |

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

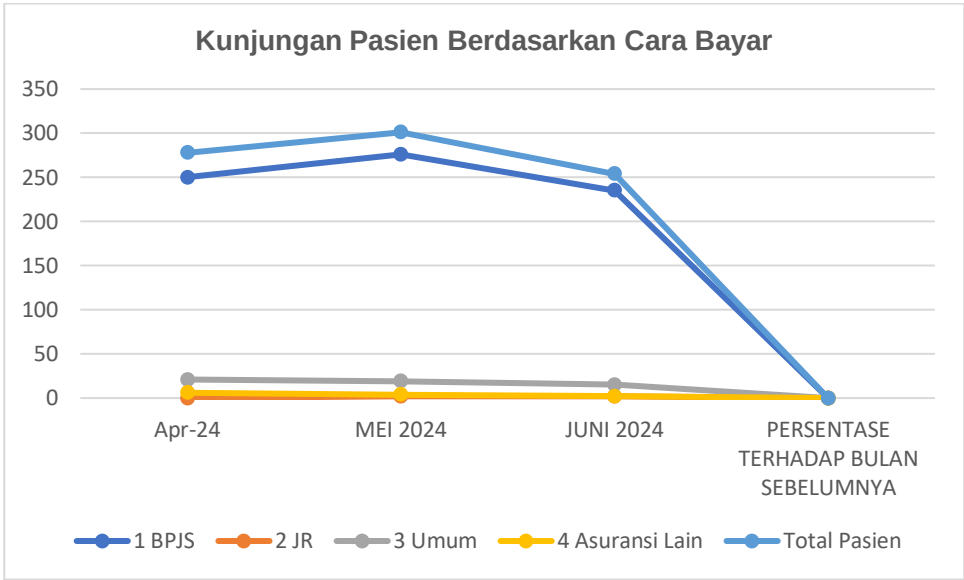
| NO. | BULAN     | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                           |                                                          | TOTAL PASIEN                                                    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |           | BPJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UMUM                                  | JKK                                                                                                       | JR/ASURANSI                                              |                                                                 |
| 1   | JUNI 2024 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                    | 2                                                                                                         | 5                                                        | 56                                                              |
|     | Analisa   | Pasien BPJS dalam bulan Juni mengalami kenaikan meskipun hanya 2,7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasien umum mengalami peningkatan 20% | Pasien JKK mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang hanya 0 sekarang naik 100 % terdapat 2 pasien | Untuk pasien asuransi mengalami penurunan drastis 66,6 % | Total pasien bulan Juni mengalami penurunan 3,7% dari bulan mei |
|     | RTL       | Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap,serta bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru |                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                 |

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 250        | 276      | 235       | ↓17%                                 |
| 2            | JR            | 0          | 2        | 2         | 0%                                   |
| 3            | Umum          | 21         | 19       | 15        | ↓27%                                 |
| 4            | Asuransi Lain | 6          | 4        | 2         | ↓100%                                |
| Total Pasien |               | 278        | 301      | 254       | ↓19%                                 |

3.3.2.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

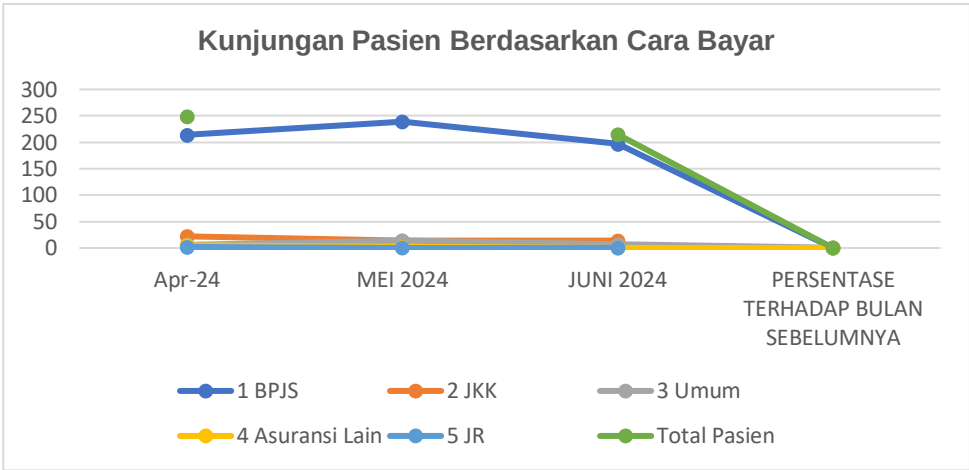
| NO. | BULAN JUNI 2024 | RAWAT INAP                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIEN                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                 | BPJS                                                                                                                                                             | UMUM                                                                                                                                                           | JKK                                          | JR/ASURANSI                                                                                                                                                               |                                  |
| 1   | Analisis        | Pasien BPJS mengalami penurunan 17 % di bulan juni,dikarenakan DPJP sudah mulai memahami knkb dan pasien kunjungan dari igd terutama pasien anak juga menurun    | Untuk pasien Umum di bulan juni mengalami penurunan 27 % dikarenakan hampir semua pasien prima husada pasien bpjs,terutama yang dulunya umum sudah daftar bpjs | Untuk pasien JKK tetap dari bulan sebelumnya | Untuk pasien asuransi lain mengalami penurunan 100% dikarenakan persaingan rumah sakit yang banyak sehingga untuk asuransi masih minim di rumah sakit prima husada malang | Total keseluruhan ada 254 pasien |
|     | RTL             | Total pasien setiap bulanya masih naik turun sehingga perlu pemantuanya dan bekerja sama dengan bagian marketing untuk menjaring pasien asuransi dari perusahaan |                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                           |                                  |

3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 214        | 239      | 197       | ↓21,3%                               |
| 2            | JKK           | 22         | 14       | 14        | 0%                                   |
| 3            | Umum          | 6          | 14       | 7         | 50%                                  |
| 4            | Asuransi Lain | 5          | 2        | 0         | ↓ 100%                               |
| 5            | JR            | 2          | 0        | 0         | 0%                                   |
| Total Pasien |               | 249        | 269      | 215       | ↓ 20,07%                             |

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

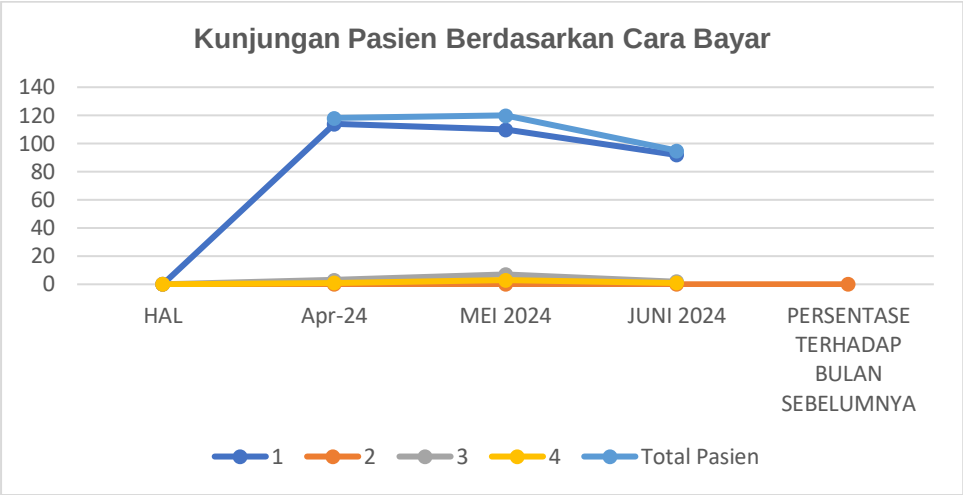
| NO. | BULAN                      | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                              |                                                     | TOTAL PASIEN                                             |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                            | BPJS                                                                                                                                                                                                                     | UMUM                                                    | JKK                                                                          | JR/ASURANSI                                         |                                                          |
| 1   | Analisis capaian Juni 2024 | Pasien BPJS mengalami penurunan di bulan juni 2024 yaitu sebanyak 54 pasien ,21,3 %                                                                                                                                      | Pasien Umum mengalami penurunan 50% dari bulan mei 2024 | Pasien JKK 2 bulan terakhir tetap tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan | Pasien Asuransi juga masih tetap tidak ada kenaikan | Penurunan dari bulan mei 20,07 % yaitu 215 jumlah pasien |
|     | RTL                        | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, Selalu berkoordinasi dengan pihak manajemen terlebih marketing untuk menjaring pasien baik dari pasien KLL maupun asuransi perusahaan |                                                         |                                                                              |                                                     |                                                          |

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 114        | 110      | 92        | ↓ 16,3%                              |
| 2            | JKK           | 0          | 0        | 0         | 0                                    |
| 3            | Umum          | 3          | 7        | 2         | ↓ 71,4%                              |
| 4            | Asuransi Lain | 1          | 3        | 1         | ↓ 66,6%                              |
| Total Pasien |               | 118        | 120      | 95        | ↓ 20,8%                              |

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

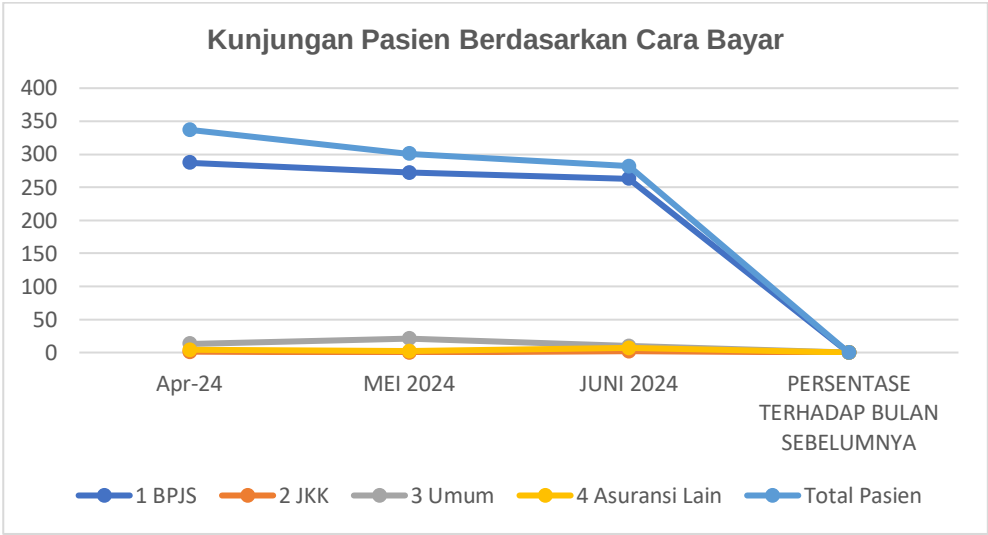
| NO. | BULAN                             | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                               | KESIMPULAN                                                                             |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | BPJS                                                                                                                                                                                                          | UMUM                                                                                                                                                                                      | JKK                                         | JR/ASURANSI                                                                                   |                                                                                        |
| 1   | Analisis capaian 3 bulan terakhir | Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir ini masih naik turun apalagi pada saat bulan juni dikarenakan beberapa hal terutama ada hari raya idul adha turun sampai 16,3% dari bulan sebelumnya                       | Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir juga sama dengan pasien BPJS masih naik turun tidak ada signifikan atau grafik yang naik terus di tandai dengan menurunnya angka pada bulan juni 71,4% | Dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien JKK | Pasien Asuransi masih mengalami naik turun terutama bulan juni ini turun dari bulan mei 66,6% | Pada bulan juni total pasien sangat turun di abndingkan 2 bulan sebelumnya yaitu 20,8% |
|     | RTL                               | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan bagian manajemen terutama marketing untuk pasien asuransi dan pasien KLL yang ada di wilayah utara |                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                               |                                                                                        |

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 287        | 272      | 263       | ↓3,3%                                |
| 2            | JKK           | 1          | 0        | 2         | ↑100%                                |
| 3            | Umum          | 13         | 21       | 10        | ↓ 52,3%                              |
| 4            | Asuransi Lain | 4          | 2        | 7         | ↑100%                                |
| Total Pasien |               | 337        | 301      | 282       | 6,31%                                |

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

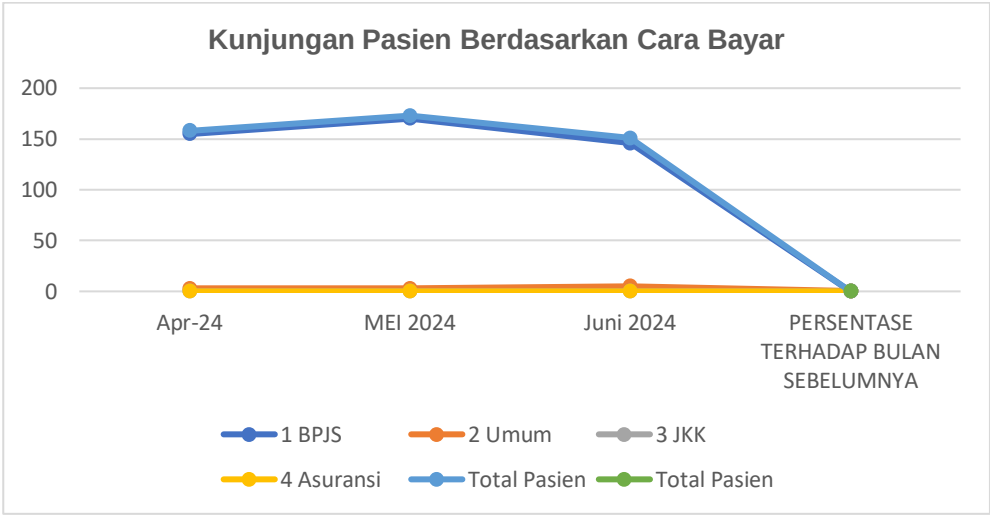
| NO. | BULAN                             | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | KESIMPULAN                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | BPJS                                                                                                                                                                                             | UMUM                                                                                                                                                          | JKK                                                                                                                                                                | JR/ASURANSI                                                                                                               |                                                                                                                        |
| 1   | Analisis capaian 3 bulan terakhir | Pasien BPJS mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan April 2024 yaitu sebanyak 305 pasien                                                                              | Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir masih naik turun dan masih belum stabil apalagi bulan juni penurunan paling banyak dari 2 bulan sebelumnya sebanyak 52,3 % | Pasien JKK berbanding terbalik dengan pasien umum untuk pasien pasien JKK bulan juni peningkatan 100% terdapat 2 pasien karena bulan mei tidak terdapat pasien jkk | Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan juni 2024 yaitu sebanyak 7 pasien | Penurunan pada bulan juni 2024 ini menunjukkan grafik dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan dikarenakan hari raya |
|     | RTL                               | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, mengurangi jumlah komplain terkait pelayanan maupun keramahan perawat yang kurang bagus dalam melakukan etika |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                        |

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April – Juni 2024)

| NO           | HAL      | APRIL 2024 | MEI 2024 | Juni 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|----------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS     | 155        | 170      | 146       | ↓ 14,11%                             |
| 2            | Umum     | 3          | 3        | 5         | ↑ 40%                                |
| 3            | JKK      | 0          | 0        | 0         | 0%                                   |
| 4            | Asuransi | 0          | 0        | 0         | 0%                                   |
| Total Pasien |          | 158        | 173      | 151       | ↓ 12,7%                              |

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

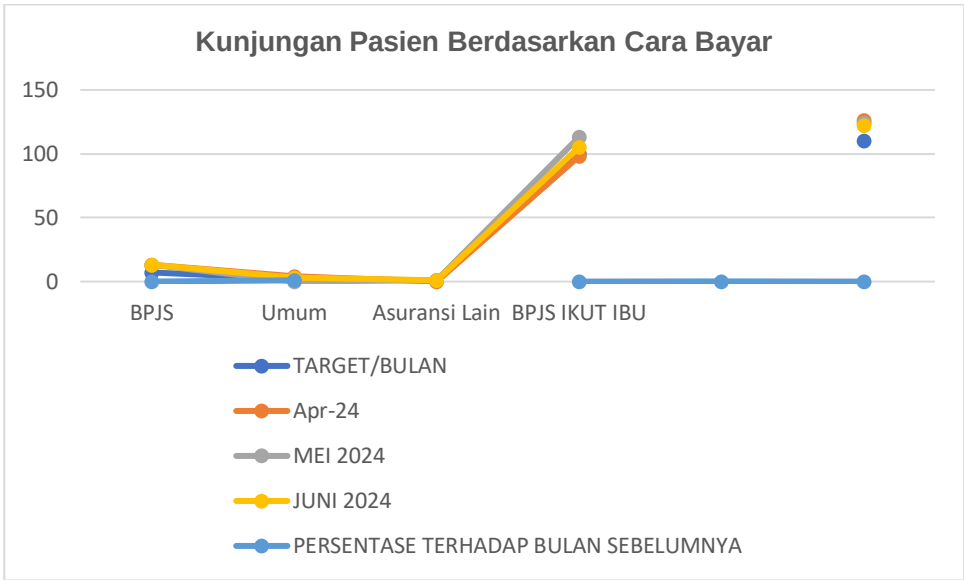
| NO. | BULAN                            | RAWAT INAP                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                |                                                        | KESIMPULAN                           |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                  | BPJS                                                                                                                                              | UMUM                                                                                                                                              | JKK                                            | JR/ASUR ANSI                                           |                                      |
| 1   | Analisis capaian April-Juni 2024 | Pasien BPJS 3 bulan terakhir masih naik turun tidak signifikan naik terus apalagi hari raya selalu penurunan terutama bulan juni penurunan 14,1 % | Pasien umum pada bulan April-Juni 2024 mengalami peningkatan 40% yaitu 2 pasien 2 bulan sebelumnya jumlah pasien 3 untuk bulan juni 2024 5 pasien | Tidak ada pasien JKK Mei                       | Tidak ada pasien asuransi di bulan Mei                 | Kunjungan mengalami penurunan 12,7 % |
| 2   | RTL                              | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan                                                                  | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan                                                                  | Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan | Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD |                                      |

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)

| NO           | HAL           | TARGET/BULAN | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 7            | 13         | 13       | 13        | 0%                                   |
| 2            | Umum          | 2            | 4          | 0        | 3         | ↑100%                                |
| 3            | Asuransi Lain | 1            | 0          | 1        | 1         | 100%                                 |
| 4            | BPJS IKUT IBU | 100          | 98         | 113      | 105       | ↓7%                                  |
| Total Pasien |               | 110          | 126        | 124      | 122       | ↓1,6%                                |

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

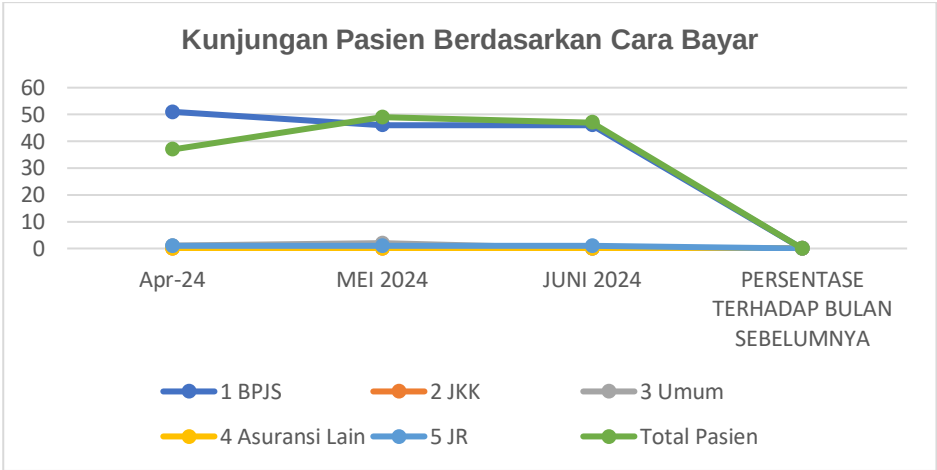
| NO. | BULAN     | RAWAT INAP                                                              |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                     | Kesimpulan                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | BPJS                                                                    | UMUM                                                                                                | ASURANSI                                                                                         | BPJS IKUT IBU                                                                                       | Total Pasien                                                                                        |
| 1   | Juni 2024 | 13                                                                      | 3                                                                                                   | 1                                                                                                | 105                                                                                                 | 122                                                                                                 |
|     | Analisa   | Pasien BPJS mengalami stagnan dengan bulan sebelumnya sebanyak 13 tetap | Untuk pasien Umum mengalami kenaikan sebelumnya a pasien 0 untuk bulan juni 3 pasien                | Dalam 3 bulan terakhir kenaikan pasien tidak signifikan dan masih tetap seperti bulan sebelumnya | Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan 7 %                                                        | Dalam 3 bulan terakhir pasien masih belum stabil masih naik turun                                   |
|     | RTL       | Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya | Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing | Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi | Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing | Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing |

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024                  | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 51         | 46       | 46                         | 0%                                   |
| 2            | JKK           | 0          | 0        | 0                          | 0%                                   |
| 3            | Umum          | 1          | 2        | 0                          | ↓100%                                |
| 4            | Asuransi Lain | 0          | 0        | 0                          | 0%                                   |
| 5            | JR            | 1          | 1        | 1                          | 0%                                   |
| Total Pasien |               | 37         | 49       | 46 (karena pasien jr+bpjs) | ↓8%                                  |

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April-Juni 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

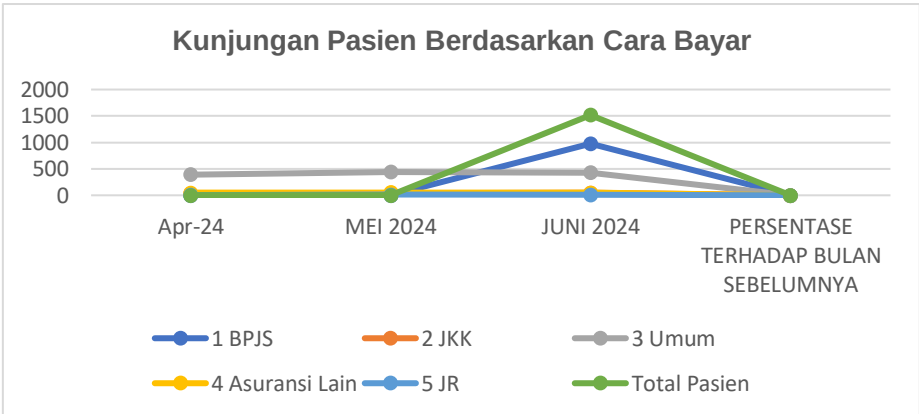
| NO. | BULAN                     | RAWAT INAP                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | KESIMPULAN                                                                                            |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | BPJS                                                                                                                                                 | UMUM                                                                                                                     | JKK                                                                                                                      | JR/ASURANSI                                                                                                              |                                                                                                       |
| 1   | Analisis 3 bulan terakhir | Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil dan masih naik turun tidak ada kenaikan lebih untuk bulan juni sama dengan bulan mei 46 pasien | Pasien UMUM tidak ada kenaikan juga untuk bulan ini pasien umum turun dari bulan sebelum sebelumnya                      | Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan                                                                                      | 3 bulan terakhir pasien ICU yang JR tidak ada kenaikan dan penurunan tetap hanya 1 pasien                                | Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU masih naik turun untuk juni total 46 pasien |
| 2   | RTL                       | Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya                             | Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya | Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya | Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya |                                                                                                       |

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2024)

| NO           | HAL           | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 1.383      | 1.301    | 976       | ↓33%                                 |
| 2            | JKK           | 34         | 35       | 49        | ↑28,5%                               |
| 3            | Umum          | 393        | 440      | 432       | ↓1,8%                                |
| 4            | Asuransi Lain | 46         | 51       | 49        | ↓4%                                  |
| 5            | JR            | 7          | 9        | 10        | ↑10%                                 |
| Total Pasien |               | 1.834      | 1.861    | 1516      | ↓21%                                 |

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April- Juni 2024)



3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

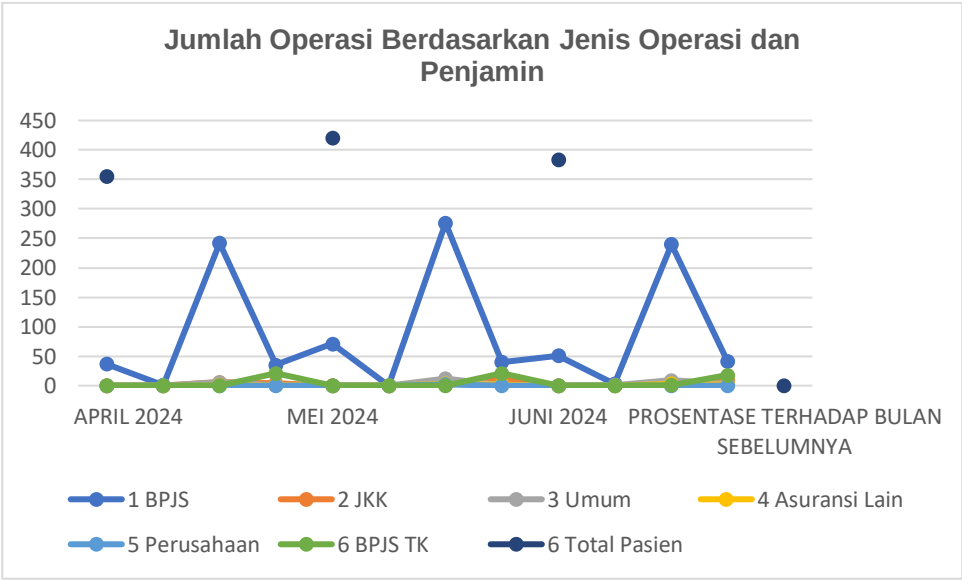
| NO. | BULAN JUNI | RAWAT INAP                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | TOTAL PASIEN                                                                                                                      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | BPJS                                                                                                                                                         | UMUM                                                                                                                      | JKK                                                                                                                                                                         | JR/ASURANSI                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| 1   | Analisis   | Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir masih naik turun terutama bulan juni 2024 mengalami penurunan 325 pasien (↓ 33%)                                 | Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan juni 2024 pasien mengalami penurunan 8 pasien (↓1,8%) | Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir selalu naik terlebih bulan juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 14 pasien (↑29%)                                  | Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan Asuransi mengalami penurunan 1 pasien                                                                  | Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami penurunan di bulan juni 2024 320 pasien                                        |
| 2   | RTL        | Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang | Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal      | Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang | Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi | Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre) |

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.5.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (April-Juni 2024)

| NO | HAL           | APRIL 2024 |   |    |    | MEI 2024 |   |    |    | JUNI 2024 |   |     |    | PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|----|---------------|------------|---|----|----|----------|---|----|----|-----------|---|-----|----|--------------------------------------|
|    |               | k          | s | b  | kh | k        | s | b  | kh | k         | s | b   | kh |                                      |
| 1  | BPJS          | 37         | 1 | 24 | 35 | 7        | 0 | 27 | 40 | 51        | 3 | 240 | 41 |                                      |
| 2  | JKK           | 0          | 0 | 6  | 4  | 0        | 0 | 1  | 13 | 0         | 0 | 3   | 9  |                                      |
| 3  | Umum          | 0          | 0 | 6  | 1  | 0        | 0 | 12 | 1  | 0         | 1 | 9   | 3  |                                      |
| 4  | Asuransi Lain | 0          | 0 | 1  | 1  | 0        | 0 | 3  | 2  | 0         | 0 | 3   | 2  |                                      |
| 5  | Perusahaan    | 0          | 0 | 0  | 0  | 0        | 0 | 2  | 0  | 0         | 0 | 0   | 0  |                                      |
| 6  | BPJS TK       | 0          | 0 | 0  | 21 | 0        | 0 | 0  | 21 | 0         | 0 | 1   | 18 |                                      |
|    | Total Pasien  | 355        |   |    |    | 420      |   |    |    | 384       |   |     |    | ↓8,5%                                |

3.3.5.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (April - Juni 2024)



3.3.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| NO. | BULAN                             | IKO                                                                                                            |                                                                  |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                          | KESIMPULAN                                                                                        |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | BPJS                                                                                                           | BPJS TK                                                          | UMUM                                                     | JKK                                                                                                   | JR/ASURANSI                                                                                              |                                                                                                   |
| 1   | Analisis capaian 3 bulan terakhir | Pasien BPJS mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan mei 2024 18,60% 72 pasien                            | Pasien BPJS TK mengalami kenaikan dari maret sampai mei 3 pasien | Pasien Umum naik dari bulan april ke mei 7 pasien 53,84% | Pasien JKK masih belum stabil dan tetapi setiap bulan naik,untuk bulan mei 2024 naik 4pasien ,28,57 % | Pasien Asuransi / JR mengalami belum stabil selama 3 bulan mengalami kenaikan 60% ,untuk pasien 3 pasien | Selama 3 bulan jumlah operasi yang ada di IKO belum stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan |
| 2   | RTL                               | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkolaborasi dengan IKO |                                                                  |                                                          |                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                   |

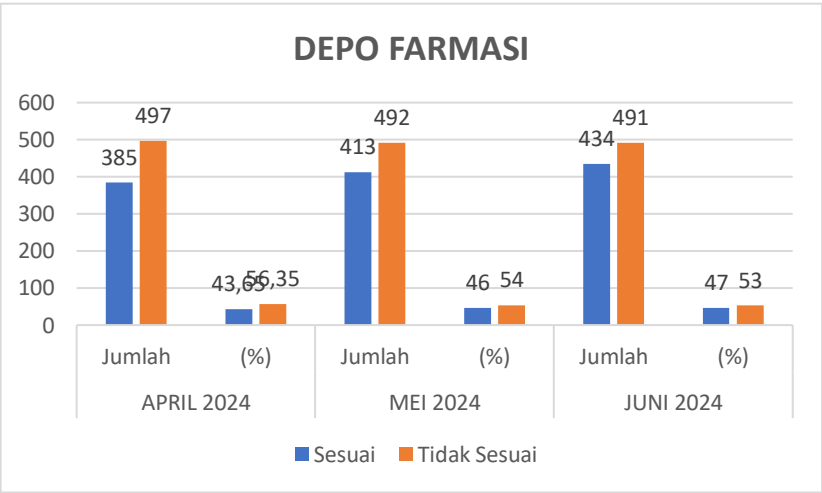
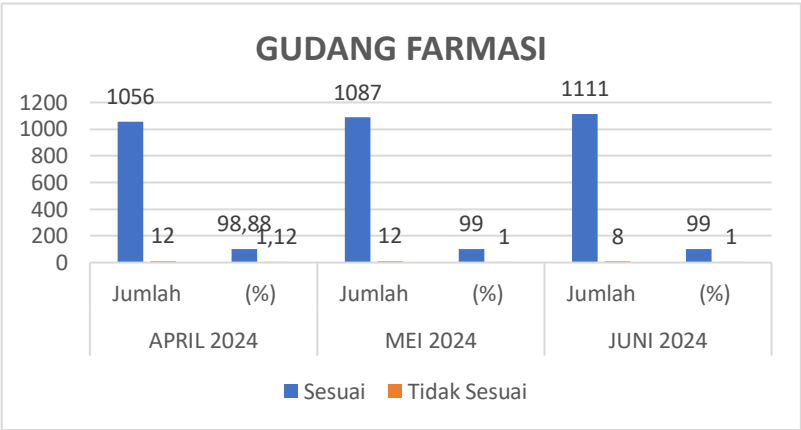
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

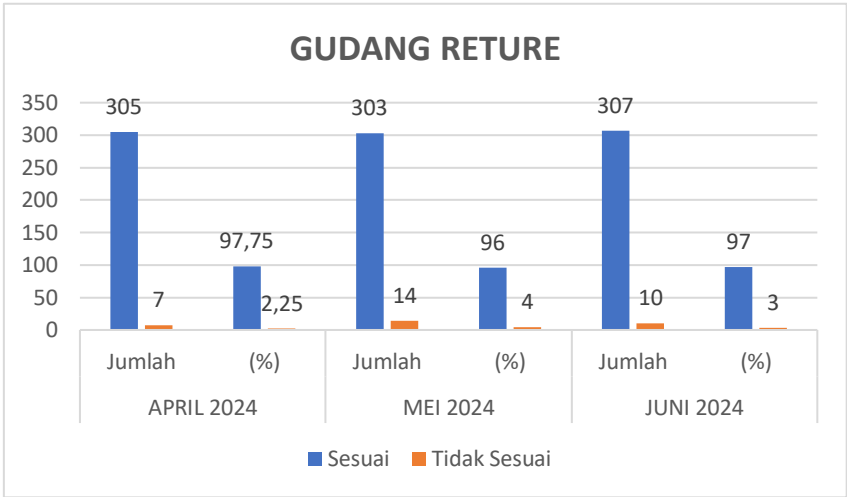
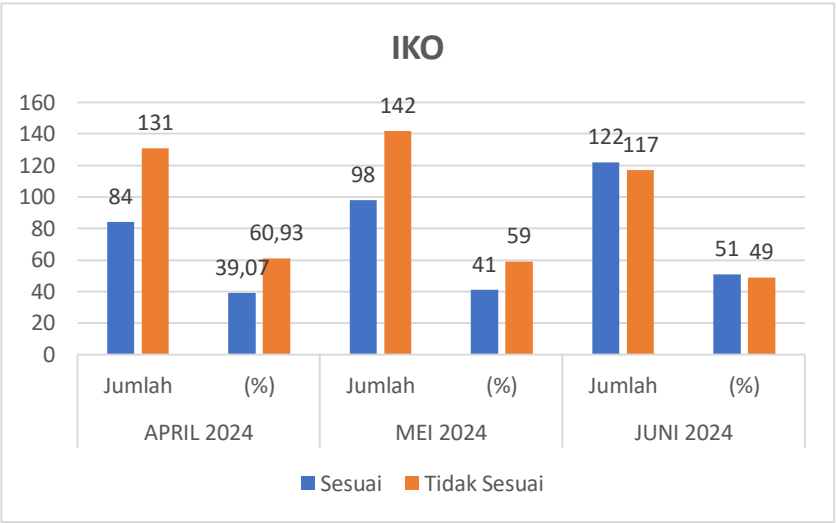
3.4.1 Instalasi Farmasi

3.4.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan April - Juni 2024

| UNIT         | STOCK        | JUMLAH STOK |        |          |      |           |      |
|--------------|--------------|-------------|--------|----------|------|-----------|------|
|              |              | APRIL 2024  |        | MEI 2024 |      | JUNI 2024 |      |
| GUDANG       | Sesuai       | 1056        | 98,88% | 1087     | 99%  | 1111      | 99%  |
|              | Tidak Sesuai | 12          | 1,12%  | 12       | 1%   | 8         | 1%   |
|              | Total        | 1068        | 100%   | 1099     | 100% | 1119      | 100% |
| DEPO FARMASI | Sesuai       | 385         | 43,65% | 413      | 46%  | 434       | 47%  |
|              | Tidak Sesuai | 497         | 56,35% | 492      | 54%  | 491       | 53%  |
|              | Total        | 882         | 100%   | 905      | 100% | 925       | 100% |
| IKO          | Sesuai       | 84          | 39,07% | 98       | 41%  | 122       | 51%  |
|              | Tidak Sesuai | 131         | 60,93% | 142      | 59%  | 117       | 49%  |
|              | Total        | 215         | 100%   | 240      | 100% | 239       | 100% |
| GUDANG RETUR | Sesuai       | 305         | 97,75% | 303      | 96%  | 307       | 97%  |
|              | Tidak Sesuai | 7           | 2,25%  | 14       | 4%   | 10        | 3%   |
|              | Total        | 312         | 100%   | 317      | 100% | 317       | 100% |

3.4.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan April - Juni 2024





3.4.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

| NO | ANALISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Terdapat obat sudah diinput retur tetapi belum diinput release di Depo, contoh: Cefadroxil Kapsul - Hexpharm.<br>Terdapat stock di Gudang Retur yang terinput oleh Programmer dikarenakan trial fitur penerimaan hibah lainnya.                                                                                                                                                                                                                                 | Dilakukan penyesuaian stock.<br>Petugas Depo dan Gudang Farmasi lebih teliti dalam serah terima obat retur dan mengecek kesesuaian fisik dan sistem yang sudah di release. |
| 2. | Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan SIMRS.<br>Seperti:<br>a. Rekap obat yang tidak ada di kertas kerja rak obat luar:<br>- F00462 Erlamycetin Tetes Telinga<br>- F03326 Akilen Tetes Telinga<br>- F00576 Genoint Salep Mata<br>b. Rekap obat yang harusnya masuk di kertas kerja rak OOT :<br>- F04164 Tramadol Tab 50 mg - Otto<br>c. Rekap obat yang tidak ada di kertas kerja rak obat sirup:<br>- F03498 Helixim Syr 100 mg/5 ml | Koordinasi antara Kepala Instalasi Farmasi dengan Keuangan untuk update rak dan kertas kerja.                                                                              |
| 3. | Rekap Near ED sediaan farmasi di Gudang Farmasi yang kurang dari 3 bulan :<br>a. Bulan Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barang-barang Near ED di Gudang Farmasi akan dialihkan ke PHS yang lebih fast moving pemakaiannya.                                                                         |

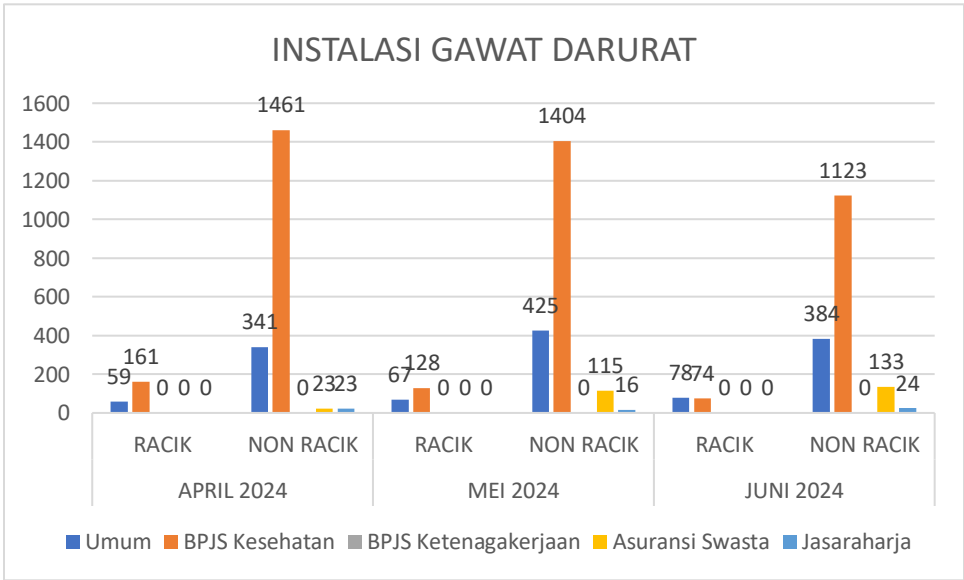
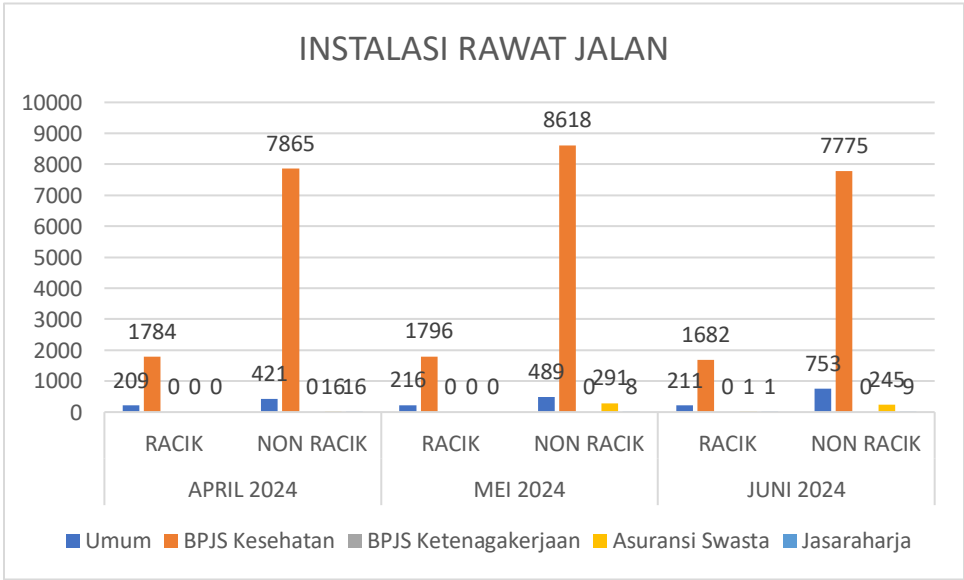
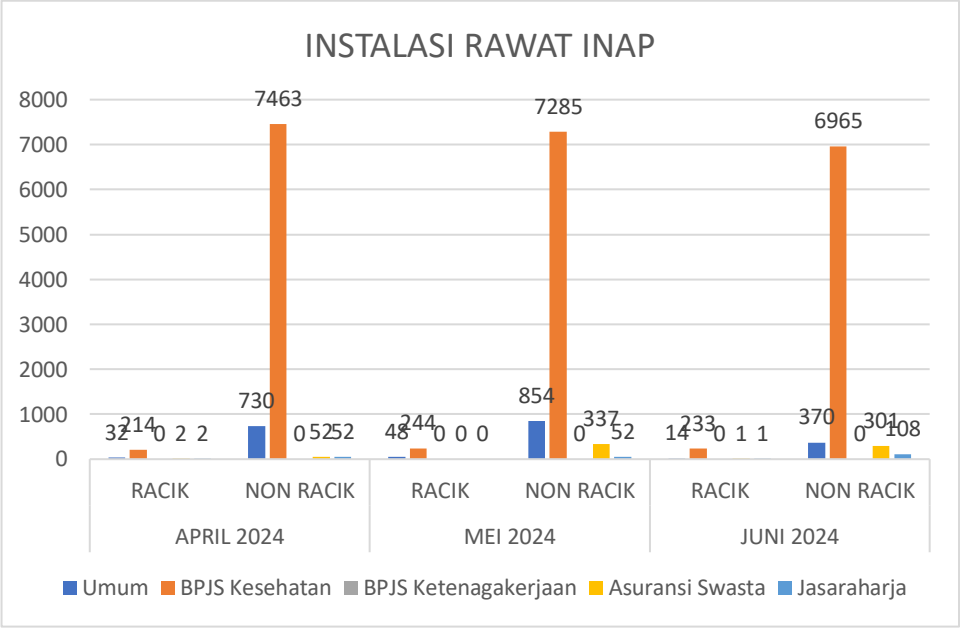
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- F00901 Meylon 8,4% 25 ml - Otsuka</li> </ul> <p>b. Bulan September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F03173 Acetylcysteine Inf 200 mg/50 ml – Yarindo.</li> <li>- F01471 Widahes 130 Unicap Inf – Widatra.</li> <li>- F03750 Ethambutol Tab 400 mg.</li> <li>- F03094 Ezelin Insulin.</li> <li>- F02925 S-Omevell Inj 40 mg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 4. | <p>Master dengan kode barang F04155 isi satuan awal adalah 25.</p> <p>Kemudian pada tanggal 12/06/2024, barang datang dengan kemasan yang berubah menjadi isi satuan 100, sehingga dilakukan input penerimaan dengan penyesuaian master barang, yang awalnya 31 box isi satuan 100 disesuaikan menjadi 124 box isi satuan 25.</p> <p>Pada tanggal 13/06/2024 dilakukan permintaan update master barang isi satuan menjadi 100, dan sudah dirubah oleh programmer pada tanggal 13/06/2024.</p> <p>Akan tetapi jumlah penerimaan di hari sebelumnya berubah kembali menjadi isi satuan 100, yang seharusnya isi satuannya adalah 25.</p>    | Koordinasi dengan programmer untuk update isi satuan pada master barang agar transaksi sebelumnya di <i>lock</i> , sehingga tidak ada pergerakan data dan dilakukan penyesuaian stock.    |
| 5. | <p>Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan SIMRS, seperti : F02896 Hexadol Mint Solution 100 ml - Otto, kertas kerjanya masuk pada rak obat sirup, sedangkan di SIMRS masuk pada rak obat luar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi antara Kepala Instalasi Farmasi dengan Keuangan untuk update rak dan kertas kerja.                                                                                             |
| 6. | <p>Petugas Farmasi ketika entry data seringkali tidak memperhatikan ED dan No. Batch. Implikasinya, beberapa sediaan farmasi menjadi near ED, terjadi ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, contoh : Prolon tab, Cefuroxim inj.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Koordinasi Kepala Instalasi Farmasi dengan sdm untuk edukasi dalam peningkatan ketelitian.                                                                                                |
| 7. | <p>Rekap Near ED sediaan farmasi di Depo Farmasi yang kurang dari 3 bulan :</p> <p>a. Bulan Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F00901 Meylon 8,4% 25 ml – Otsuka</li> <li>- F02322 Indop Inj 750 mg - OGB Fahrenheit</li> <li>- F00214 Cairan Kaen MG3 500 ml – Otsuka</li> <li>- F00349 Comafusin Hepar Inf – Kalbe</li> </ul> <p>b. Bulan September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F01712 Desolex Lotion 30 ml – SDM</li> <li>- F03090 Nairet Inj 0.25 mg/ml – Otto</li> <li>- F02521 Pioglitazone Tab 30 mg – Yarindo</li> <li>- F03173 Acetylcysteine Inf 200 mg/50 ml – Yarindo</li> </ul> | Sediaan farmasi near ed akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. |

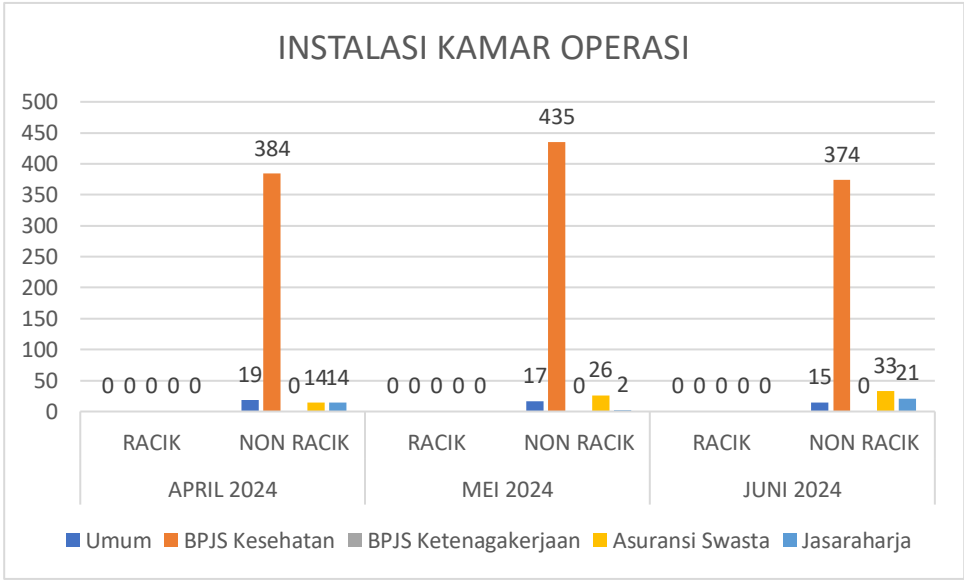
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - F01471 Widahe 130 Unicap Inf - Widatra                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | Ditemukan adanya selisih pada sediaan barang dengan kode barang F04350 Pil KB Lynestrenol - BKKBN (hibah) sebanyak 2.800 pada SIMRS. Setelah di telusur ternyata penempatan sediaan barangnya langsung diserahkan ke asisten dokter Poli Obyn. | Koordinasi Kepala Instalasi Farmasi dengan Asisten Poli terkait penempatan sediaan hibah Pil KB dikarenakan obat near ED 12/2024 dan inisiatif dari perawat agar obat langsung diserahkan ke pasien post partum (seringkali tidak ada resep) dan agar pasien tidak antri ke farmasi. Dan perawat tetap input resep obat hibah tersebut agar mengurangi stok di Depo Farmasi. |
| 9.  | Master barang dengan kode F00693 ISPRINOL TAB 500MG tidak masuk di rak (sehingga tidak masuk di stok opname) Fisik 32 tab, disistem 40 tab.                                                                                                    | Koordinasi Kepala Instalasi Farmasi dengan Keuangan update rak dan kertas kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | Ditemukan selisih kurang barang RED DOT ELECTRODE sebanyak 215 pcs dikarenakan pemakaian di Poli tidak terinput di resep pasien.                                                                                                               | Koordinasi Kepala Instalasi Farmasi dengan Karu Poli terkait serah terima dan input peresepan. Pengajuan red dot electrode masuk tarif tindakan treadmill.                                                                                                                                                                                                                   |

3.4.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran April - Juni 2024

| NO          | UNIT | PENJAMIN             | BULAN/JENIS RESEP |           |          |           |           |           |
|-------------|------|----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|             |      |                      | APRIL 2024        |           | MEI 2024 |           | JUNI 2024 |           |
|             |      |                      | RACIK             | NON RACIK | RACIK    | NON RACIK | RACIK     | NON RACIK |
| 1.          | IRNA | Umum                 | 32                | 730       | 48       | 854       | 14        | 370       |
|             |      | BPJS Kesehatan       | 214               | 7463      | 244      | 7285      | 233       | 6965      |
|             |      | BPJS Ketenagakerjaan | 0                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|             |      | Asuransi Swasta      | 2                 | 52        | 0        | 337       | 1         | 301       |
|             |      | Jasaraharja          | 2                 | 52        | 0        | 52        | 1         | 108       |
| Total       |      |                      | 250               | 8297      | 292      | 8820      | 249       | 7993      |
| 2.          | IRJA | Umum                 | 209               | 421       | 216      | 489       | 211       | 753       |
|             |      | BPJS Kesehatan       | 1784              | 7865      | 1796     | 8618      | 1682      | 7775      |
|             |      | BPJS Ketenagakerjaan | 0                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|             |      | Asuransi Swasta      | 0                 | 16        | 0        | 291       | 1         | 245       |
|             |      | Jasaraharja          | 0                 | 16        | 0        | 8         | 1         | 9         |
| Total       |      |                      | 1993              | 8318      | 2012     | 9406      | 1895      | 8782      |
| 3.          | IGD  | Umum                 | 59                | 341       | 67       | 425       | 78        | 384       |
|             |      | BPJS Kesehatan       | 161               | 1461      | 128      | 1404      | 74        | 1123      |
|             |      | BPJS Ketenagakerjaan | 0                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|             |      | Asuransi Swasta      | 0                 | 23        | 0        | 115       | 0         | 133       |
|             |      | Jasaraharja          | 0                 | 23        | 0        | 16        | 0         | 24        |
| Total       |      |                      | 220               | 1848      | 195      | 1960      | 152       | 1664      |
| 4.          | IKO  | Umum                 | 0                 | 19        | 0        | 17        | 0         | 15        |
|             |      | BPJS Kesehatan       | 0                 | 384       | 0        | 435       | 0         | 374       |
|             |      | BPJS Ketenagakerjaan | 0                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         |
|             |      | Asuransi Swasta      | 0                 | 14        | 0        | 26        | 0         | 33        |
|             |      | Jasaraharja          | 0                 | 14        | 0        | 2         | 0         | 21        |
| Total       |      |                      | 0                 | 431       | 0        | 480       | 0         | 443       |
| Total Resep |      |                      | 2463              | 18894     | 2499     | 20666     | 2296      | 18882     |

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran April - Juni 2024





**Analisis :**

- 1. Total Resep di Bulan Juni 2024 mengalami penurunan, baik resep di IGD, IRNA, IRJA dan IKO. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien.
- 2. Tarikan data pasien BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi satu dengan Asuransi Swasta dan Jasaraharja (jika menjadi penjamin pertama), dibuktikan dengan jumlah kunjungan pasien di IGD sebanyak 49 sedangkan pelayanan resep di IGD tidak ada atau 0.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Koordinasi dengan Programmer untuk memisahkan data pasien BPJS Ketenagakerjaan dari data pasien Asuransi Swasta supaya mendapatkan data yang valid.

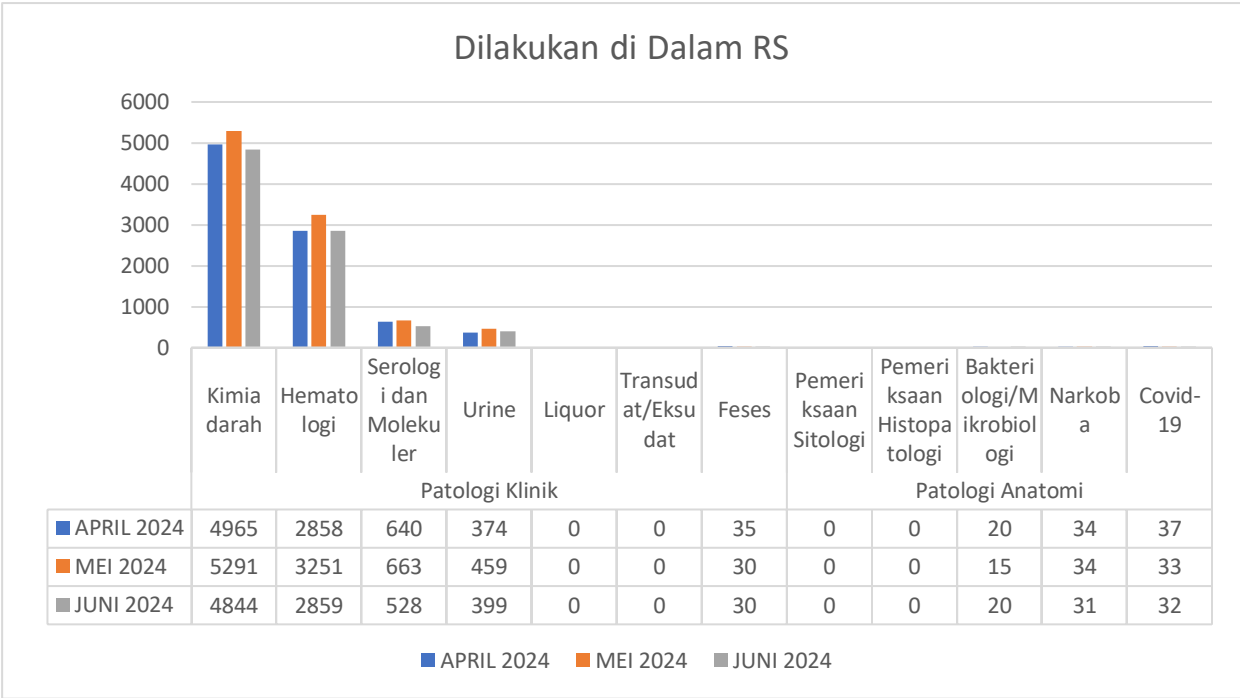
**3.1.2 Laboratorium**

**3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar April - Juni 2024**

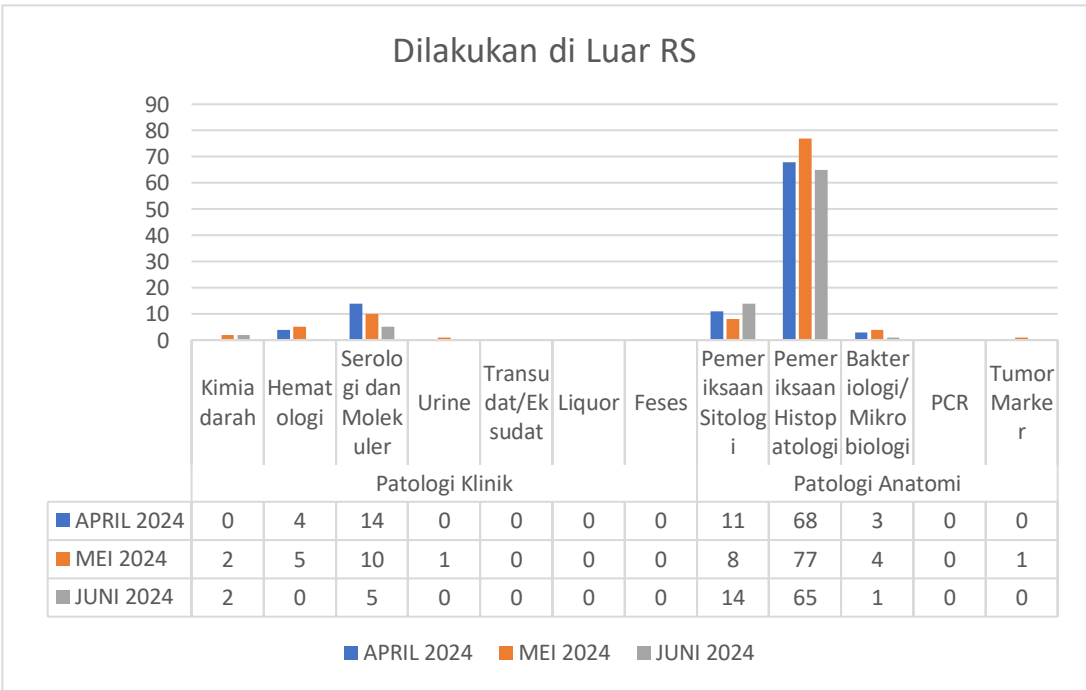
| NO              | JENIS PEMERIKSAAN         | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|-----------|
| Dilakukan di RS |                           |            |          |           |
| 1.              | Patologi Klinik           |            |          |           |
|                 | Kimia darah               | 4965       | 5291     | 4844      |
|                 | Hematologi                | 2858       | 3251     | 2859      |
|                 | Serologi dan Molekuler    | 640        | 663      | 528       |
|                 | Urine                     | 374        | 459      | 399       |
|                 | Liquor                    | -          | -        | -         |
|                 | Transudat/Eksudat         | -          | -        | -         |
|                 | Feses                     | 35         | 30       | 30        |
| 2.              | Patologi Anatomi          |            |          |           |
|                 | Pemeriksaan Sitologi      | 0          | 0        | 0         |
|                 | Pemeriksaan Histopatologi | 0          | 0        | 0         |
| 3.              | Bakteriologi/Mikrobiologi | 20         | 15       | 20        |
| 4.              | Narkoba                   | 34         | 34       | 31        |
| 5.              | Covid-19                  | 37         | 33       | 32        |
| Dirujuk         |                           |            |          |           |
| 1.              | Patologi Klinik           |            |          |           |
|                 | Kimia darah               | 0          | 2        | 2         |
|                 | Hematologi                | 4          | 5        | 0         |
|                 | Serologi dan Molekuler    | 14         | 10       | 5         |
|                 | Urine                     | 0          | 1        | 0         |

|    |                           |    |    |    |
|----|---------------------------|----|----|----|
|    | Transudat/Eksudat         | -  | -  | -  |
|    | Liquor                    | -  | -  | -  |
|    | Feses                     | 0  | 0  | 0  |
| 2. | Patologi Anatomi          |    |    |    |
|    | Pemeriksaan Sitologi      | 11 | 8  | 14 |
|    | Pemeriksaan Histopatologi | 68 | 77 | 65 |
| 3. | Bakteriologi/Mikrobiologi | 3  | 4  | 1  |
| 4. | PCR                       | 0  | 0  | 0  |
| 5. | Tumor Marker              | 0  | 1  | 0  |

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit



3.1.2.3 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan Juni 2024 yaitu :
  - a) Patologi Anatomi : 79 sampel
  - b) Patalogi Klinik : 7 sampel
  - c) Bakteri/Mikrobiologi : 1 sampel
  - d) Lain-lain (Tumor Marker) : 0 sampel

Rencana Tindak Lanjut

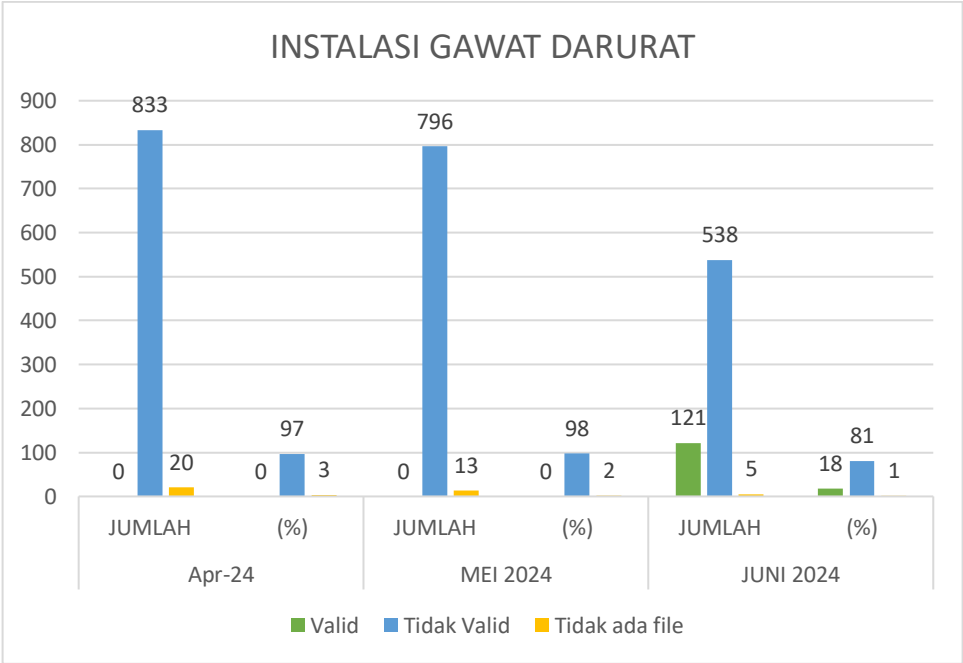
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan sistem digital.

3.1.3 Rekam Medis – Pendaftaran

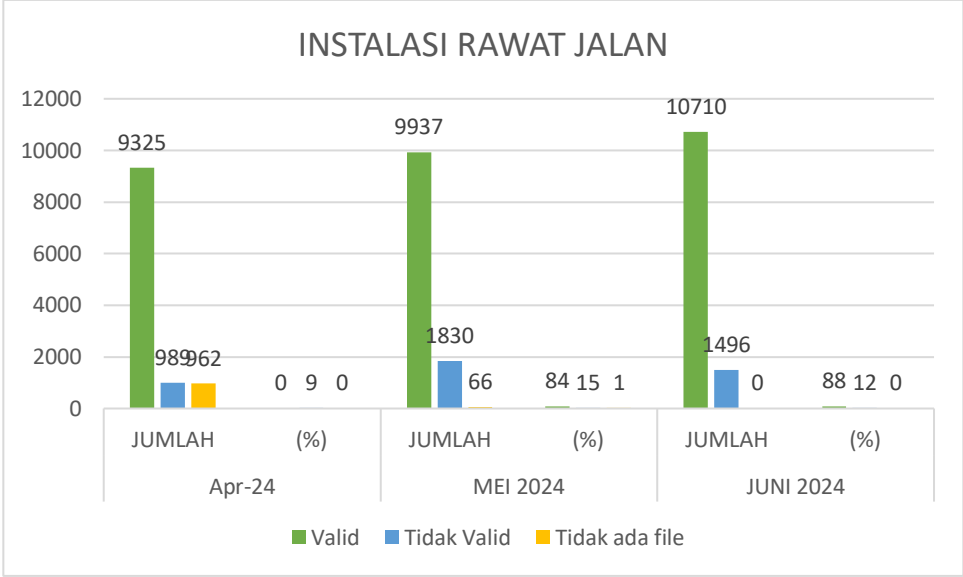
3.1.3.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan April - Juni 2024

| NO | UNIT      | KUALIFIKASI    | BULAN      |      |          |     |           |     |
|----|-----------|----------------|------------|------|----------|-----|-----------|-----|
|    |           |                | APRIL 2024 |      | MEI 2024 |     | JUNI 2024 |     |
|    |           |                | JUMLAH     | (%)  | JUMLAH   | (%) | JUMLAH    | (%) |
| 1  | IGD       | Valid          | 0          | 0    | 0        | 0   | 121       | 18  |
|    |           | Tidak Valid    | 833        | 97   | 796      | 98  | 538       | 81  |
|    |           | Tidak ada file | 20         | 3    | 13       | 2   | 5         | 1   |
|    |           | Total          | 853        |      | 809      |     | 664       |     |
| 2  | IRJA/POLI | Valid          | 9325       | 82,5 | 9937     | 84  | 10710     | 88  |
|    |           | Tidak Valid    | 989        | 9    | 1830     | 15  | 1496      | 12  |
|    |           | Tidak ada file | 962        | 8,5  | 66       | 1   | 0         |     |
|    |           | Total          | 11276      |      | 11833    |     | 12206     |     |

3.1.3.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan April - Juni 2024



3.1.3.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan April - Juni 2024



Analisis :

1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 121 Data E-RM dari 0 Data E-RM, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
2. Ada 81% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis.
3. Terjadi penurunan data tidak valid di IRJA, hal ini juga disebabkan adanya perubahan alur penyetoran casemix/data kunjungan pasien per hari.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Ada beberapa tanda tangan pasien belum muncul.
3. Pada fitur “keadaan umum” di lembar triage pengkajian awal medis igd muncul di Billing rekam medis, tetapi di Billing IGD tidak muncul.
4. Berikut link permasalahan yang ditemui

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ\\_D\\_k/edit#gid=1732600455](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455)

Rencana Tindak Lanjut :

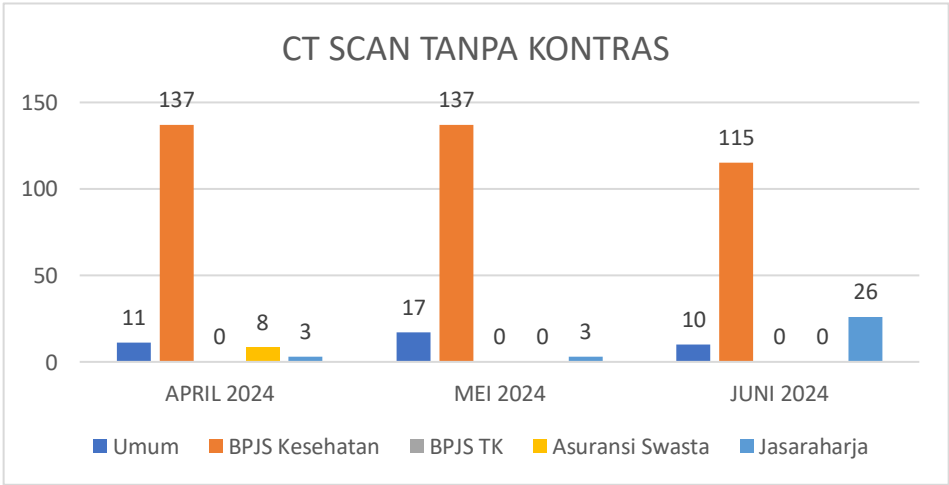
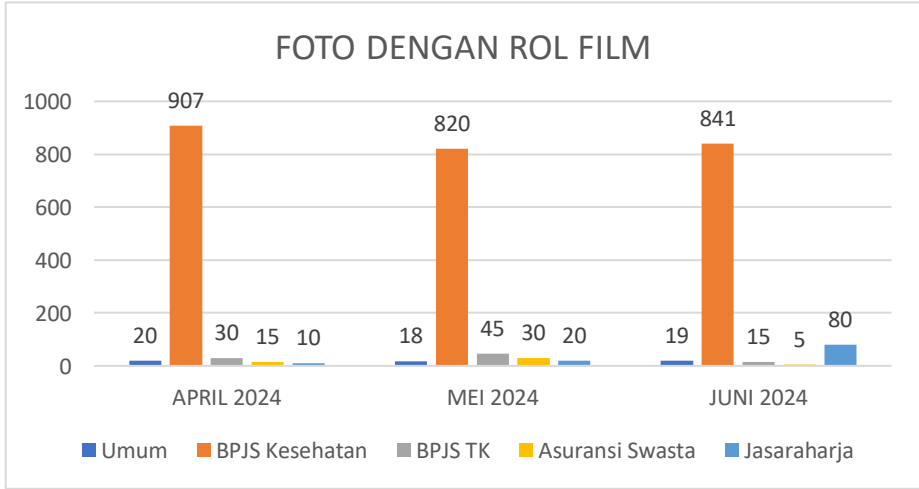
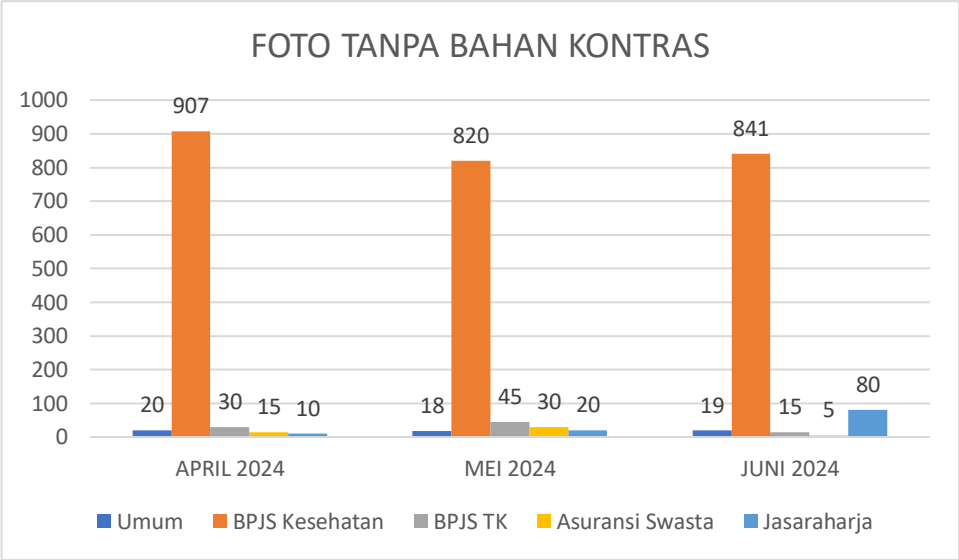
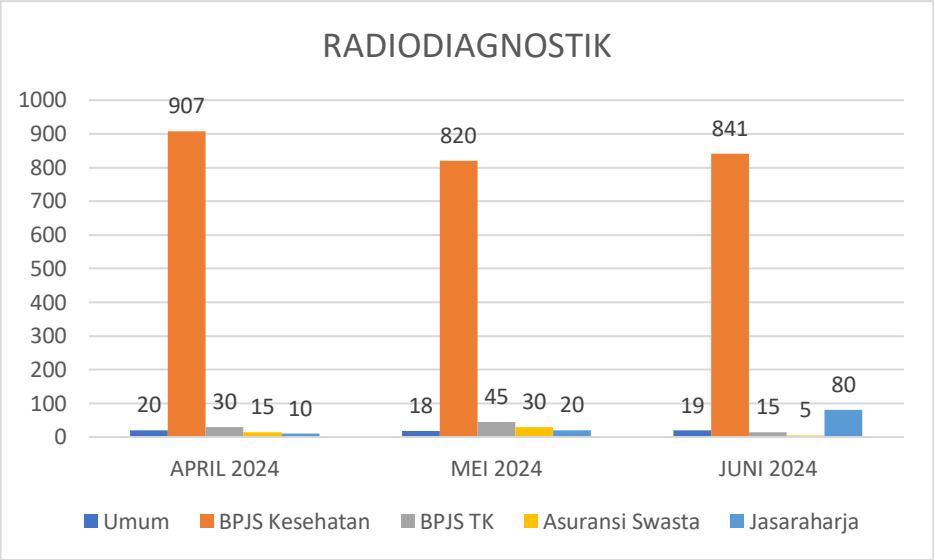
1. Ketidakiengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :
2. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
3. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
4. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

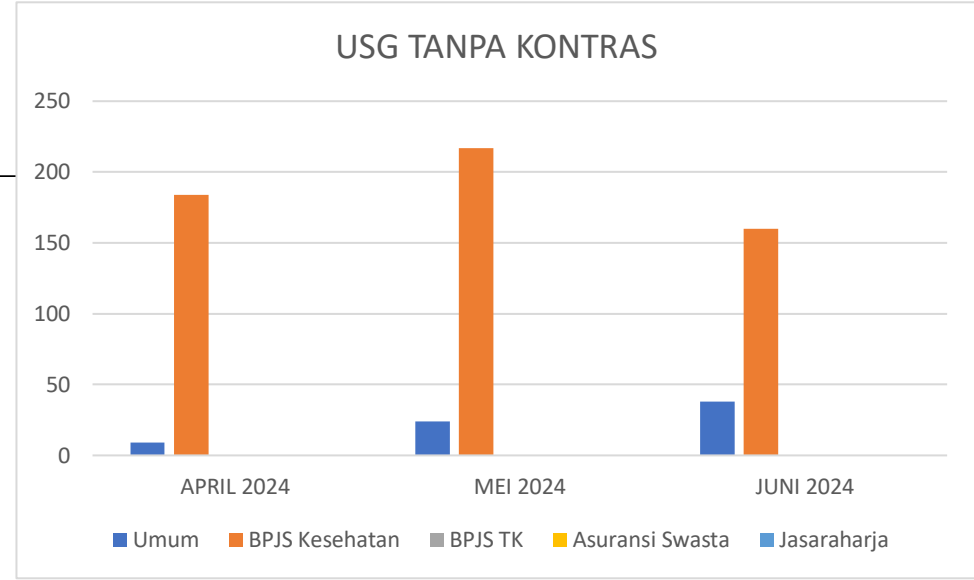
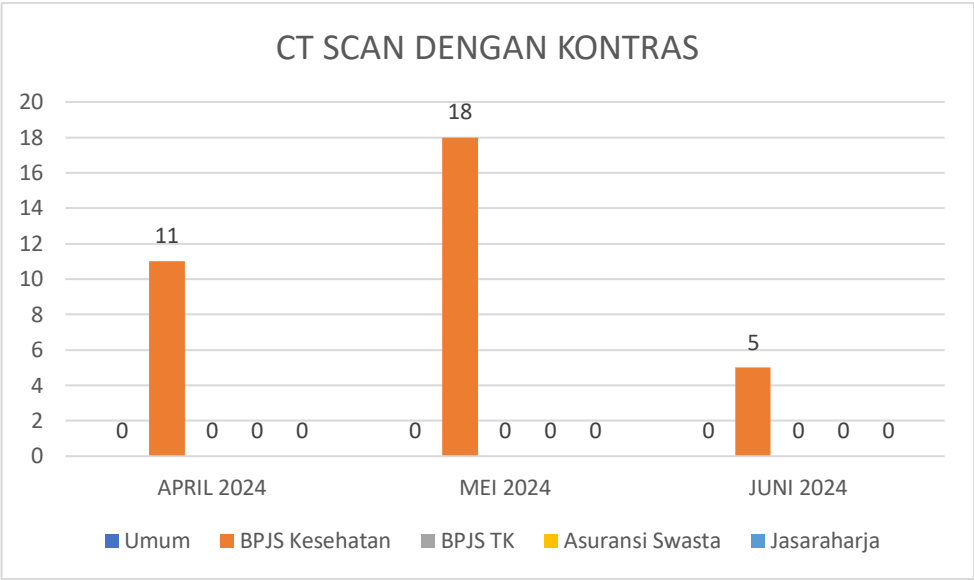
3.1.4 Radiologi

3.1.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi April – Juni 2024

| NO    | JENIS PEMERIKSAAN        | JENIS PEMBAYARAN | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-------|--------------------------|------------------|------------|----------|-----------|
| 1     | Radiodiagnostik          | Umum             | 20         | 18       | 19        |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 907        | 820      | 841       |
|       |                          | BPJS TK          | 30         | 45       | 15        |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 15         | 30       | 5         |
|       |                          | Jasaraharja      | 10         | 20       | 80        |
| TOTAL |                          |                  | 982        | 938      | 960       |
| 2     | Foto Tanpa Bahan Kontras | Umum             | 20         | 18       | 19        |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 907        | 820      | 841       |
|       |                          | BPJS TK          | 30         | 45       | 15        |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 15         | 30       | 5         |
|       |                          | Jasaraharja      | 10         | 20       | 80        |
| TOTAL |                          |                  | 982        | 938      | 960       |
| 3     | Foto Dengan Rol Film     | Umum             | 20         | 18       | 19        |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 907        | 820      | 841       |
|       |                          | BPJS TK          | 30         | 45       | 15        |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 15         | 30       | 5         |
|       |                          | Jasaraharja      | 10         | 20       | 80        |
| TOTAL |                          |                  | 982        | 938      | 960       |
| 4     | CT Scan Tanpa Kontras    | Umum             | 11         | 17       | 10        |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 137        | 137      | 115       |
|       |                          | BPJS TK          | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 8          | 0        | 0         |
|       |                          | Jasaraharja      | 3          | 3        | 26        |
| TOTAL |                          |                  | 159        | 157      | 151       |
| 5     | CT Scan Dengan Kontras   | Umum             | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 11         | 18       | 5         |
|       |                          | BPJS TK          | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | Jasaraharja      | 0          | 0        | 0         |
| TOTAL |                          |                  | 11         | 18       | 5         |
| 6     | USG Tanpa Kontras        | Umum             | 9          | 24       | 38        |
|       |                          | BPJS Kesehatan   | 184        | 217      | 160       |
|       |                          | BPJS TK          | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | Asuransi Swasta  | 0          | 0        | 0         |
|       |                          | Jasaraharja      | 0          | 0        | 0         |
| TOTAL |                          |                  | 193        | 241      | 198       |

3.1.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi April – Juni 2024





Analisis :

- 1. Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terkahir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.  
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
  - a. Radiodiagnostik : 960
  - b. USG Tanpa Kontras : 198
  - c. CT Scan Tanpa Kontras : 151
- 2. Pada Bulan Juni 2024 pemeriksaan radiodiagnostik tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pada 2 bulan sebelumnya sudah mencapai angka 982, sedangkan Bulan Juni 2024 hanya mencapai angka 960.

Rencana Tindak Lanjut :

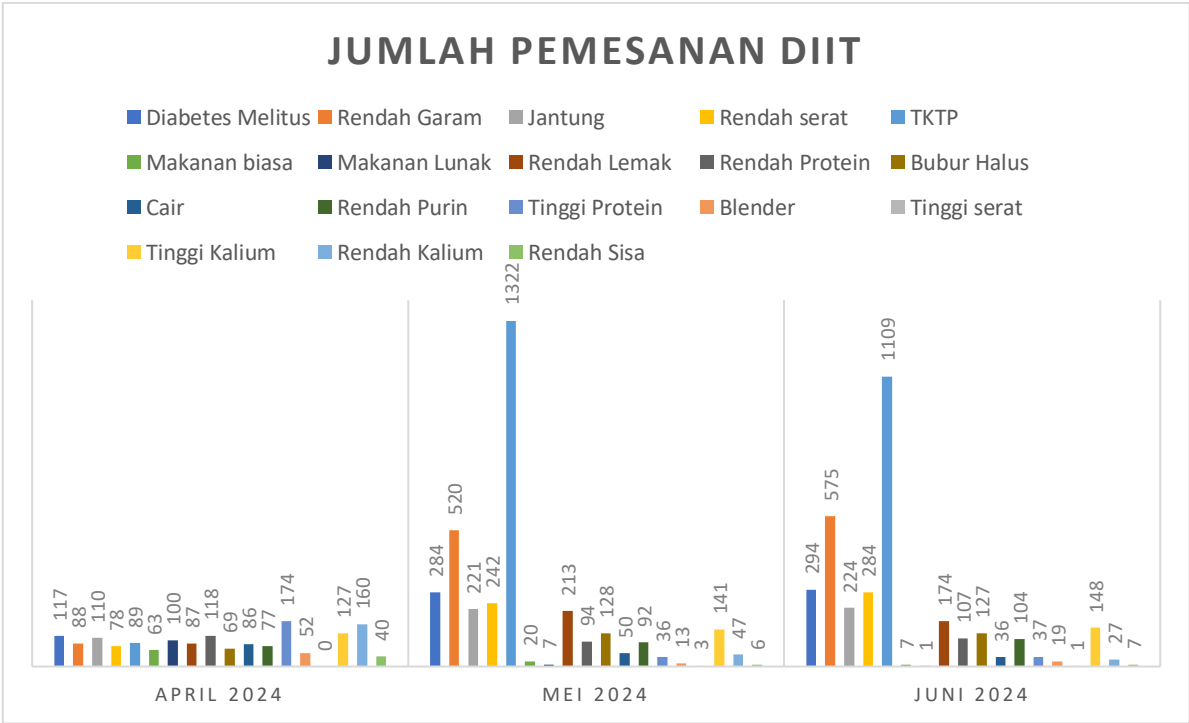
- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU pemeriksaan USG.

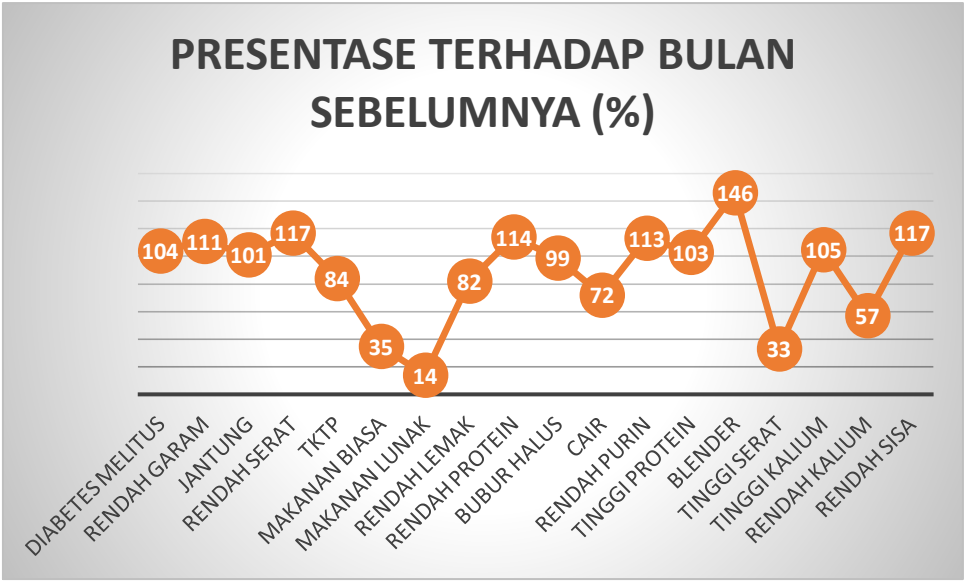
3.4.5 Gizi

3.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit April - Juni 2024

| NO    | NAMA DIIT        | JUMLAH PESANAN DIIT |          |           | PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%) |
|-------|------------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------------------|
|       |                  | APRIL 2024          | MEI 2024 | JUNI 2024 |                                          |
| 1     | Diabetes Melitus | 117                 | 284      | 294       | 104                                      |
| 2     | Rendah Garam     | 88                  | 520      | 575       | 111                                      |
| 3     | Jantung          | 110                 | 221      | 224       | 101                                      |
| 4     | Rendah serat     | 78                  | 242      | 284       | 117                                      |
| 5     | TKTP             | 89                  | 1322     | 1109      | 84                                       |
| 6     | Makanan biasa    | 63                  | 20       | 7         | 35                                       |
| 7     | Makanan Lunak    | 100                 | 7        | 1         | 14                                       |
| 8     | Rendah Lemak     | 87                  | 213      | 174       | 82                                       |
| 9     | Rendah Protein   | 118                 | 94       | 107       | 114                                      |
| 10    | Bubur Halus      | 69                  | 128      | 127       | 99                                       |
| 11    | Cair             | 86                  | 50       | 36        | 72                                       |
| 12    | Rendah Purin     | 77                  | 92       | 104       | 113                                      |
| 13    | Tinggi Protein   | 174                 | 36       | 37        | 103                                      |
| 14    | Blender          | 52                  | 13       | 19        | 146                                      |
| 15    | Tinggi serat     | 0                   | 3        | 1         | 33                                       |
| 16    | Tinggi Kalium    | 127                 | 141      | 148       | 105                                      |
| 17    | Rendah Kalium    | 160                 | 47       | 27        | 57                                       |
| 18    | Rendah Sisa      | 40                  | 6        | 7         | 117                                      |
| TOTAL |                  | 3419                | 3439     | 3281      | 95                                       |

3.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit April – Juni 2024





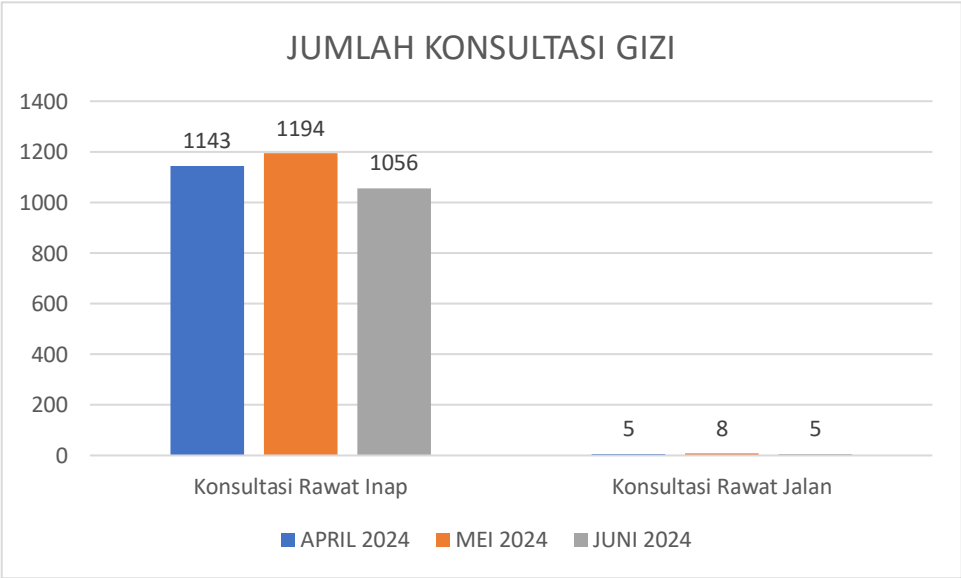
**Analisis :**  
Adanya penurunan jumlah pesanan diit tetapi tidak signifikan, jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien rawat inap.  
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
  - 2. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
  - 3. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.

**3.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi April - Juni 2024**

| NO    | INDIKASI               | BULAN      |          |           |
|-------|------------------------|------------|----------|-----------|
|       |                        | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1     | Konsultasi Rawat Inap  | 1143       | 1194     | 1056      |
| 2     | Konsultasi Rawat Jalan | 5          | 8        | 5         |
| Total |                        | 1148       | 1202     | 1061      |

**3.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi April - Juni 2024**



**Analisis :**  
Data jumlah konsultasi gizi stabil, konsultasi rawat inap tidak kurang dari 1000 dan konsultasi reawat jalan tidak lebih dari 10, hal ini disebabkan karena kurangnya promosi yang aktif untuk menarik peminat konsultasi gizi di rawat jalan, dan kurangnya permintaan konsultasi dari DPJP.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
  2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
  3. Menjalankan Prima Health Meals.

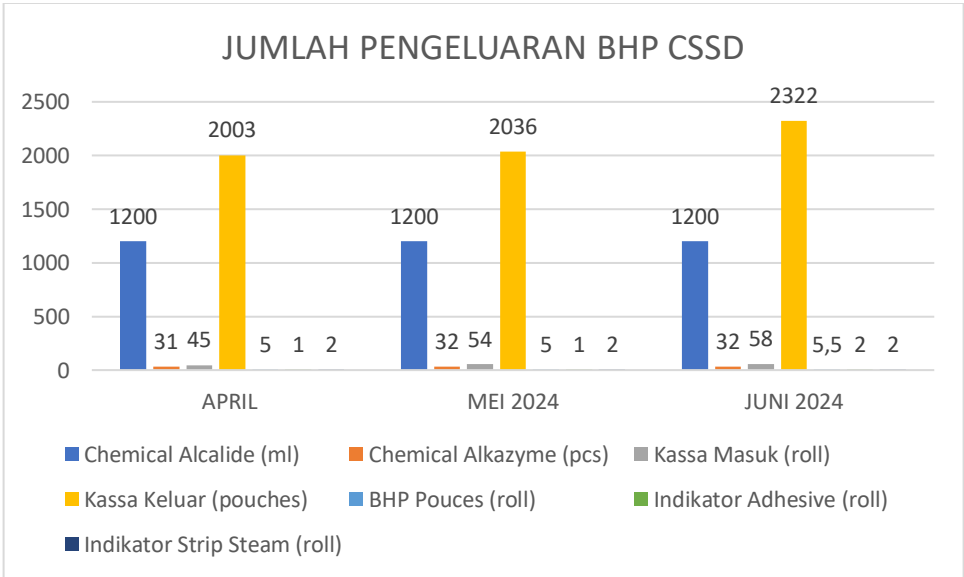
3.4.6 CSSD – Laundry

3.4.6.1 CSSD

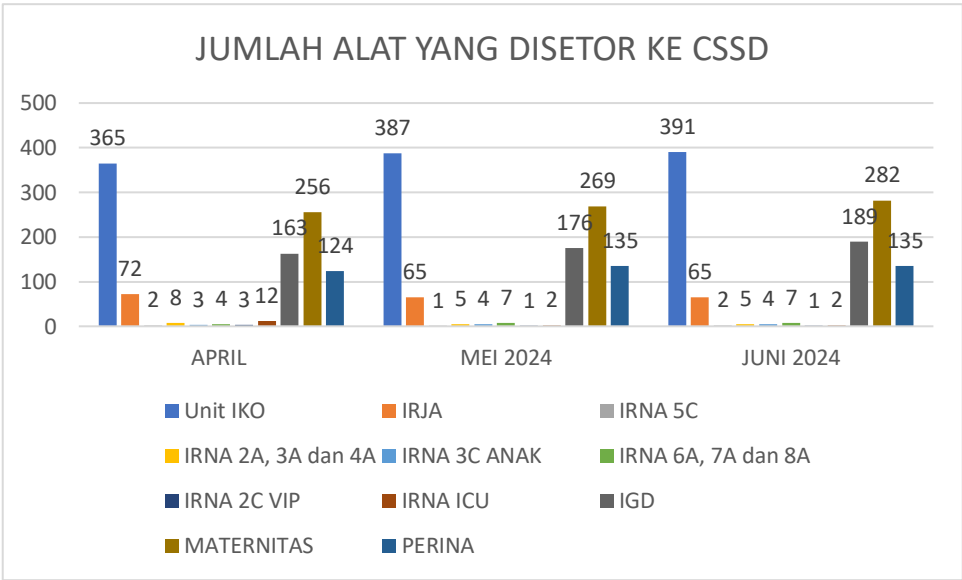
3.4.6.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan April - Juni 2024

| NO                      | HAL                          | BULAN      |          |           |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------|
|                         |                              | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| BHP                     |                              |            |          |           |
| 1                       | Chemical Alcalide (ml)       | 1200       | 1200     | 1200      |
| 2                       | Chemical Alkazyme (pcs)      | 31         | 32       | 32        |
| 3                       | Kassa Masuk (roll)           | 45         | 54       | 58        |
| 4                       | Kassa Keluar (pouches)       | 2003       | 2036     | 2322      |
| 5                       | BHP Pouces (roll)            | 5          | 5        | 5.5       |
| 6                       | Indikator Adhesive (roll)    | 1          | 1        | 2         |
| 7                       | Indikator Strip Steam (roll) | 2          | 2        | 2         |
| Alat yang disetor (set) |                              |            |          |           |
| 8                       | Unit IKO                     | 365        | 387      | 391       |
| 9                       | IRJA                         | 72         | 65       | 65        |
| 10                      | IRNA 5C                      | 2          | 1        | 2         |
| 11                      | IRNA 2A, 3A dan 4A           | 8          | 5        | 5         |
| 12                      | IRNA 3C ANAK                 | 3          | 4        | 4         |
| 13                      | IRNA 6A, 7A dan 8A           | 4          | 7        | 7         |
| 14                      | IRNA 2C VIP                  | 3          | 1        | 1         |
| 15                      | IRNA ICU                     | 12         | 2        | 2         |
| 16                      | IGD                          | 163        | 176      | 189       |
| 17                      | MATERNITAS                   | 256        | 269      | 282       |
| 18                      | PERINA                       | 124        | 135      | 135       |
| Jumlah                  |                              | 1012       | 1052     | 1083      |

3.4.6.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan April - Juni 2024



3.4.6.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan April - Juni 2024



**Analisis :**  
Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sebanyak 1.143 set, diikuti dari Unit Maternitas 807 set dan IGD 528 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

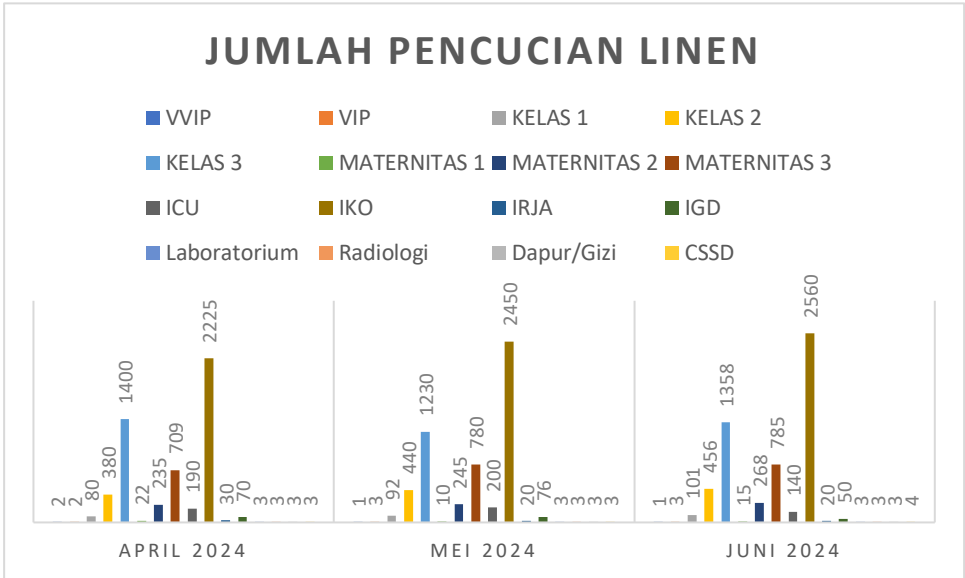
- Rencana Tindak Lanjut :**
- Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per Bulan Juli 2024.
  - Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

3.4.6.2 Laundry

3.4.6.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan April – Juni 2024

| NO    | ASAL UNIT  | JUMLAH PER BULAN (KG) |          |           |
|-------|------------|-----------------------|----------|-----------|
|       |            | APRIL 2024            | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1     | VVIP       | 2                     | 1        | 1         |
| 2     | VIP        | 2                     | 3        | 3         |
| 3     | KELAS 1    | 80                    | 92       | 101       |
| 4     | KELAS 2    | 380                   | 440      | 456       |
| 5     | KELAS 3    | 1400                  | 1230     | 1358      |
| 6     | mater 1    | 22                    | 10       | 15        |
| 7     | mater 2    | 235                   | 245      | 268       |
| 8     | mater 3    | 709                   | 780      | 785       |
| 9     | ICU        | 190                   | 200      | 140       |
| 10    | IKO        | 2225                  | 2450     | 2560      |
| 11    | IRJA       | 30                    | 20       | 20        |
| 12    | IGD        | 70                    | 76       | 50        |
| 13    | Laborat    | 3                     | 3        | 3         |
| 14    | Radiologi  | 3                     | 3        | 3         |
| 15    | Dapur/gizi | 3                     | 3        | 3         |
| 16    | CSSD       | 3                     | 3        | 4         |
| TOTAL |            | 5357                  | 5559     | 5770      |

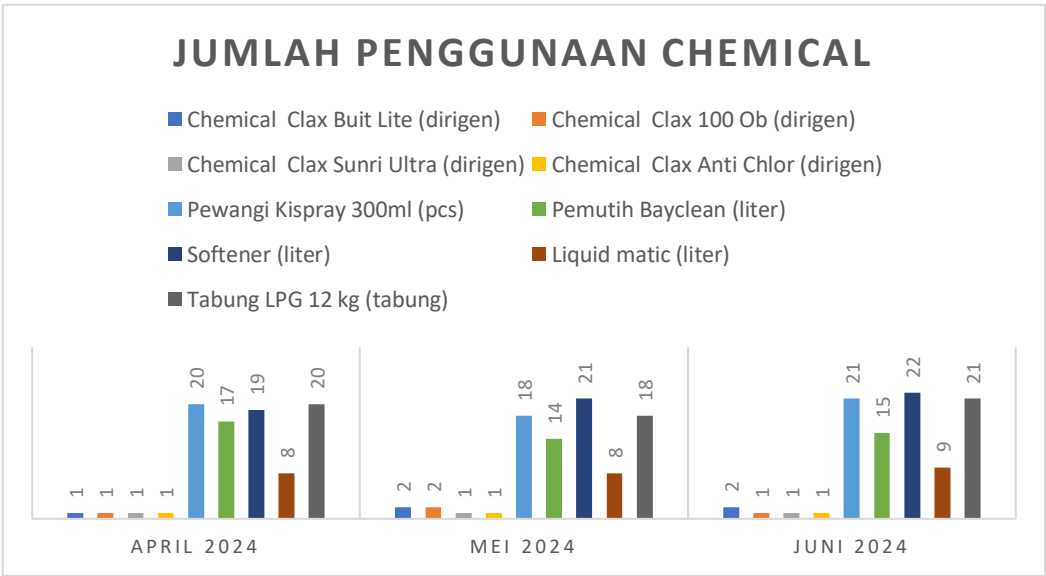
3.4.6.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan April – Juni 2024



3.4.6.2.3 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan April – Juni 2024

| NO    | ASAL UNIT                           | JUMLAH PER BULAN |          |           |
|-------|-------------------------------------|------------------|----------|-----------|
|       |                                     | APRIL 2024       | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1     | Chemical Clax Buit Lite (dirigen)   | 1                | 2        | 2         |
| 2     | Chemical Clax 100 Ob (dirigen)      | 1                | 2        | 1         |
| 3     | Chemical Clax Sunri Ultra (dirigen) | 1                | 1        | 1         |
| 4     | Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)  | 1                | 1        | 1         |
| 5     | Pewangi Kispray 300ml (pcs)         | 20               | 18       | 21        |
| 6     | Pemutih Bayclean (liter)            | 17               | 14       | 15        |
| 7     | Softener (liter)                    | 19               | 21       | 22        |
| 8     | Liquid matic (liter)                | 8                | 8        | 9         |
| 9     | Tabung LPG 12 kg (tabung)           | 20               | 18       | 21        |
| TOTAL |                                     | 88               | 85       | 93        |

3.4.6.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan April – Juni 2024



Analisa :

- 1. Terdapat peningkatan jumlah pencucian linen dari bulan sebelumnya sebanyak 11kg, berbanding lurus dengan jumlah penggunaan chemical di Laundry pada Bulan Juni 2024.
- 2. Dalam 3 bulan terakhir jumlah pencucian linen terbanyak dari Unit IKO mencapai rata-rata angka 2400kg setiap bulannya, hal ini disebabkan jumlah operasi per hari bisa mencapai diatas 5 operasi dengan operator yang berbeda dan diikuti dari ruang perawatan kelas 3, yaitu mencapai rata-rata angka 1400kg setiap bulannya.

Rencan Tindak Lanjut :

Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

| NO | UNIT                  | PENDIDIKAN                      | TOTAL | JUMLAH | TETAP | TIDAK TETAP | RESIGN |
|----|-----------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| 1  | Direktur              | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 2  | Kabid Pelayanan medik | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 3  | Kabid Penunjang Medik | D3 Kebidanan                    | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 4  | Kabid Umum & Keuangan | Dokter Gigi                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 5  | Kabid Keperawatan     | Profesi Ners                    | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 6  | Dokter IGD            | Dokter Umum                     | 7     | 7      | 0     | 7           | 0      |
| 7  | Dokter Ruangan        | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 8  | Farmasi               | SMK                             | 41    | 5      | 0     | 5           | 0      |
|    |                       | D3 Farmasi                      |       | 19     | 4     | 15          | 1      |
|    |                       | S1 Apoteker                     |       | 12     | 0     | 12          | 0      |
|    |                       | S1 Farmasi                      |       | 3      | 0     | 3           | 0      |
|    |                       | S1 Analisis Farmasi dan Makanan |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | S1 Ekonomi                      |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 9  | Asuransi Center       | SMA                             | 11    | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                             |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kesehatan                    |       | 3      | 0     | 3           | 0      |
|    |                       | D3 Asuransi Kesehatan           |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 RMIK                         |       | 5      | 0     | 5           | 0      |
| 10 | CSSD                  | SMK                             | 4     | 2      | 1     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Keperawatan                  |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Farmasi                      |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 11 | Fisioterapi           | D3 Fisioterapi                  | 4     | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kesehatan                    |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | S1 Terapi Wicara                |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 12 | Gizi                  | SMP                             | 16    | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                             |       | 6      | 0     | 6           | 0      |
|    |                       | SMA                             |       | 2      | 0     | 2           | 0      |
|    |                       | D3 Gizi                         |       | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D4 Gizi                         |       | 2      | 0     | 2           | 0      |
|    |                       | S1 Gizi                         |       | 2      | 1     | 1           | 0      |
| 13 | Humas &               | S1 Kesehatan                    | 2     | 1      | 0     | 1           | 0      |

|    |                        |                       |    |    |   |    |   |
|----|------------------------|-----------------------|----|----|---|----|---|
|    | Marketing              | Masyarakat            |    |    |   |    |   |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 1  | 0 | 0  | 0 |
| 14 | ICU dan HCU            | D3 Keperawatan        | 12 | 5  | 1 | 4  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 6  | 4 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Kebidanan          |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 15 | IGD                    | D3 Kebidanan          | 28 | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | D4 Kebidanan          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 10 | 0 | 10 | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 7  | 1 | 6  | 0 |
| 16 | IKO                    | D3 Kebidanan          | 12 | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 3  | 1 | 2  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 3 | 5  | 0 |
| 17 | IPCN                   | Profesi Ners          | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 18 | IPSRs                  | D3 TEM                | 7  | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | SKM                   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | D3 Teknik             |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | S1 Teknik             |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | SMA                   |    | 3  | 1 | 2  | 0 |
| 19 | IRJA                   | D3 Kebidanan          | 27 | 5  | 3 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 13 | 6 | 7  | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan Gigi   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 4 | 4  | 0 |
| 20 | IRNA 2C                | D3 Keperawatan        | 7  | 2  | 0 | 2  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 1 | 4  | 0 |
| 21 | IRNA 6A & 7A & 8A      | D3 Keperawatan        | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 4  | 0 | 4  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 0 | 8  | 0 |
| 22 | IRNA 3C Anak           | D3 Keperawatan        | 14 | 8  | 0 | 8  | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 23 | IRNA 3A & 4A           | D3 Keperawatan        | 19 | 14 | 0 | 14 | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 24 | IRNA 5C                | D3 Keperawatan        | 10 | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 25 | Maternitas             | D3 Kebidanan          | 11 | 7  | 7 | 1  | 1 |
|    |                        | D4 Kebidanan          |    | 2  | 1 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Bidan         |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 26 | Neonatologi            | D3 Keperawatan        | 9  | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 4  | 3 | 1  | 0 |
| 27 | Keuangan dan Akuntansi | SMA                   | 10 | 4  | 1 | 3  | 0 |
|    |                        | S1                    |    | 5  | 3 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Keuangan           |    | 1  | 0 | 1  |   |
| 28 | Laboratorium           | D3 Kesehatan          | 10 | 4  | 0 | 4  | 0 |
|    |                        | D3 Analisis Kesehatan |    | 4  | 1 | 3  | 0 |
|    |                        | D4 Analisis Kesehatan |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 29 | Laundry                | SMA                   | 5  | 5  | 3 | 2  | 0 |
| 30 | Rekam Medis            | D3 RMIK               | 10 | 9  | 3 | 6  | 0 |
|    |                        | D4 RMIK               |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 32 | Pendaftaran            | SMA                   | 15 | 6  | 1 | 5  | 0 |
|    |                        | D3 RMIK               |    | 4  | 2 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Kesehatan          |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
|    |                        | S1 Sosial             |    | 1  | 0 | 1  | 0 |

|    |                                                    |                                  |    |    |   |    |   |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|---|----|---|
|    |                                                    | D4 Manajemen                     |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 33 | PIPP                                               | Ners                             | 5  | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                                                    | D3 Keperawatan                   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                                                    | D3 Kebidanan                     |    | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                                                    | D4 Kebidanan                     |    | 2  | 1 | 1  | 0 |
| 34 | PMKP                                               | Profesi Ners                     | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 35 | Radiologi                                          | D3 Radiodiagnostik & Radioterapi | 7  | 7  | 0 | 7  | 0 |
| 36 | SDM                                                | S1 Psikologi                     | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 37 | Sekretaris                                         | S1 Administrasi Publik           | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 38 | SIMRS & IT                                         | S1 Komunikasi                    | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 39 | Umum Rumah Tangga                                  | S1 Ekonomi                       | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 40 | Cleaning Service                                   | SMP                              | 44 | 3  | 1 | 2  | 0 |
|    |                                                    | SMA                              |    | 41 | 5 | 36 | 0 |
| 41 | Security                                           | SMA                              | 12 | 12 | 6 | 6  | 0 |
| 42 | Driver                                             | SMA                              | 5  | 5  | 1 | 4  | 0 |
| 43 | Gudang Umum                                        | SMA                              | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 44 | Dokter Spesialis Syaraf                            |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 45 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah        |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 46 | Dokter Spesialis Paru                              |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 47 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam                    |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 1 |
| 48 | Dokter Spesialis Anestesi                          |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 49 | Dokter Spesialis Bedah                             |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 50 | Dokter Spesialis Bedah Plastik                     |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 51 | Dokter Spesialis Orthopedi                         |                                  | 3  | 3  |   | 3  | 0 |
| 52 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi                  |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 53 | Dokter Spesialis Patologi Klinis                   |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 54 | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 55 | Dokter Spesialis Mata                              |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 56 | Dokter Spesialis Urologi                           |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 57 | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                    |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 58 | Dokter Spesialis Obstetry Ginekology               |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 59 | Dokter Gigi Spesialis Orthodontist                 |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 60 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin                 |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 61 | Dokter Spesialis THT                               |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |

|       |                                     |  |     |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------------|--|-----|---|---|---|---|
| 62    | Dokter Spesialis<br>Gigi Periodonti |  | 1   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63    | Dokter Spesialis<br>Radiologi       |  | 2   | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64    | Dokter Spesialis<br>Bedah Saraf     |  | 1   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65    | Dokter Spesialis<br>Gigi Anak       |  | 1   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL |                                     |  | 453 |   |   |   |   |

**Keterangan :**  
Pada bulan Juni tidak terdapat pengurangan maupun penambahan staf

**3.5.1.2 Rekrutmen**

| NO | PROFESI                               | JUMLAH YANG<br>DIBUTUHKAN | TERPENUHI | KEKURANGAN | PENYEBAB                               | RENCANA<br>TINDAK<br>LANJUT                                                                           |
|----|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apoteker                              | 2                         | 0         | 2          | Sulit mencari kandidat yang cocok      | Dilakukan rekrutmen tertutup dengan menggunakan relasi karyawan apoteker rs                           |
| 2  | TTK                                   | 3                         | 0         | 3          | Sulit mencari kandidat yang cocok      | Dilakukan rekrutmen tertutup dengan menggunakan relasi karyawan apoteker rs                           |
| 3  | Terapi Okupasi                        | 1                         | 0         | 1          | Sulit mencari kandidat terapis okupasi | Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi |
| 4  | Terapi Wicara                         | 1                         | 0         | 1          | Sulit mencari kandidat terapis wicara  | Menghubungi sosial media komunitas terapis wicara, menghubungi kampus dengan jurusan terapis wicara   |
| 5  | Dokter Spesialis Bedah Mulut          | 1                         | 0         | 1          |                                        |                                                                                                       |
| 6  | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1                         | 0         | 1          |                                        |                                                                                                       |
| 7  | Dokter Spesialis Radiologi            | 1                         | 0         | 1          |                                        |                                                                                                       |

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

| NO | TANGGAL | JENIS ORIENTASI | NAMA STAF | PENDIDIKAN | PROFESI | SPMJ (TANGGAL MASUK) | KETERANGAN |
|----|---------|-----------------|-----------|------------|---------|----------------------|------------|
| -  | -       | -               | -         | -          | -       | -                    | -          |

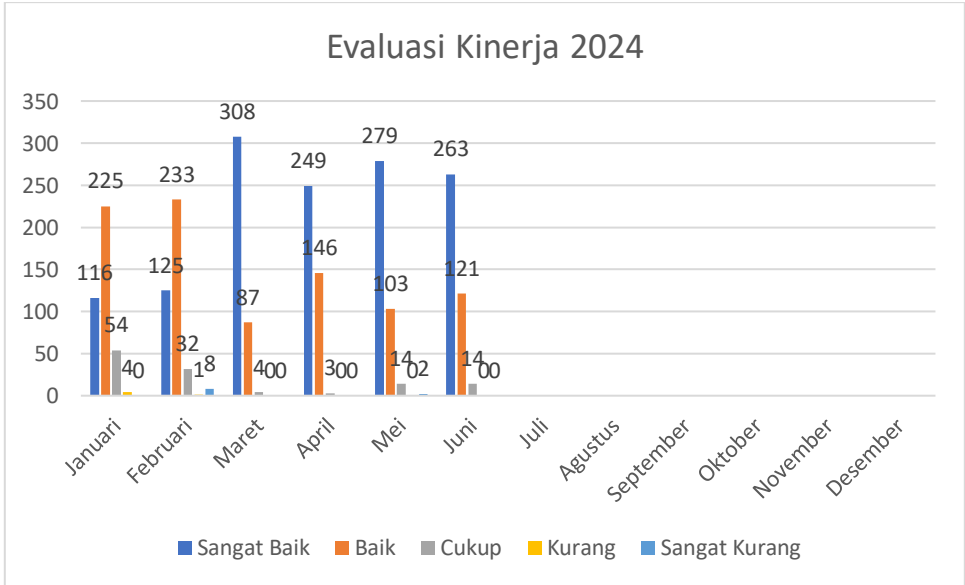
3.5.1.4 Diklat

| NO | TANGGAL PELAKSANAAN | JENIS DIKLAT       | JUDUL DIKLAT                          | SASARAN                              | KETERANGAN                                         | RTL                                      |
|----|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 4 Juni 2024         | Internal           | Diklat Episiotomi dan Ruptur          | Bidan RS Prima Husada Malang         | Diklat dihadiri oleh seluruh peserta yang diundang | Lengkapi Umandok, upload ke google drive |
| 2  | 5 Juni 2024         | Hibrid (PHM & PHS) | TOT                                   | Direksi RS                           | Diklat dihandle oleh PT DPM                        | Diklat dihandle oleh PT DPM              |
| 3  | 12 Juni 2024        | Internal           | Diklat Stunting dan Wasting Unit Gizi | Tim Ahli Gizi RS Prima Husada Malang | Diklat dihadiri oleh seluruh peserta yang diundang | Lengkapi Umandok, upload ke google drive |

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

| NO | KATEGORI      | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|---------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Sangat Baik   | 116     | 125      | 308   | 249   | 279 | 263  |
| 2  | Baik          | 225     | 233      | 87    | 146   | 103 | 121  |
| 3  | Cukup         | 54      | 32       | 4     | 3     | 14  | 14   |
| 4  | Kurang        | 4       | 1        | 0     | 0     | 0   | 0    |
| 5  | Sangat Kurang | 0       | 8        | 0     | 0     | 2   | 0    |

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



**Analisis :**  
Naik turun ini mayoritas adalah karena tingkat keterlambatan karyawan meningkat.Terdapat tren yang karyawan kategori “sangat baik” menjadi “baik”.

**Rencana Tindak Lanjut :**

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.

**3.5.1.6 Konseling**

**3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024**

| NO | JENIS     | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|-----------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Konseling | 0       | 13       | 11    | 12    | 5   | 2    |

**Analisis :**

Program konseling karyawan rutin belum berjalan dikarenakan staf SDM fokus pada konseling ketertiban jam kerja (keterlambatan) mulai bulan Mei 2024.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Mengkonsep Kembali program konseling dan menjadikannya program rutin dan berkelanjutan.

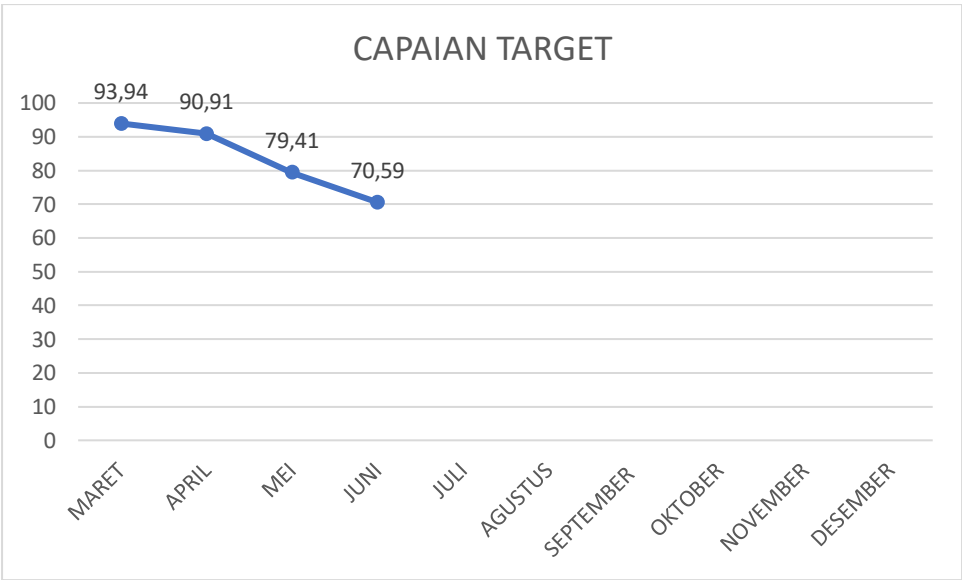
**3.5.2 MFK dan K3RS**

**3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis**

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

**3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis**

| NO | KET                 | TARGET | MARET | APRIL | MEI   | JUNI  |
|----|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Capaian Maintenance | 90%    | 93,94 | 90,91 | 79.41 | 70.59 |



**Analisis :**  
Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan dental unit ke Klinik Mutiara Sehat PTP

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Follow up ke Karu/Ka unit untuk memberikan info ketika alat medis yang belum di maintenance tidak dalam kondisi dipakai.
  2. Koordinasi dengan PT untuk wewenang alat medis klinik

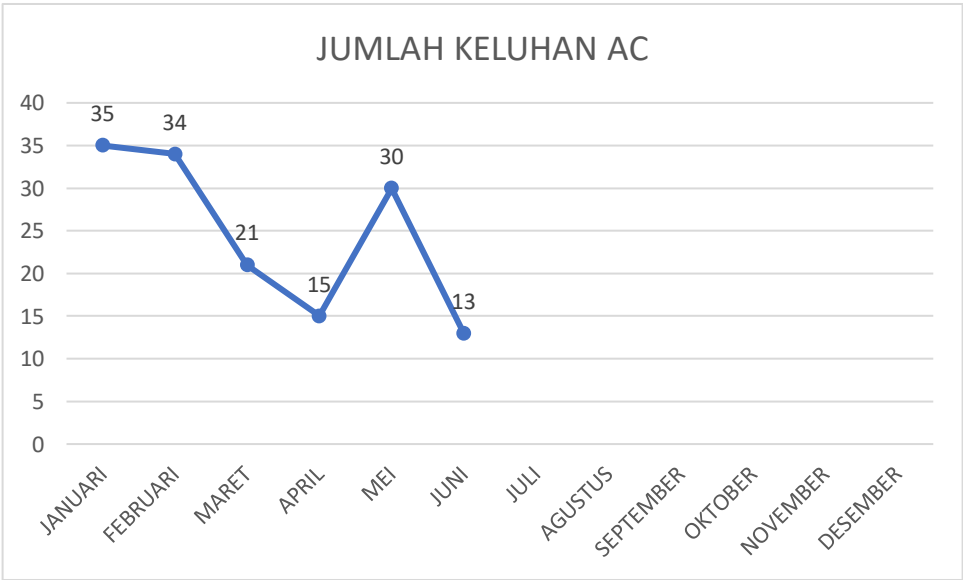
**3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis**

**3.5.2.2.1 Air Conditioner**

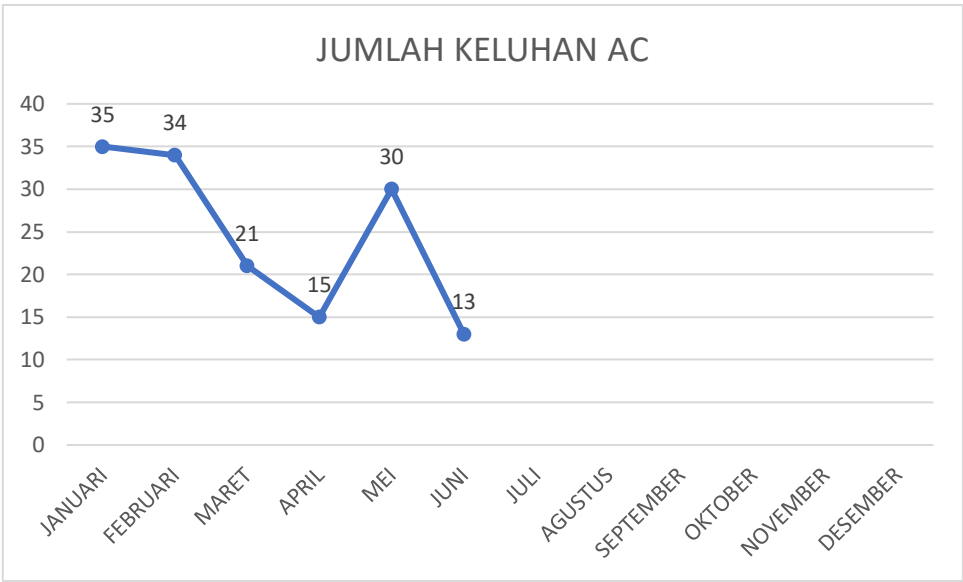
**3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split**

| NO | BULAN    | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----|----------|----------------------------|---------|------------|-----------------------|
| 1  | JANUARI  | 95                         | 54      | 57%        | BELUM MENCAPAI TARGET |
| 2  | FEBRUARI | 95                         | 69      | 73%        | BELUM MENCAPAI TARGET |
| 3  | MARET    | 95                         | 94      | 99%        | BELUM MENCAPAI TARGET |
| 4  | APRIL    | 95                         | 61      | 64%        | BELUM MENCAPAI TARGET |
| 5  | MEI      | 95                         | 94      | 99%        | BELUM MENCAPAI TARGET |
| 6  | JUNI     | 95                         | 89      | 94%        | BELUM MENCAPAI TARGET |

**3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintenance AC**



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



- Analisis :**
- Sudah terdapat progress perbaikan yang baik terhadap pemeliharaan AC baik secara fisik maupun pelaporan ini berdampak pada keluhan staf di unit terhadap AC mulai berkurang setiap bulannya.
- Beberapa penyebab yang mengakibatkan target masih tidak tercapai :
1. Masih ada pemeliharaan yang tidak tercatat sehingga tidak masuk laporan
  2. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS
  3. AC ruangan masih terdapat pasien / dalam pemakaian

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait system pencatatan dan target perbulan.
  2. Pembuatan aplikasi lokal IPSRS sebagai reminder

3.5.2.2.3 Genset  
3.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

| NO | BULAN    | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----|----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1  | Januari  | 5x/bulan                   | 5x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 2  | Februari | 5x/bulan                   | 5x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 3  | Maret    | 5x/bulan                   | 5x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 4  | April    | 5x/bulan                   | 5x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 5  | Mei      | 5x/bulan                   | 5x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 6  | Juni     | 5x/bulan                   | 3x/bulan | 60%        | Tidak mencapai target |

**Analisis :**

Pada bulan Juni pemeliharaan genset dilakukan sebanyak 3x karena sedang pembenahan IPAL dan Perbaikan ruang PICU. Hal ini akan ditindaklanjuti di bulan depan.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Monitoring dan evaluasi berkala

3.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

| NO | BULAN    | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----|----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1  | Januari  | 3x/bulan                   | 3x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 2  | Februari | 3x/bulan                   | 3x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 3  | Maret    | 3x/bulan                   | 2x/bulan | 67%        | Sudah mencapai target |
| 4  | April    | 3x/bulan                   | 3x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 5  | Mei      | 3x/bulan                   | 3x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |
| 6  | Juni     | 3x/bulan                   | 3x/bulan | 100%       | Sudah mencapai target |

**Analisis :**  
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervise, petugas sudah berkeliling dan melakukan pencatatan.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan Evaluasi

3.5.2.2.5 Liquid Oksigen

3.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

| JUNI 2024  |             |                   |           |        |                   |            |  |
|------------|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|------------|--|
| TANGGAL    | STOK LIQUID | SEBELUM PENGISIAN | PENGUNAAN | SATUAN | KETERANGAN        | PENGIRIMAN |  |
| 01/06/2024 | 2382        | 2223              | 159       | MMHG   |                   |            |  |
| 02/06/2024 | 2223        | 1968              | 255       | MMHG   |                   |            |  |
| 03/06/2024 | 1968        | 1835              | 133       | MMHG   |                   |            |  |
| 04/06/2024 | 1835        | 1584              | 251       | MMHG   |                   |            |  |
| 05/06/2024 | 1584        | 1324              | 260       | MMHG   |                   |            |  |
| 06/06/2024 | 1324        | 1100              | 224       | MMHG   |                   |            |  |
| 07/06/2024 | 1100        | 878               | 222       | MMHG   |                   |            |  |
| 08/06/2024 | 878         | 661               | 217       | MMHG   | Sebelum pengisian |            |  |
| 08/06/2024 | 661         | 2388              |           | MMHG   | Sesudah pengisian | 1727       |  |
| 09/06/2024 | 2388        | 2177              | 211       | MMHG   |                   |            |  |
| 10/06/2024 | 2177        | 2066              | 111       | MMHG   |                   |            |  |
| 11/06/2024 | 2066        | 1810              | 256       | MMHG   |                   |            |  |
| 12/06/2024 | 1810        | 1584              | 226       | MMHG   |                   |            |  |
| 13/06/2024 | 1584        | 1376              | 208       | MMHG   |                   |            |  |
| 14/06/2024 | 1376        | 1087              | 289       | MMHG   |                   |            |  |
| 15/06/2024 | 1087        | 982               | 105       | MMHG   | Sebelum pengisian |            |  |
| 15/06/2024 | 982         | 2977              |           | MMHG   | Sesudah pengisian | 1995       |  |
| 16/06/2024 | 2977        | 2674              | 303       | MMHG   |                   |            |  |
| 17/06/2024 | 2674        | 2545              | 129       | MMHG   |                   |            |  |
| 18/06/2024 | 2545        | 2359              | 186       | MMHG   |                   |            |  |
| 19/06/2024 | 2359        | 2146              | 213       | MMHG   |                   |            |  |
| 20/06/2024 | 2146        | 1878              | 268       | MMHG   |                   |            |  |
| 21/06/2024 | 1878        | 1624              | 254       | MMHG   |                   |            |  |
| 22/06/2024 | 1624        | 1426              | 198       | MMHG   |                   |            |  |
| 23/06/2024 | 1624        | 1269              | 355       | MMHG   |                   |            |  |

|                                                 |      |      |      |      |                   |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|
| 24/06/2024                                      | 1269 | 1135 | 134  | MMHG |                   |      |      |
| 25/06/2024                                      | 1135 | 992  | 143  | MMHG | Sebelum pengisian |      |      |
| 25/06/2024                                      | 992  | 3280 |      | MMHG | Sesudah pengisian | 2288 |      |
| 26/06/2024                                      | 3280 | 3033 | 247  | MMHG |                   |      |      |
| 27/06/2024                                      | 3033 | 2843 | 190  | MMHG |                   |      |      |
| 28/06/2024                                      | 2843 | 2554 | 289  | MMHG |                   |      |      |
| 29/06/2024                                      | 2554 | 2389 | 165  | MMHG |                   |      |      |
| 30/06/2024                                      | 2389 | 2288 | 101  | MMHG |                   |      |      |
|                                                 |      |      |      | MMHG |                   |      |      |
|                                                 |      |      |      | MMHG |                   |      |      |
|                                                 |      |      |      | MMHG |                   |      |      |
| Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini        |      |      | 5888 | MMHG |                   |      |      |
| Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini |      |      |      |      |                   | 6010 | MMHG |

**Analisis :**  
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan.  
 Stok oksigen selalu terjaga.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan Evaluasi

3.5.2.2.6 IPAL

3.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

| NO | KETERANGAN        | TARGET   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI  | JUNI |
|----|-------------------|----------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| 1  | Pemeliharaan IPAL | 1x/bulan | 100%    | 100%     | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

**Analisis :**  
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

| NO | KETERANGAN              | TARGET   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI  | JUNI |
|----|-------------------------|----------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| 1  | Pemeliharaan filter air | 2x/bulan | 100%    | 100%     | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

**Analisis :**  
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.8 Lift

3.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

| NO | KETERANGAN        | TARGET   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI  | JUNI |
|----|-------------------|----------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| 1  | Pemeliharaan lift | 2x/bulan | 100%    | 100%     | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

**Analisis :**  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.9 UPS

3.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

| NO | KETERANGAN       | TARGET   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI  | JUNI |
|----|------------------|----------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| 1  | Pemeliharaan UPS | 2x/bulan | 100%    | 100%     | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

**Analisis :**  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

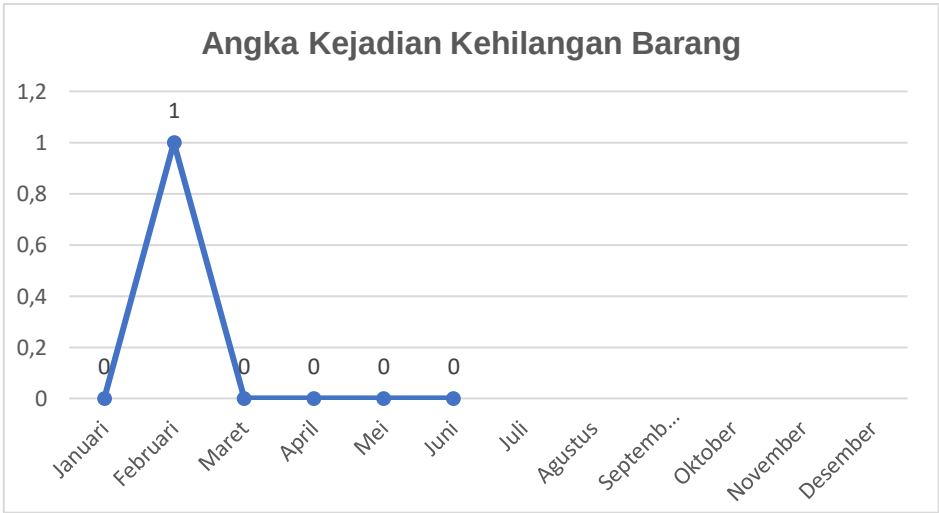
**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi

3.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

| NO | JENIS AKTIVITAS                  | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|----------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1. | Angka kejadian kehilangan barang | 0       | 0        | 0     | 2     | 0   | 0    |

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



| NO | JENIS AKTIVITAS                  | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|----------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Angka kejadian kehilangan barang | 0       | 0        | 0     | 2     | 0   | 3    |

**Keterangan :**

04 – 06 – 2024 : telah ditemukan tas pengunjung di area parkir depan igd telah diamankan di pos igd & telah di kondisikan oleh pemilik

05 – 06 – 2024 : ditemukan kontak motor terjatuh di sekitar depan area igd diamankan di pos security igd ( box )

22 – 06 – 2024 : Ditemukan jam tangan di area kamar mandi samping iko telah diamankan di pos security

**Analisis :**

Tidak ada kehilangan barang pada bulan Juni 2024

**Rencana Tindak Lanjut :**

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

| NO | JENIS AKTIVITAS          | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|--------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1. | Angka kejadian kekerasan | 0       | 0        | 0     | 0     | 0   | 0    |

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



**Analisis :**

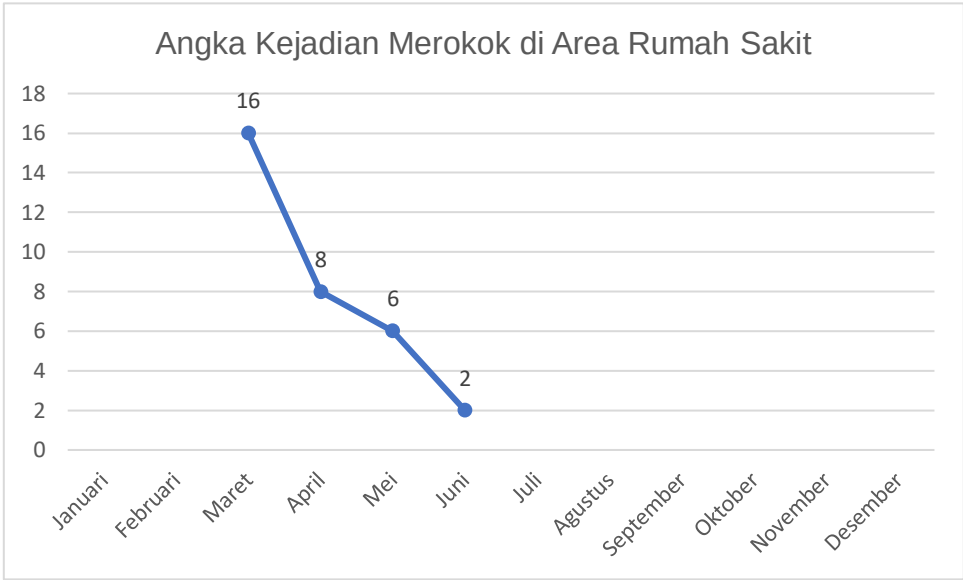
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan

**Rencana Tindak Lanjut :**

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

| NO | JENIS AKTIVITAS                            | JANUARI        | FEBRUARI       | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit | Tidak tercatat | Tidak tercatat | 16    | 8     | 6   | 2    |



Analisis :

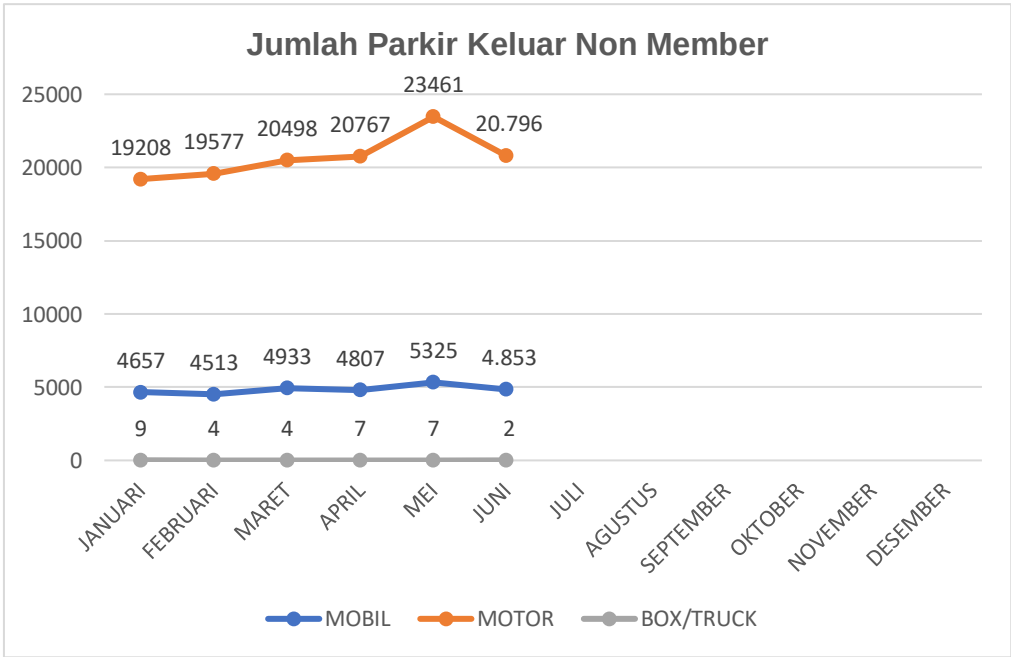
Angka kejadian merokok mulai mengalami penurunan karena patroli dari satpam yang lebih intens. Namun masih ada yang belum tercatat karena keterbatasan pengawasan setiap waktu dari pihak security yang harus berjaga di pos masing-masing.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Penurunan jumlah parkir di Bulan Juni diakibatkan oleh jumlah kunjungan pasien yang juga menurun.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

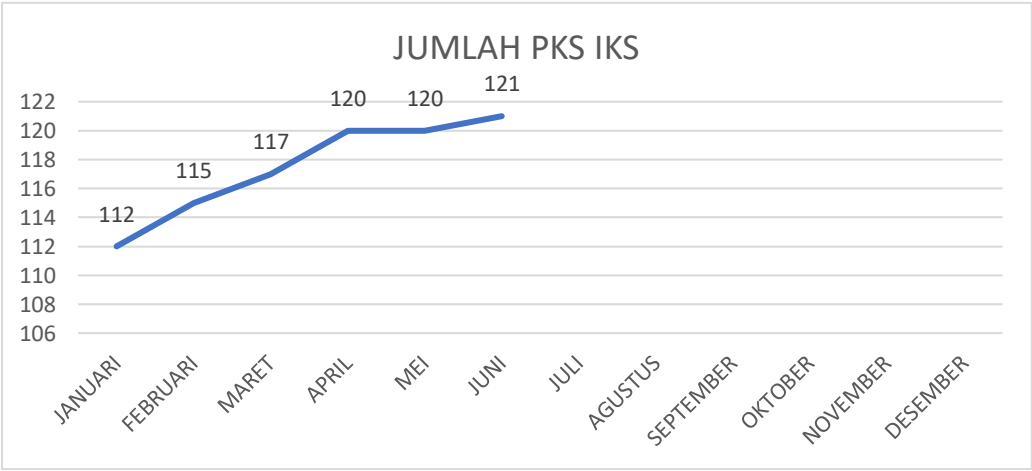
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

| NO | KETERANGAN           | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|----------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Jumlah PKS IKS AKTIF | 112     | 115      | 117   | 120   | 120 | 121  |

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan Juni 2024

| NO | NAMA PKS                                     | PROGRES PENGURUSAN | KENDALA                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Pesta Pora Abadi                          | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 2  | PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia | TTD Dir PT         | -                                                                                          |
| 3  | PT Tentrem Sejahtera                         | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 4  | PT Ustegra                                   | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 5  | PT Randi Cones Indonesia                     | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 6  | PT Kharisma Selaras                          | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 7  | PT Tonggak Ampuh                             | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 8  | RS Universitas Brawijaya                     | Disposisi SIMRS    | Ada beberapa notice dari pihak kedua yang harus di review Kembali oleh bagian legal PT DPM |
| 9  | PT Citra Karsa Dinamika                      | TTD Dir PT         | -                                                                                          |
| 10 | PT Moor Sukses Internasional                 | Disposisi SIMRS    | -                                                                                          |
| 11 | PT Green Mountains Natural Foods             | Review pihak kedua | -                                                                                          |
| 12 | PT New Minatex                               | Review pihak kedua | -                                                                                          |

**Analisis :**

- 1. Pada bulan Juni, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua
- 3. PKS dengan PT Beruang Madu tidak diperpanjang karena RSPH Malang menegmbangkan pelayanan baru dengan nama “Primantara” untuk menggantikan PT Beruang Madu (Beetu) sebagai vendor jasa layanan antar obat.
- 4. PKS PT Teman Sejati Sejahtera Abadi diperpanjang dengan kolaborasi dengan Vendor lain yaitu PT Tenang Sejahtera (PKS PT DPM dengan PT TSSA & TS)

**Rencana Tindak Lanjut :**

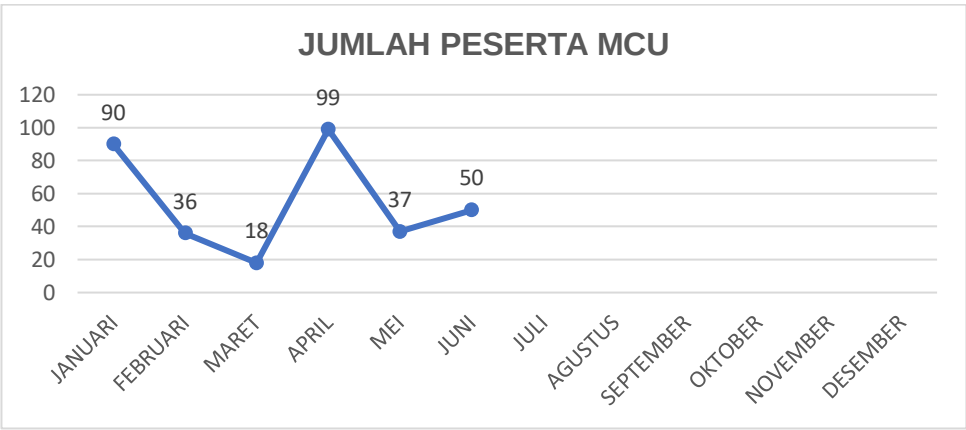
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

**3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)**

**3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU**

| NO | KETERANGAN         | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|--------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | JUMLAH PESERTA MCU | 90      | 36       | 18    | 99    | 37  | 50   |

**3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU**



**Analisis :**

Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Review hasil kunjungan dengan PDSA :

**Plan :**

- 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan
- 2. Mempromosikan program MCU
- 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan

**Do :**

- 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan dan Universitas
- 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain

**Study :**

- 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU.
- 2. Perusahaan dan universitas memilih harga MCU paling murah diantara vendor.
- 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan.

**Action :**

- 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru
- 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

**3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal**

**3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal**

| NO | KETERANGAN       | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
|----|------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|
| 1  | Jumlah Kunjungan | 6       | 10       | 19    | 4     | 7   | 17   |

**3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal**



**Analisis :**

Terjadi kenaikan pada bulan Juni 2024 dikarenakan respon HRD beberapa perusahaan merespon lebih cepat.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Menghubungi HRD dalam list perusahaan untuk menjadwalkan kunjungan kembali bagi perusahaan yang belum.

3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Juni 2024

| REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN |                             |                      |            |            |                      |                            |                   |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| NO                              | PERIODE LAYANAN             | TARIF FPK/ PENGAJUAN | TGL FPK    | TGL BAYAR  | REALISASI PEMBAYARAN | SELISIH AUDIT DAN ADM BANK | SALDO PIUTANG FPK |
| PELAYANAN 2023                  |                             |                      |            |            |                      |                            |                   |
|                                 |                             |                      |            |            |                      |                            | -                 |
| 1                               | OBAT KRONIS SEPT 23         | 435.837.336          | 18.01.2024 | 29.01.2024 | 435.837.336          |                            | -                 |
| 2                               | FPK REG UTAMA DES 23        | 6.189.055.000        | 18.01.2024 | 29.01.2024 | 6.189.055.000        |                            | -                 |
| 5                               | FPK 'OBAT KRONIS OKT 23     | 493.809.876          | 18.02.2024 | 26.02.2024 | 493.809.876          |                            | -                 |
| 6                               | FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE  | 6.650.000            | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 6.650.000            |                            | -                 |
| 7                               | FPK LUPIS NOV 23 ALKES      | 6.215.000            | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 6.215.000            |                            | -                 |
| 8                               | FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE  | 7.210.000            | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 7.210.000            |                            | -                 |
| 9                               | FPK LUPIS DES 23 ALKES      | 6.710.000            | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 6.710.000            |                            | -                 |
| 10                              | FPK OBAT KRONIS NOV 2023    | 465.212.636          | 21.03.2024 | 01.04.2024 | 465.212.636          |                            | -                 |
| 11                              | FPK PEND DES 23             | 607.514.500          | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 607.514.500          |                            | -                 |
| 12                              | FPK OBAT KRONIS DES 2023    | 469.804.704          | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 469.804.704          |                            | -                 |
| 13                              | FPK OBAT KRONIS Pend Des 23 | 10.367.860           | 08.05.2024 | 20.05.2024 | 10.367.860           |                            | -                 |
| PELAYANAN 2024                  |                             |                      |            |            |                      |                            |                   |
| 1                               | FPK Januari 2024            | 7.006.082.092        | 18.02.2024 | 28.02.2024 | 6.967.698.792        | 38.383.300                 | -                 |
|                                 | FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE  | 6.015.000            | 20.03.2024 | 16.04.2024 | 6.015.000            |                            | -                 |
|                                 | FPK LUPIS JAN 24 ALKES      | 12.485.000           | 20.03.2024 | 16.04.2024 | 12.485.000           |                            | -                 |
|                                 | FPK OR Januari 2024         | 516.543.814          | 08.05.2024 | 20.05.2024 | 516.543.814          |                            | -                 |
|                                 | FPK Pending Januari 2024    | 468.390.779          | 08.05.2024 | 20.05.2024 | 468.390.779          |                            | -                 |
| 2                               | FPK Februari 2024           | 7.215.241.743        | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 7.215.241.743        |                            | -                 |
|                                 | FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE  | 7.740.000            | 20.03.2024 | 16.04.2024 | 7.740.000            |                            | -                 |
|                                 | FPK LUPIS JAN 24 ALKES      | 3.795.000            | 20.03.2024 | 16.04.2024 | 3.795.000            |                            | -                 |
|                                 | FPK OR Februari 2024        | 498.722.702          | 08.05.2024 | 20.05.2024 | 498.722.702          |                            | -                 |
|                                 | FPK PEND REGULER FEBRUARI   | 373.212.100          | 10.06.2024 | 19.06.2024 | 373.212.100          |                            | -                 |
| 3                               | FPK Maret 2024              | 7.372.267.949        | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 7.350.598.749        | 21.669.200                 | -                 |
|                                 | FPK AMBULANCE MARET 24      | 5.280.000            | 14.06.2024 | 10.06.2024 | 5.280.000            |                            | -                 |
|                                 | FPK ALKES MARET 24          | 3.465.000            | 14.06.2024 | 10.06.2024 | 3.465.000            |                            | -                 |
| 4                               | FPK April 2024              | 6.926.723.374        | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 6.901.742.874        | 24.980.500                 | -                 |
|                                 | FPK AMBULANCE APRIL 24      | 3.270.000            | 14.06.2024 | 10.06.2024 | 3.270.000            |                            | -                 |
|                                 | FPK ALKES APRIL 24          | 3.630.000            | 14.06.2024 | 10.06.2024 | 3.630.000            |                            | -                 |
| 5                               | FPK MEI 2024                | 7.537.333.400        | 23.06.2024 | 01.07.2024 | 7.493.109.800        | 44.223.600                 | -                 |
| 6                               | KLAIM JUNI 2024 BELUM FPK   | 7.513.234.000        |            |            |                      |                            | 7.513.234.000     |
|                                 |                             | 54.171.818.865       |            |            | 46.529.328.265       | 129.256.600                | 7.513.234.000     |

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

| REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN |                 |       |           |        |             |          |        |
|----------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------|-------------|----------|--------|
| NO                                     | PERIODE LAYANAN | JENIS | JML KLAIM | FPK    | Tidak Layak | JML PEND | % PEND |
| 1                                      | FEB 24          | RJ    | 11.519    | 11.514 | 2           | 5        | 0,0%   |
|                                        |                 | RI    | 1.004     | 992    | -           | 12       | 1%     |
| 2                                      | MARET 24        | RJ    | 11.887    | 11.882 |             | 5        | 0,0%   |
|                                        |                 | RI    | 1.104     | 983    |             | 121      | 11%    |
| 3                                      | APRIL 24        | RJ    | 11.384    | 11.366 | 2           | 18       | 0,2%   |
|                                        |                 | RI    | 1.082     | 990    | -           | 92       | 9%     |
| 4                                      | MEI 24          | RJ    | 12.641    | 12.628 | 3           | 13       | 0,1%   |
|                                        |                 | RI    | 1.098     | 1.026  | -           | 72       | 7%     |

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

| NO                  | DESKRIPSI            | SALDO AWAL PIUTANG | PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA) | SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA) | PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN) | PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN) | SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN) | SALDO AKHIR PIUTANG | UMUR PIUTANG  |            |            |             | JUMLAH PIUTANG |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|
|                     |                      | a                  | b                             | (a-b-c= d)                      | e                                   | f                           | (e-f-g=h)                     | d+h                 | 0-30 HARI     | 31-60 HARI | 61-90 HARI | 91-120 HARI | Total          |
| PERIODE JUNI 2024 : |                      |                    |                               |                                 |                                     |                             |                               |                     |               |            |            |             |                |
| 1                   | Asuransi             | 201.576.640        | 144.341.589                   | 55.175.358                      | 191.365.932                         | 15.283.312                  | 175.492.574                   | 230.667.932         | 226.894.146   | 1.453.528  | 253.027    | 551.589     | 230.667.932    |
| 2                   | Perusahaan           | 166.578.274        | 94.557.388                    | 72.015.987                      | 61.216.187                          | 10.015.303                  | 51.200.884                    | 123.216.870         | 82.788.263    | 31.875.899 | -          | -           | 123.216.870    |
| 3                   | Mandiri inhealth     | 99.673.569         | 77.432.007                    | 23.972.831                      | 33.608.521                          | -                           | 33.608.521                    | 57.581.352          | 57.581.352    | -          | -          | -           | 57.581.352     |
| 4                   | Jasa Rahnaja         | 49.890.081         | 49.563.048                    | 327.034                         | 271.979.025                         | 729.833                     | 271.249.191                   | 271.576.225         | 271.576.225   | -          | -          | -           | 271.576.225    |
| 5                   | BPJS Ketenagakerjaan | 1.655.528.019      | 485.864.540                   | 1.167.698.249                   | 495.377.405                         | -                           | 495.377.405                   | 1.663.075.654       | 1.635.450.180 | 27.026.474 | -          | -           | 1.663.075.654  |
| Total Saldo         |                      |                    |                               |                                 |                                     |                             |                               | 2.346.118.034       | 2.274.290.167 | 60.355.901 | 253.027    | 551.589     | 2.346.118.034  |

Keterangan :

1. Cut off piutang per tanggal 30 Juni 2024 dengan saldo Rp 2.346.118.034
2. Rp 804.616 merupakan piutang asuransi takaful dan reliance fullerthorh
3. BPJS Ketenagakerjaan bulan juni sudah melakukan pembayaran Rp 485.864.540,-

3.5.6.2 Klaim Pending

| NO | MASALAH                                                                                         | DAMPAK        | TINDAK LANJUT               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | Penggunaan diagnosa GERD (melampirkan scoring GERD)                                             | Klaim Pending | Menjawab konfirmasi pending |
| 2. | Penggunaan kode I11.0 (HHD with CHF) diminta mengganti I11.9 (HHD tnpa Echo)                    | Klaim Pending | Menjawab konfirmasi pending |
| 3. | Permintaan penggantian menggunakan kode (Z03.8 (kode suspek) Untuk diagnosa pasien yang dirujuk | Klaim Pending | Menjawab konfirmasi pending |

3.5.7 PIPP – MOD – MPP

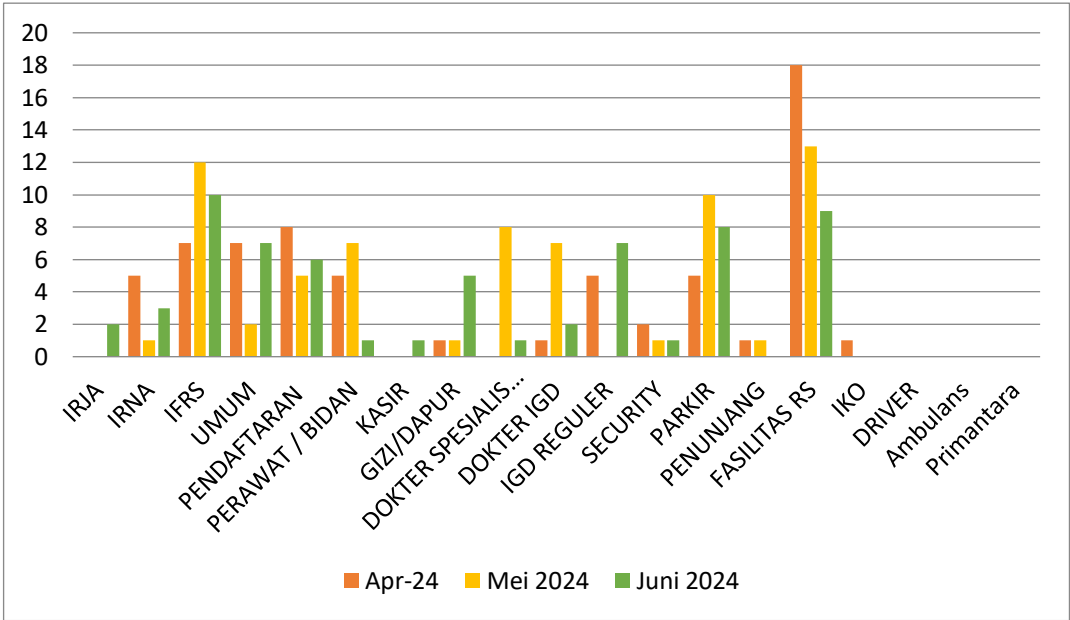
3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Juni 2024

| NO  | JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-----|--------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1.  | IRJA                                 | 0          | 0        | 2         |
| 2.  | IRNA                                 | 5          | 1        | 3         |
| 3.  | IFRS                                 | 7          | 12       | 10        |
| 4.  | UMUM                                 | 7          | 2        | 7         |
| 5.  | PENDAFTARAN                          | 8          | 5        | 6         |
| 6.  | PERAWAT / BIDAN                      | 5          | 7        | 1         |
| 7.  | KASIR                                | 0          | 0        | 1         |
| 8.  | GIZI/DAPUR                           | 1          | 1        | 5         |
| 9.  | DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)      | 0          | 8        | 1         |
| 10. | DOKTER IGD                           | 1          | 7        | 2         |
| 11. | IGD REGULER                          | 5          | 0        | 7         |
| 12. | SECURITY                             | 2          | 1        | 1         |
| 13. | PARKIR                               | 5          | 10       | 8         |
| 14. | PENUNJANG                            | 1          | 1        | 0         |
| 15. | FASILITAS RS                         | 18         | 13       | 9         |

|       |            |    |    |    |
|-------|------------|----|----|----|
| 16    | IKO        | 1  | 0  | 0  |
| 17    | DRIVER     | 0  | 0  | 0  |
| 18    | Ambulans   | 0  | 0  | 0  |
| 19    | Primantara | 0  | 0  | 0  |
| Total |            | 66 | 68 | 63 |

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juni 2024



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Juni 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Juni 2024 menurun disbanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan April 2024 sebanyak 68 kasus complain. Sedangkan pada bulan juni menurun menjadi 63 kasus complain.
2. Komplain terbanyak pada bulan Juni 2024 yaitu dari Farmasi sebanyak 10 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 13 jenis complain dengan rincian :
  - 1) Fasilitas RS sebanyak 5 kasus ( Diadakan kantin RS, tiap kamar mandi diberikan pemanas air, ruang tunggu operasi kurang nyaman, amar rawat inap diperbanyak.)
  - 2) Parkir sebanyak 8 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2024

| NO | JENIS PASIEN KOMPLAIN | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|----|-----------------------|------------|----------|-----------|
| 1. | Langsung tatap muka   | 4          | 3        | 1         |
| 2. | Tidak Langsung :      |            |          |           |
|    | a. Chatt (Whatsapp)   | 11         | 11       | 8         |
|    | b. Google review      | 0          | 6        | 9         |

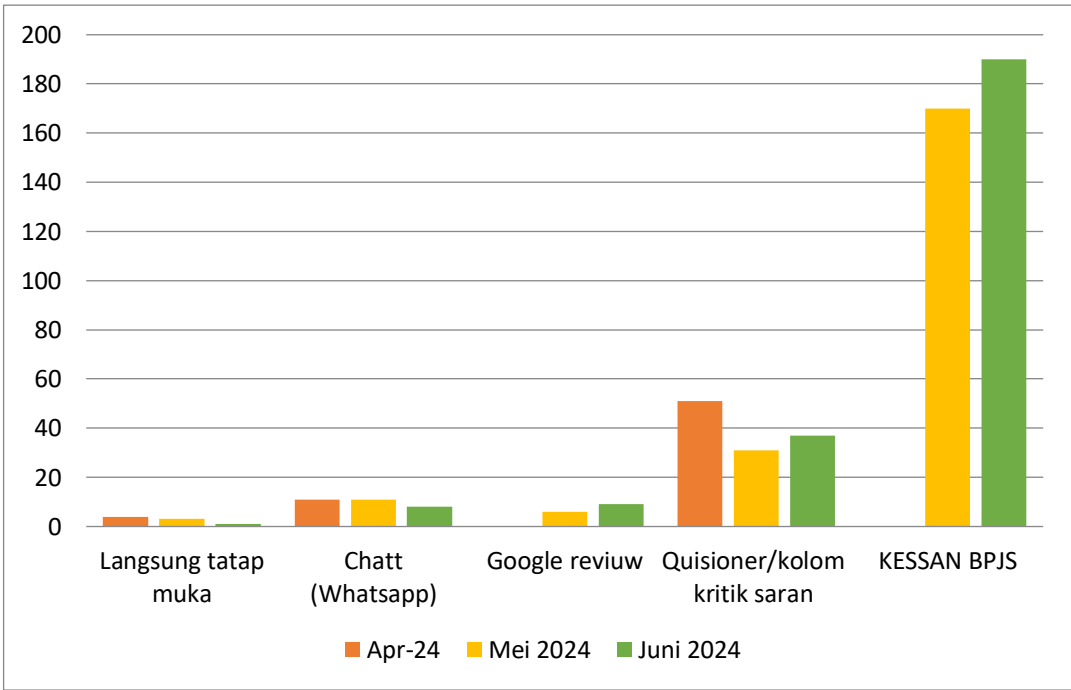
|    |                              |    |     |     |
|----|------------------------------|----|-----|-----|
| 3. | Quisioner/kolom kritik saran | 51 | 31  | 37  |
| 4. | KESSAN BPJS                  | 0  | 170 | 190 |

**Rincian KESSAN**

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

| NO | KETERANGAN  | BINTANG 1 | BINTANG 2 | BINTANG 3 | BINTANG 4 | BINTANG 5 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | KESSAN BPJS | 0         | 0         | 0         | 17        | 173       |

**3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2024**



**Analisis :**

Pada bulan Juni 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 37 kasus komplain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari chat WA sebanyak 8 kasus, secara tatap muka / langsung 1 kasus, sedangkan dari google rewiuw sebanyak 9 kasus.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juni 2024

| NO | JENIS PASIEN COMPLAIN        | WAKTU TANGGAP     |                                                                                                   | WAKTU PENYELESAIAN |            | < 3 HR<br>MANAJERIAL<br>RS | 7 HR<br>KE<br>PT |
|----|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------------|
|    |                              | STANDARD<br>< 5 ‘ | PENCAPAIAN<br>(DARI<br>WAKTU<br>TOTAL<br>DIBAGI JML<br>KOMPLAI<br>ATAU RATA2<br>WAKTU<br>TANGGAP) | STANDARD<br>< 60 ‘ | PENCAPAIAN |                            |                  |
| 1. | Langsung tatap muka          | 100%              | 100%                                                                                              | 100%               | 1          | 0                          | 0                |
|    |                              |                   |                                                                                                   |                    |            | 100%                       |                  |
| 2. | Chatt (WA/Tele/SMS/IG)       | 100%              | 100%                                                                                              | 100%               | 8          | 0                          | 0                |
|    |                              |                   |                                                                                                   |                    | 100%       |                            |                  |
| 3. | Google reviuw                | 100%              | 100%                                                                                              | 100%               | 9          | 0                          | 0                |
|    |                              |                   |                                                                                                   |                    | 100%       |                            |                  |
| 4. | Quisioner/kolom kritik saran | 100%              | 100%                                                                                              | 100%               | 37         | 0                          | 5                |
|    |                              |                   |                                                                                                   |                    | 85%        |                            |                  |
| 5. | KESSAN                       | 100%              | 0                                                                                                 | 100%               | 190        | 0                          | 0                |
|    |                              |                   |                                                                                                   |                    | 100%       |                            |                  |

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Juni 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 91%, hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 13 jenis complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 5 kasus ( Diadakan kantin RS, tiap kamar mandi diberikan pemanas air, ruang tunggu operasi kurang nyaman, kamar rawat inap diperbanyak.)
- 2) Parkir sebanyak 8 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir

Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait diantaranya :

- 1. Fasilitas RS
  - a) Kantin RS
  - b) Wather Heter
  - c) Ruang tunggu kamar operasi
  - d) Kamar rawat inap diperbanyak

- 2. Parkir

Terkait parkir yang dikeluhkan adalah tariff parkir yang terlalu mahal dan tidak ada akses khusus untuk pasien rawat inap, sehingga keluarga pasien terlalu banyak membayar parkir setiap keluar masuk RS saat mengambil barang dirumah atau diluar RS.

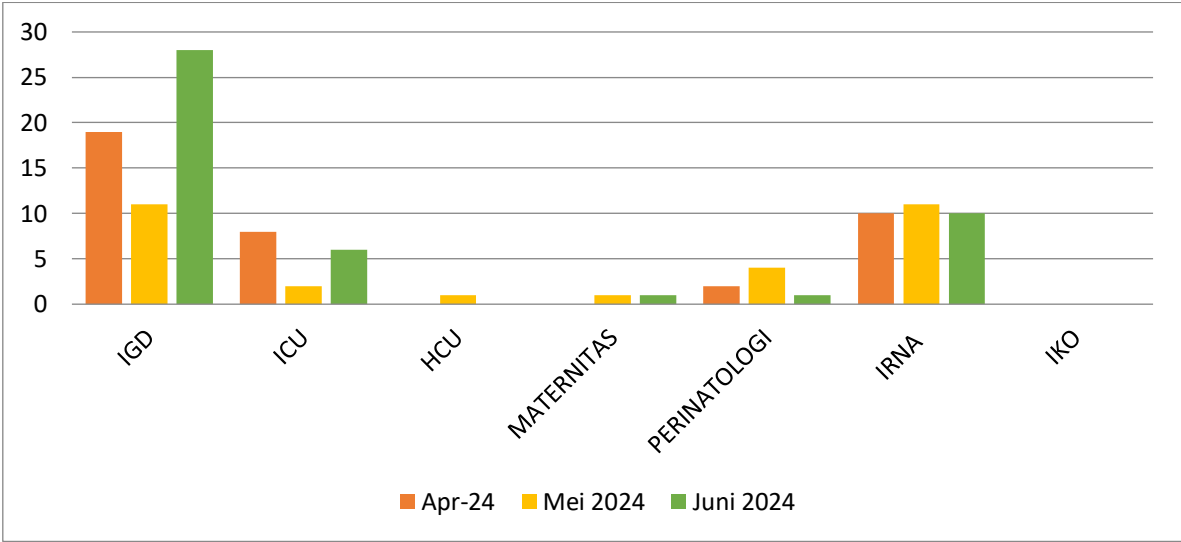
Sudah dilakukan pelaporan oleh Kabid umum dan keuangan ke PT terkait hal tersebut → Untuk tariff tidak bisa berubah

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Juni 2024

| NO    | UNIT PERUJUK | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-------|--------------|------------|----------|-----------|
| 1.    | IGD          | 19         | 11       | 28        |
| 2.    | ICU          | 8          | 2        | 6         |
| 3.    | HCU          | 0          | 1        | 0         |
| 4.    | MATERNITAS   | 0          | 1        | 1         |
| 5.    | PERINATOLOGI | 2          | 4        | 1         |
| 6     | IRNA         | 10         | 11       | 10        |
| 7     | IKO          | 0          | 0        | 0         |
| Total |              | 39         | 30       | 46        |

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juni 2024



| NO | NAMA PASIEN              | UNIT | DIAGNOSIS                                                  | DPJP                                | RS TUJUAN                | ALASAN RUJUK        | LAMA RAWAT | PLAVON HABIS |
|----|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 1  | Tn. Gunadi               | IGD  | CKD, DM Hipoglikemia, DOC, HT, Anemia                      | dr. Heri Sp.PD                      | RSSA                     | Pro HD              | 1          | Tidak        |
| 2  | Ny. Yunita Asriviani     | IGD  | G1p0ab0 uk. 37-38 mgg dengan inpartu kala 2 letak sungsang | dr. Aida Sp.OG                      | RS Prasetya Husada       | Pro SC Cito         | 1          | Tidak        |
| 3  | Tn. Moch Agung Adi Utomo | IRNA | CVA ICH, CKD, Hipokalemia                                  | dr. Farid Sp.S raber dr. Heri Sp.PD | RSUD Dr Soetomo Surabaya | Pro HD              | 3          | Tidak        |
| 4  | Ny. Siti Choiriyah       | ICU  | UAP, HHD, AV Block St I                                    | dr. Miryanti, Sp. JP                | RS UMM                   | Pro PCI             | 2          | Tidak        |
| 5  | Ny. Winarni              | IGD  | Susp CVA Infark dd Haemoragic, Hipertensi                  | dr. Syahrir Sp.S                    | RST Soepraoen            | Pro Stroke Unit     | 2          | Tidak        |
| 6  | Tn. Markasum             | IGD  | CKD, Necrotizing fascitis regio scapula                    | dr. Heri Sp.PD                      | RSSA                     | Pro HD              | 2          | Tidak        |
| 7  | Ny. Kaseh                | IRNA | CVA ICH                                                    | dr. Dewi Sp.N                       | RSSA                     | Pro Stroke Unit     | 2          | Tidak        |
| 8  | Tn. Noto                 | IRNA | Susp Tetanus                                               | dr. Anton Sp.B                      | RST Soepraoen            | Pro Isolasi Tetanus | 3          | Tidak        |
| 9  | Ny. Bawon                | IGD  | DOC ec CVA Infark Luas                                     | dr. Syahrir Sp.S                    | RST Soepraoen            | Pro Stroke Unit     | 2          | Tidak        |
| 10 | Ny. Indarwati            | IGD  | Abd. Pain pos trauma abdomen dd Internal                   | dr. Zaki, Sp. B                     | RSSA                     | Pro Bedah digestif  | 1          | Tidak        |

|    |                                |      |                                                                                                       |                                             |                 |                                              |   |                                                                 |
|----|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                |      | bleeding                                                                                              |                                             |                 |                                              |   |                                                                 |
| 11 | Nn. DEWINDA WAHYU SETYONINGRUM | IGD  | COR + ICH parietal D + vulnus apertum Parietal S                                                      | dr. Sigit, Sp. BP                           | RSSA            | Pro Bedah Syaraf dan membutuhkan alat khusus | 1 | Tidak                                                           |
| 12 | TN. SAMSUDIN                   | IRNA | CVA 2nd attack+CAD+Susp. Bronkitis                                                                    | dr. Farid, Sp. N                            | RS Lavalette    | Pro Stroke Unit                              | 2 | Tidak                                                           |
| 13 | Tn Ismail                      | IRNA | CVA ICH                                                                                               | dr Fahima, Sp.N                             | RSSA            | Pro Stroke Unit                              | 2 | Tidak                                                           |
| 14 | Ny Sudarmi                     | IRNA | CVA ICH, ICH Subcortex dextra volume 7cc, HT                                                          | dr Fahima, Sp.N                             | RST Soepraoen   | Pro EVD                                      | 3 | Tidak                                                           |
| 15 | Tn Gusti Ivanto                | ICU  | COR, Edema cerebri                                                                                    | dr Fachri, Sp.BS                            | RST Soepraoen   | Pro Craniotomy                               | 3 | Tidak                                                           |
| 16 | Ny. Sunarsih                   | MTS  | G3P0101 Ab0 uk. 32-34 mgg dengan PPI + DFF+ Trombositopeni                                            | dr. Humaira Sp.OG konsul dr. Ardhi Sp.PD    | RSSA            | Pro ICU post OP maternal dan NICU            | 4 | Tidak                                                           |
| 17 | Tn. Hadi Sumarsono             | IGD  | DOC + COB+ ICH                                                                                        | dr. Anton Sp.B                              | RST Soepraoen   | Pro Bedah Syaraf dan membutuhkan alat khusus | 2 | Tidak                                                           |
| 18 | Ny. Rodiyah Baagil             | IGD  | 1. Anemia 2.leukopeni 3.efusi pleura s. ec pneumonia dd TB                                            | dr. Elvi, Sp. P                             | RS Karsa Husada | Pro ICU TB                                   | 2 | Tidak                                                           |
| 19 | By. Ny. Rokhani                | NEO  | RDS, BBLR                                                                                             | dr. Fiona, Sp. A                            | RSSA            | Pro Ventilator dan perawatan NICU            | 3 | Tidak                                                           |
| 20 | Tn Udi Wijayanto               | IGD  | DOC ec CVA ICH                                                                                        | Dr Dewi, Sp.S                               | RST Soepraoen   | Pro stroke unit                              | 2 | Tidak                                                           |
| 21 | Tn Kutuk Mujianto              | IGD  | STEMI anteroseptal onset 6 jam , HHD                                                                  | dr Mira, Sp.JP                              | RST Soepraoen   | Pro PCI                                      | 1 | Tidak                                                           |
| 22 | Ny Siti Arini                  | ICU  | DOC ec hipoglikemia, anemia                                                                           | dr Heri, Sp.PD                              | RSSA            | Pro Edoskopi + Transfusi                     | 2 | Tidak                                                           |
| 23 | Tn Nacrowi Mail                | IGD  | Septic condition suspnpneumonia, AKI, anemia st chronic isease                                        | dr Ardhi, Sp.PD                             | RSSA            | Pro HD                                       | 2 | Tidak                                                           |
| 24 | Ny Rahmasanti                  | IGD  | CKDM ADHF, Edema anasarka, efusi pleura , HHD                                                         | dr Heri, Sp.PD                              | RSSA            | Pro HD                                       | 2 | Tidak                                                           |
| 25 | Tn. Panali                     | IGD  | ICH+SAH Parietotemporal dex, CF Distal radius ulna sin, edema cerebri, FR lefort II                   | dr. Andi Abdillah Sp.B                      | RSUD Bangil     | Pro Bedah Syaraf dan membutuhkan alat khusus | 2 | Tidak                                                           |
| 26 | Ny. Siti Rubaiyah              | IGD  | Anemia, Melena                                                                                        | dr. Heri Sp.PD                              | RST Soepraoen   | Pro Edoskopi + Transfusi                     | 2 | Tidak                                                           |
| 27 | Tn. Cahyono                    | IGD  | Edema anasarka, efusi pleura, susp syndrome nefrotik dd nefritik                                      | dr. Heri Sp.PD                              | RSSA            | Pro ICU TB                                   | 2 | Tidak                                                           |
| 28 | Tn. Muhammad Riadho            | IGD  | AKI dd CKD, Obs dyspneu ec pneumonia dd TB Paru, Edema anasarka, DM Hiperglikemia (675), Anemia (9.3) | dr. Heri Sp.PD                              | RST Soepraoen   | Pro HD                                       | 1 | Tidak                                                           |
| 29 | Ny. Debora                     | IGD  | CF Collum Femur Dex, Azetomia ec AKI dd CKD                                                           | dr. Heri Sp.PD                              | RSSA            | Pro HD                                       | 2 | Tidak                                                           |
| 30 | Tn. Sulistiharto               | IGD  | Chest pain dt STEMI, RV infarct + Rwyat VT dng nadi                                                   | dr. Mira, Sp. JP                            | RSSA            | Pro PCI                                      | 1 | Tidak                                                           |
| 31 | Tn. Satari                     | IRNA | BPH POST TURP, CVA Infark                                                                             | dr. Edi, Sp. U konsul dr. Syahrir, Sp. N    | RSSA            | Pro Stroke Unit                              | 3 | Tidak                                                           |
| 32 | Tn. Moh Yani                   | ICU  | Respiratory failure                                                                                   | dr. Andy, Sp. P                             | RSSA            | Pro HCU RSSA                                 | 4 | Tarif RS : 5.258.138<br>Plavon : 3.791.500<br>Minus : 1.466.638 |
| 33 | Tn. Yudi Muhadi                | ICU  | CKD, ALO, Anemia, Hiperkalemia                                                                        | dr. Miryanti, Sp. JP raber dr. Heri, Sp. PD | RSSA            | Pro HD                                       | 3 | Tarif RS : 7.587.229<br>Plavon : 6.753.700<br>Minus :           |

|    |                        |      |                                                                                         |                                      |                 |                               |   |                                                                 |
|----|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
|    |                        |      |                                                                                         |                                      |                 |                               |   | 833.529                                                         |
| 34 | Tn. Tauchid            | IGD  | STEMI Inferior onset 2 jam, HT                                                          | dr. Yoga Sp.JP                       | RS Persada      | Pro PCI                       | 1 | Tidak                                                           |
| 35 | Ny. Sukati             | IGD  | NSTEMI, Total AV Block, Cardiogenic shock, HF, DM Type 2                                | dr. Yoga Sp.JP                       | RSSA            | Pro Early PCI dan back up TPM | 2 | Tidak                                                           |
| 36 | Tn. Rustam             | IGD  | DOC ec CVA ICH Ponds                                                                    | dr. Farid, Sp. N                     | RST Soepraoen   | Pro Stroke Unit               | 1 | Tidak                                                           |
| 37 | Ny. Siti Fatimah       | IRNA | CVA 3rd Attack + HT                                                                     | dr. Farid, Sp. N                     | RST Soepraoen   | Pro Stroke Unit               | 2 | Tidak                                                           |
| 38 | Ny. Jumikem            | IGD  | DOC, UREMIC ENCELOPHATY ec CKD                                                          | dr. Zora, Sp. PD                     | RS Karsa Husada | Pro HD                        | 2 | Tidak                                                           |
| 39 | Tn. Romli              | IGD  | DM Hiperglikemia, Hematemesis melena, Anemia, CKD                                       | dr. Heri Sp.PD                       | RSSA            | Pro HD                        | 1 | Tidak                                                           |
| 40 | Tn. Rebin              | IGD  | Transaminitis hiponatremi, susp TB Paru, Pneumonia cap sepsis, Gagal napas type 1       | dr. Yunita Sp.P                      | RSSA            | Pro Back up ventilator        | 1 | Tidak                                                           |
| 41 | Tn. Warlik             | IGD  | Dizziness dr anemia, anemia dt melena, bisitopenia, azotemia, hipokalemia, cardiomegaly | dr. Heri Sp.PD                       | RST Soepraoen   | Pro CVCU                      | 1 | Tidak                                                           |
| 42 | Ny. Suwatin            | IRNA | DM, Nefrolitiasis. Plegmon dasar mulur, Hemoroid grade II                               | dr. Heri Sp.PD konsul dr. Anton Sp.B | RST Soepraoen   | Pro Biopsi                    | 2 | Tarif RS : 8.904.014<br>Plavon : 3.414.900<br>Minus : 5.489.114 |
| 43 | Ny. Farida Agustina    | IGD  | DOC ec Susp CVA Emboli, AF RVR, Hipokalemia                                             | dr. Syahrir Sp.S                     | RS Lavalette    | Pro Stroke Unit               | 2 | Tidak                                                           |
| 44 | Tn. IR Purnama Atmadja | IRNA | NSTEMI, CHF dt CAD, DM tipe 2                                                           | dr. Mira, Sp. JP                     | RS Persada      | Pro PCI                       | 4 | Tidak                                                           |
| 45 | Tn.Chotamin            | ICU  | 1. Respiratory failure type 2 2. Pneumonia 3. COPD AE                                   | dr.Andy.,Sp.P konsul dr.Heru.,Sp.An  | RST Soepraoen   | Pro Ventilator                | 2 | Tidak                                                           |
| 46 | Nn. Siti Nur AnisA     | IGD  | 1. COR 2. CF Humeri S 3. CF Mandibula D et S                                            | dr. oka sp.ot                        | RST Soepraoen   | Pro alat Locking khusus       | 2 | Tidak                                                           |

Analisis :

1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, pada bulan april 2024 39 pasien, pada bulan mei sebanyak 30 pasien dan pada bulan Juni sebanyak 46 pasien. dengan rincian : IGD 28 pasien, IRNA 10 pasien, Neonatus 1 pasien, ICU 6 pasien, maternitas 1 pasien
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
  - a) Pro HD = 10 kasus
  - b) Pro unit stoke = 10 kasus
  - c) Pro PCI = 5 kasus
  - d) Pro Bedah digestif = 1
  - e) Membutuhkan alat khusus = 5
  - f) Pro ventilator = 3
  - g) Pro isolasi TB = 2
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya sebesar Rp.16.615674 Sedangkan pada bulan Juni 2024 terdapat 3 pasien dengan jumlah total minus : Rp.7.789.281

Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

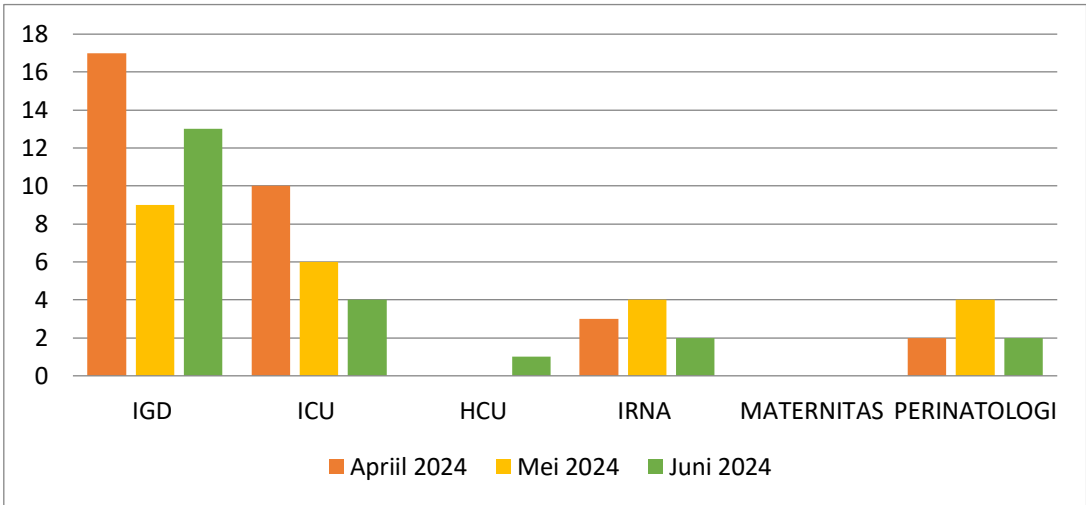
3.5.7.6 Pengisian Form A, B, Discart Planning

3.5.7.6.1 Kelengkapan Pengisian Form A-B dan Dischard Palanning Bulan Juni 2024

| NO | NAMA PETUGAS                  | FORM MPP | DISCARD PLANING |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|
|    |                               | JUMLAH   | JUMLAH          |
| 1  | Daning Pravitia YSM, S.Tr.Keb | 142      | 64              |
| 2  | Novita Pratama M,Amd.Keb      | 105      | 56              |
| 3  | Fadilla Ayu,S.Kep             | 124      | 73              |
| 4  | Cindytya,S.Kep                | 98       | 64              |
| 5  | Wiwit Indah Yanti,S.Kep       | 144      | 63              |

3.5.7.6.2 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juni 2024

| NO    | UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| 1.    | IGD                        | 17         | 9        | 13        |
| 2.    | ICU                        | 10         | 6        | 4         |
| 3     | HCU                        | 0          | 0        | 1         |
| 4.    | IRNA                       | 3          | 4        | 2         |
| 5.    | MATERNITAS                 | 0          | 0        | 0         |
| 6     | PERINATOLOGI               | 2          | 4        | 2         |
| Total |                            | 32         | 23       | 22        |



| NO | NAMA PASIEN                 | UNIT | DIAGNOSIS                                                                                                                                                       | DPJP                                     |
|----|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | An. Davisa Ayuska Elensa EF | IRNA | GEA, Dehidrasi berat, Seizure, Sepsis                                                                                                                           | dr. Dicky Sp.A                           |
| 2  | Ny. Nur Cholifah            | IGD  | DOC Post ROSC, Uremic Encephalopathy                                                                                                                            | dr. Ardhi, Sp. PD                        |
| 3  | Tn. Mujiono                 | IGD  | Anemia (HB5,2), Jaundice, Hipokalemia (2,1), General Weakness dt low intake, disfagia, riw stroke, azotemia dd aki dd ckd, syock condition dd syock hipovolemik | dr. Heri Sp.PD                           |
| 4  | Tn. Sumo                    | IRNA | Emboli stroke, AKI, Hematuri                                                                                                                                    | dr. farid Sp.S<br>konsul dr. Ardhi Sp.PD |
| 5  | Tn. Kapitan Hitu Hali       | IGD  | DOC ec SVT                                                                                                                                                      | dr. Yoga, Sp.JP                          |

|    |                       |     |                                       |                                                                    |
|----|-----------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6  | Tn. Ismo Wahyudi      | ICU | Respiratory Failure, DM Hiperglikemia | dr. Heru, Sp. An                                                   |
| 7  | NY. ENDANG KUSMIATI   | IGD | COB                                   | dr. Zaki, Sp. B                                                    |
| 8  | Ny Yayuk Ekawati      | IGD | DOA                                   | dr Muchlas                                                         |
| 9  | Ny Irne Neneng Haliah | IGD | DOC ac DSS                            | dr Heri, Sp.PD                                                     |
| 10 | Ny. Inayah            | IGD | DOA                                   | dr. Muchlas                                                        |
| 11 | Ny. Rokayah           | IGD | DOC ec Obs Seizure                    | dr. Sofia                                                          |
| 12 | An Rudi               | ICU | Ileus obstruktif                      | dr Andi, Sp.B                                                      |
| 13 | Tn. Amat              | ICU | DOC, ARDS                             | dr. andi Sp.P<br>konsul dr. Farid<br>Sp.N konsul dr.<br>Heri SP.PD |
| 14 | Tn. Parno             | IGD | DOC                                   | dr. Ardhi, Sp. PD                                                  |
| 15 | Tn. Suliadi           | HCU | DOC, KAD                              | dr. Ardhi, Sp. PD                                                  |
| 16 | Tn. Nawawi            | IGD | DOC Susp CVA ICH                      | dr. Fahima, Sp.<br>S                                               |
| 17 | Tn. Suwandi           | ICU | DOC, ARDS, Pneumonia Aspirasi         | dr. Farid Sp.S                                                     |
| 18 | By. Ny Sa'dyatul      | NEO | IUFD                                  | dr. Humaira<br>Sp.OG                                               |
| 19 | Ny. Sunikmah          | IGD | DOA                                   | dr. Sofia                                                          |
| 20 | Tn. Mijono            | IGD | DOC                                   | dr. Andira                                                         |
| 21 | Tn. Mustari           | IGD | SYOCK HIPOVOLEMIK                     | dr. Sofia                                                          |
| 22 | By Ny Miftahul Jannah | NEO | Asfiksi nerat                         | dr Dicky, Sp.A                                                     |

Analisa :

- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juni 2024 sebanyak 22 pasien
- Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 13 pasien, ICU sebanyak 4 pasien, HCU sebanyak 1 pasien, IRNA 2 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
- Pada bulan Juni 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 3 kasus.
- Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.7 Pengisian Form A, B dan Discart Planning

3.5.7.7.1 Tabel Kelengkapan Pengisian Form A, B dan Discart Planning

| NO | NAMA PETUGAS                  | FORM MPP | DISCARD PLANING |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|
|    |                               | JUMLAH   | JUMLAH          |
| 1  | Daning Pravitia YSM, S.Tr.Keb | 142      | 64              |
| 2  | Novita Pratama M,Amd.Keb      | 105      | 56              |
| 3  | Fadilla Ayu,S.Kep             | 124      | 73              |
| 4  | Cindytya,S.Kep                | 98       | 64              |
| 5  | Wiwit Indah Yanti,S.Kep       | 144      | 63              |

3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

| NO | JENIS            | TARGET | MEI     |            |
|----|------------------|--------|---------|------------|
|    |                  |        | CAPAIAN | PROSENTASE |
| 1  | SEIRI / RINGKAS  | 6      | 4.02    | 67%        |
| 2  | SEITON / RAPI    | 8      | 7.00    | 88%        |
| 3  | SEISO / RESIK    | 66     | 36.12   | 55%        |
| 4  | SEIKETSU / RAWAT | 8      | 5.67    | 71%        |
| 5  | SHITSUKE / RAJIN | 12     | 8.09    | 67%        |

| SEIRI / RINGKAS                       | DESKRIPSI                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penempatan Alat Kebersihan di Janitor | Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kebersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi |
| Penempatan alat kebersihan di Trolley | Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi  |
| Kondisi bak pembersih / kereta peras  | Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| SEITON / RAPI                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Kerapian baju petugas CS              | CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih                                                                                                                                                 |
| Penggunaan ID card                    | CS Menggunakan id card sesuai aturan                                                                                                                                                                      |
| Penanganan sampah Medis dan Non Medis |                                                                                                                                                                                                           |
| Penempatan sampah medis dan nonmedis  | tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.                                                                                         |
| Penempatan plastik                    | Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| SEISO / RESIK                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Lantai                                | Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.                                                                          |
| Langit – Langit / Plafon              | Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                          |
| Kaca Luar – Dalam                     | Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.                                                                                                                |
| Jendela / Tralis                      | Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.                                                                                                                                                |
| Tirai (vertical blind, gordyn)        | Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.                                                                                                                                                             |
| Lampu                                 | Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                          |
| Saklar & stopkontak                   | Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.                                                                                                                                                            |
| Sarana pemadam kebakaran              | Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.                                                                                                                           |
| Objek Berbahan Stainless              | Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                         |
| Dinding                               | Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wastafel dan eye wash              | Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam. |
| Kamar Mandi                        | Kebersihan dan bau                                                                                                                                                                                                |
| Ruangan                            | Tidak bau amis, pesing, dan anyir.                                                                                                                                                                                |
| Plafon/langit-langit               | Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                       |
| Kasa nyamuk                        | Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.                                                                                                                                                  |
| Dinding Keramik                    | Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.                                                                                                                           |
| Closed                             | Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.                                                                                                                           |
| Kran                               | Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.                                                                                                                                                                     |
| Pintu                              | Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.                                                                                                                                                                            |
| Urinoir                            | Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.                                                                                                                                                            |
| Bak Mandi                          | Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.                                                                                                                                                  |
| Ember dan Gayung                   | Bersih dan tidak berlumut.                                                                                                                                                                                        |
| Lantai                             | Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.                                                                                                                           |
| Keset                              | Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.                                                                                                                                                      |
| Tempat Sampah                      | Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran                                                                           |
| Tangga                             | Bersih dan bebas sawang                                                                                                                                                                                           |
| Railing                            | Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.                                                                                                                                                    |
| Lantai (anak tangga & Bordes)      | Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.                                                                                                                                                      |
| Dinding                            | Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.                                                                                                                                                              |
| Plafon                             | Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                     |
| Lift                               | Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.                                                                                                             |
| Dek Level                          | Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.                                                                                                              |
| Pagar                              | Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                     |
| Spoel hock/Dapur                   | Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.                                                                                                                                     |
| Pembersihan Tempat Sampah / Trolly | Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.                                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SEIKETSU / RAWAT</b>            |                                                                                                                                                                                                                   |
| Poles lantai di ruangan            | Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan                                                                                                                   |
| Pemakaian APD                      | APD masker, sepatu, sarung tangan                                                                                                                                                                                 |
| Penandaan alat kebersihan          | Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi                                                                                        |
| Kebersihan Diri Petugas            | Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap                                                                                                                                                            |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |                                                   |
| <b>SHITSUKE / RAJIN</b>                                |                                                   |
| Kompetensi CS<br>Memperagakan Cuci tangan dengan benar | Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan |
| Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan        | Segera di TL dan dilaporkan dalam grup            |
| Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator        | Segera di TL dan dilaporkan dalam grup            |

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

| JENIS            | TARGET | CAPAIAN JUNI |
|------------------|--------|--------------|
| SEIRI / RINGKAS  | 30     | 61%          |
| SEITON / RAPI    | 40     | 89%          |
| SEISO / RESIK    | 330    | 54%          |
| SEIKETSU / RAWAT | 40     | 72%          |
| SHITSUKE / RAJIN | 60     | 69%          |

**Analisis :**  
 Pada bulan Juni metode penilaian ada perubahan sehingga akan dapat dievaluasi untuk dibandingkan dengan bulan depan.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

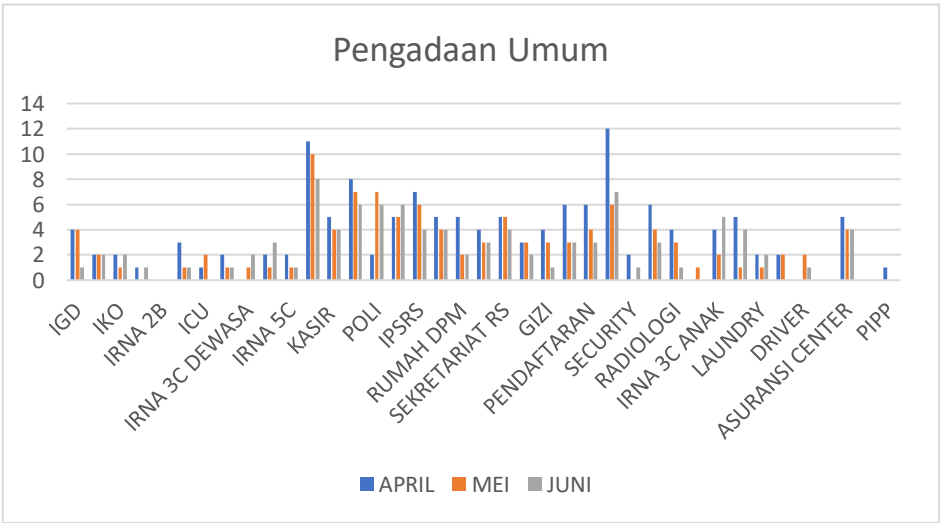
3.5.9     **Pengadaan dan Gudang Umum**

3.5.9.1   **Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang**

| NO | UNIT             | APRIL | MEI | JUNI |
|----|------------------|-------|-----|------|
| 1  | IGD              | 4     | 4   | 1    |
| 2  | MATERNITAS       | 2     | 2   | 2    |
| 3  | IKO              | 2     | 1   | 2    |
| 4  | IRNA 2A          | 1     | 0   | 1    |
| 5  | IRNA 2B          | 0     | 0   | 0    |
| 6  | IRNA 2C          | 3     | 1   | 1    |
| 7  | ICU              | 1     | 2   | 0    |
| 8  | IRNA 3A          | 2     | 1   | 1    |
| 9  | IRNA 3C DEWASA   | 0     | 1   | 2    |
| 10 | IRNA 4C+4A       | 2     | 1   | 3    |
| 11 | IRNA 5C          | 2     | 1   | 1    |
| 13 | KASIR            | 5     | 4   | 4    |
| 14 | DAPUR            | 8     | 7   | 6    |
| 15 | POLI             | 2     | 7   | 6    |
| 16 | CLEANING SERVICE | 5     | 5   | 6    |
| 17 | IPSRS            | 7     | 6   | 4    |

|    |                 |    |   |   |
|----|-----------------|----|---|---|
| 18 | GUDANG FARMASI  | 5  | 4 | 4 |
| 19 | RUMAH DPM       | 5  | 2 | 2 |
| 20 | SEKRETARIAT PT  | 4  | 3 | 3 |
| 21 | SEKRETARIAT RS  | 5  | 5 | 4 |
| 22 | CSSD            | 3  | 3 | 2 |
| 23 | GIZI            | 4  | 3 | 1 |
| 24 | REKAM MEDIS     | 6  | 3 | 3 |
| 25 | PENDAFTARAN     | 6  | 4 | 3 |
| 26 | DEPO FARMASI    | 12 | 6 | 7 |
| 27 | SECURITY        | 2  | 0 | 1 |
| 28 | LABORATORIUM    | 6  | 4 | 3 |
| 29 | RADIOLOGI       | 4  | 3 | 1 |
| 30 | FISIOTERAPI     | 0  | 1 | 0 |
| 31 | IRNA 3C ANAK    | 4  | 2 | 5 |
| 32 | NS NICU         | 5  | 1 | 4 |
| 33 | LAUNDRY         | 2  | 1 | 2 |
| 34 | LANTAI 6A,7A,8A | 2  | 2 | 0 |
| 35 | DRIVER          | 0  | 2 | 1 |
| 36 | SIMRS           | 0  | 0 | 0 |
| 37 | ASURANSI CENTER | 5  | 4 | 4 |
| 38 | DPW             | 0  | 0 | 0 |
| 39 | PIPP            | 1  | 0 | 0 |

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



**Analisis :**

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan Depo Farmasi

**Rencana Tindak Lanjut :**

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

**3.6 Komite dan Tim**

**3.6.1 Komite Mutu**

**3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional**

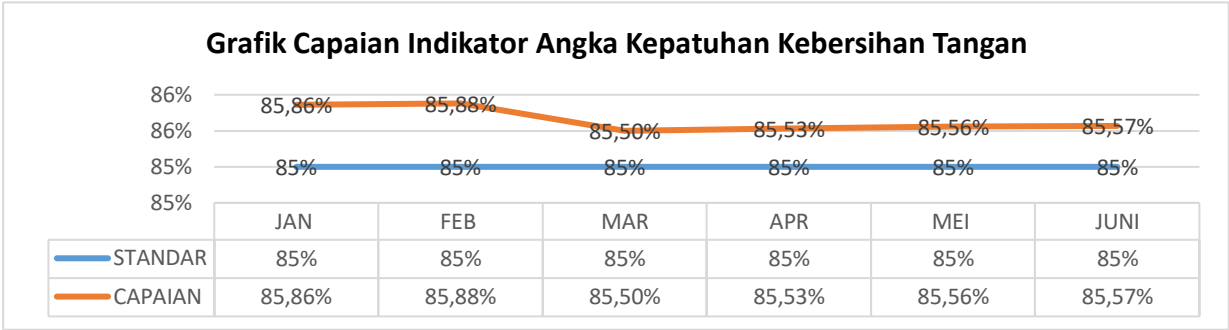
| NO                      | JUDUL                                             | STAND   | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| INDIKATOR MUTU NASIONAL |                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                       | Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan                 | ≥ 85%   | 85,86%  | 85,88%  | 85,5%   | 85,53%  | 85,56%  | 85,57%  |
| 2                       | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)    | 100%    | 93,04%  | 93,15%  | 93,3%   | 93,52%  | 93,73%  | 93,8%   |
| 3                       | Kepatuhan Identifikasi Pasien                     | 100%    | 99,9%   | 81,2%   | 98,78%  | 100%    | 99,99%  | 99,95%  |
| 4                       | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi    | ≥ 80%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5                       | Waktu Tunggu Rawat Jalan                          | ≥ 80%   | 95,2%   | 91,7%   | 95,74%  | 52,7%   | 65,2%   | 72,8%   |
| 6                       | Penundaan Operasi Elektif                         | ≤ 5%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 7                       | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                     | ≥ 80%   | 76,19%  | 79,08%  | 79,28%  | 78,06%  | 76,32%  | 78,47%  |
| 8                       | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium               | 100%    | 98,69%  | 98,8%   | 98,46%  | 97,5%   | 98,9%   | 99,69%  |
| 9                       | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional         | ≥ 80%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 10                      | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | ≥ 80%   | 63,8%   | 71,62%  | 67,56%  | 66,7%   | 100%    | 92,5%   |
| 11                      | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh    | 100%    | 98,47%  | 97,47%  | 99,54%  | 99,67%  | 95,86%  | 85,57%  |
| 12                      | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain                  | ≥ 80%   | 100%    | 93,15%  | 100%    | 100%    | 100%    | 93,8%   |
| 13                      | Kepuasan Pasien                                   | ≥ 76,61 | 100%    | 91,89%  | 99,63%  | 99,82%  | 99,63%  | 99,95%  |

3.6.1.1.1

Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1

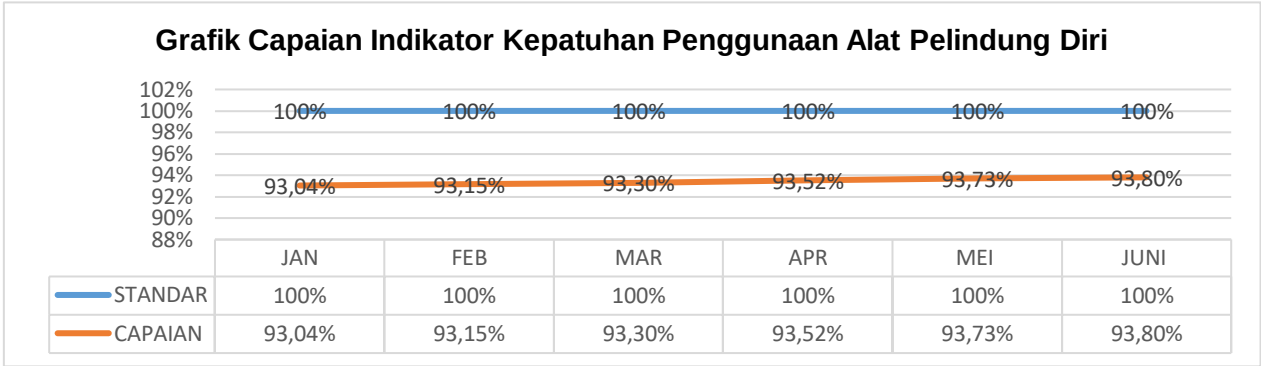
Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| PLAN                           | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| DO                             | <div>1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit.</div> <div>2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya.</div> <div>3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan.</div> <div>4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan.</div> <div>5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.</div>                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| STUDY                          | Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,57%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP. |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| ACTION/R TL                    | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SASARAN                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Meningkatkan kebersihan tangan | Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%. | <div>1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan.</div> <div>2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.</div> <div>3. Memberikan reward-pembelajaran.</div> <div>4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.</div> <div>5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.</div> | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

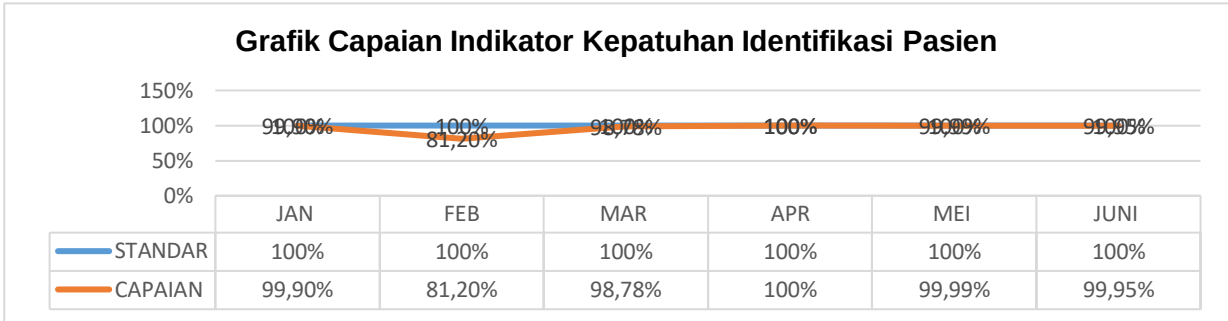
3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| PLAN                                  | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |
| DO                                    | <div>1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai.</div> <div>2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.</div> <div>3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.</div> <div>4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD.</div> <div>5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.</div> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |
| STUDY                                 | Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,8% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |            |
| ACTION/RTL                            | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SASARAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD. | Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya. | <div>1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD.</div> <div>2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya.</div> <div>3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.</div> <div>4. Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak.</div> <div>5. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.</div> | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

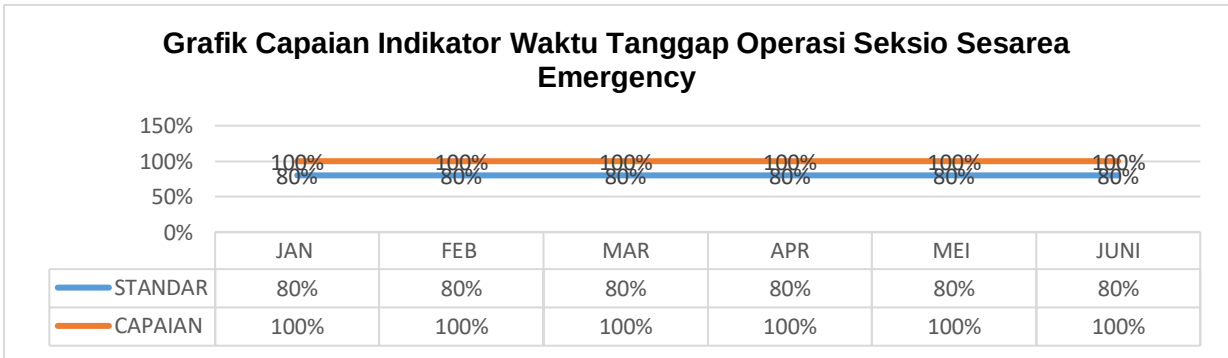
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| PLAN                                         | Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| DO                                           | <div>1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan</div> <div>2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien</div> <div>3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| STUDY                                        | Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei dan Juni, capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. |                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                 |            |
| ACTION/RTL                                   | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SASARAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                               | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien | Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya. | <div>1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit</div> <div>2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat</div> | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

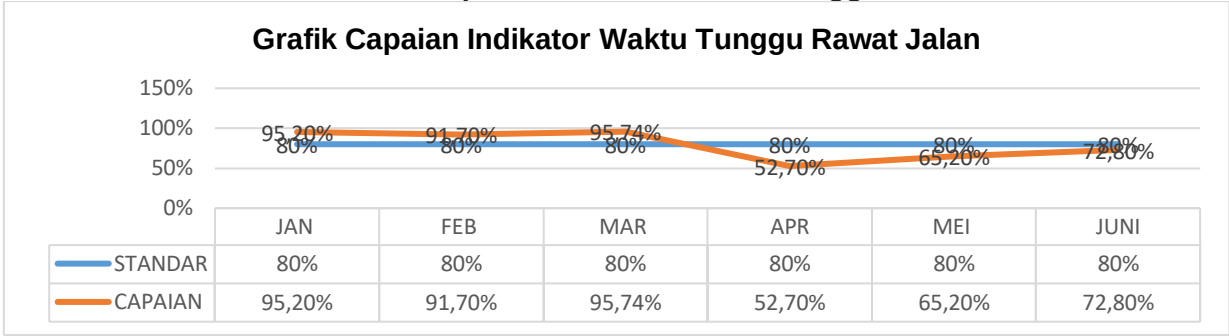
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



**Analisa Capaian :**  
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

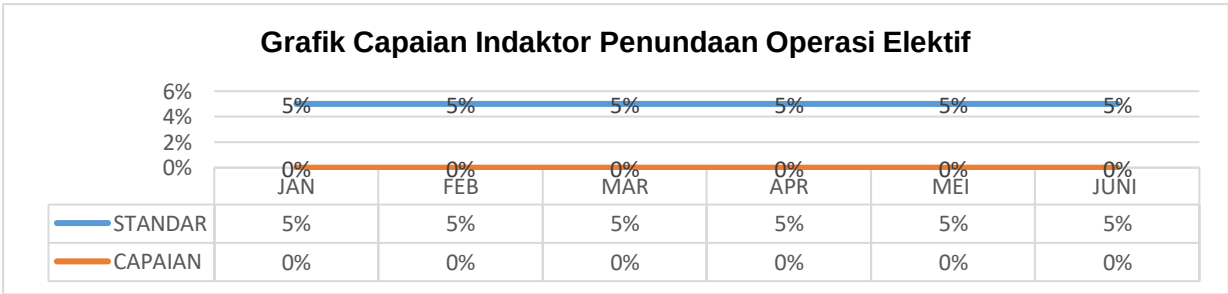
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                             |              |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| PLAN                                                     | Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                             |              |            |
| DO                                                       | Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                             |              |            |
| STUDY                                                    | <p>Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. Pada bulan Mei tahun 2024 diketahui prosentase waktu tunggu rawat jalan 65,2% dan bulan Juni 72,8%.</p> <p>1. Dpjp tepat waktu : dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr, Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A, dr.Elvi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S</p> <p>2. Dpjp Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M,</p> <p>3. Dpjp dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.</p> |                               |                                                                                             |              |            |
|                                                          | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SASARAN                       | STRATEGI                                                                                    | PELAKSANA    | WAKTU      |
| Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan. | Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waktu tunggu rawat jalan <80% | Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM. | Manajemen RS | Satu bulan |

3.6.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

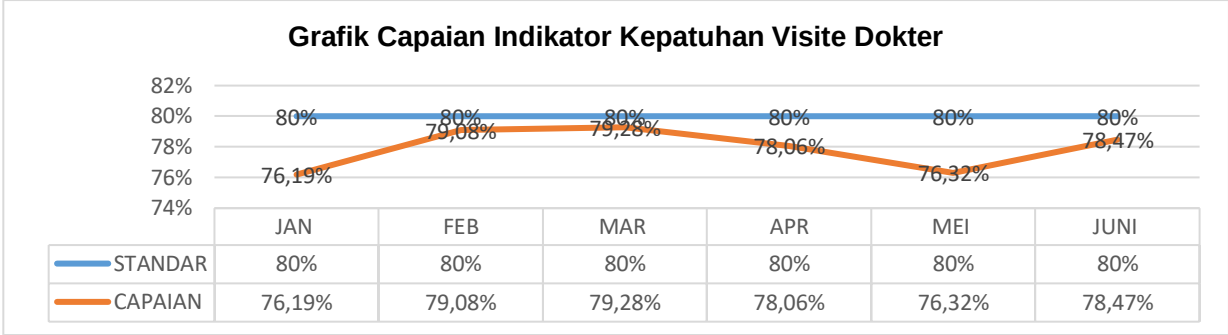


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Juni tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

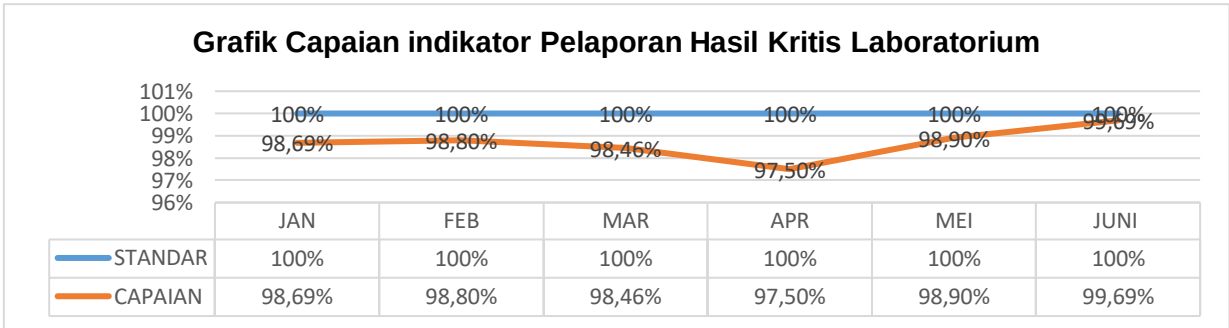
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                           |              |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| PLAN                                       | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                           |              |            |
| DO                                         | Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                           |              |            |
| STUDY                                      | <p>Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap.</p> <p>Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr.</p> <p>Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)</p> |                                                                       |                                                                                                                                           |              |            |
|                                            | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SASARAN                                                               | STRATEGI                                                                                                                                  | PELAKSANA    | WAKTU      |
| Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter | Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya | Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00 | Manajemen RS | Satu bulan |

3.6.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

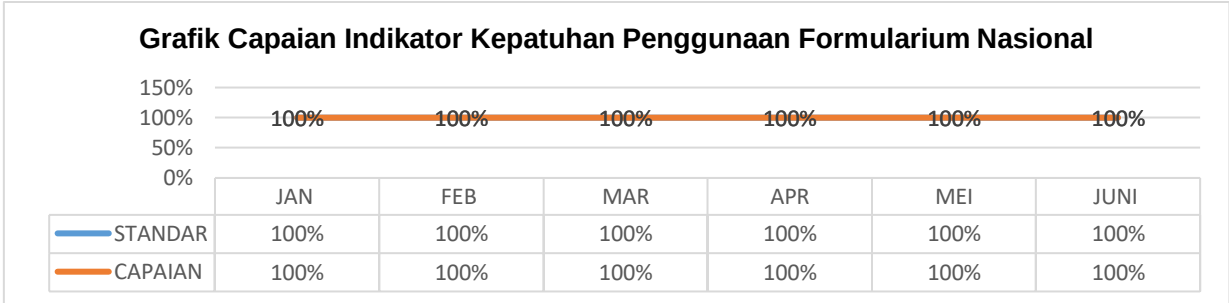


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%                                                                                                                                                                                                                 |
| DO    | Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.                                                                                                             |
| STUDY | Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap. |

| ACTION/RTL                                                         | TUJUAN                                                             | SASARAN                                                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PELAKSANA                                          | WAKTU      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium | Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium | Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya | 1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor<br>2. Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap. | 1. Komite mutu<br>2. Kepala instalasi laboratorium | Satu bulan |

3.6.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

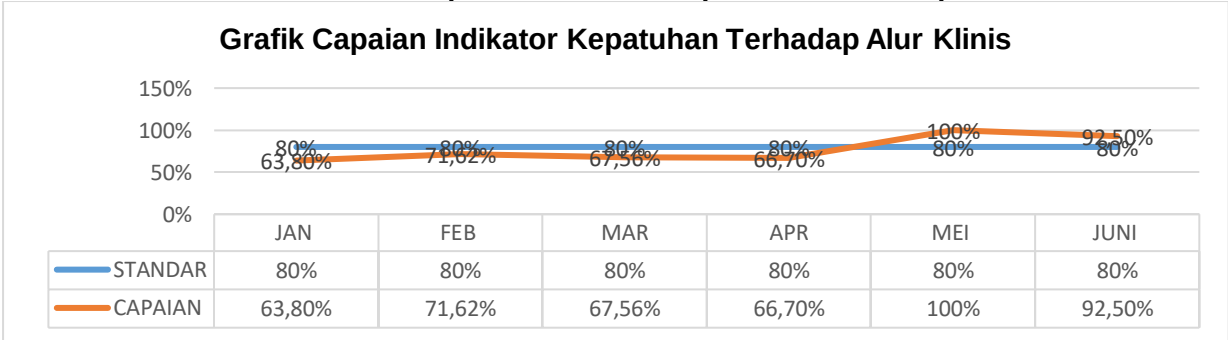
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



**Analisis Capaian :**  
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Juni Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

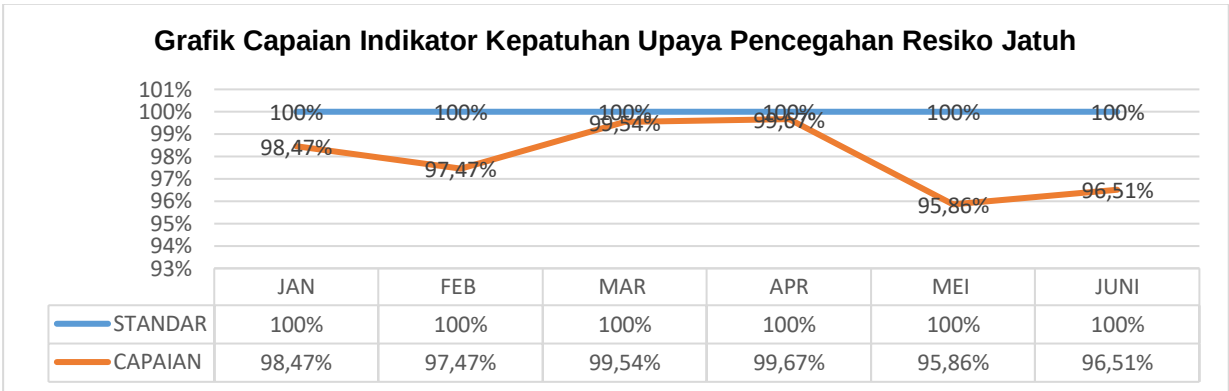
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



| PLAN                                                          | Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| DO                                                            | Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa. |                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| STUDY                                                         | Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |             |            |
| ACTION/RTL                                                    | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                   | SASARAN                                                                      | STRATEGI                                                                                                                                                                                                | PELAKSANA   | WAKTU      |
| Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis | Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis                                                                                                                                                            | Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%. | Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa. | Komite mutu | Satu bulan |

3.6.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

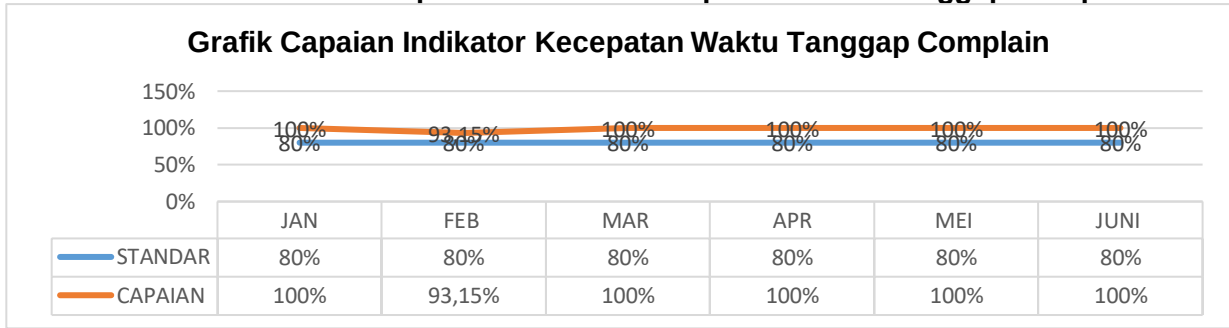
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| PLAN                                                                   | Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| DO                                                                     | Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| STUDY                                                                  | Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| ACTION/RTL                                                             | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                                           | PELAKSANA                    | WAKTU      |
| Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh | Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%. | KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. | Perawat instalasi rawat inap | Satu bulan |

3.6.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

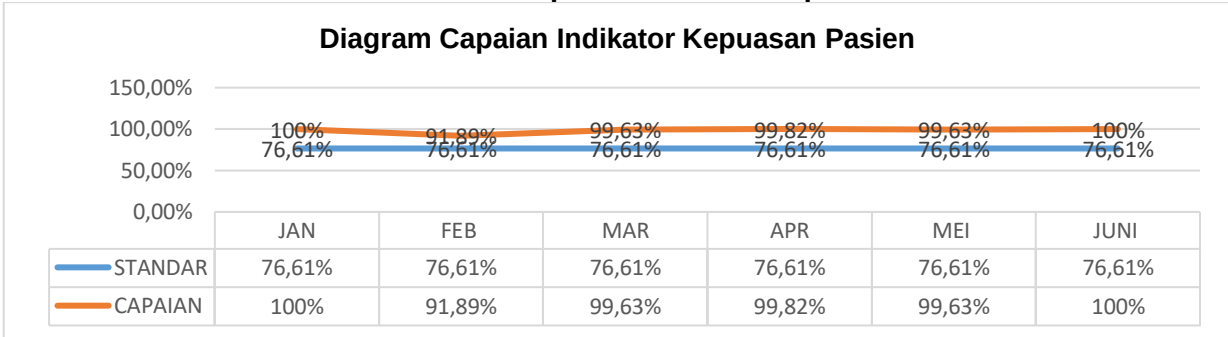


**Analisis**

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga Juni capaian kembali meningkat menjadi 100%.

3.6.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



**Analisis :**  
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 sudah mencapai standart

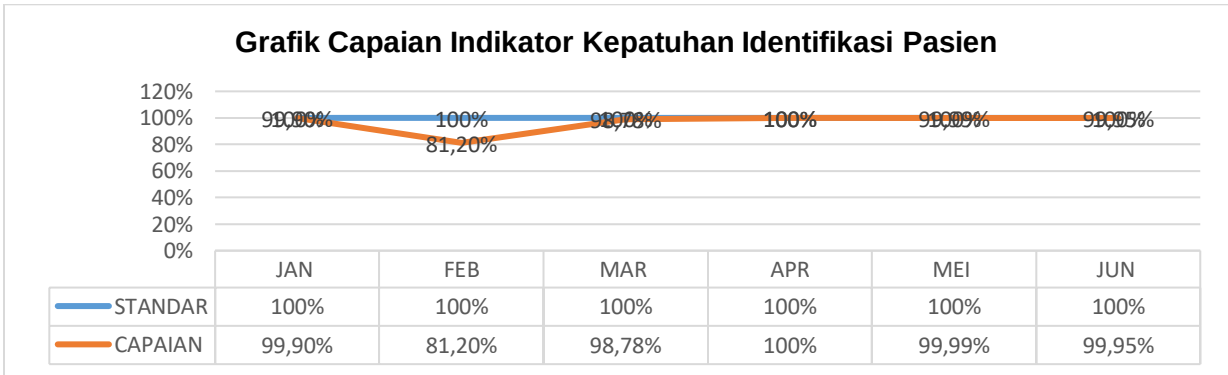
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

| NO. | JUDUL                                                    | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUNI '24 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1   | Kepatuhan identifikasi pasien                            | 100%  | 99,9%   | 81,2%   | 98,78%  | 100%    | 99,99%  | 99,95%   |
| 2   | Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 3   | Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi  | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 4   | Kepatuhan kebersihan tangan                              | 100%  | 85,86%  | 85,88%  | 85,5%   | 85,53%  | 85,56%  | 85,57%   |
| 5   | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh           | 100%  | 98,47%  | 97,47%  | 99,54%  | 99,67%  | 95,86%  | 95,51%   |

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

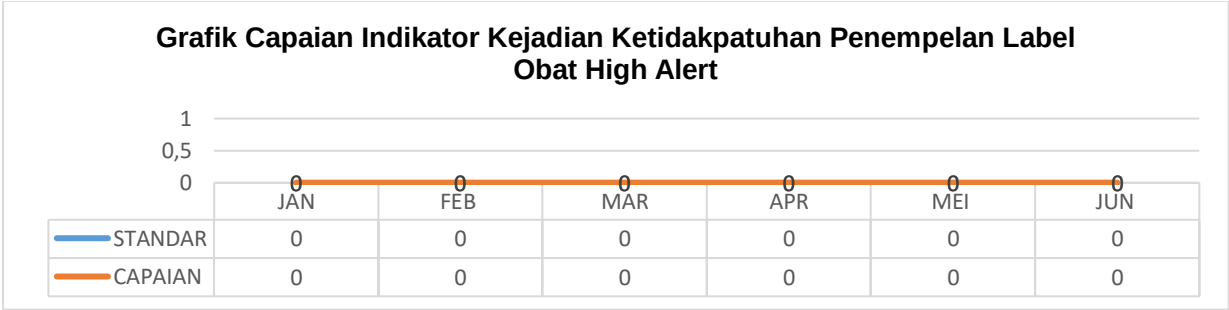


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DO    | <div>1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan</div> <div>2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien</div> <div>3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STUDY | Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei dan Juni, capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. |

| ACTION/RTL                                   | TUJUAN                                       | SASARAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                            | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien | Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien | Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya. | 1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit<br>2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

### 3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

#### 3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



#### Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 telah mencapai standart.

### 3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

#### 3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

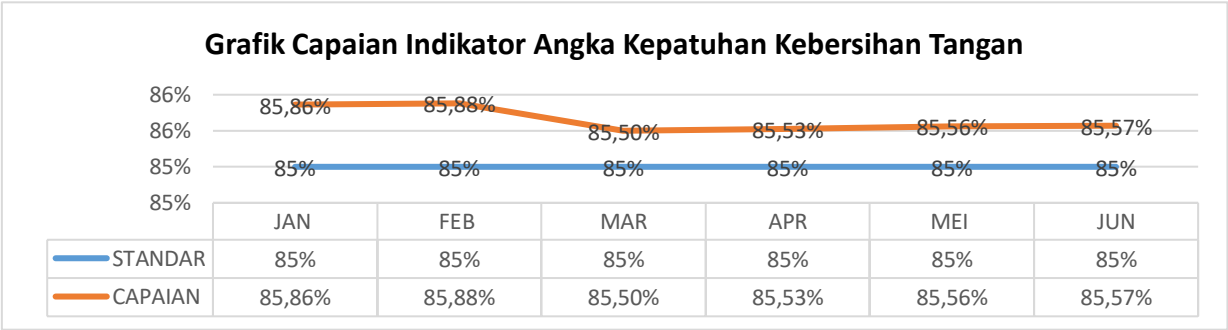


#### Analisis :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 telah mencapai standart.

### 3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

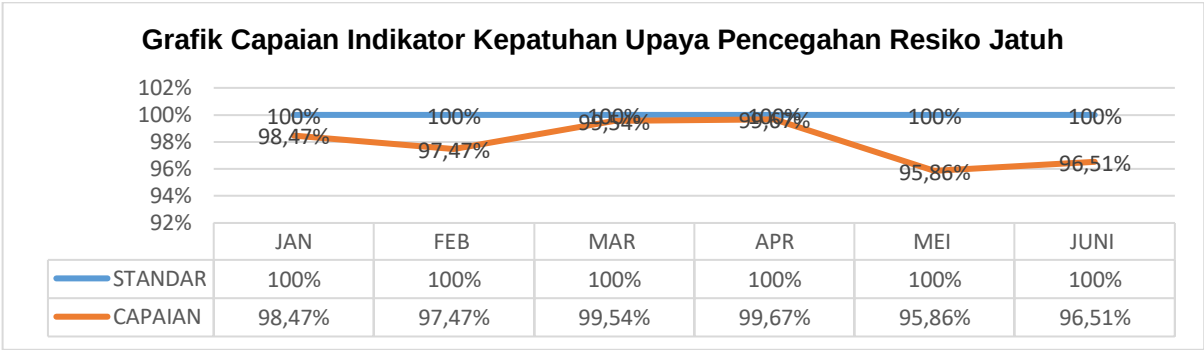
#### 3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| PLAN                            | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |
| DO                              | 1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit.<br>2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya.<br>3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan.<br>4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan.<br>5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |
| STUDY                           | Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,57%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP. |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |
| ACTION/RTL                      | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SASARAN                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Meningkatkan kebersihan tangan. | Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%. | 1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan.<br>2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.<br>3. Memberikan reward-pembelajaran.<br>4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.<br>5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.2.1.5Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



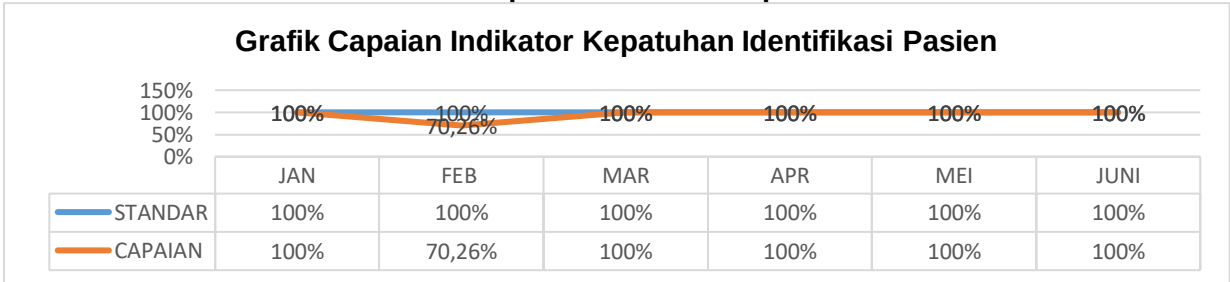
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| PLAN                                                                   | Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| DO                                                                     | Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| STUDY                                                                  | Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. |                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                              |            |
| ACTION/RTL                                                             | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                                           | PELAKSANA                    | WAKTU      |
| Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh | Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%. | KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. | Perawat instalasi rawat inap | Satu bulan |

3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

| NO | JUDUL                                                           | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien                                   | 100%  | 100%    | 70,26%  | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan penggunaan formularium Nasional                       | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 3  | Kejadian kesalahan penyiapan obat                               | 0     | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4  | Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA              | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5  | Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit. | 0%    | 68,81%  | 69,59%  | 73,43%  | 79,11%  | 78,13%  |
| 6  | Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.           | 0%    | 41,48%  | 50,77%  | 56,18%  | 61,29%  | 58,52%  |
| 7  | Kejadian kesalahan pemberian obat                               | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8  | Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.                       | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9  | Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert        | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 | Kejadian kesalahan input e-resep                                | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 | Kejadian petugas tertusuk jarum                                 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 | Kejadian terkena pemanas mesin press puyer                      | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13 | Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap                   | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14 | Kekosongan stok farmasi                                         | 0%    | 0,27%   | 0,36%   | 0,53%   | 0,7%    | 0%      |

3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

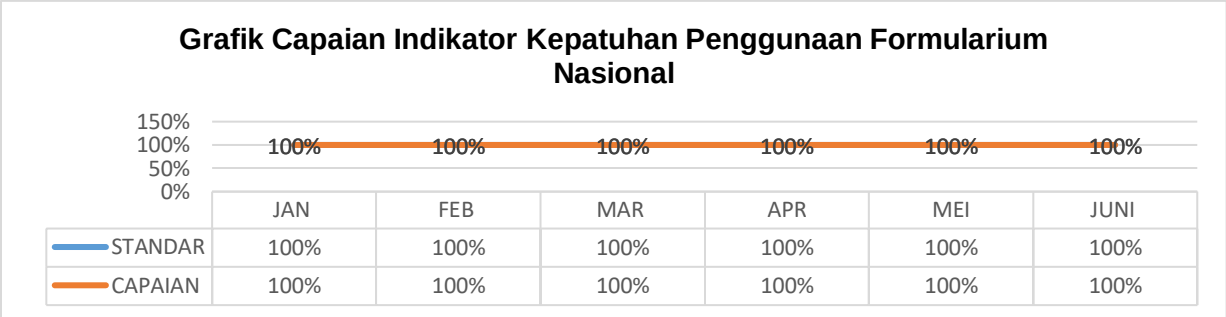


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DO    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan</li><li>2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien</li><li>3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah</li></ol> |
| STUDY | Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga Juni capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan                   |

|                                            | melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut. |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| ACTION/RTL                                 | TUJUAN                                                                                                                                                  | SASARAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                          | PELAKSANA               | WAKTU      |
| Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien | Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien                                                                                                              | Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya. | 1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit<br>2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat | Seluruh petugas farmasi | Satu bulan |

3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

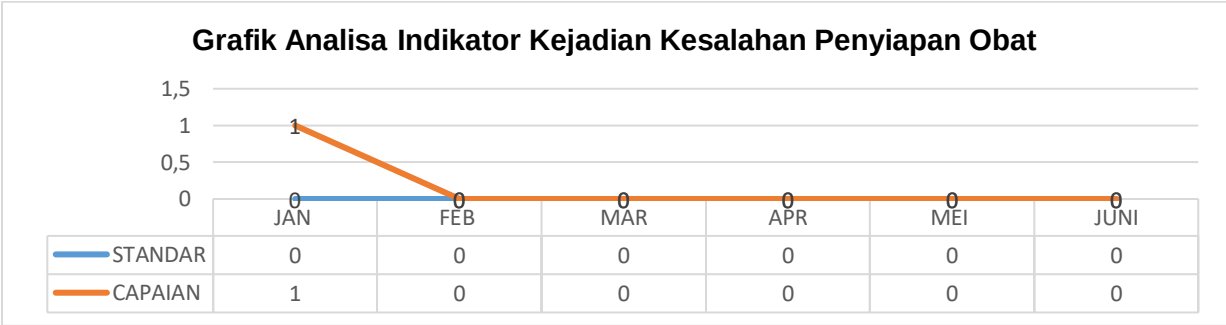


Analisis Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

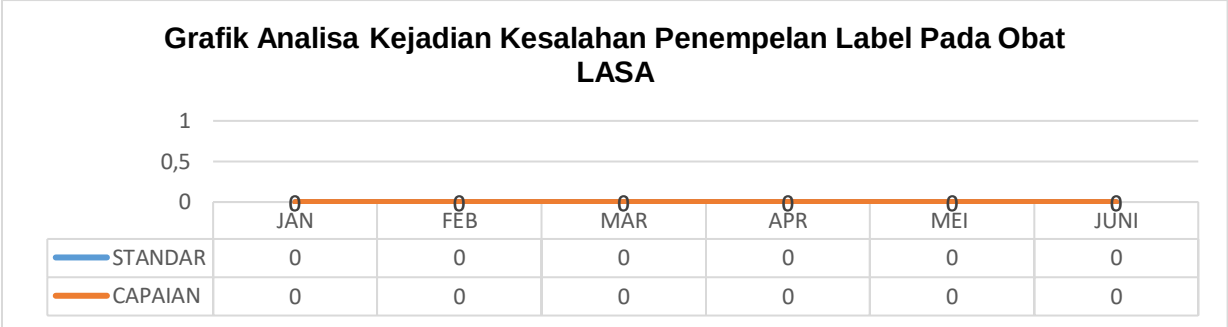


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.                                                                                                                                                                                          |
| DO    | 1. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan<br>2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat<br>3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat                                                 |
| STUDY | Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga Juni tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat. |

| ACTION/RT L                                              | TUJUAN                                                   | SASARAN                                     | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                               | PELAKSANA               | WAKTU      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat | Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat | Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat | 1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan<br>2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat<br>3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat | Seluruh petugas farmasi | Satu bulan |

3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

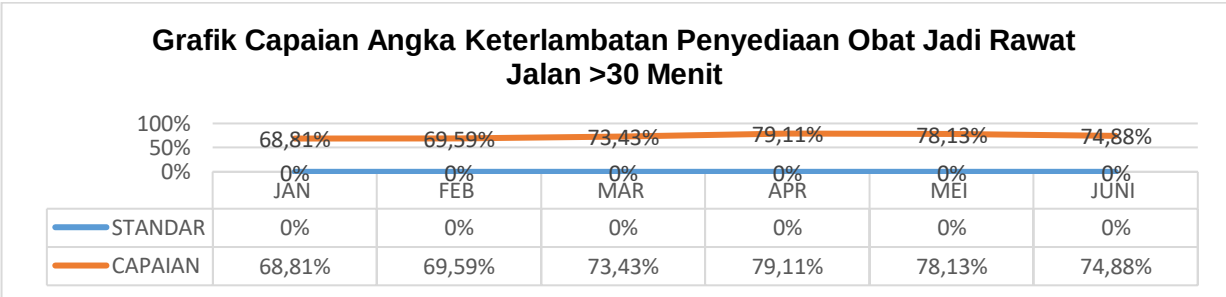
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



**Analisis Capaian :**  
 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

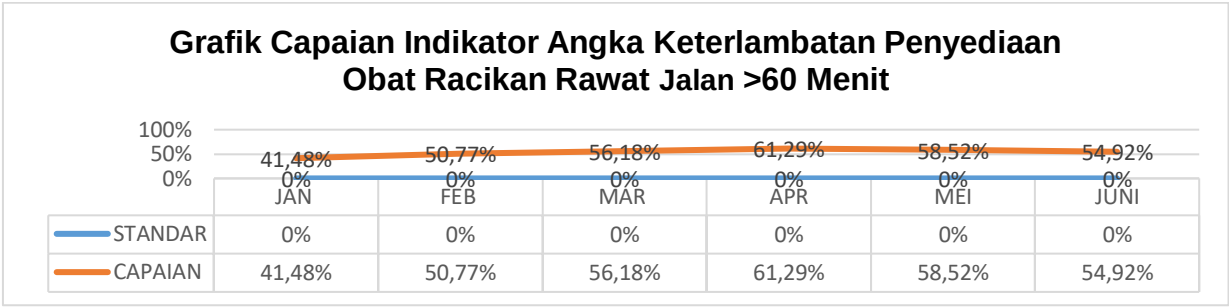


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.                                                                                                                                                                                                                                              |
| DO    | 1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan<br>2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai<br>3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai                    |
| STUDY | Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena :<br>1. Pasien cendereung naik beberapa hari.<br>2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan |

| ACTION/R TL                                                                | TUJUAN                                                                     | SASARAN                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PELAKSANA               | WAKTU      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit. | Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit. | Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit . | 1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan<br>2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai<br>3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai | Seluruh petugas farmasi | Satu bulan |

3.6.1.2.2.6 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

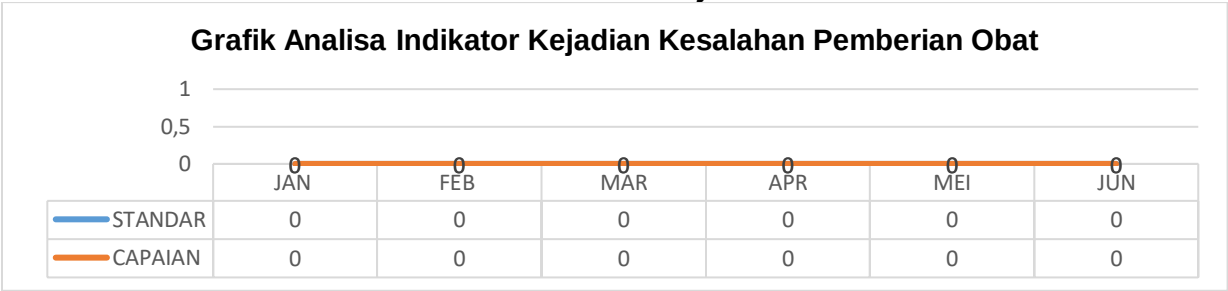
3.6.1.2.2.6.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



| PLAN                                                   | Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                         |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| DO                                                     | 1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan<br>2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai<br>3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai                      |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                         |            |
| STUDY                                                  | Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena :<br>4. Pasien cendereung naik beberapa hari<br>1. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                         |            |
| ACTION/R TL                                            | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SASARAN                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                     | PELAKSANA               | WAKTU      |
| Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan | Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit . | 1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan<br>2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai | Seluruh petugas farmasi | Satu bulan |

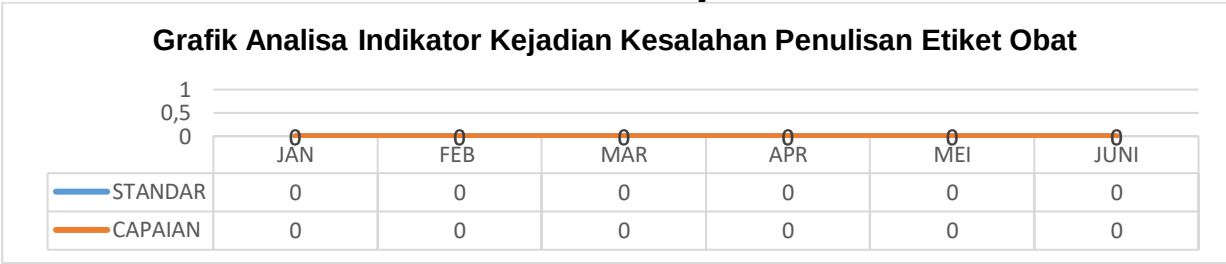
|                        |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| rawat jalan >60 menit. |  |  | 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai |  |  |
|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat  
3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



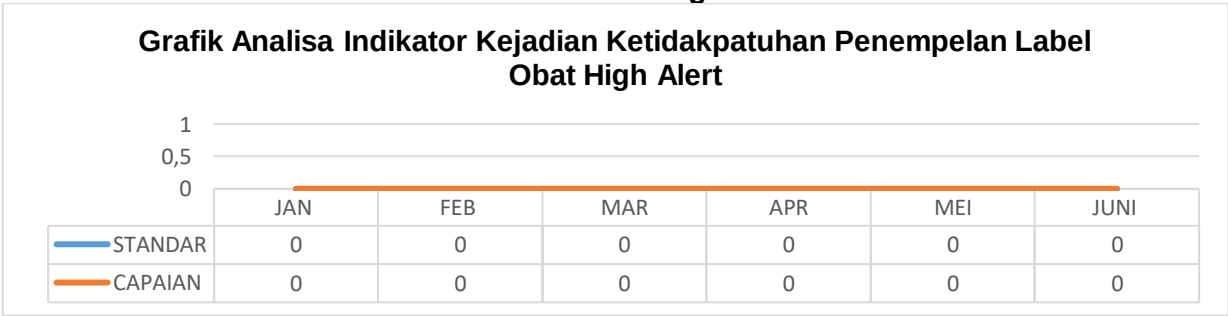
**Analisis Capaian :**  
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat  
3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



**Analisis :**  
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

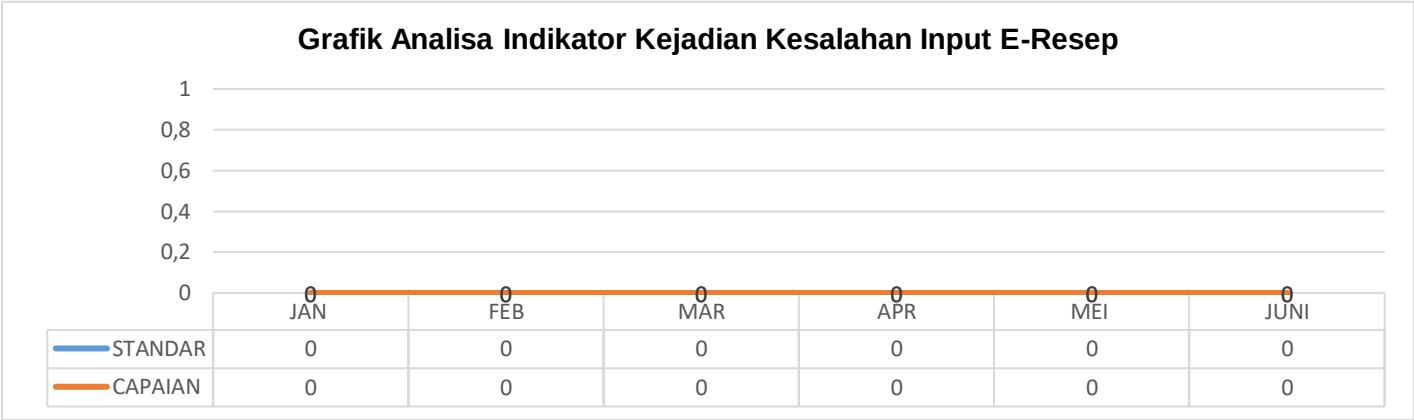
3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert  
3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



**Analisis:**  
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep

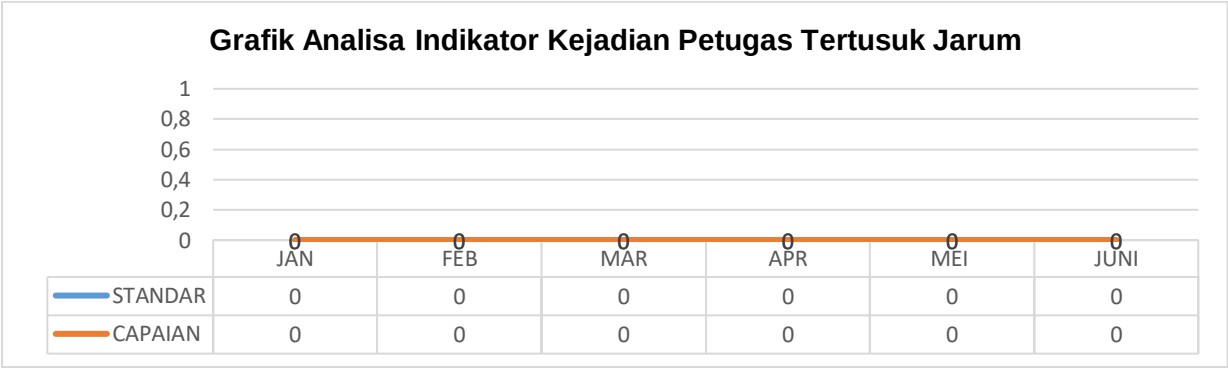


**Analisis :**

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

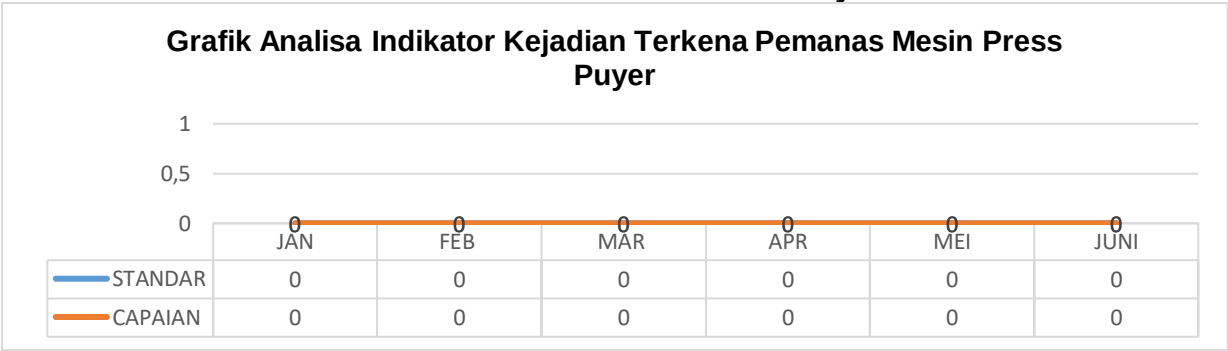


**Analisis:**

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

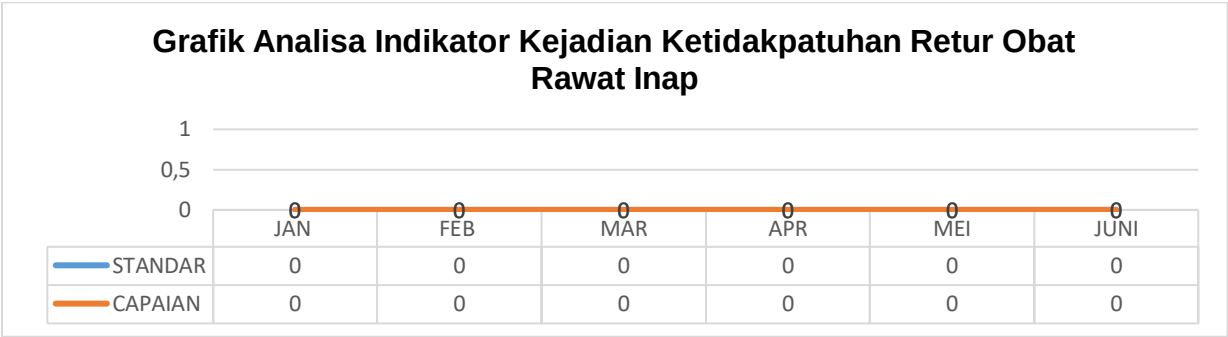


**Analisis :**

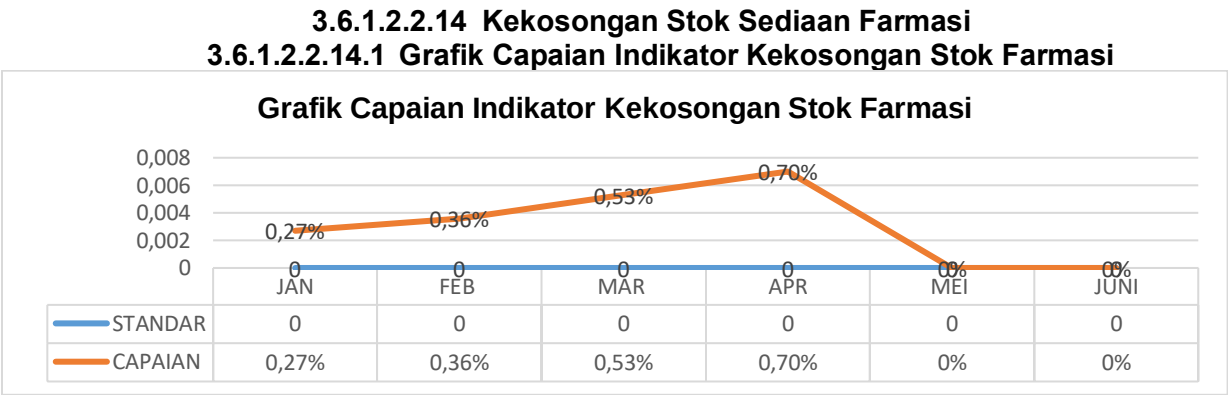
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



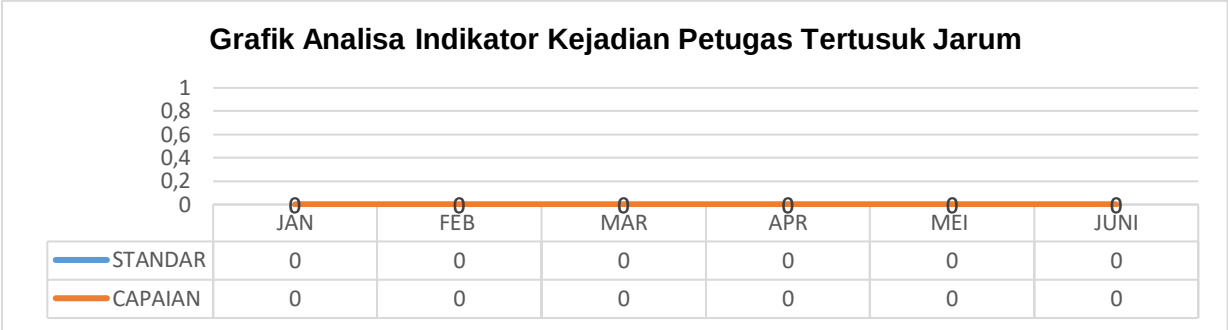
**Analisis Capaian :**  
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024.



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                           |                                                        |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| PLAN                                     | Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                           |                                                        |            |
| DO                                       | Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                           |                                                        |            |
| STUDY                                    | Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei dan Juni masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena :<br>1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena :<br>- Barang sedang kosong distributor<br>- Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf<br>2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada<br>3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan<br>4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali<br>5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf<br>6. Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin |                                           |                                                                                                                           |                                                        |            |
| ACTION/R TL                              | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN                                   | STRATEGI                                                                                                                  | PELAKSANA                                              | WAKTU      |
| Mengurangi angka kekosongan stok farmasi | Mengurangi angka kekosongan stok farmasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi | Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order. | 1. Kepala Instalasi farmasi<br>2. Pengadaan Farmasi PT | Satu bulan |

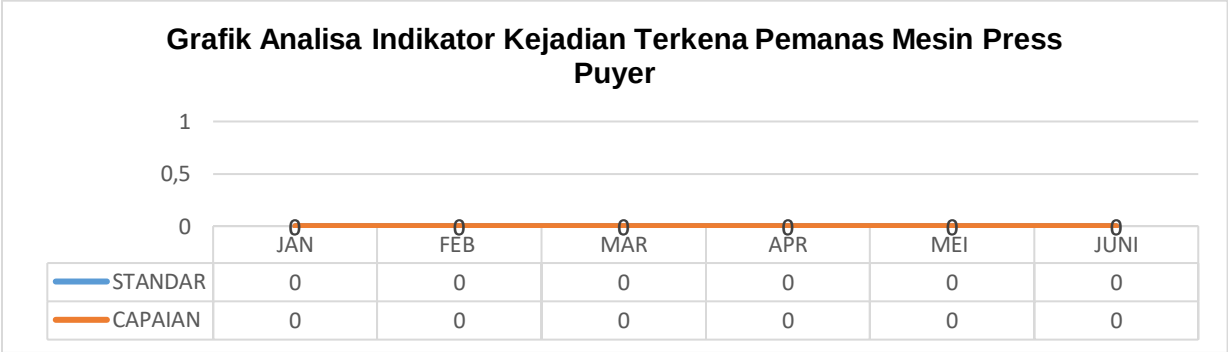
| 3.6.1.2.3 Manajemen Resiko |                                                        |       |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NO                         | JUDUL                                                  | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
| 1                          | Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan) | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                          | Kejadian terkena pemanas mesin press puyer             | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum  
3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



| PLAN                        | Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                              |                                  |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| DO                          | 1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM.<br>2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan.<br>3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman.<br>4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan. |                                                         |                                                                                                                              |                                  |            |
| STUDY                       | Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                              |                                  |            |
| ACTION/RTL                  | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN                                                 | STRATEGI                                                                                                                     | PELAKSANA                        | WAKTU      |
| Melakukan penyuntikan aman. | Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya. | Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. | Seluruh petugas pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer  
3.6.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



**Analisis:**  
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024.

**3.6.1.3 Mutu Unit**  
**3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat**

| NO | JUDUL                                                | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Kepatuhan Identifikasi Pasien                        | 100%  | 100%    | 96,25%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2. | Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD | 0%    | 0%      | 0,17%   | 0%      | 0,28%   | 0,15%   | 0,67%   |
| 3. | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh       | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 4. | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri            | 0%    | 0,7%    | 0,85%   | 0,61%   | 0,73%   | 0,5%    | 2,61%   |
| 5. | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci       | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

**3.2.1.3.2 IRNA 2A**

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  |         |         |         |         | 97,64%  | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  |         |         |         |         | 45,54%  | 76,92%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis ( <i>Clinical Pathway</i> )                    | ≥80%  |         |         |         |         | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  |         |         |         |         | 100%    | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    |         |         |         |         | 0%      | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100%  |         |         |         |         | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)                               | 100%  |         |         |         |         | 100%    | 100%    |

**3.2.1.3.2 IRNA 2C**

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 93,41%  | 100%    | 97,22%  | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 80%     | 73,53%  | 74,84%  | 73,57%  | 73,23%  | 62,6%   |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis ( <i>Clinical Pathway</i> )                    | ≥80%  | 0%      | -       | -       | 0%      | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 96,8%   | 100%    | 95,93%  | 100%    | 93,75%  | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 1,03%   | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100%  | 94,7%   | 100%    | 100%    | 97,14%  | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)                               | 100%  | 86,49%  | 86,36%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.3 IRNA 3A

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 93,18%  | 89,4%   | 91,28%  | 80,29%  | 87,79%  | 91,45%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)                             | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0,75%   | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100%  | 84,96%  | 87,65%  | 82,43%  | 83,94%  | 89,17%  | 91,45%  |

3.2.1.3.4 IRNA 4A

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 94,84%  | 78,23%  | 86,54%  | 86,84%  | 89,19 % | 95%     |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)                             | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 71,83%  | 97%     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100%  | 100%    | 90,75%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)                               | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 97,4%   | 100%    |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)                             | ≥80%  | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0,37%   | 0%      | 0,39%   |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7. | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)                               | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.6 IRNA 5C

| NO | JUDUL                                             | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                     | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                     | ≥80%  | 62,07%  | 66,86%  | 64,86%  | 55,35%  | 67,48%  | 67,48%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

|   |                                                                               |      |        |        |        |        |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 5 | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%   | 0,54%  | 0,55%  | 0,74%  | 0%     | 0%     | 0%     |
| 6 | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024) | 100% | 99,13% | 97,75% | 93,02% | 96,38% | 95,58% | 95,58% |
| 7 | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)                               | 100% | 86,49% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

3.2.1.3.7 IRNA 6A

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 61,11%  | 79,63%  | 84,92%  | 83,21%  | 82,79%  | 76.47%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis ( <i>Clinical Pathway</i> )                    | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0,7%    |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024) | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)                               | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.8 IRNA 7A

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | MAR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 97,92%  |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 58,22%  | 76,67%  | 75%     | 84,56%  | 76,74%  | 63,78%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis ( <i>Clinical Pathway</i> )                    | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 96,67%  | 100%    | 100%    | 100%    | 97,12%  | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0,7%    | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024) | 100%  | 100%    | 86,52%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)                               | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 91,09%  |

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 92,21%  | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                                 | ≥80%  | 54,39%  | 78,49%  | 81,45%  | 84,56%  | 71,76%  | 75,93%  |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis ( <i>Clinical Pathway</i> )                    | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh                                | 100%  | 100%    | 99,15%  | 100%    | 100%    | 96,72%  | 100%    |
| 5  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 6  | Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024) | 100%  | 100%    | 100%    | 98,91%  | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7  | Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)                               | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.2.10 ICU

| NO | JUDUL                                                  | STAND | JAN '24 | FEB '23 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                          | 100%  | 100%    | 100%    | 98,2%   | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                          | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 98,7%   | 100%    | 100%    |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)      | ≥80%  |         |         |         |         |         |         |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh         | 100%  | 81,8%   | 92,53%  | 86%     | 90,4%   | 100%    | 100%    |
| 5  | Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 6  | Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.      | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 90,7%   | 95,4%   |
| 7  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri              | 0%    | -       | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |

3.2.1.3.2.11 HCU

| NO | JUDUL                                                  | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                          | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                          | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 3  | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)      | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 4  | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh         | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 96,3%   | 100%    | 100%    |
| 5  | Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan | 100%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 6  | Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU       | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 7  | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri              | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |

3.2.1.3.2.12 IRJA

| NO | JUDUL                              | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien      | 100%  | 99,75%  | 100%    | 95,71%  | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Waktu tunggu rawat jalan           | ≥80%  | 95,2%   | 91%     | 95,74%  | 52,7%   | 63.8%   | 72,8%   |
| 3  | Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter | 100%  | 84,42%  | 82,35%  | 84,04%  | 84,04%  | 70.04%  | 81,72%  |
| 4  | Angka rujukan horizontal FKRTL     | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 37,03%  | 0%      |

3.2.1.3.2.13 Maternitas

| NO. | JUDUL                                             | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|---------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Kepatuhan Identifikasi Pasien                     | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2   | Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.   | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 3   | Kepatuhan waktu visite dokter.                    | ≥80%  | 99,44%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 4   | Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway) | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5   | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.   | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 98,63%  |

|    |                                                                                                                        |      |       |       |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6  | Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit                                                            | <5%  | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7  | Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit                                                                        | <10% | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 8  | Angka kematian ibu                                                                                                     | 0%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 9  | Kejadian perdarahan post partum                                                                                        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 10 | Kejadian partus lama                                                                                                   | 0    | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 3     |
| 11 | Kejadian eklamsi                                                                                                       | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 12 | Kejadian pre eklamsi                                                                                                   | 0    | 3     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 13 | Kejadian infeksi nifas                                                                                                 | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 14 | Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC                                                                                    | 0%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 15 | Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP          | 100% | 3,82% | 0,83% | 3,6%  | 8,49% | 6,41% | 5,69% |
| 16 | Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                        | 100% | 3,82% | 0,83% | 3,6%  | 8,49% | 6,41% | 5,69% |
| 17 | Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 | Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri                                                                              | 0%   | 0%    | 0%    | 0,73% | 0%    | 0%    | 0%    |

3.2.1.3.2.14 NICU

| NO | JUDUL                                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                                                 | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)                             | ≥80%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3  | Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh                                       | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 4  | Kepatuhan waktu visite dokter                                                 | ≥80%  | 85,92%  | 90,63%  | 84,72%  | 90,8%   | 84,82%  | 82,35%  |
| 5  | Prosentase pulang atas permintaan sendiri                                     | 0%    | 0%      | 4,17%   | 3,26%   | 0%      | 0%      | 0%      |
| 6  | Angka Kematian Bayi                                                           | 0     | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 3,7%    | 1,28%   |
| 7  | Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

3.2.1.3.2.15 IKO

| NO | JUDUL                                                                                | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien.                                                       | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Penundaan operasi elektif.                                                           | ≤ 5%  | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | -       |
| 3  | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.                                      | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 4  | Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit                                             | 0     | 0       | 10      | 10      | 10      | 10      | 82,35%  |
| 5  | Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general                   | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |
| 6  | Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,28%   |

|    |                                                                                |    |    |    |        |    |    |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|--------|
| 7  | Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi    | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 8  | Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi             | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 100%   |
| 9  | Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | -      |
| 10 | Kejadian tidak dilaksanakan SSC                                                | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 100%   |
| 11 | Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah                                    | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 100%   |
| 12 | Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi                        | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | -      |
| 13 | Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi                    | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 100%   |
| 14 | Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)         | 0% | 0% | 0% | 23,08% | 0% | 0% | 82,35% |

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

| NO | JUDUL                                                            | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien                                    | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Pelaporan hasil kritis laboratorium                              | 100%  | 98,69%  | 98,8%   | 98,48%  | 97,5%   | 98,9%   | 99,68%  |
| 3  | Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling                    | 0     | 3       | 2       | 4       | 2       | 2       | 12      |
| 4  | Kejadian salah input hasil laboratorium                          | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5  | Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024) | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |

3.2.1.3.2.17 Radiologi

| NO | JUDUL                                                              | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien                                      | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 97,54%  |
| 2  | Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi                   | 0%    | 3,72%   | 3,61%   | 2,65%   | 3,81%   | 3,81%   | 1,63%   |
| 3  | Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024) | 0     | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

3.2.1.3.2.18 Gizi

| NO | JUDUL                                     | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien             | 100%  | 99,76%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kejadian kesalahan pemberian diit         | 0     | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3  | Kejadian adanya benda asing dalam makanan | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4  | Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan      | 0     | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |

3.2.1.3.2.19 Farmasi

| NO | JUDUL                                     | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kepatuhan identifikasi pasien             | 100%  | 100%    | 70,26%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kepatuhan penggunaan formularium Nasional | ≥80%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

|    |                                                                 |    |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3  | Kejadian kesalahan penyiapan obat                               | 0  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4  | Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA              | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5  | Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit. | 0% | 68,81% | 69,59% | 73,43% | 79,11% | 78,13% | 75,45% |
| 6  | Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.           | 0% | 41,48% | 50,77% | 56,18% | 61,29% | 58,52% | 54,92% |
| 7  | Kejadian kesalahan pemberian obat                               | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 8  | Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.                       | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert        | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | Kejadian kesalahan input e-resep                                | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | Kejadian petugas tertusuk jarum                                 | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 12 | Kejadian terkena pemanas mesin press puyer                      | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap                   | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi

| NO | JUDUL                   | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kekosongan stok farmasi | 0%    | 0,27%   | 0,36%   | 0,53%   | 0,7%    | 0%      | 0%      |

3.2.1.3.2.21 PPI

| NO. | JUDUL                                                                    | STAND   | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APRIL '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 1.  | IDO (Infeksi Daerah Operasi)                                             | ≤ 2 %   | 0,24%   | 0,8%    | 0,27%   | 0 %       | 0,24 %  | 0 %     |
| 2.  | IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)                                       | ≤3,5‰   | 0‰      | 0‰      | 0‰      | 0‰        | 0‰      | 0‰      |
| 3.  | VAP (Ventilation Associated Pneumonia)                                   | ≤ 5,8 ‰ | 0‰      | 0‰      | 0‰      | 0‰        | 0‰      | 0‰      |
| 4.  | ISK (Infeksi Saluran Kencing)                                            | ≤ 4,7 ‰ | 0‰      | 0‰      | 0‰      | 0‰        | 0‰      | 0‰      |
| 5.  | Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)                            | ≤ 5 %   | 0,28%   | 0,22%   | 0,4%    | 0,25%     | 0,34%   | 0,15%   |
| 6.  | Angka Decubitus                                                          | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%        | 0%      | 0%      |
| 7.  | Angka kepatuhan kebersihan tangan                                        | >85%    | 85,86%  | 85,88%  | 85,5%   | 85,53 %   | 85,62%  | 85,62%  |
| 8.  | Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas                              | 100%    | 93,04%  | 93,05%  | 93,3%   | 93,52%    | 93,73%  | 93,73%  |
| 9.  | Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan | 100%    | 91,91%  | 92,09%  | 92,22%  | 92,29%    | 92,19%  | 92,19%  |
| 10. | Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       |

3.2.1.3.2.22 PIPP

| NO. | JUDUL                                                                                                | STAND  | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN                                                      | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2   | Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN                                                          | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 3   | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain                                                                     | 100%   | 100%    | 93,15%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 4   | Kepuasan Pasien                                                                                      | 76,61% | 100%    | 91,89%  | 99,63%  | 99,82%  | 99,63%  | 99,63%  |
| 5   | Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024) | 100%   | 86,94%  | 75,31%  | 57,76%  | 52,92%  | 55,36%  | 55,36%  |

3.2.1.3.2.23 SDM

| NO. | JUDUL                                          | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.     | 0     | 0       | 0       | 1       | 0       | 1       | 2       |
| 2   | Angka kedisiplinan staf terhadap finger print. | 100%  | 98,99%  | 98,97%  | 99,14%  | 98,76%  | 95,9%   | 98,93%  |
| 3   | Angka keterlambatan kehadiran staf             | 0%    | 3,32%   | 3,34%   | 2,97%   | 14,3%   | 4,12%   | 5,09%   |

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

| NO. | JUDUL                                                                                                                | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Angka kejadian nomor rekam medis ganda.                                                                              | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |
| 2.  | Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap                                                                      | 0%    | -       | -       | 96,65%  | 93,04%  | 94,08%  | 93,81%  |
| 3.  | Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024) | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.  | Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)                                   | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 5.  | Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam                                                    | 0%    | 0%      | 0%      | 7,06%   | 9,44%   | 7,88%   | 5,68%   |

3.2.1.3.2.25 Keuangan

| NO | JUDUL                                                   | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari | 0%    | 7,7%    | 6%      | 3,86%   | 10,98%  | 1,57%   | 0,78%   |
| 2  | Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri           | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3  | Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS               | 0%    | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      |

3.2.1.3.2.26 K3RS

| NO | JUDUL                                              | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|----------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR. | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 2  | Kejadian kebakaran di ruangan.                     | 0     | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

| NO. | JUDUL                                                         | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Angka pending klaim BPJS                                      | 0%    | 1,07%   | 1,04%   | 0,78%   | 0,97%   | -       | 0,62%   |
| 2   | Prosentase readmisi pasien rawat inap                         | 0%    | 1,69%   | 1,04%   | 2,17%   | 1,66%   | 2,25%   | 1,66%   |
| 3   | Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024) | 100%  | 9,73%   | 0,57%   | 0,44%   | 0,42%   | 0,55    | 0,46%   |
| 4   | Kejadian Pasien Tidak Di SEP                                  | 0     | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0       |

3.2.1.2.28 IPSRS

| NO | JUDUL                                                                        | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam | 0%    | 100%    | 91%     | 89%     | 89,47%  | 91,67%  | 91,67%  |

3.2.1.3.2.29 UMUM

| NO | JUDUL                                       | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Keterlambatan barang datang di Gudang       | 0     | 3       | 7       | 4       | 3       | 6       | 6       |
| 2  | Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit | 0     | 11      | 4       | 5       | 2       | 4       | 5       |

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

| NO | JUDUL                                    | STAND | DES '23 | JAN '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit | 0%    | 1,39%   | 1,67%   | 29,17%  | 28,95%  | 3,13%   | 3,45%   |

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

| NO | JUDUL                                                                          | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya | 0%    | 34,21%  | 0%      | 20,69%  | 78,38%  | 48,72%  | 26,67%  |
| 2  | Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja     | 0%    | 25%     | 100%    | 62,5%   | 71,83%  | 56,25%  | 41,67%  |
| 3  | Angka tindakan lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam        | 0%    | 65%     | -       | 60,71%  | 86,21%  | 22,73%  | 17,86%  |

3.2.1.3.2.31 Laundry

| NO | JUDUL                                 | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Angka keterlambatan penyediaan linen  | 0%    | 0%      | 5,2%    | 1,95%   | 4,19%   | 1,35%   | 1,48%   |
| 2  | Kejadian linen ruang perawatan hilang | 0     | 0       | 0       | 0%      | 0%      | 0%      | 0       |

3.2.1.3.2.33 CSSD

| NO | JUDUL                                   | STAN | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|-----------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kejadian ditemukannya instrument hilang | 0    | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2  | Kejadian instrument kurang              | 0    | 1       | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

| NO | JUDUL                                           | STAND | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN'24 |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari   | 0%    | 99,17%  | 90,88%  | 100%    | 100%    | 100%    | 98,65% |
| 2  | Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari | 0%    | 93,71   | 100%    | 92,82%  | 92,82 % | 91,73%  | 87,44% |

3.2.1.3.2.35 IT

| NO | JUDUL                                                   | STAN | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kejadian downtime                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2  | Resptime penanganan internet dan billing error < 30 mnt | 100% | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 3  | Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit        | 100% | 96,97%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

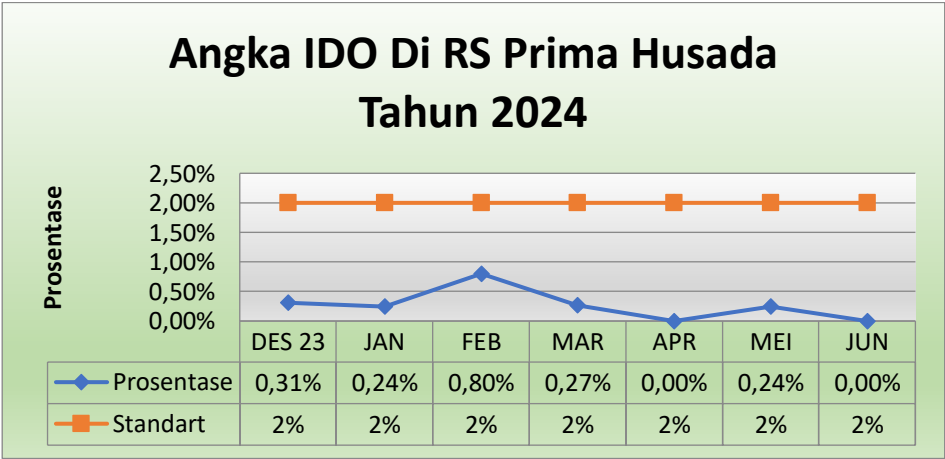
| NO | JUDUL                                                         | STAN | JAN '24 | FEB '24 | MAR '24 | APR '24 | MEI '24 | JUN '24 |
|----|---------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam | 100% | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

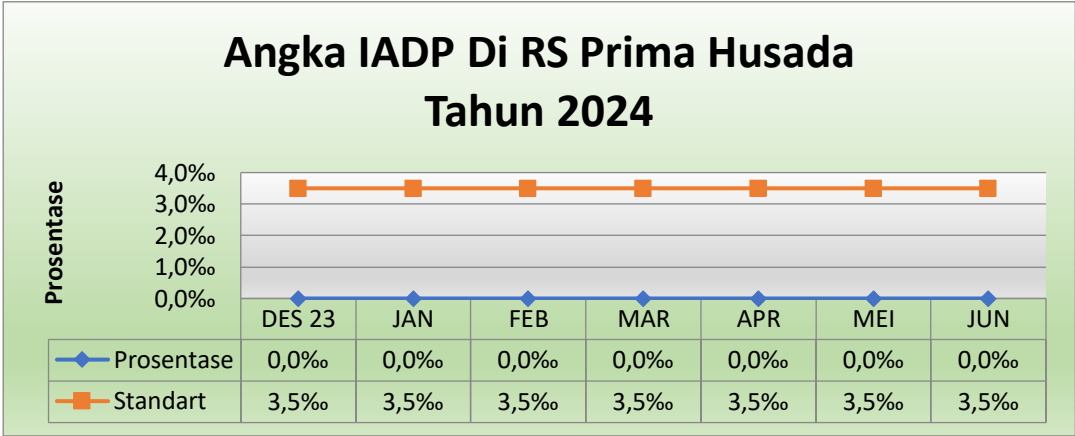


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DO    | <ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan koordinasi dengan DPJP obgyn terkait Teknik aseptik pada saat melakukan perawatan luka maupun prosedur operasi.</li><li>Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong).</li><li>Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptik saat melakukan proses perawatan luka pasien.</li><li>Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS.</li><li>Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin.</li><li>Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.</li></ol> |
| STUDY | Tidak ditemukan kasus IDO pada bulan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ACTION/RTL              | TUJUAN                                                      | SASARAN                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PELAKSANA                                                  | WAKTU      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Pertahankan bundle IDO. | Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO. | Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya. | 1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan.<br>2. Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka.<br>3. Monitoring kepatuhan mandi dengan air sabun sebelum operasi.<br>4. Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang.<br>5. Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptik saat melakukan rawat luka/tindakan bedah. | 1. Perawat /Bidan<br>2. Dokter<br>3. Karu<br>4. IPCLN/IPC� | Satu bulan |

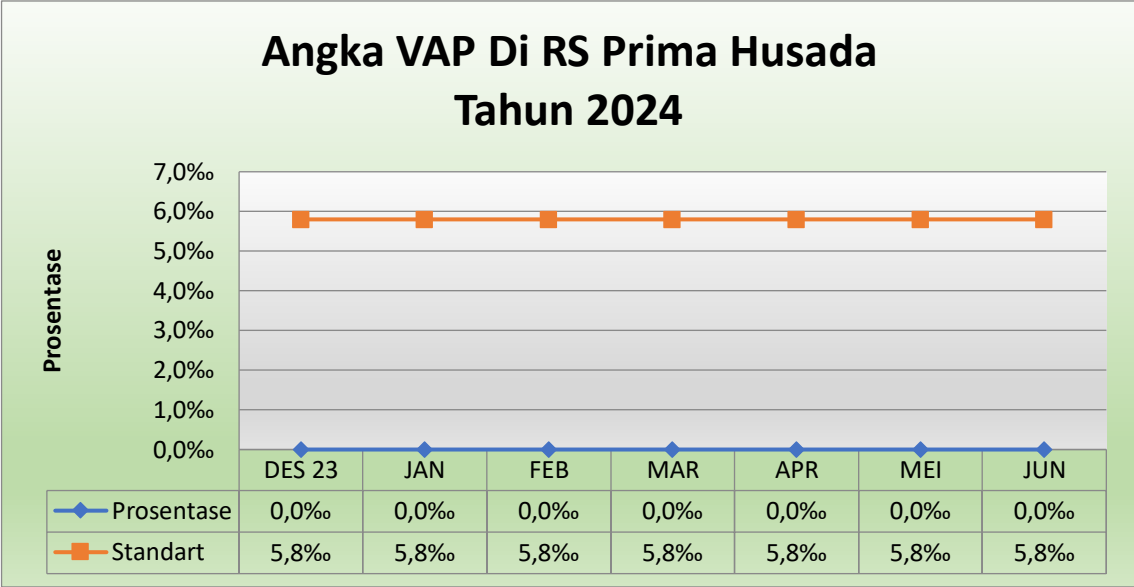
3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



3.6.1.1.3 VAP

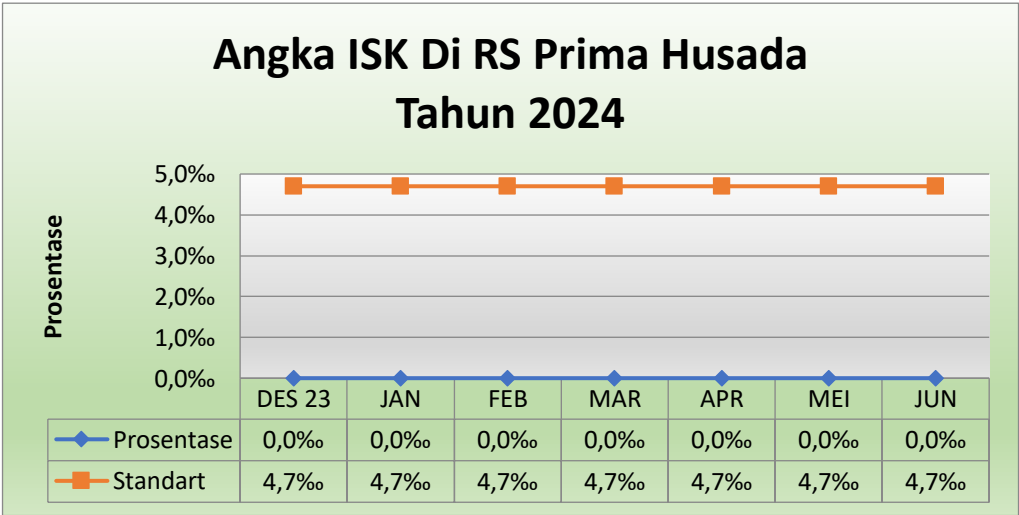
3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



|                                   |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| PLAN                              | Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰) |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |            |
| DO                                | Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |            |
| STUDY                             | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 83 hari lama pemasangan ventilator.     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |            |
| ACTION/RTL                        | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                               | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                              | PELAKSANA                                                  | WAKTU      |
| Pertahankan kepatuhan bundle VAP. | Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.                        | Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya. | 1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan.<br>2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator.<br>3. Monitoring posisi tepat pasien head of bed >30°-45°.<br>4. Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral hygiene. | 1. Perawat /Bidan<br>2. Dokter<br>3. Karu<br>4. IPCLN/IPCN | Satu bulan |

3.6.1.1.4 ISK

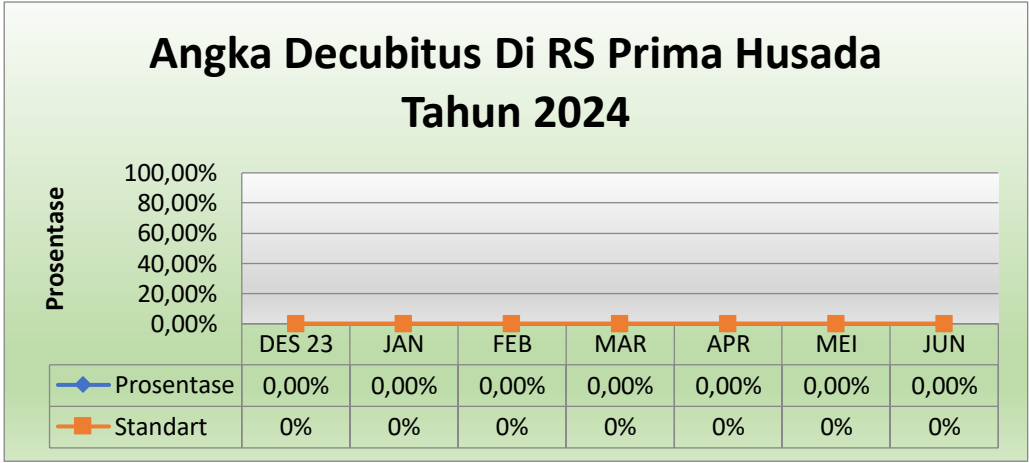
3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



|                                   |                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| PLAN                              | Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            |
| DO                                | Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            |
| STUDY                             | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 974 hari lama pemakaian kateter pasien. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            |
| ACTION/RTL                        | TUJUAN                                                                                      | SASARAN                                                               | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PELAKSANA                                                  | WAKTU      |
| Pertahankan kepatuhan bundle ISK. | Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.                              | Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya. | 1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan.<br>2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter.<br>3. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter.<br>4. Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine. | 1. Perawat /Bidan<br>2. Dokter<br>3. Karu<br>4. IPCLN/PCPN | Satu bulan |

3.6.1.1.5 Decubitus

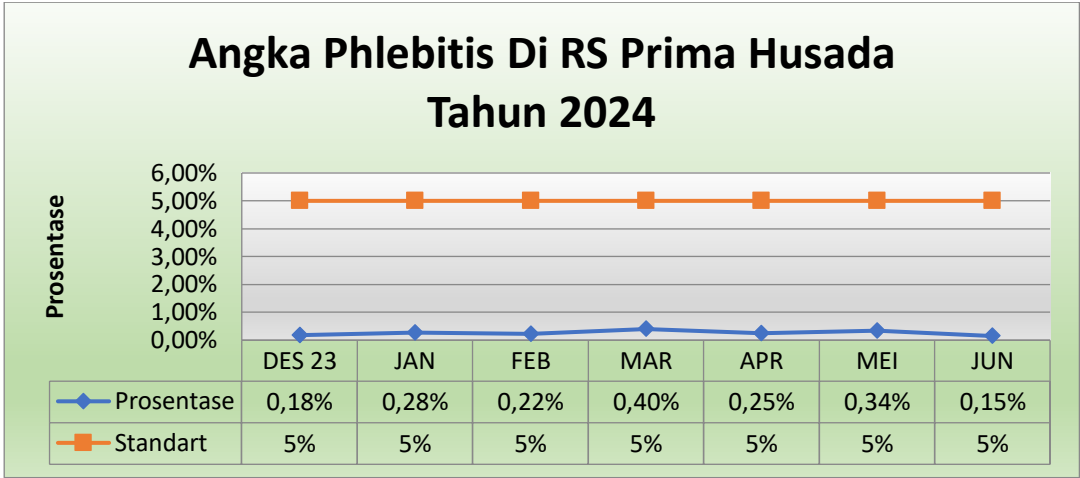
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



|                                             |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| PLAN                                        | Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| DO                                          | Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| STUDY                                       | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 10 pasien tirah baring lama (>3x24 jam). |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |            |
| ACTION/RTL                                  | TUJUAN                                                                                       | SASARAN                                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PELAKSANA                                     | WAKTU      |
| Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus. | Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.                     | Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya. | 1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan.<br>2. Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki).<br>3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus.<br>4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.<br>5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar. | 1. Perawat /Bidan<br>2. Karu<br>3. IPCLN/PCPN | Satu bulan |

3.6.1.1.6 Phlebitis

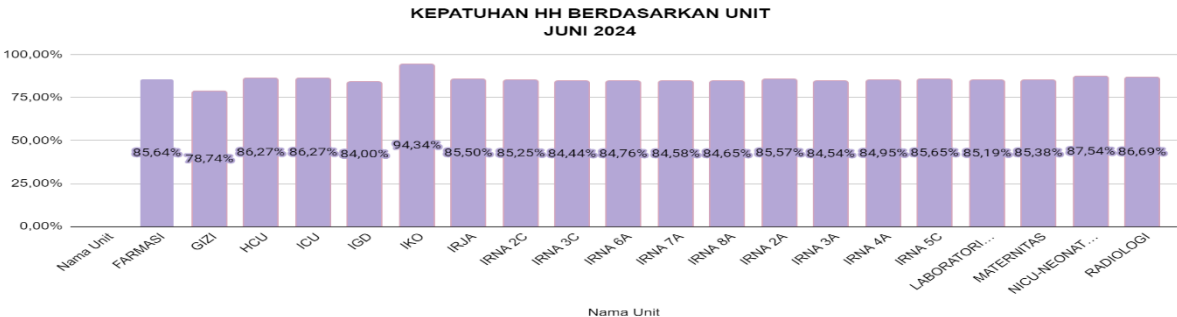
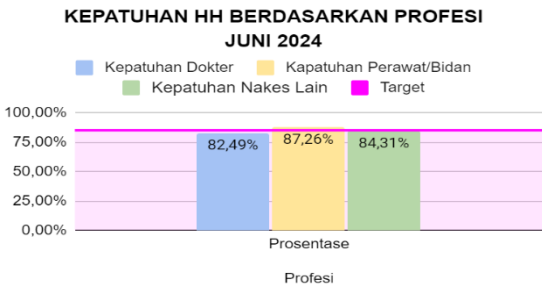
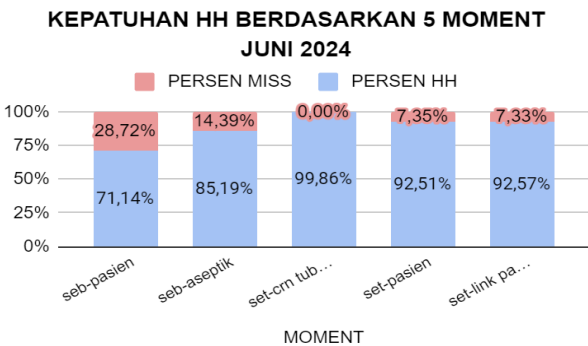
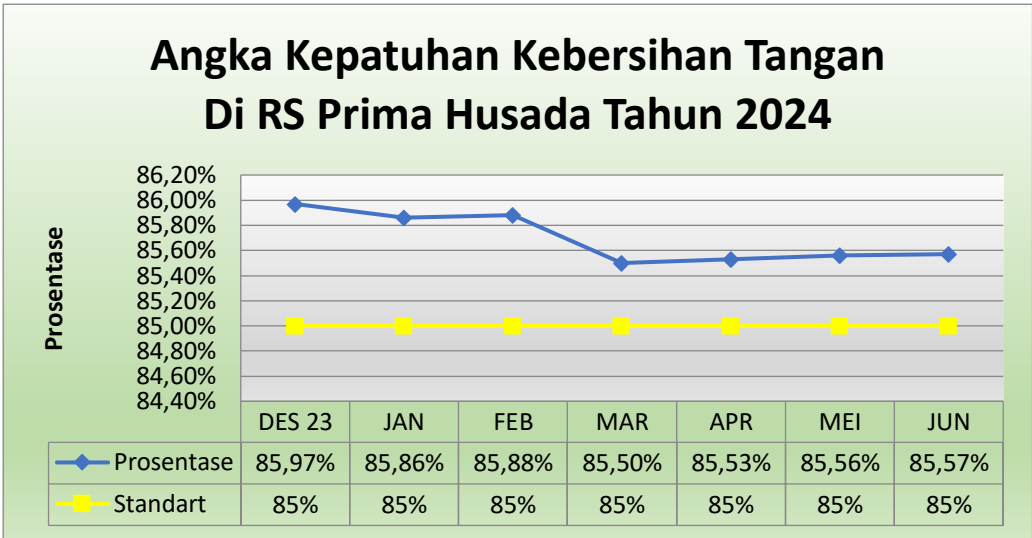
3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



| PLAN                                    | Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| DO                                      | 1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO.<br>2. Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar.<br>3. Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus.<br>4. Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptic saat penyuntikan.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |
| STUDY                                   | Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2721 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,15%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 2 dari 4 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien yang mendapat cairan/obat yang konsentrasinya lebih pekat (NS 3%) dan transfuse darah. 3 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien lansia dimana pembuluh darah pasien cenderung lebih rentan phlebitis dan mendapatkan injeksi antibiotic.<br>Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis). |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |
| ACTION/RTL                              | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SASARAN                                                                     | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PELAKSANA                                                  | WAKTU      |
| Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis. | Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya. | 1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan.<br>2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus.<br>3. Monitoring teknik aseptic dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus.<br>4. Monitoring penyuntikan yang aman.<br>5. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic.<br>6. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.<br>7. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. | 1. Perawat /Bidan<br>2. Dokter<br>3. Karu<br>4. IPCLN/PCPN | Satu bulan |

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)

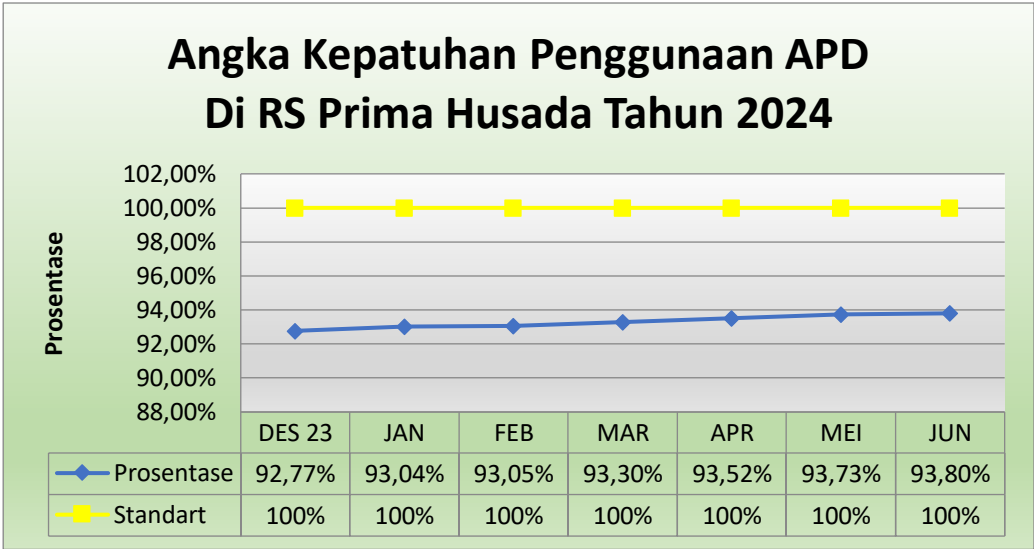


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DO    | <div>1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit.</div> <div>2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya.</div> <div>3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan.</div> <div>4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan.</div> <div>5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STUDY | Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,57%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (82,49%) dan nakes lain (84,31%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (71,14%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter. |

| ACTION/RTL                      | TUJUAN                                    | SASARAN                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Meningkatkan kebersihan tangan. | Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan. | Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%. | 1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan.<br>2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.<br>3. Memberikan reward-pembelajaran.<br>4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.<br>5. Mengingatnkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

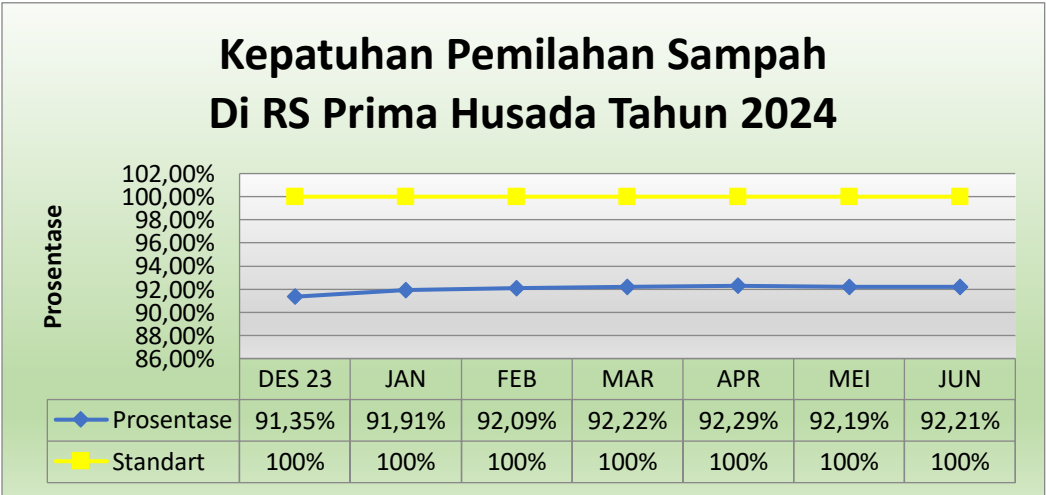
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN  | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DO    | 1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai.<br>2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.<br>3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.<br>4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD.<br>5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. |
| STUDY | Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,80% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit sudah mulai sedikit paham dan bisa menggunakan                                                                                                           |

|                                       | APD yang sesuai.                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ACTION/RTL                            | TUJUAN                                        | SASARAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD. | Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit. | Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya. | 1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD.<br>2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya.<br>3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.<br>4. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan. | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

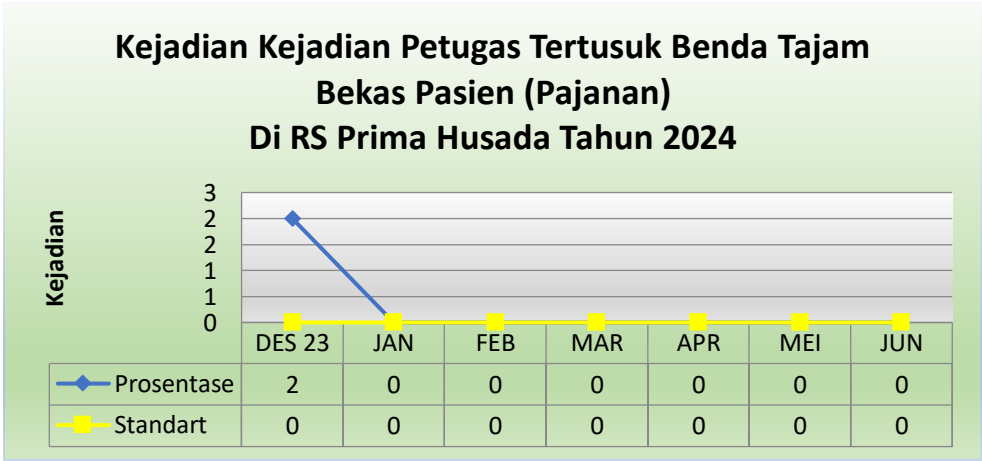
3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius  
 3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| PLAN                                          | Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| DO                                            | 1. Melakukan supervise terkait pemilahan pembuangan sampah di unit pelayanan pasien.<br>2. Melakukan supervise terkait pembuangan sampah di ruang TPS B3.<br>3. Melakukan sosialisasi pemilahan sampah yang yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.<br>4. Menegur langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar.     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| STUDY                                         | Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,19%, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan kesalahan pemilahan sampah terutama pada sampah infeksius dimana ditemukan ujung tajam selang infus tidak dibuang disafety box. Selain itu juga ditemukan bungkus-bungkus alkes yang seharusnya dibuang di sampah non infeksius dibuang di sampah infeksius. |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |            |
| ACTION/RTL                                    | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SASARAN                                                                                 | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PELAKSANA                                       | WAKTU      |
| Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit. | Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tercapainya kepatuhan pemilahan sampah unit minimal meningkat 3% pada bulan berikutnya. | 1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah.<br>2. Menegur langsung petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan.<br>3. Menyampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA. | Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS. | Satu bulan |

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------|
| PLAN       | Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           |       |
| DO         | 1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM.<br>2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan.<br>3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman.<br>4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan. |         |          |           |       |
| STUDY      | Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           |       |
| ACTION/RTL | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN | STRATEGI | PELAKSANA | WAKTU |

|                             |                                                     |                                                         |                                                                                                                              |                                  |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Melakukan penyuntikan aman. | Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian. | Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya. | Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. | Seluruh petugas pelayanan di RS. | Satu bulan |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

| NO | UNIT          | TARGET   | APRL | MEI  | JUN  | %              | MANDOK | KETERANGAN |
|----|---------------|----------|------|------|------|----------------|--------|------------|
| 1  | IRNA 2C       | 8x/Bulan | 75%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 2  | ICU HCU       | 8x/Bulan | 0%   | 25%  | 50%  | Belum Tercapai | Ada    |            |
| 3  | IRNA 3C       | 8x/Bulan | 100% | 75%  | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 4  | MATERNITAS    | 8x/Bulan | 75%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 5  | PERINATOLOGI  | 8x/Bulan | 75%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 6  | IRNA 5C       | 8x/Bulan | 25%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 7  | IRNA 2A,3A,4A | 8x/Bulan | 50%  | 50%  | 75%  | Belum Tercapai | Ada    |            |
| 8  | IRNA 6A,7A,8A | 8x/Bulan | 100% | 75%  | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 9  | IGD           | 8x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 10 | FARMASI       | 8x/Bulan | 25%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 11 | GIZI          | 8x/Bulan | 100% | 100% | 75%  | Belum Tercapai | Ada    |            |
| 12 | IRJA          | 8x/Bulan | 75%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |
| 13 | PPI           |          | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |            |

**Analisis** : Unit mengalami kenaikan produktivitas dalam melakukan edukasi kelompok.

**Rencana Tindak Lanjut** : Koordinasi dengan Kepala Ruang dan Kepala Bidang Keperawatan Lanjut

3.6.3.2 KIE Individu

| NO | UNIT          | TARGET | APRL | MEI  | JUN  | %    | KETERANGAN |
|----|---------------|--------|------|------|------|------|------------|
| 1  | IRNA 2C       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 2  | ICU HCU       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 3  | IRNA 3C       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 4  | MATERNITAS    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 5  | PERINATOLOGI  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 6  | IRNA 5C       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 7  | IRNA 2A,3A,4A | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 8  | IRNA 6A,7A,8A | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 9  | IGD           | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 10 | FARMASI       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 11 | GIZI          | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |
| 12 | IRJA          | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |            |

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

| NO | LEMBAR DRM                           | JML SAMPLE | KELENGKAPAN |       | ISI BENAR  | VERIFIKASI KE PASIEN | KET                                            |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|----------------------|------------------------------------------------|
|    |                                      |            | YA          | TIDAK |            |                      |                                                |
| 1  | General Consent                      | 14         | 14          |       | Isi sesuai | Ya                   | - -                                            |
| 2  | SBAR                                 | 14         | 14          |       | Isi sesuai | Ya                   | -                                              |
| 3  | Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan | 14         | 13          | 1     | Isi sesuai | Ya                   | Ketidaklengkapan pengisian nana terang petugas |
| 4  | Pengkajian                           | 14         | 14          |       | Isi        | Ya                   |                                                |

|    |                                                                |    |    |   |            |    |                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|----|----|---|------------|----|------------------------------------------------------------------------|
|    | Kebutuhan KIE                                                  |    |    |   | sesuai     |    |                                                                        |
| 5  | KIE Informed Consent                                           | 14 | 14 |   | Isi sesuai | Ya |                                                                        |
| 6  | CPPT                                                           | 14 | 14 |   | Isi sesuai | Ya | -                                                                      |
| 7  | Ringkasan Pasien Pulang                                        | 14 | 14 |   | Lengkap    | Ya | Rencana edukasi berkelanjutan kembali lagi ke rs.                      |
| 8  | Discharged Planning                                            | 7  | 7  |   | Lengkap    | Ya |                                                                        |
| 9  | Edukasi kolaborasi                                             | 13 | 13 | 1 | Isi sesuai | Ya | Perawat tidak mengisi edukasi kolaborasi , hanya ahli gizi dan farmasi |
| 11 | KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal) | 1  | 1  |   | Isi sesuai |    |                                                                        |
| 12 | Form AMA                                                       | 14 | 14 |   | Isi Sesuai | Ya |                                                                        |
| 13 | Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien              | 14 | 14 |   | Isi Sesuai | Ya |                                                                        |
| 14 | KIE Pre OP di Lembar Pre OP                                    | 4  | 4  |   | Isi Sesuai | Ya |                                                                        |

**Analisis** : Seluruh DRM edukasi terisi , terdapat beberapa ketidaklengkapan meliputi kekurangan pada penulisan nama petugas pemberi KIE , kekurangan pada isi yang kurang lengkap di perencanaan edukasi .

**Rencana Tindak Lanjut** : -

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

| NO | UNIT                                 | TARGET    | KEGIATAN         | APR  | MEI  | JUN  | %        | MANDOK     | KET  |
|----|--------------------------------------|-----------|------------------|------|------|------|----------|------------|------|
| 1  | Komunitas Geriatri                   | 2X/Bulan  | Senam            | 100% | 50%  | 100% | Tercapai | Ada        | 100% |
|    |                                      |           | Hypnoterapi      |      |      |      |          |            |      |
|    |                                      |           | KIE              |      |      |      |          |            |      |
| 2  | Komunitas Ibu Hamil                  | 2X/Bulan  | Senam            | 100% | 50%  | 100% | Tercapai | Ada        | 100% |
|    |                                      |           | Hypnoterapi      |      |      |      |          |            |      |
|    |                                      |           | KIE              |      |      |      |          |            |      |
| 3  | Komunitas Shirothul Jannah Perempuan | 2X/Bulan  | Pengajian        | 100% | 100% | 100% | Tercapai | Ada        | 100% |
|    |                                      |           | Karya wisata     |      |      |      |          |            |      |
| 4  | Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki | 2X/Bulan  | Pengajian        | 100% | 100% | 100% | Tercapai | Ada        | 100% |
| 5  | Bimbingan Doa                        | 8X/Bulan  | Mendoakan Pasien | 100% | 100% | 100% | 100%     | Ada        | 100% |
| 6  | General Meeting Karyawan             | 1x/2Bulan |                  | 100% |      | 100% |          | Terlaksana | 100% |
| 7  | Pembinaan Fatayat                    | 1X/Tahun  |                  |      |      |      |          |            |      |

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

| NO | UNIT                                      | TARGET   | APR | MEI | JUN | %  | MANDOK | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|----|--------|------------|
| 1  | PONEK                                     | 4X/Bulan | 0%  | 0%  | 0%  | 0% |        |            |
| 2  | HIV                                       | 4X/Bulan | 0%  | 0%  | 0%  | 0% |        |            |
| 3  | STUNTING dan WASTING                      | 4X/Bulan | 0%  | 0%  | 0%  | 0% |        |            |
| 4  | KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA) | 4X/Bulan | 0%  | 0%  | 0%  | 0% |        |            |
| 5  | TB DOTS                                   | 4X/Bulan | 0%  | 0%  | 0%  | 0% |        |            |

**Analisis** : Penanggungjawab PROGNAS Inaktif selama Tahun 2024 tidak melakukan kegiatan edukasi kelompok

**Rencana Tindak Lanjut** : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

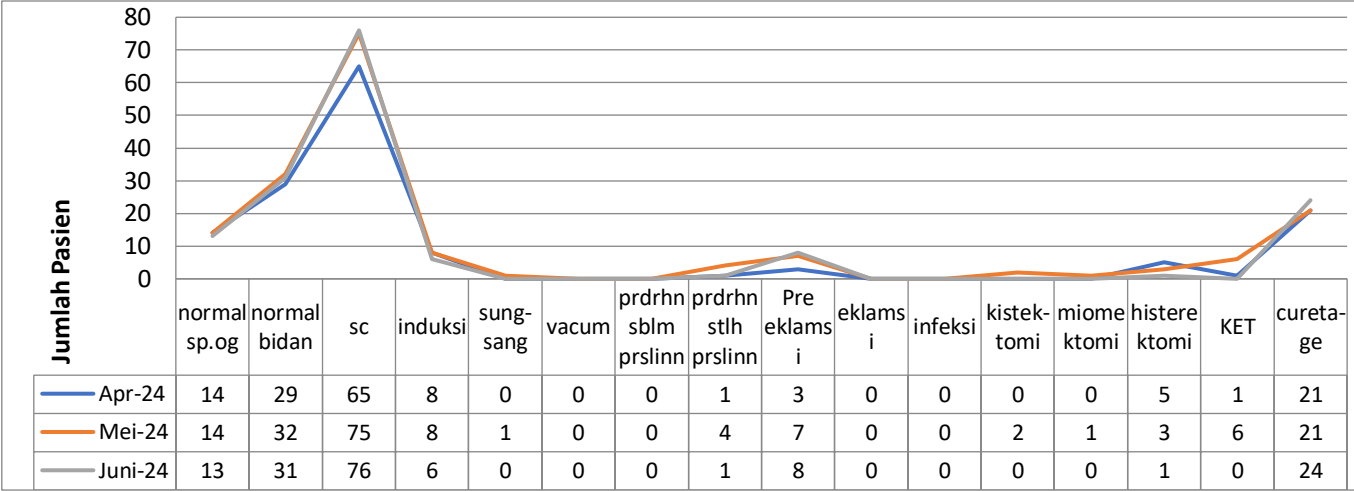
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Mei 2024

| NO | JENIS PELAYANAN                  | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                                  | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | Persalinan                       |                  |                |                 |
|    | a. Persalinan Normal Sp. OG      | 14               | 14             | 13              |
|    | b. Persalinan Normal Bidan       | 29               | 32             | 31              |
|    | c. <i>SectioCaesaria</i>         | 65               | 75             | 76              |
| 2  |                                  |                  |                |                 |
|    | a. Induksi / Drip                | 8                | 8              | 6               |
|    | b. Sungsang                      | 0                | 1              | 0               |
|    | c. Vacuum                        | 0                | 0              | 0               |
| 3  |                                  |                  |                |                 |
|    | a. Perdarahan sebelum Persalinan | 0                | 0              | 0               |
|    | b. Perdarahan setelah Persalinan | 1                | 4              | 1               |
|    | c. Pre Eklamsi                   | 3                | 7              | 8               |
|    | d. Eklamsi                       | 0                | 0              | 0               |
|    | e. Infeksi                       | 0                | 0              | 0               |
| 4  |                                  |                  |                |                 |
|    | a. Curretage                     | 21               | 21             | 24              |
|    | b. Kistektomi                    | 0                | 2              | 0               |
|    | c. Miomektomi                    | 0                | 1              | 0               |
|    | d. Histerectomy                  | 5                | 3              | 1               |
|    | e. KET                           | 1                | 6              | 0               |

3.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Juni 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 76 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan Juni 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 13 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 31 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada Persalinan sungsang pada bulan April dan Juni 2024 sedangkan pada bulan Mei ada 1 persalinan sungsang. Sedangkan untuk persalinan dengan vacuum pada bulan April sampai dengan Juni 2024 tidak ada.
4. Induksi Persalinan pada bulan Juni mengalami penurunan yaitu 6 pasien, sedangkan pada bulan April dan Mei sebanyak 8 pasien.
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juni 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 8 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan April sampai dengan Juni 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan Juni sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 24 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

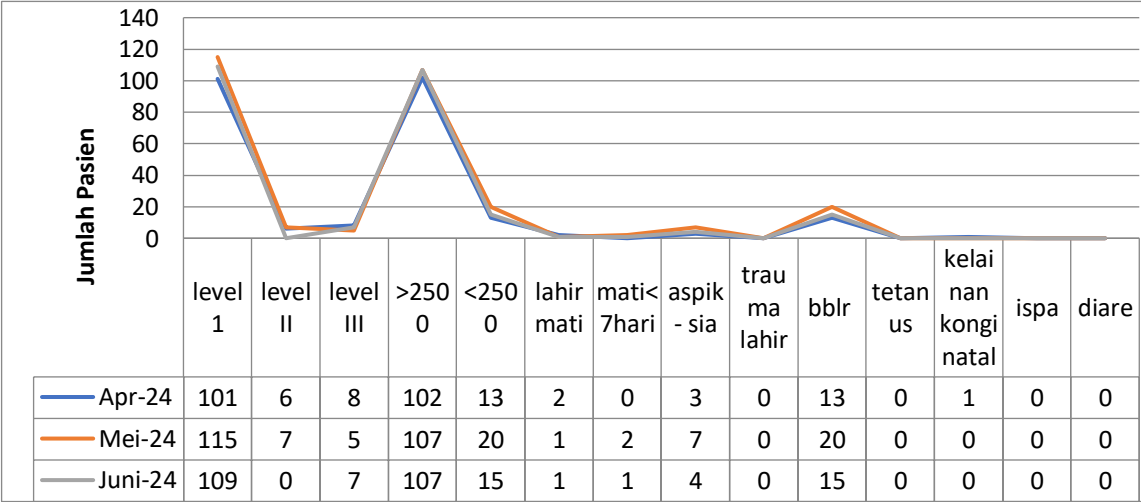
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек Juni 2024

| NO | JENIS PELAYANAN           | JUMLAH PASIEN          |                      |                       |
|----|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|    |                           | BULAN<br>APRIL<br>2024 | BULAN<br>MEI<br>2024 | BULAN<br>JUNI<br>2024 |
| 1  |                           |                        |                      |                       |
|    | a. Level 1                | 101                    | 115                  | 109                   |
|    | b. Level II               | 0                      | 7                    | 6                     |
|    | c. Level III              | 8                      | 5                    | 7                     |
| 2  |                           |                        |                      |                       |
|    | a. ≥ 2500 gram            | 102                    | 107                  | 107                   |
|    | b. ≤ 2500 gram            | 13                     | 20                   | 15                    |
| 3  |                           |                        |                      |                       |
|    | a. Kelahiran Mati         | 2                      | 1                    | 1                     |
|    | b. Mati Neonatal < 7 Hari | 0                      | 2                    | 1                     |
| 4  |                           |                        |                      |                       |
|    | a. Asphyxia               | 3                      | 7                    | 4                     |
|    | b. Trauma Kelahiran       | 0                      | 0                    | 0                     |
|    | c. BBLR                   | 13                     | 20                   | 15                    |
|    | d. Tetanus Neonatorum     | 0                      | 0                    | 0                     |
|    | e. Kelainan Congenital    | 1                      | 0                    | 0                     |
|    | f. ISPA                   | 0                      | 0                    | 0                     |
|    | g. DIARE                  | 0                      | 0                    | 0                     |
| 5  | Lain-lain                 | 0                      | 0                    | 0                     |

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 109 bayi. Dan pada level 2 tidak ada. Sedangkan pada level 3 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Mei dan Juni 2024 tetap sebanyak 107 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

4. Kasus BBLR pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 15 bayi.
5. Kasus kelahiran mati pada bulan Mei maupun Juni tetap yaitu sebanyak 1 kasus
6. Masih ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Juni menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1 kasus

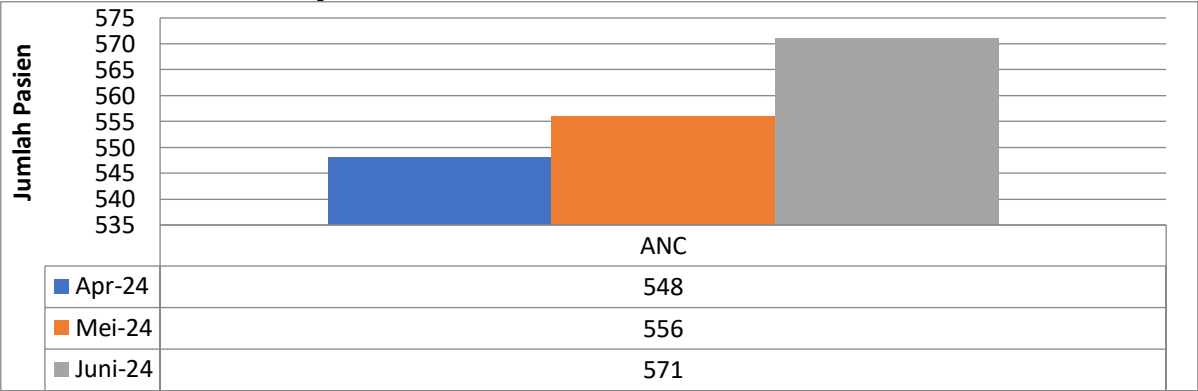
**Rencana dan Tindak Lanjut**

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

**3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)**  
**Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek RSPHM Juni 2024**

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH              |                   |                    |
|----|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|    |                 | BULAN<br>APRIL 2024 | BULAN<br>MEI 2024 | BULAN<br>JUNI 2024 |
| 1  | ANC             | 548                 | 556               | 571                |

**Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Juni 2024**

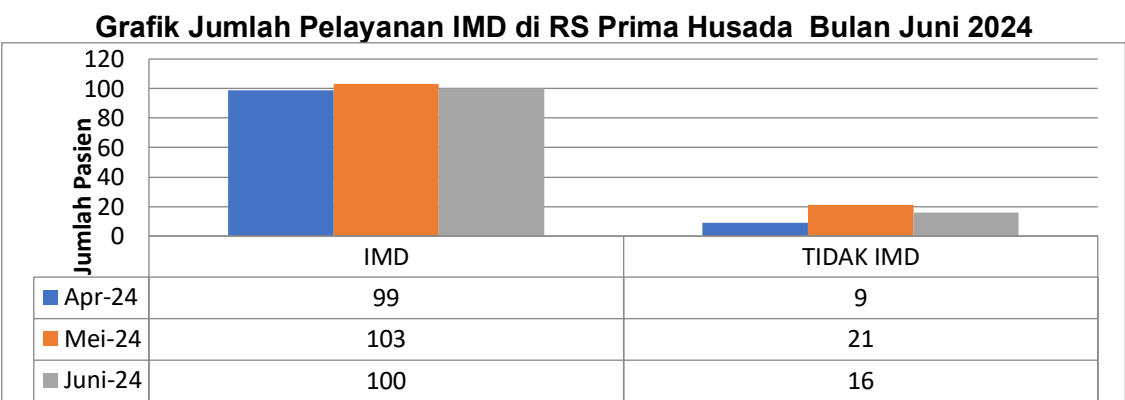


**Analisis :**  
Pelayanan ANC pada bulan Juni 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 571 kunjungan.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

**3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)**  
**Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Juni 2024**

| NO | URAIAN    | JUMLAH PASIEN          |                      |                       |
|----|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|    |           | BULAN<br>APRIL<br>2024 | BULAN<br>MEI<br>2024 | BULAN<br>JUNI<br>2024 |
| 1  | IMD       | 99                     | 103                  | 100                   |
| 2  | Tidak IMD | 9                      | 21                   | 16                    |

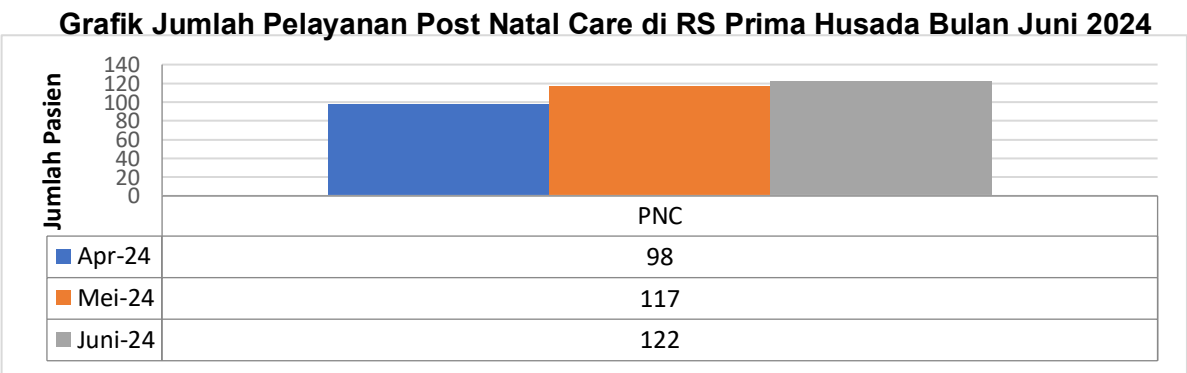


- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 100 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
  - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
  - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

**3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)**  
**Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Juni 2024**

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH           |                |                 |
|----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                 | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | PNC             | 98               | 117            | 122             |



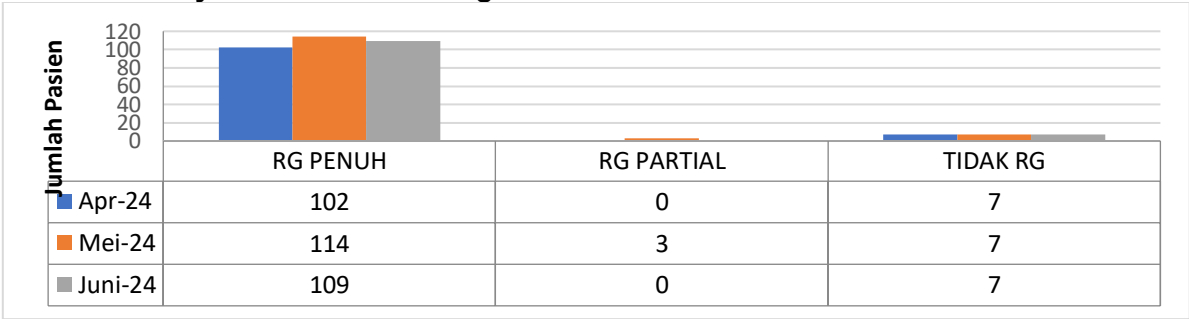
**Analisis :**  
Pelayanan PNC pada bulan Juni 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 122 kunjungan.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung  
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponек Juni 2024

| NO | URAIAN               | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                      | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | Rawat gabung penuh   | 102              | 114            | 109             |
| 2  | Rawat gabung partial | 0                | 3              | 0               |
| 3  | Tidak Rawat gabung   | 7                | 7              | 7               |

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 109 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juni dan 2 bulan sebelumnya sama, yaitu sebanyak 7 bayi.
- 3. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

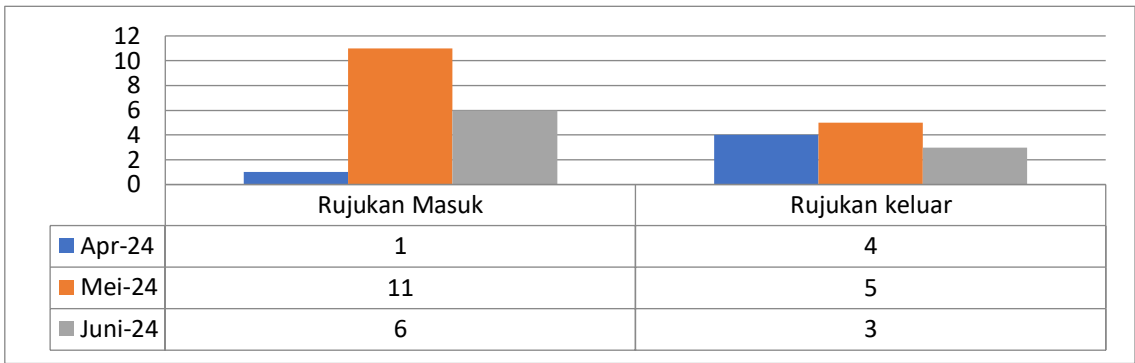
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan  
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Junii 2024

| NO | RUJUKAN        | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
|----|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Rujukan Masuk  | 1                | 11             | 6               |
| 2  | Rujukan keluar | 4                | 5              | 3               |

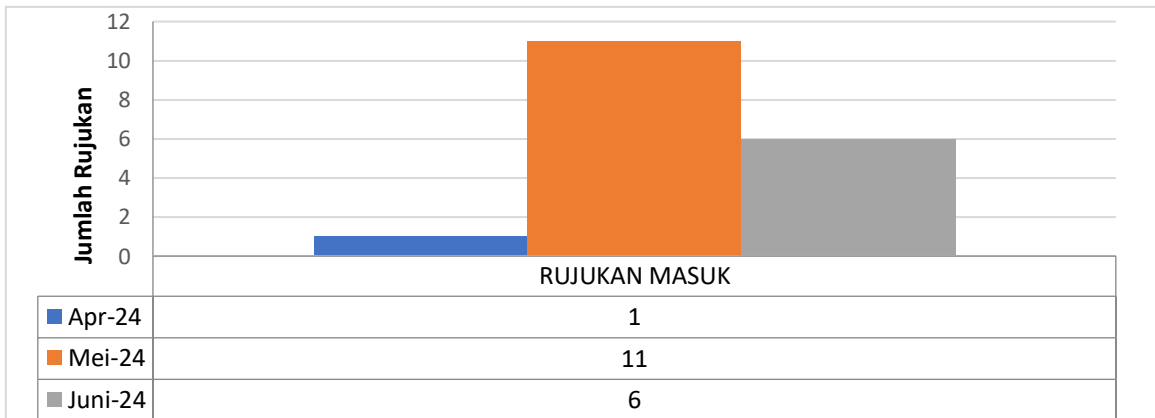
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juni 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk  
Tabel Rujukan Masuk Ponек Juni 2024

| BULAN APRIL 2024 |                                                    |                      |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1                | G1 P0000 ab000 UK 38-39 mgg dg PEB                 | BPM Sofia            |
| 2                | G1 P0000 ab000 UK 38-39 mgg dg PEB                 | BPM Sofia            |
| BULAN MEI 2024   |                                                    |                      |
| 1                | G1 P0000 Ab000 Uk 35-36 mgg dg PPR0M               | RS Permata Bunda     |
| 2                | Late HPP + Iekosinosis + anemia                    | PKM Pakis            |
| 3                | G2 P1001 ab000 Uk 35-36 mgg dg PPI + letak lintang | RS Munir             |
| 4                | G3 P2002 Ab000 Uk 32-33 mgg dg BSC 2x              | BPM Indah M          |
| 5                | G2 P0000 Ab000 Uk 30 mgg dg PPI                    | RS Permata Bunda     |
| 6                | G2 P1001 ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama         | PKM Ardimulyo        |
| 7                | G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama         | BPM Tri Widiyawati   |
| 8                | G1 P0000 Ab000 Uk 28-30 mgg dg Gemeli + PPI        | BPM Nuri Afanti      |
| 9                | G3 P2002 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama         | BPM Suma'iyah        |
| 10               | KET + ANEMIA                                       | Klinik Putra Husada  |
| 11               | G1 P0000 ab000 Uk 32-34 mgg dg KIFL + PPI          | Rs Permata Bunda     |
| BULAN JUNI 2024  |                                                    |                      |
| 1                | G3 P2002 Ab000 UK 31-32 mgg dg PEB + PPI + PTS     | RS Permata Bunda     |
| 2                | G3 P2002 Ab000 UK 12-14 mgg dg HEG                 | Klinik Mutiara Sehat |
| 3                | G2 P1001 Ab000 UK 40 – 41 mgg dg PE                | BPM Indah M          |
| 4                | G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg kala 2 lama         | BPM Tri Widiyawati   |
| 5                | G4 P0302 Ab000 UK 28-30 mgg dg Letsu + BSC + KIFA  | BPM Dillah Sobirin   |
| 6                | G3 P1001 Ab100 UK 39-40 mgg dg Kala 1 fase aktif   | BPM Susmui           |

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Juni 2024



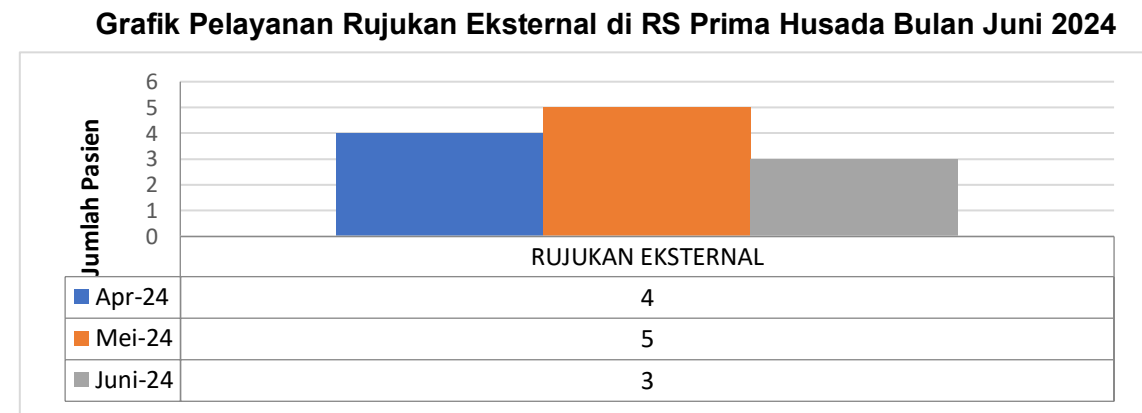
**Analisis :**  
Jumlah rujukan masuk pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar  
Tabel Rujukan Keluar Ponek Juni 2024

| BULAN APRIL 2024 |                                                          |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                | RDS+HMD dd Neonatal Pneumonia                            | RS Lavalette       |
| 2                | RDS dd HMD + BBLSR                                       | RS Lavalette       |
| 3                | RDS + Prematur + BBLSR                                   | RS Saiful Anwar    |
| 4                | Akut Abdomen + kista ovarium curiga ganas                | RS Saiful Anwar    |
| BULAN MEI 2024   |                                                          |                    |
| 1                | G4 P2012 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Gemeli + PE + edema paru  | RS Saiful Anwar    |
| 2                | G4 P2002 Ab000 UK 28-30 mgg dg Inpending Eklamsia        | RS Saiful Anwar    |
| 3                | Prematur BBLASR + RDS okHMD dd Neonatal Pneumonia        | RS Saiful Anwar    |
| 4                | Post Op Eksplorasi Laparatomi + CKD                      | RS Saiful Anwar    |
| 5                | Neonatal seizure                                         | Rs Soepraoen       |
| BULAN JUNI 2024  |                                                          |                    |
| 1                | G1 P0000 Ab000 Uk 37-38 mgg dg Kala 2 + letak Sungsang   | RS Prasetya Husada |
| 2                | G3 P0101 Ab000 Uk 32-34 mgg dg PPI + DF+ Trombositopenia | RS Saiful Anwar    |
| 3                | RDS + BBLR                                               | RS Saiful Anwar    |



Analisis :

Pada bulan Jun 2024 pasien yang dirujuk keluar meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan Sebelumnya, yaitu 3 pasien.

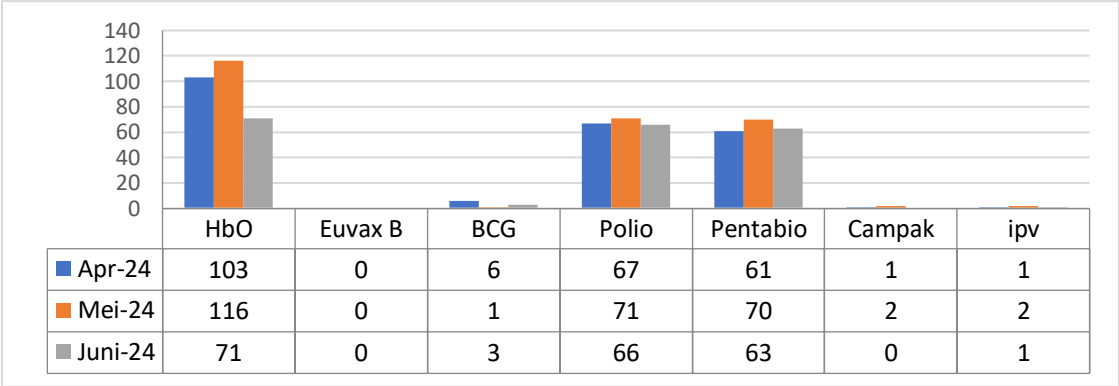
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi  
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juni 2024

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH           |                |                 |
|----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                 | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | HbO             | 103              | 116            | 71              |
| 2  | Euvax B         | 0                | 0              | 0               |
| 3  | BCG             | 6                | 1              | 3               |
| 3  | Polio           | 67               | 71             | 66              |
| 4  | Pentabio        | 61               | 70             | 63              |
| 5  | Campak          | 1                | 2              | 0               |
| 6  | IPV             | 1                | 2              | 1               |

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juni 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan Juni mengalami penurunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 71 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juni sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juni 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 3 pasien.
- 5. Pada periode Juni 2024 tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 66 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 63 pasien

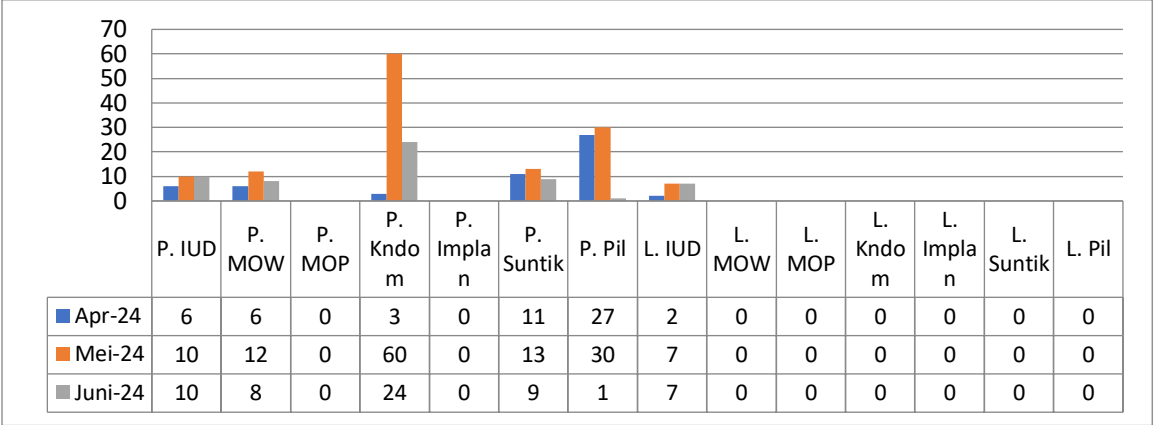
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)  
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Junii 2024

| NO | JENIS    | JUMLAH PASANG    |                |                 | JUMLAH LEPAS     |                |                 |
|----|----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |          | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | IUD      | 6                | 10             | 10              | 2                | 7              | 7               |
| 2  | MOW      | 6                | 12             | 8               | 0                | 0              | 0               |
| 3  | MOP      | 0                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               |
| 4  | Kondom   | 3                | 60             | 24              | 0                | 0              | 0               |
| 5  | Implant  | 0                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               |
| 6  | Suntikan | 11               | 13             | 9               | 0                | 0              | 0               |
| 7  | Pil      | 27               | 30             | 1               | 0                | 0              | 0               |

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Mei dan Juni 2024 tetap sebanyak 10 akseptor yang terdiri dari 6 akseptor IUD Nova T dan 4 akseptor IUD copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu hanya 24 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 1 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juni 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 penggunaan

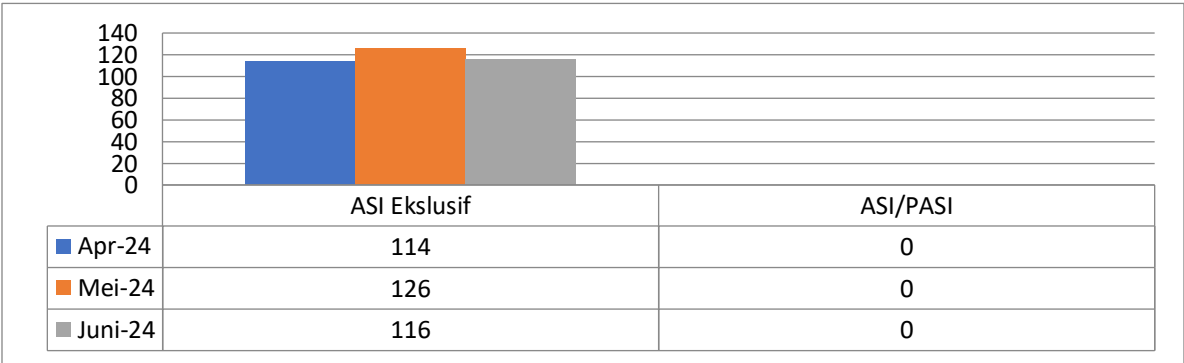
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif  
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek Mei 2024

| NO | PEMBERIAN ASI | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|---------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |               | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | Asi eksklusif | 114              | 126            | 116             |
| 2  | Asi /PASI     | 0                | 0              | 0               |

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juni mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 116 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

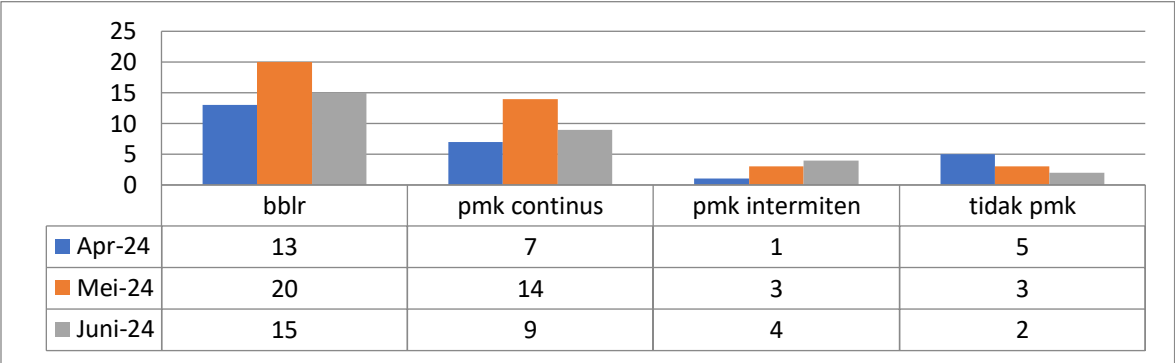
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek RSPHM Juni 2024

| NO | URAIAN         | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | Bayi BBLR      | 13               | 20             | 15              |
| 2  | PMK continuos  | 7                | 14             | 9               |
| 3  | PMK Intermiten | 1                | 3              | 4               |
| 4  | Tidak PMK      | 5                | 3              | 2               |

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juni 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menjadi 4 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 9 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan terdapat 2 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Juni 2024, dan menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

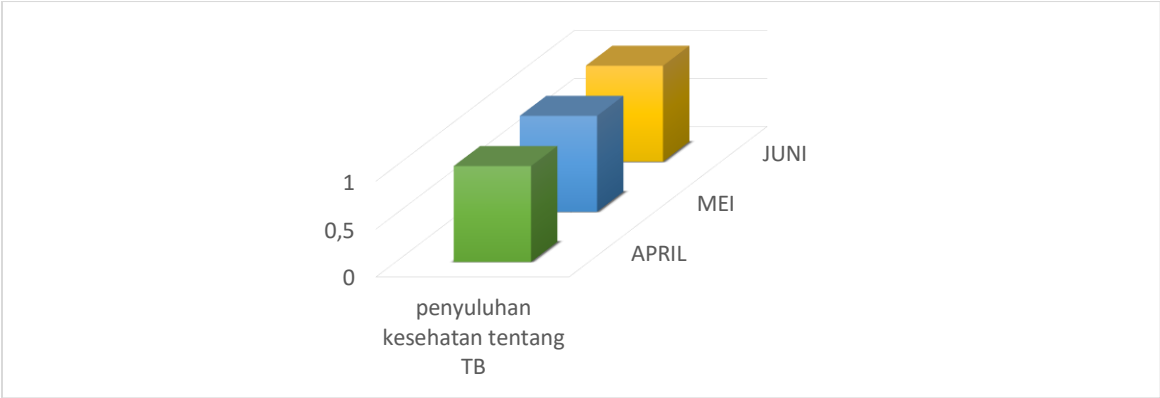
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

3.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

| NO | JENIS PELAYANAN                           | JUMLAH KEGIATAN |     |      |
|----|-------------------------------------------|-----------------|-----|------|
|    |                                           | APRIL           | MEI | JUNI |
| 1  | Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis | 1               | 1   | 1    |

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



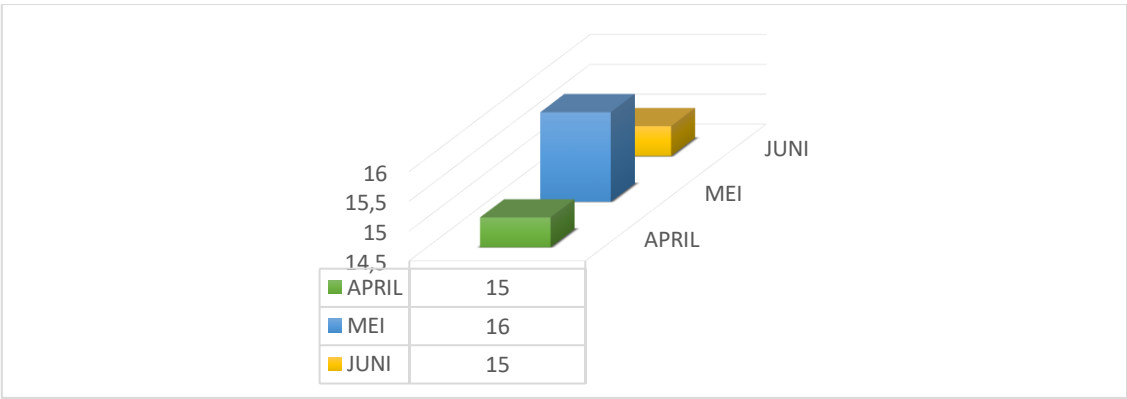
**Analisis:**  
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

**Rencana dan Tindak Lanjut:**  
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

| NO | JENIS SKRINING   | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|------------------|---------------|-----|------|
|    |                  | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pemberian Masker | 15            | 16  | 15   |

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



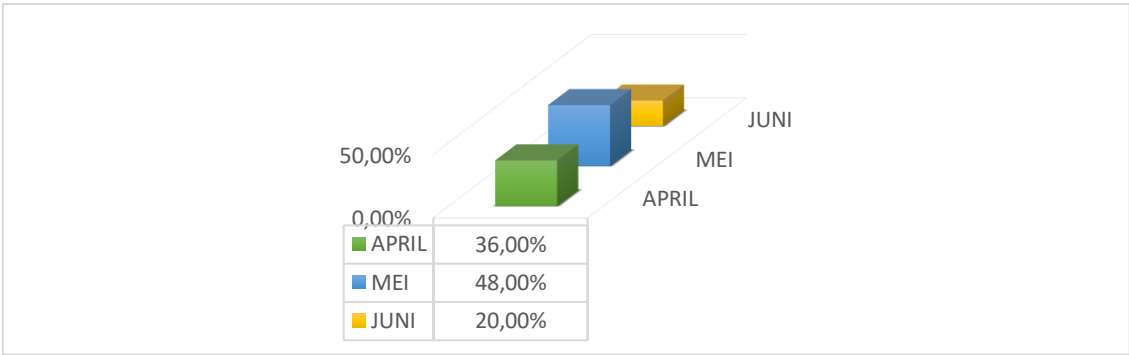
- Analisis :**
- 1. Pada bulan April 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
  - 2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
  - 3. Pada bulan Juni 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
  - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

**3.1.2.2.3      Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis**

| NO | JENIS SKRINING                                                | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|
|    |                                                               | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis | 36            | 49  | 20   |

**Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada**



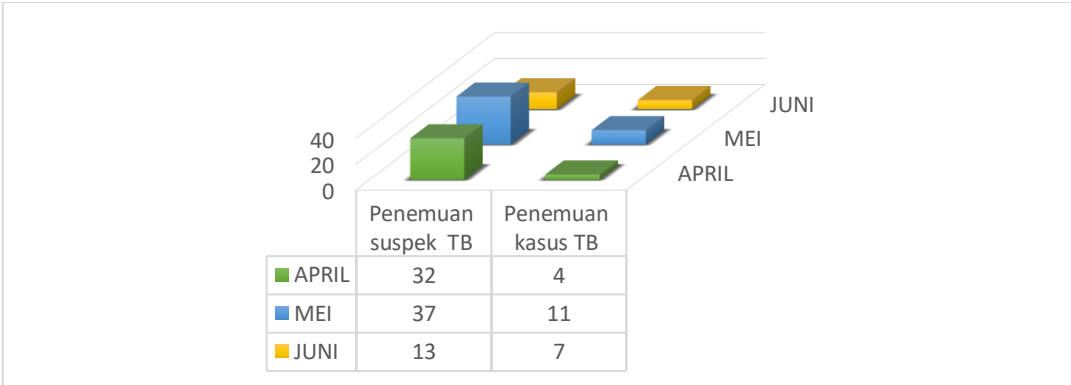
- Analisis :**
- 1. Pada bulan April 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36
  - 2. Pada bulan Mei 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 48
  - 3. Pada bulan Juni 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 20

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

**3.1.2.2.4      Penemuan Kasus TB**

| NO | KEGIATAN           | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|--------------------|---------------|-----|------|
|    |                    | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Penemuan suspek TB | 32            | 37  | 13   |
| 2  | Penemuan kasus TB  | 4             | 11  | 7    |

**Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada**



**Analisis :**

- 1. Pada bulan April 2024 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
- 2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 37 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 11 pasien
- 3. Pada bulan Juni 2024 terdapat 13 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 7 pasien

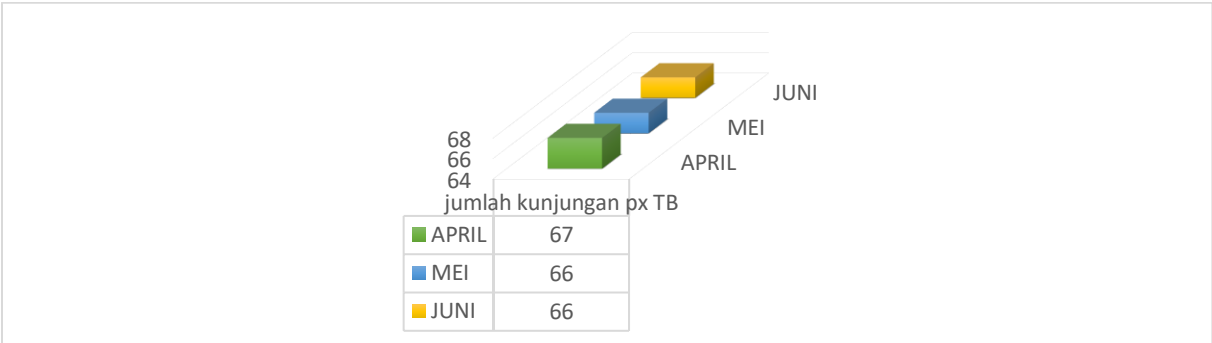
**Rencana dan Tindak Lanjut:**

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

**3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB**

| NO | KEGIATAN                        | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|---------------------------------|---------------|-----|------|
|    |                                 | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pasien TB Kunjungan Keseluruhan | 67            | 66  | 66   |

**Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada**



**Analisis:**

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan APRIL 2024 di poli pasien TBC mencapai 67 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan MEI 2024 di poli pasien TBC mencapai 66 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan JUNI 2024 di poli pasien TBC mencapai 66 pasien.

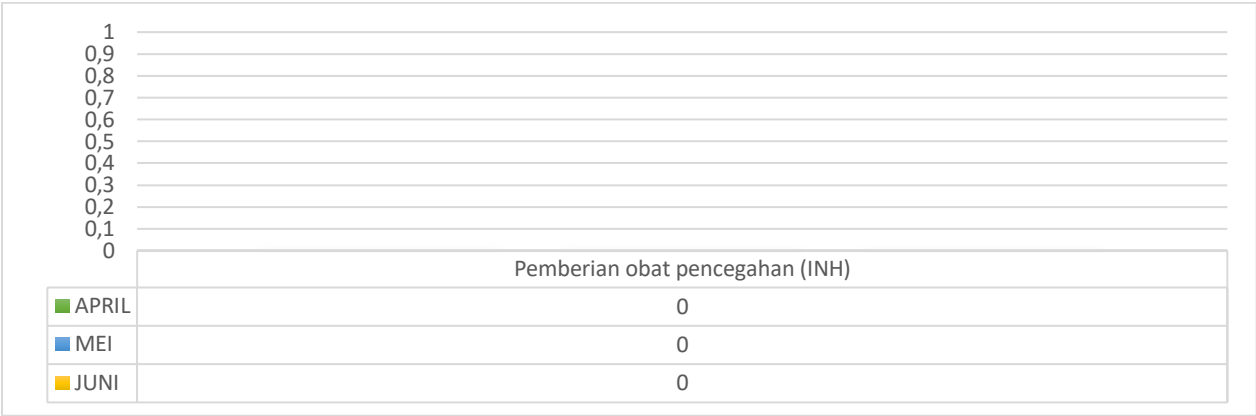
**Rencana dan Tindak Lanjut :**

Meningkatkan kunjungan pasien

**3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan**

| NO | KEGIATAN                        | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|---------------------------------|---------------|-----|------|
|    |                                 | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pemberian obat pencegahan (INH) | 0             | 0   | 0    |

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



**Analisis :**  
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

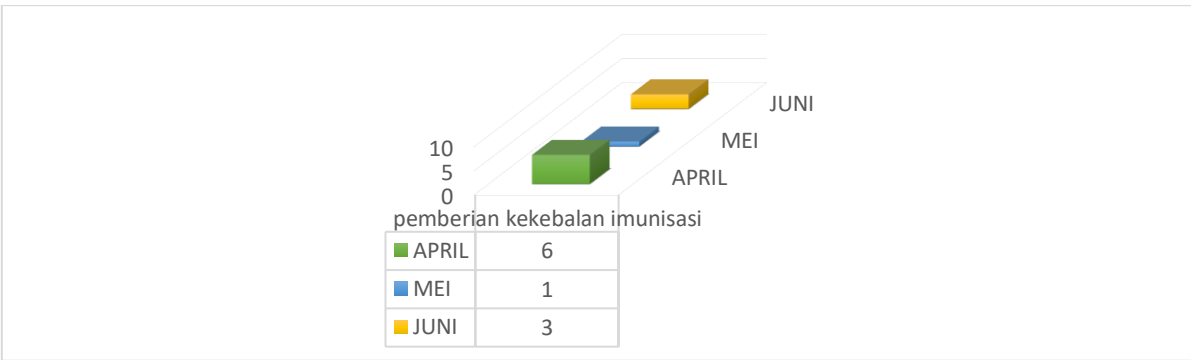
**Rencana dan Tindak Lanjut**

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

**3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG**

| NO | KEGIATAN                | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|-------------------------|---------------|-----|------|
|    |                         | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pemberian imunisasi BCG | 6             | 1   | 3    |

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



- Analisis :**
1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 6 pasien yang diimunisasi pada bulan April
  2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
  3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni

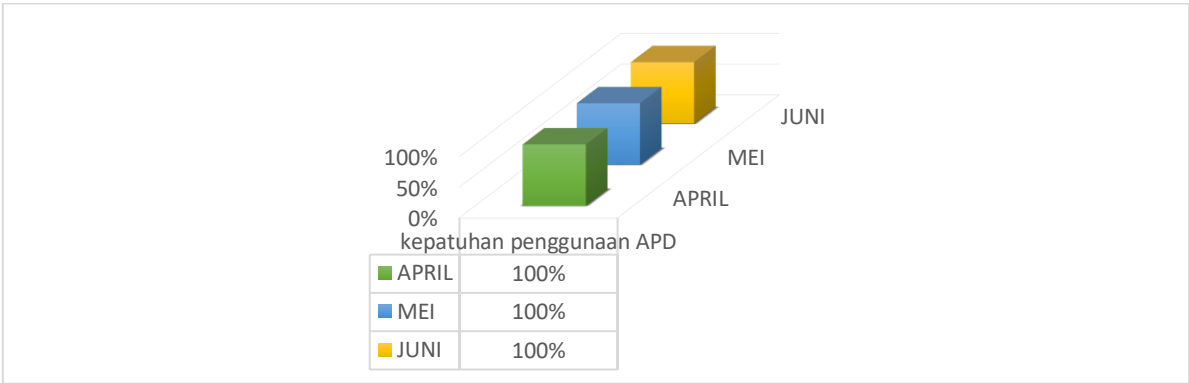
**Rencana dan Tindak Lanjut :**

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

| NO | KEGIATAN                                | JUMLAH PASIEN |      |      |
|----|-----------------------------------------|---------------|------|------|
|    |                                         | APRIL         | MEI  | JUNI |
| 1. | Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD | 100%          | 100% | 100% |

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



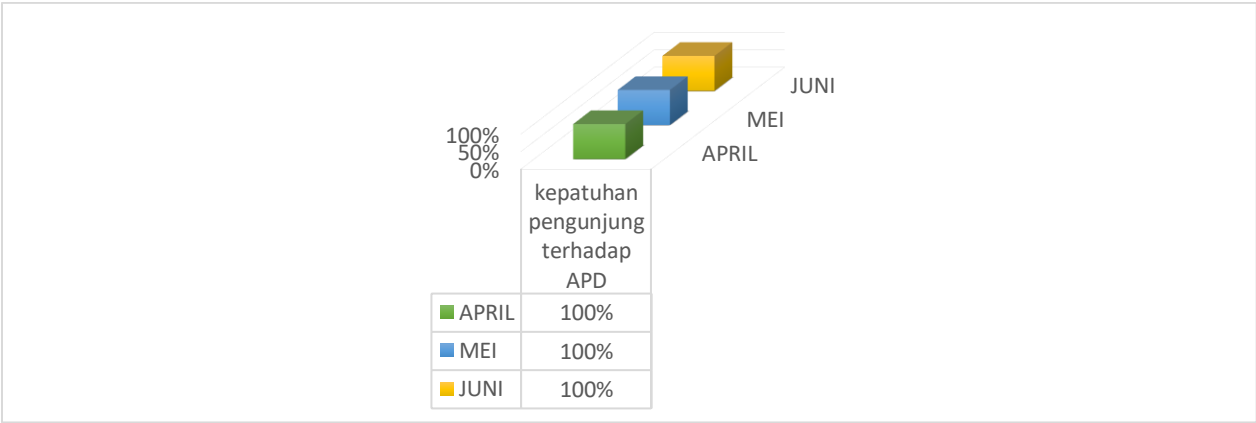
**Analisis :**  
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

| NO | KEGIATAN                                 | JUMLAH PASIEN |      |      |
|----|------------------------------------------|---------------|------|------|
|    |                                          | APRIL         | MEI  | JUNI |
| 1. | Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD | 100%          | 100% | 100% |

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



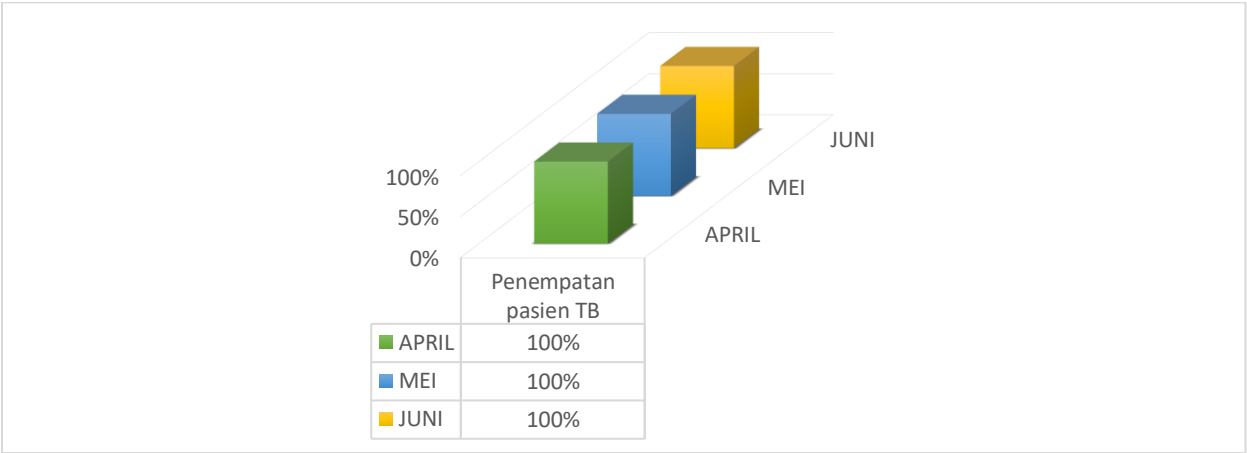
**Analisis:**  
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

| NO | KEGIATAN             | JUMLAH PASIEN |      |      |
|----|----------------------|---------------|------|------|
|    |                      | APRIL         | MEI  | JUNI |
| 1. | Penempatan pasien TB | 100%          | 100% | 100% |

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



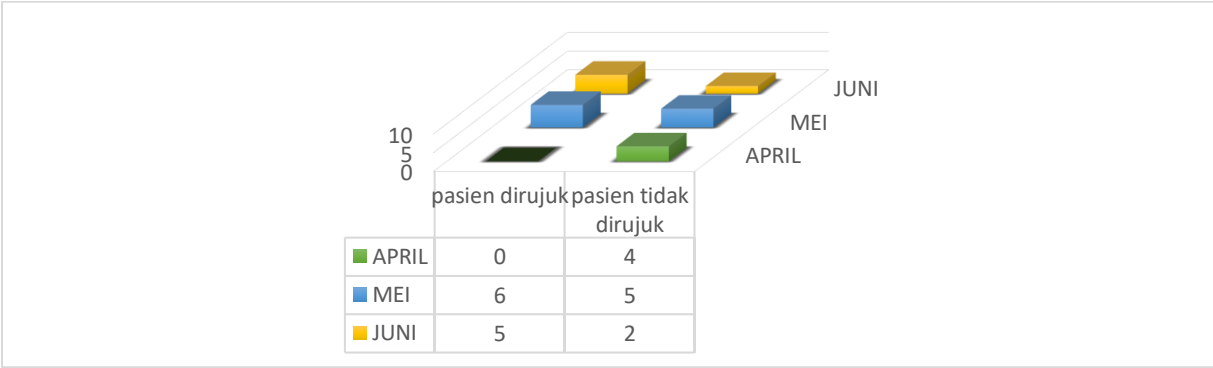
**Analisis:**  
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

| NO | KEGIATAN                     | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|------------------------------|---------------|-----|------|
|    |                              | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pasien TB yang dirujuk       | 0             | 4   | 5    |
| 2. | Pasien TB yang tidak dirujuk | 4             | 2   | 2    |

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



**Analisis :**

1. Pada bulan April 2024 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 6 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

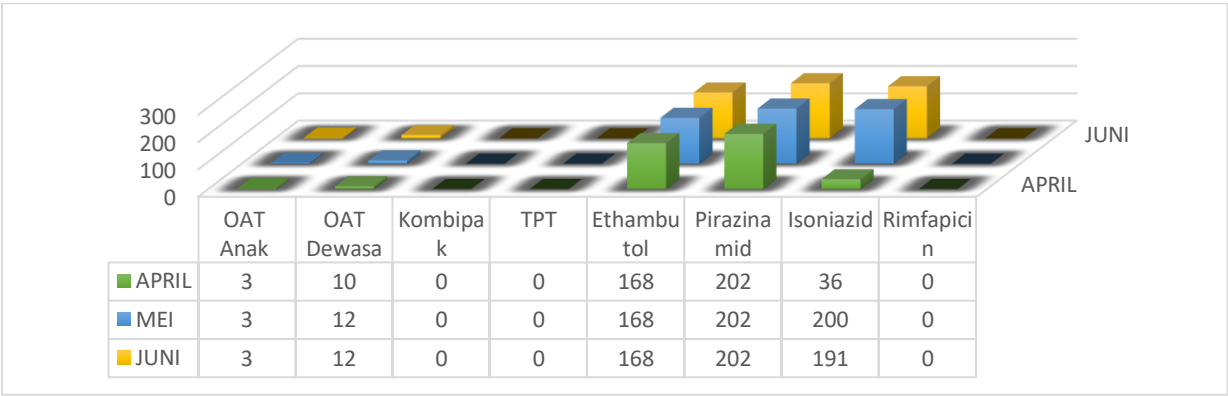
3. Pada bulan Juni 2024 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

| NO | KEGIATAN    | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|-------------|---------------|-----|------|
|    |             | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | OAT Anak    | 3             | 3   | 3    |
| 2. | OAT Dewasa  | 10            | 12  | 12   |
| 3. | Kombipak    | 0             | 0   | 0    |
| 4. | TPT         | 0             | 0   | 0    |
| 5. | Ethambutol  | 168           | 168 | 168  |
| 6. | Pirazinamid | 202           | 202 | 202  |
| 7. | Isoniazid   | 36            | 200 | 191  |
| 8. | Rimfapicin  | 0             | 0   | 0    |

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



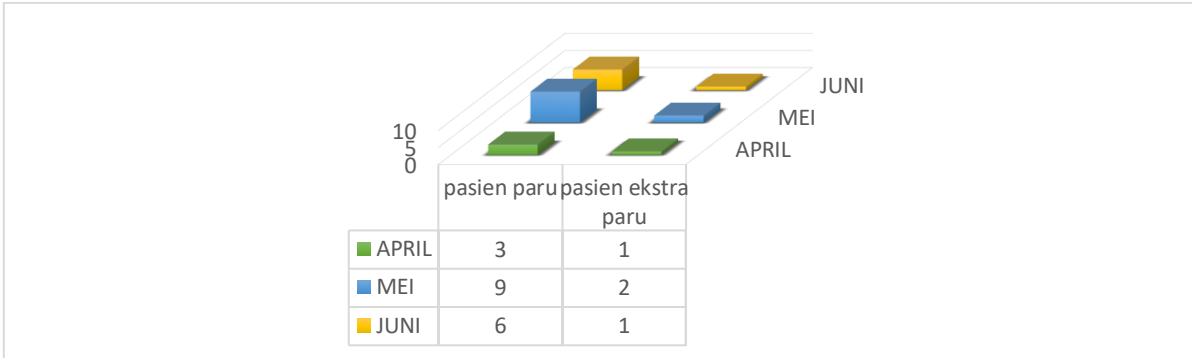
**Analisis :**  
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

| NO | KEGIATAN           | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|--------------------|---------------|-----|------|
|    |                    | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pasien paru        | 3             | 9   | 6    |
| 2. | Pasien Ekstra paru | 1             | 2   | 1    |

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1. Pada bulan April 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 2 pasien ekstra paru
- 3. Pada bulan Juni 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

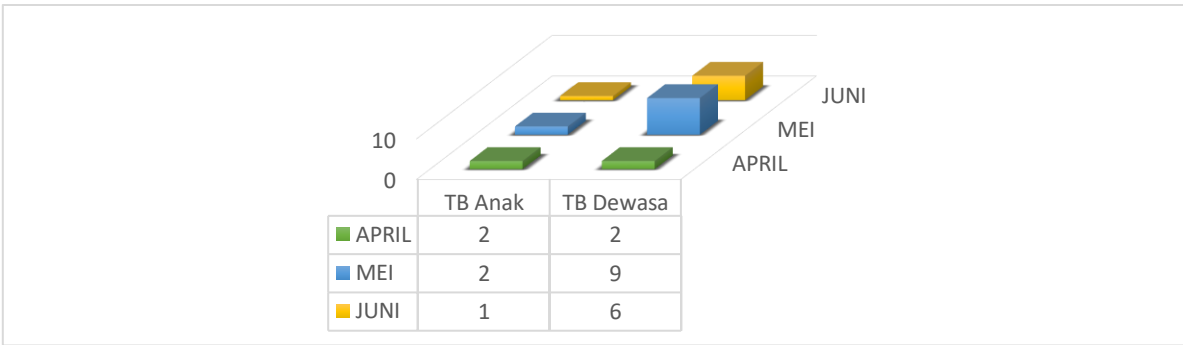
Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

| NO | KEGIATAN      | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|---------------|---------------|-----|------|
|    |               | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pasien Anak   | 2             | 2   | 1    |
| 2. | Pasien Dewasa | 2             | 9   | 6    |

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan April terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
- 2. Pada bulan Mei terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai pasien 3 pasien
- 3. Pada bulan Juni terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai pasien 1 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

| NO | KEGIATAN                 | NAMA PASIEN | PATUH | TIDAK PATUH | ALASAN |
|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|--------|
| 1. | dr. Andy, Sp. P          | Ny. S       | V     |             |        |
|    |                          | Ny. I       | V     |             |        |
|    |                          | Ny. S       | V     |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
| 2. | dr. Catur Elvi p., Sp. P |             |       |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
|    |                          | Tn. P       | V     |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
| 3. | dr. Yunita, Sp. P        |             |       |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
|    |                          | Ny. S       | V     |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |
|    |                          |             |       |             |        |

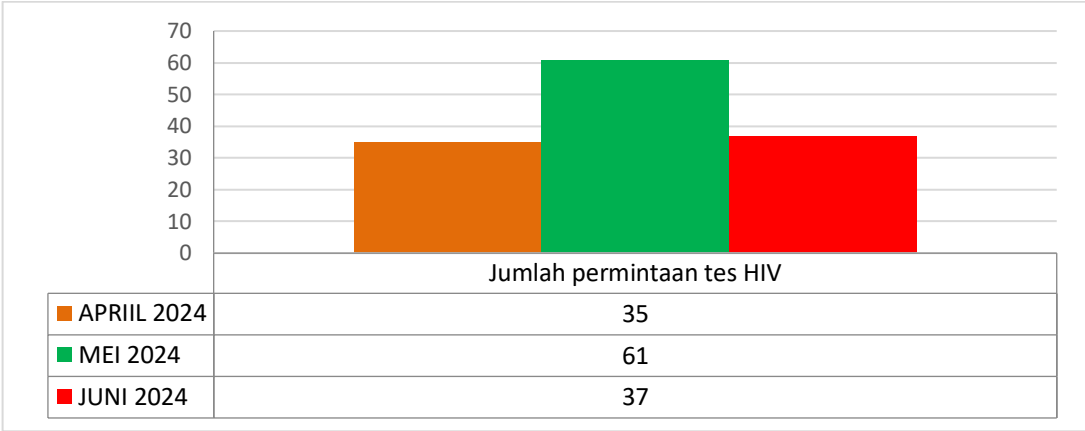
**Analisis :**  
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

| Jumlah Permintaan Tes HIV |                     |            |          |           |
|---------------------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| NO                        | URAIAN              | BULAN      |          |           |
|                           |                     | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1                         | Permintaan Test HIV | 35         | 61       | 37        |

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada  
Bulan Juni 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Juni 2024 sebanyak 37 pemeriksaan. Pemeriksaan menurun dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebanyak 61 pemeriksaan dan pada bulan april 2024 sebanyak 35 pasien. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

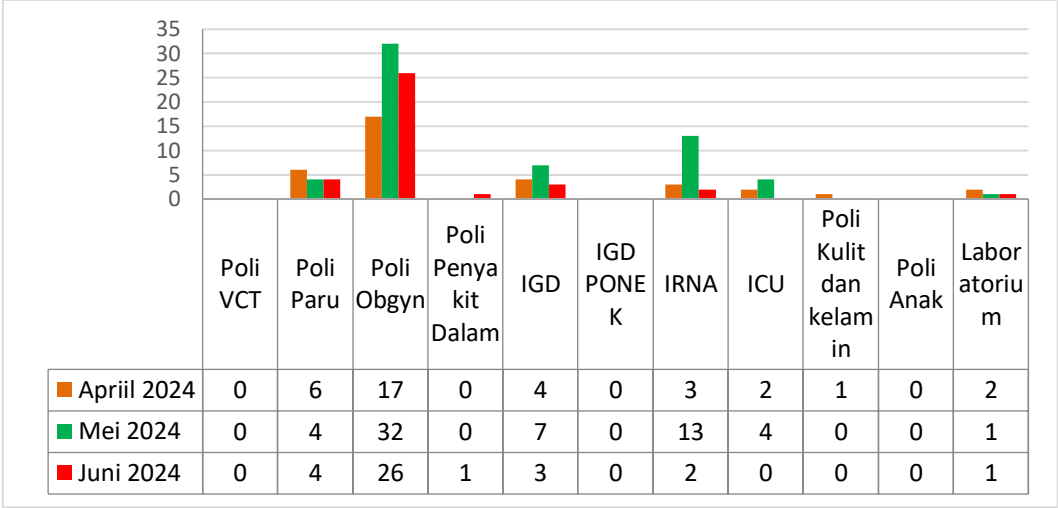
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

| NO | URAIAN                 | BULAN      |          |           |
|----|------------------------|------------|----------|-----------|
|    |                        | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Poli VCT               | 0          | 0        | 0         |
| 2  | Poli Paru              | 6          | 4        | 4         |
| 3  | Poli Obgyn             | 17         | 32       | 26        |
| 4  | Poli Penyakit Dalam    | 0          | 0        | 1         |
| 5  | IGD                    | 4          | 7        | 3         |
| 6  | IGD PONEK              | 0          | 0        | 0         |
| 7  | IRNA                   | 3          | 13       | 2         |
| 8  | ICU                    | 2          | 4        | 0         |
| 9  | Poli Kulit dan kelamin | 1          | 0        | 0         |
| 10 | Poli Anak              | 0          | 0        | 0         |
| 11 | Laboratorium           | 2          | 1        | 1         |

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada  
Bulan Juni 2024



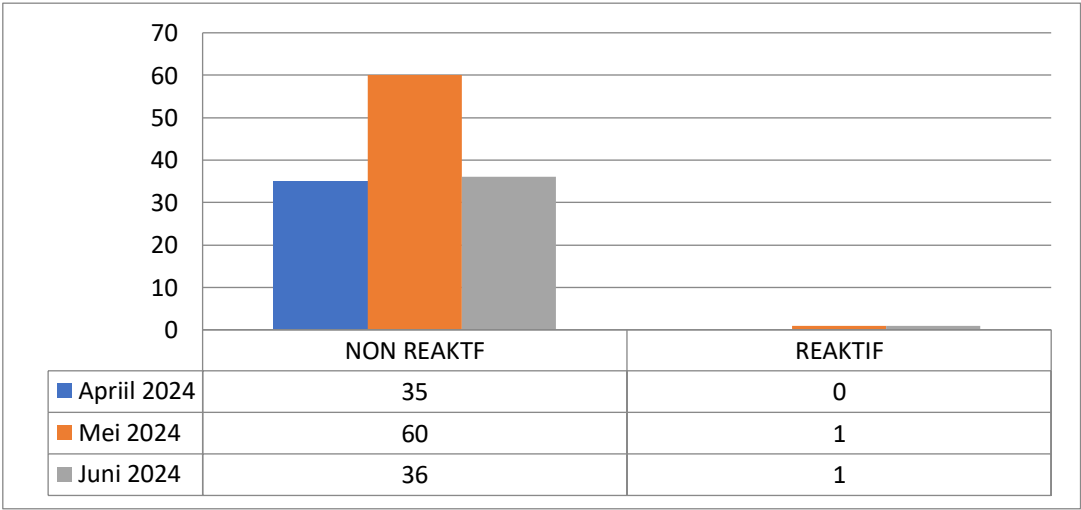
**Analisis :**  
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan april 2024 sebanyak 15 pasien. pada bulan Mei sebanyak 32 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2024 sebanyak 26 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

| NO | URAIAN      | BULAN      |          |           |
|----|-------------|------------|----------|-----------|
|    |             | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Non Reaktif | 35         | 60       | 36        |
| 2  | Reaktif     | 0          | 1        | 1         |

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada  
Bulan Juni 2024



**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan 1 data status HIV dengan status reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Juni 2024. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya sama yaitu 1 pasien.

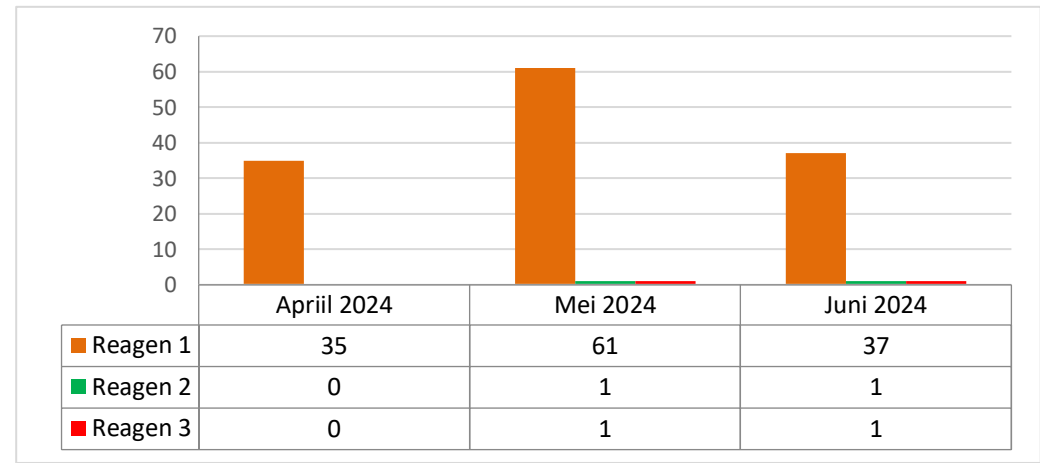
**Rencana Tindak Lanjut :**

Rumah Sakt Prima Husada Malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

**3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen**

| No | URAIAN   | BULAN      |          |           |
|----|----------|------------|----------|-----------|
|    |          | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Reagen 1 | 35         | 61       | 37        |
| 2  | Reagen 2 | 0          | 1        | 1         |
| 3  | Reagen 3 | 0          | 1        | 1         |

**Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024**



**Analisis :**

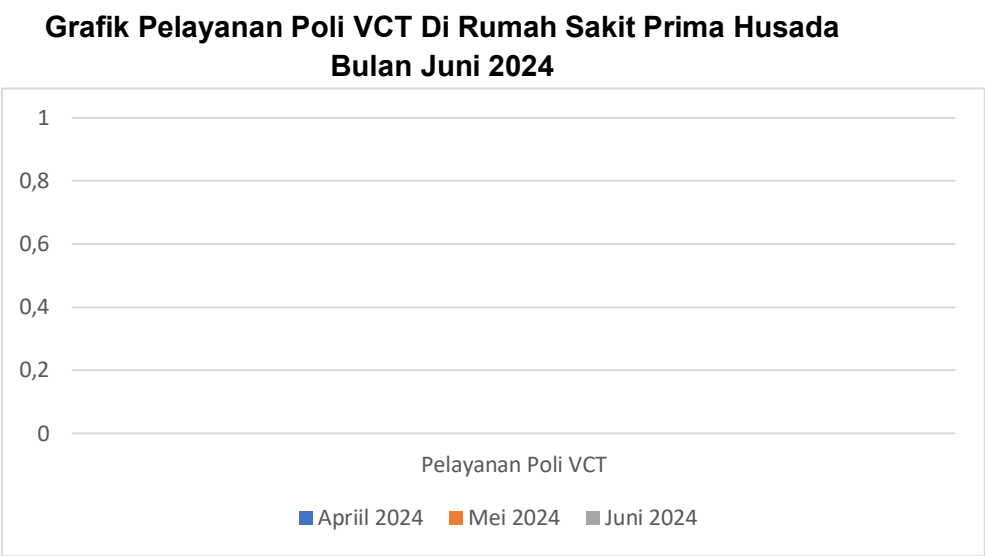
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan April 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 1 saja. Pada bulan Mei ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Sedangkan pada bulan Juni memakai sampai dengan reagen 3. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei dan juni 2024 ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif sebanyak 1 pasien.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3. Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif

**3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct ( Voluntary Conseling And Testing )**

| No | URAIAN             | BULAN      |          |           |
|----|--------------------|------------|----------|-----------|
|    |                    | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Pelayanan Poli VCT | 0          | 0        | 0         |



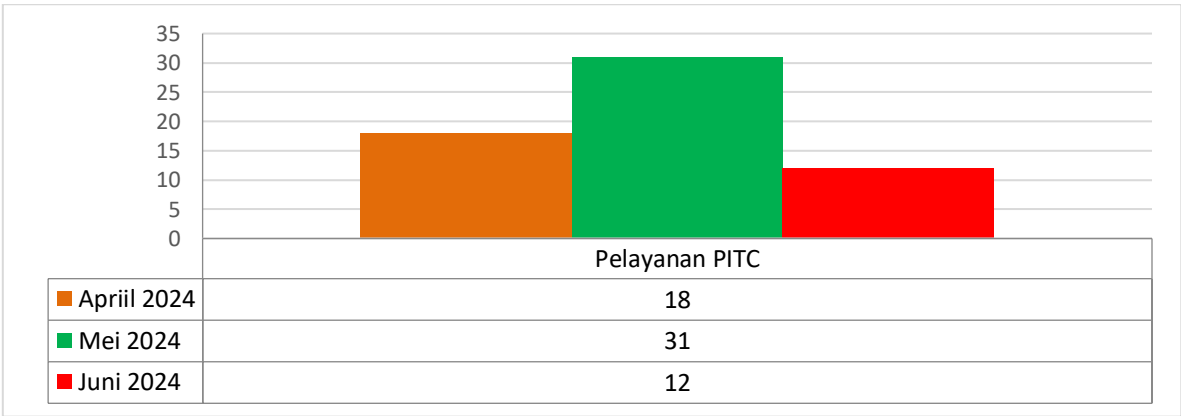
**Analisis pelayanan Poli VCT**  
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

**Rencana Tindak Lanjut**  
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husada belum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

**3.1.2.3.5 Pelayanan PITC ( Provider Initiated Testing and Counseling )**

| No | URAIAN         | BULAN      |          |           |
|----|----------------|------------|----------|-----------|
|    |                | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Pelayanan PITC | 18         | 31       | 12        |

**Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada**  
**Bulan Jun 2024**



**Analisis :**  
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan april 2024 sebanyak 18 pasien, pada bulan Mei 2024 sebanyak 31 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2024 sebanyak 12 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

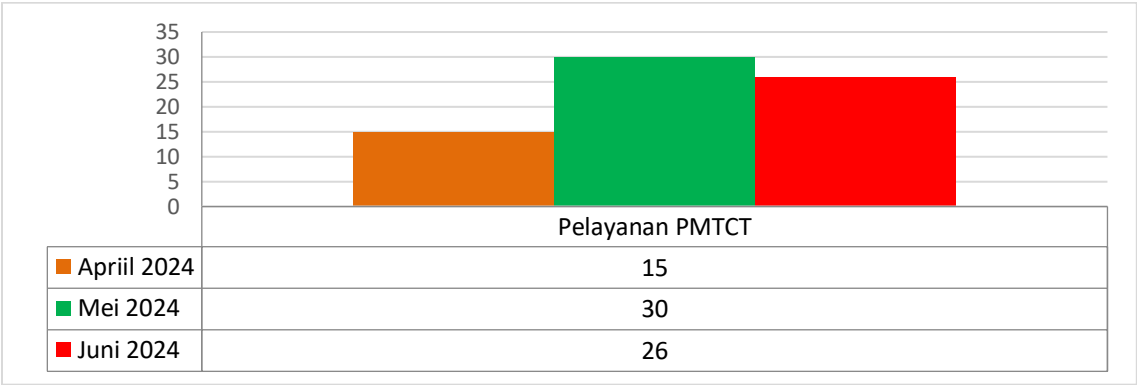
**Rencana Tindak Lanjut :**

Dilakukan peningkatan terkait penjangkaran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

**3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct ( Prevention to Mother Of Child Transmision )**

| No | URAIAN          | BULAN      |          |           |
|----|-----------------|------------|----------|-----------|
|    |                 | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Pelayanan PMTCT | 15         | 30       | 26        |

**Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada  
Bulan Juni 2024**



**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien, pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien sedangkan pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

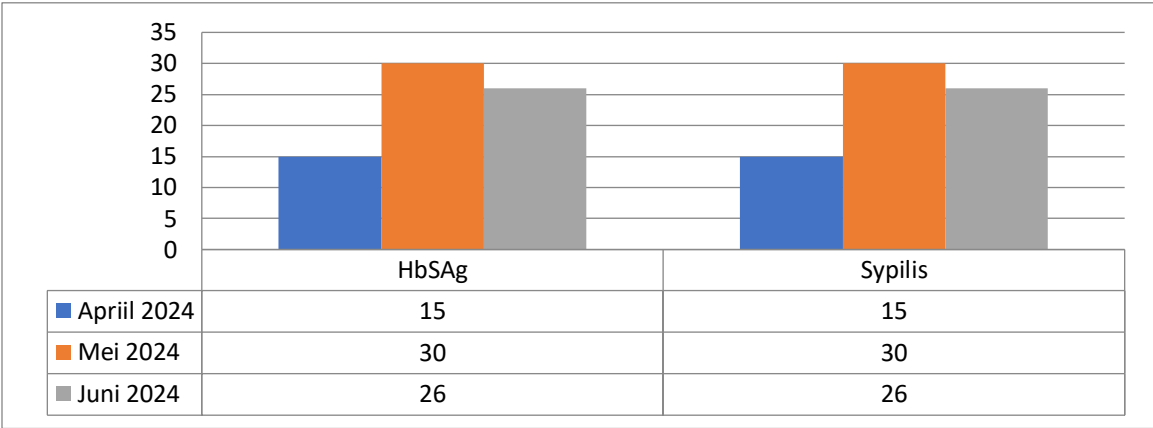
**Rencana Tindak Lanjut :**

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk *Prevention to Mother Of Child* Transmision bisa dilakukan.

**3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil**

| No | URAIAN  | BULAN      |          |           |
|----|---------|------------|----------|-----------|
|    |         | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | HbSAg   | 15         | 30       | 26        |
| 2  | Sypilis | 15         | 30       | 26        |

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil  
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien, pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien sedangkan pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien  
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

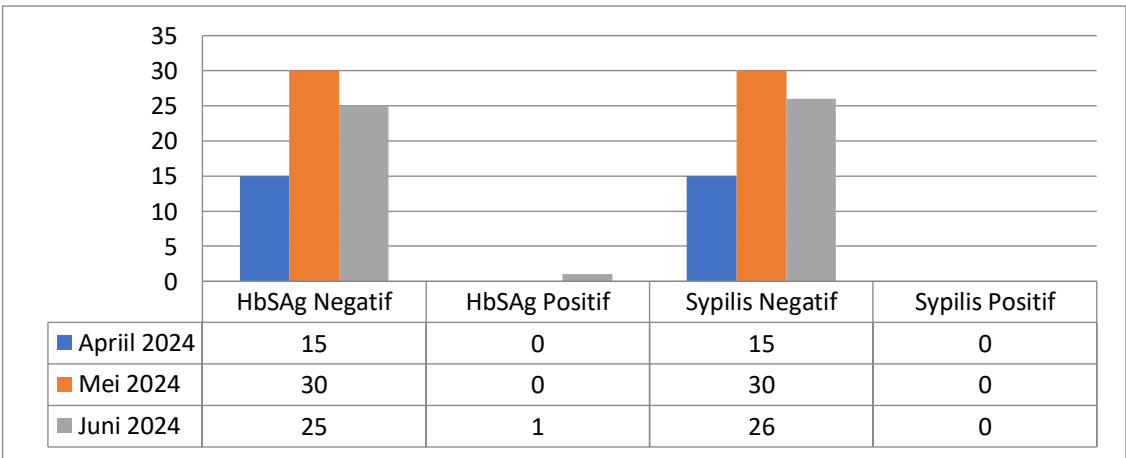
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

| No | URAIAN  | BULAN      |            |           |
|----|---------|------------|------------|-----------|
|    |         | MARET 2024 | APRIL 2024 | MEI 2024  |
| 1  | HbSAg   |            |            |           |
|    | Negatif | APRIL 2024 | MEI 2024   | JUNI 2024 |
|    | Positif |            |            |           |
| 2  | Sypilis | 15         |            |           |
|    | Negatif | 0          | 0          | 1         |
|    | Positif |            |            |           |

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil  
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa Pada bulan April 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif, begitu juga dengan bulan Mei 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan Juni 2024 didapatkan 1 pasien dengan HbSAg positif.

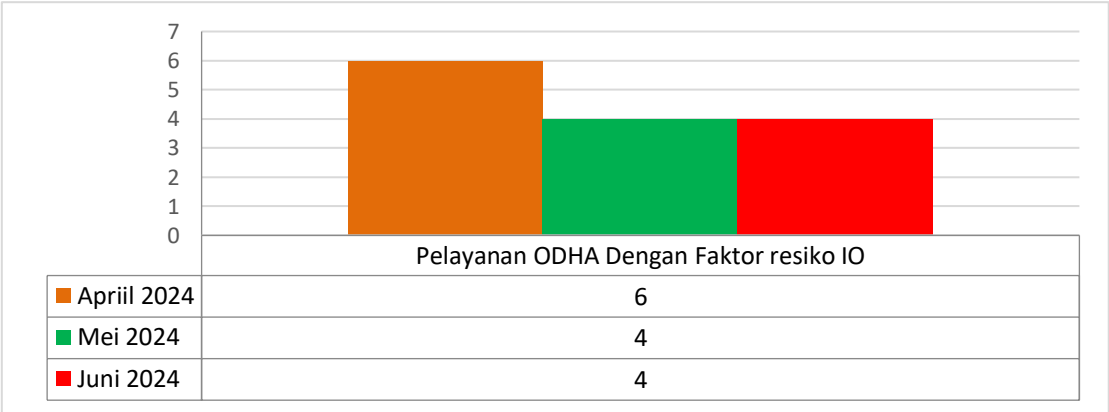
**Rencana Tindak Lanjut :**

- 1. Pada pasien HbSAg  
Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- 2. Pada pasien Syphilis  
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

**3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik**

| No | URAIAN                                 | BULAN      |          |           |
|----|----------------------------------------|------------|----------|-----------|
|    |                                        | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
| 1  | Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO | 6          | 4        | 4         |

**Grafik Pelayanan Odha Dg Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024**



**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan april 2024 sebanyak 6 pasien pada bulan Mei 2024 terjadi penurunan menjadi 4 pasien. sedangkan pada bulan juni 2024 sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

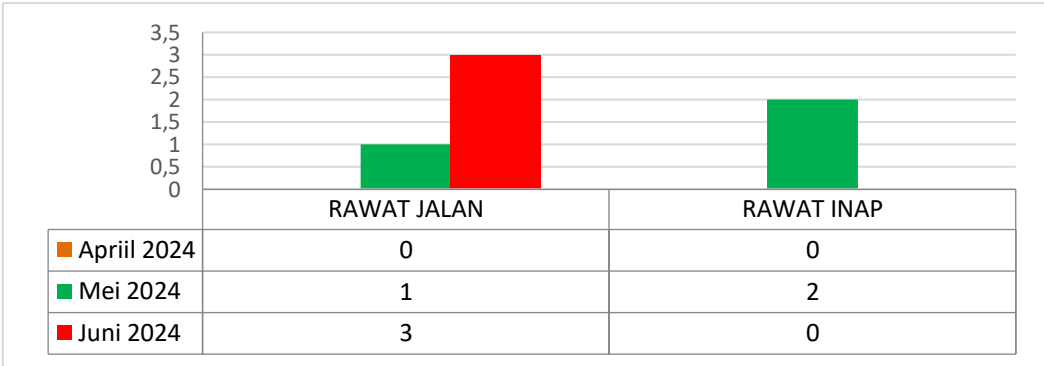
**Rencana Tindak Lanjut :**

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

| No | URAIAN      | BULAN         |             |              |
|----|-------------|---------------|-------------|--------------|
|    |             | APRIL<br>2024 | MEI<br>2024 | JUNI<br>2024 |
| 1  | Rawat Jalan | 0             | 1           | 3            |
| 2  | Rawat Inap  | 0             | 2           | 0            |

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan april 2024 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk. pada bulan Mei 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu dari rawat jalan 1 pasien, dari rawat inap sebanyak 2 pasien. Sedangkan pada bulan juni terdapat 3 pasien HIV yang dilakukan rujuk yang berasal dari rawat jalan. Hal ini dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juni 2024

| NO | KEGIATAN POKOK                                                                                               | RINCIAN KEGIATAN                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting | Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting. |
| 2  | Program 1000 HPK                                                                                             | Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien                                |
| 3  | Suplementasi Folat Pada Ibu hamil                                                                            | Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang                                                                              |
| 4  | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil                                                              | Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang                                                                      |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif                  | 1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan<br>2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas<br>3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan |
| 6  | Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)                    | Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada                                                                                                                                                                               |
| 8  | Pemberian imunisasi                                                                  | Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.                                                                                                                                |
| 9  | Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang                                        | Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi                                                | 1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal.<br>2. Konseling pemberian ASI eksklusif.<br>3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif                                                                                                                      |
| 11 | Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting                         | 1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita<br>2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak.<br>3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.  |
| 12 | Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan | Pada Bulan Juni tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Program Pemantauan dan Evaluasi                                                      | Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.                                                                                                                                                                                          |

**Analisis**

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2
Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

| PROGRAM                       | KEGIATAN                                        | SASARAN                           | LOKASI                  | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| Program 1000 HPK              | Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama | Pengunjung RS Prima Husada Malang | IRJA anak dan Kandungan | 1        | 1        | 1         |
| Suplement asi Asam folat pada | 1. Penyuluhan tentang                           | Ibu Hamil                         | Senam Hamil , Poli      | 1        | 1        | 1         |

|                                                                     |                                                                                                      |                                 |                                          |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|
| ibu hamil                                                           | pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil<br>2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat     |                                 | Kandungan, Hall gedung baru lantai 5     |   |   |   |
| Pemberian PMT Ibu Hamil                                             | Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK                           | Ibu Hamil                       | Hall gedung baru lantai 5                | 1 | 1 | 1 |
| Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif | Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif                         | Ibu hamil                       | IRJA anak dan kandungan, irna maternitas | 1 | 1 | 1 |
| Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)                              | 1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita<br>2. Pembagian PMBA              | IRNA Anak                       | -                                        | 1 | 1 | 1 |
| Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)   | Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak | Pasien Anak                     | IRJA anak                                | 1 | 1 | 1 |
| Pemberian Imunisasi                                                 | Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak                                  | Pasien anak dan Bayi baru lahir | IRJA anak                                | 1 | 1 | 1 |
| Pemberian vitamin A                                                 | Bekerja sama dengan puskesmas                                                                        | Pasien anak                     | IRJA anak                                | 0 | 0 | 0 |

|                                               |                                                                                                                         |             |                            |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---|---|---|
|                                               | terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A                                                |             |                            |   |   |   |
| Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang | Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan   | Pasien anak | Rawat Inap                 | 0 | 0 | 0 |
| Pemberian Taburia pada Baduta                 | Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia              | Pasien anak | Rawat Inap dan Rawat Jalan | 0 | 0 | 0 |
| Pemberian Obat cacing pada ibu hamil          | Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil | Ibu Hamil   | Rawat Inap dan Rawat Jalan | 0 | 0 | 0 |

**Analisis :**  
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

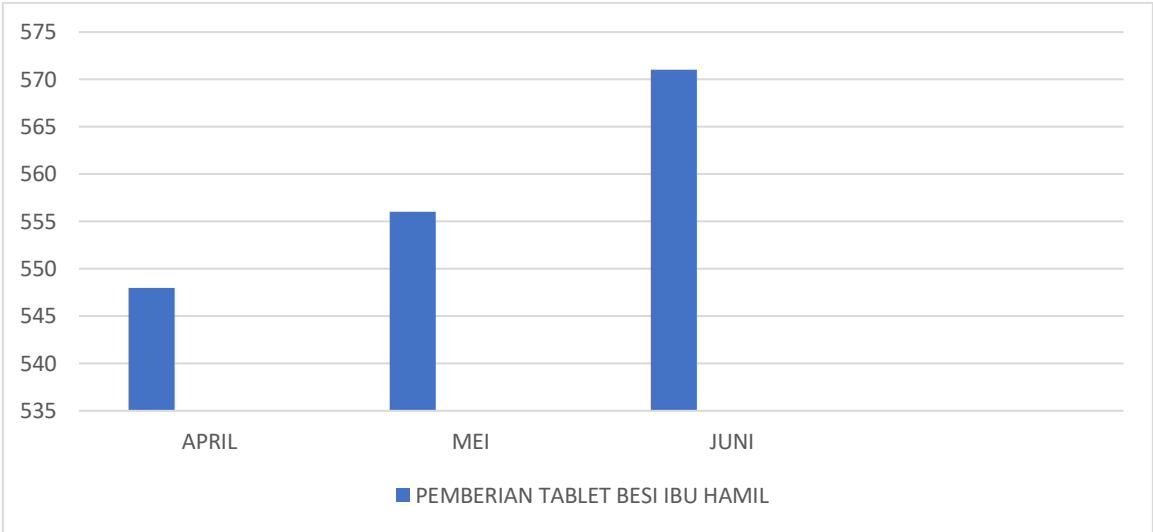
**Rencana Tindak Lanjut :**  
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil

Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

| BULAN                                                               | APR 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan | 548      | 556      | 571       |

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Juni 2024



**Analisis :**  
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat pada bulan Juni yaitu 571 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

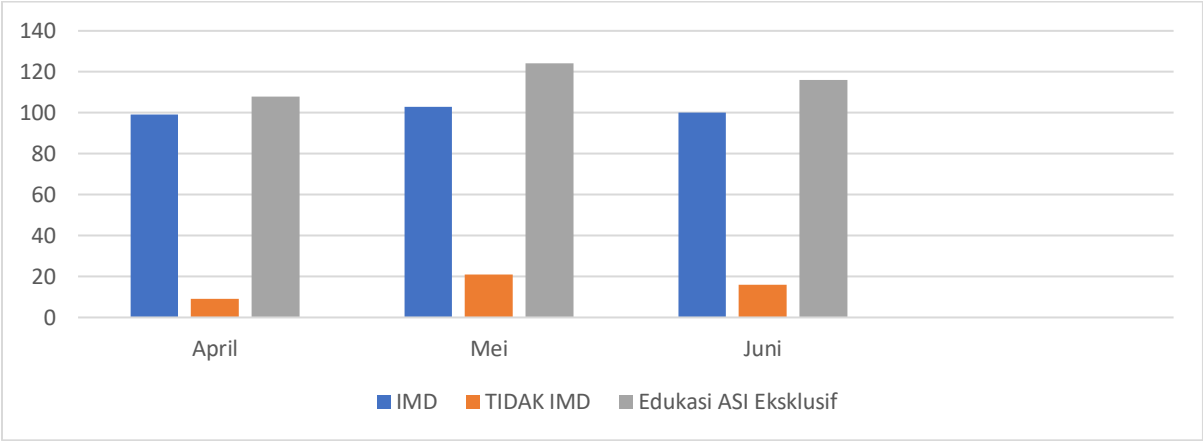
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
  - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

| NO | URAIAN                           | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                                  | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | IMD                              | 99               | 103            | 100             |
| 2  | Tidak IMD                        | 9                | 21             | 16              |
| 3  | Mendapat Konseling ASI Eksklusif | 108              | 124            | 116             |

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 100 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan Juni 2024 yaitu sebanyak 116 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

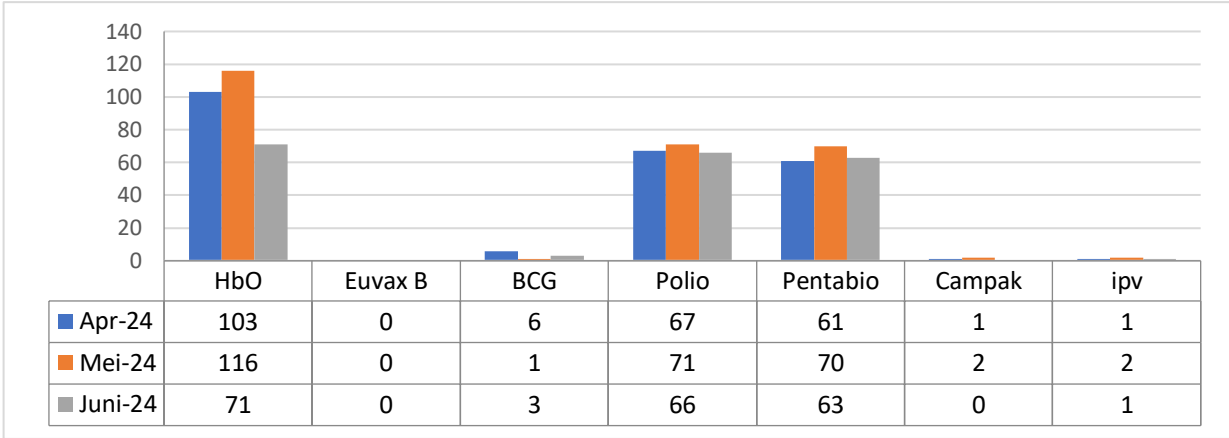
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH           |                |                 |
|----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                 | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | HbO             | 103              | 116            | 71              |
| 2  | Euvax B         | 0                | 0              | 0               |
| 3  | BCG             | 6                | 1              | 3               |
| 3  | Polio           | 67               | 71             | 66              |
| 4  | Pentabio        | 61               | 70             | 63              |
| 5  | Campak          | 1                | 2              | 0               |
| 6  | IPV             | 1                | 2              | 1               |

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juni 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan Juni mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 71 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juni sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juni 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 3 pasien.
- 5. Pada periode Juni 2024 tidak terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 66 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 63 pasien

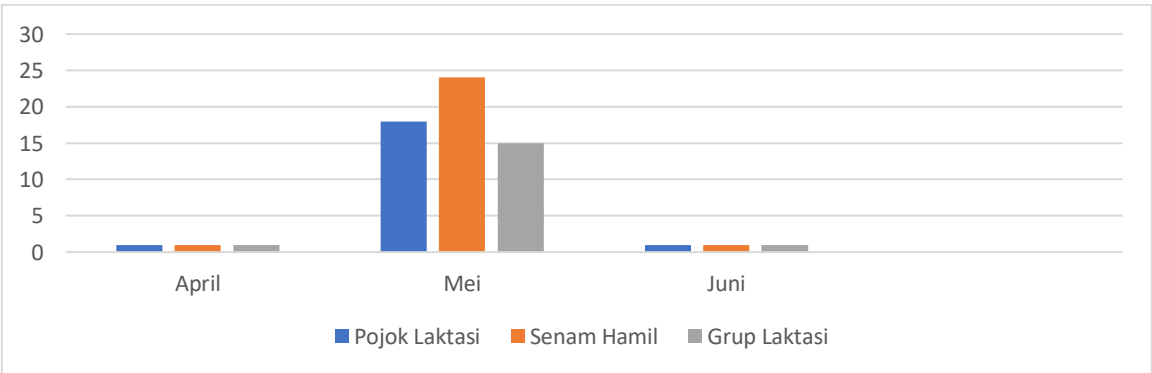
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi  
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

| KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Ruang Pojok Laktasi                                | 1          | 1        | 1         |
| Senam Hamil                                        | 18         | 24       | 15        |
| Pembentukan Grup Laktasi                           | 1          | 1        | 1         |

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2024



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang.

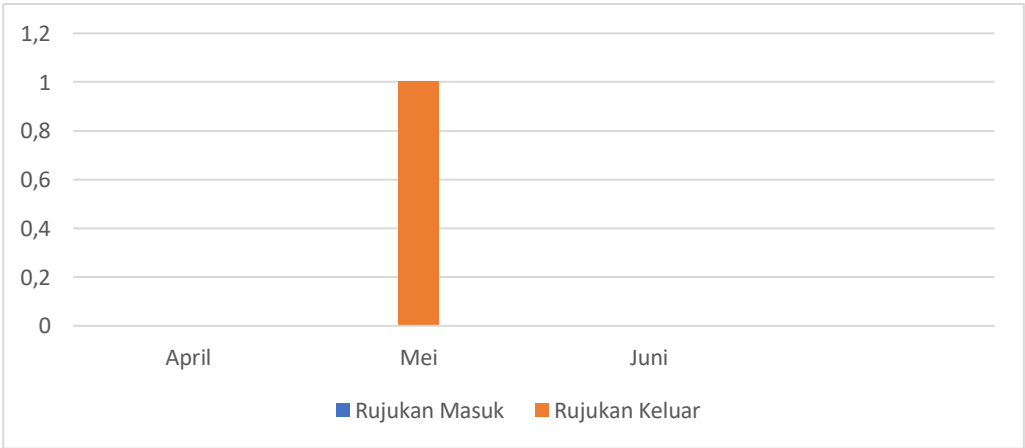
2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
3. Peserta Senam Hamil pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 24 peserta dikarenakan terdapat penambahan jumlah matras sebagai media senam hamil sehingga lebih banyak ibu hamil yang mendaftar untuk mengikuti senam hamil.

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting**  
**Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

| RUJUKAN MASUK  |               |         |                                           |               |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------------|---------------|
| BULAN          | NAMA PX       | USIA    | DIAGNOSA                                  | ASAL RUJUKAN  |
| April          | -             | -       | -                                         | -             |
| Mei            | -             | -       | -                                         | -             |
| Juni           | -             | -       | -                                         | -             |
| RUJUKAN KELUAR |               |         |                                           |               |
| BULAN          | NAMA PX       | USIA    | DIAGNOSA                                  | ASAL RUJUKAN  |
| April          | -             | -       | -                                         | -             |
| Mei            | Zahirul Ihsan | 7 Bulan | Pneumonia, Gizi Buruk, Down Syndrome, PJB | RSUD Sidoarjo |
| Juni           | -             | -       | -                                         | -             |



**Analisis :**  
 Terdapat 1 pasien pada bulan Maret dan pada bulan Mei dirujuk ke RSUD Sidoarjo dengan diagnosa Pneumonia, Gizi Buruk, Down syndrome, dan PJB Chronic.

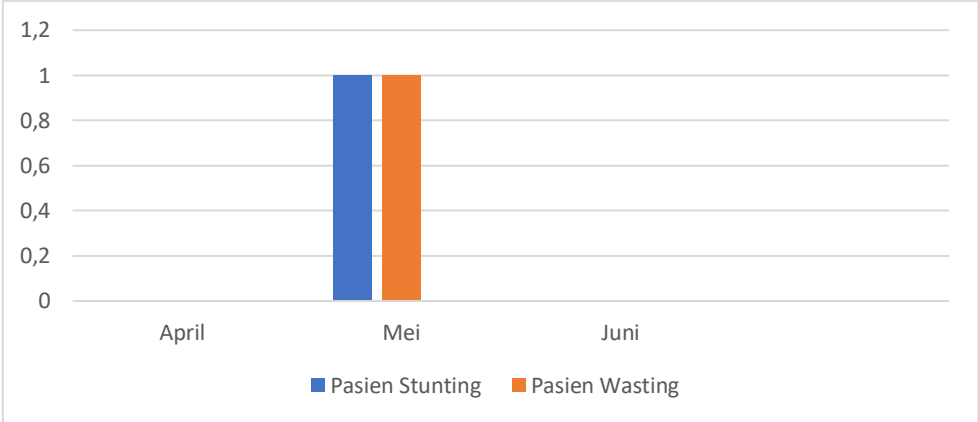
**Rencana Tindak Lanjut:**  
 Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8
Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

| BULAN                  | APRIL 2024 | MEI 2024 | JUNI 2024 |
|------------------------|------------|----------|-----------|
| Jumlah Pasien Stunting | 0          | 1        | 0         |
| Jumlah Pasien Wasting  | 0          | 1        | 0         |

**Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan**



**Analisis :**

Terdapat 1 pasien wasting pada bulan dan Mei. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Pada bulan Maret terdapat 1 pasien stunting yang merupakan pasien yang sudah dalam pantauan puskesmas. Sehingga ahli gizi berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi puskesmas dalam pemberian terapi balita stunting dan wasting.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

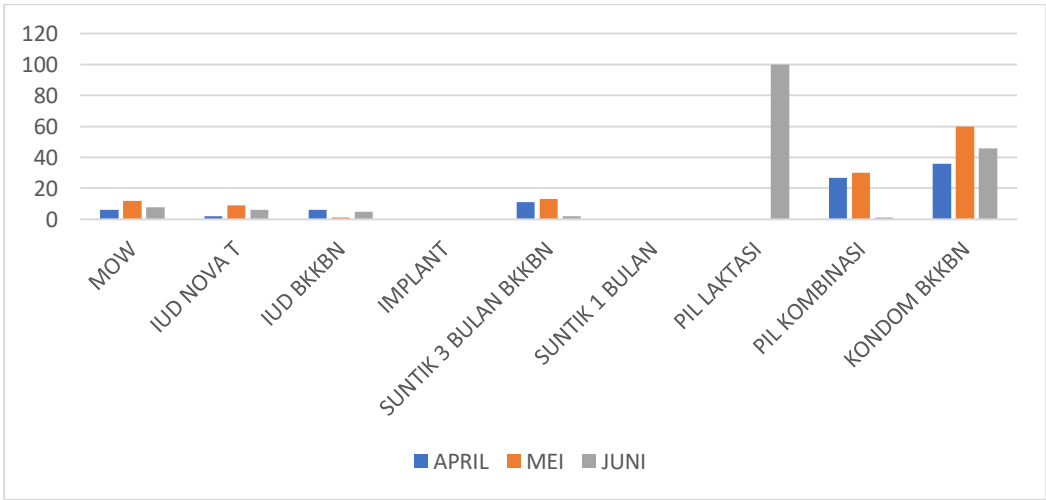
3.1.2.5
KBRS

3.1.2.6
Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi

| NO | JENIS PELAYANAN      | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                      | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | MOW                  | 6                | 12             | 8               |
| 2  | IUD Nova T           | 2                | 9              | 6               |
| 3  | IUD BKKBN            | 6                | 1              | 5               |
| 4  | IMPLANT              | 0                | 0              | 0               |
| 5  | SUNTIK 3 BULAN BKKBN | 11               | 13             | 2               |
| 6  | SUNTIK 1 BULAN       | 0                | 0              | 0               |

|   |               |    |    |    |
|---|---------------|----|----|----|
| 7 | PIL KOMBINASI | 27 | 30 | 1  |
| 8 | PIL LAKTASI   | 0  | 0  | 0  |
| 9 | KONDOM BKKBN  | 36 | 60 | 46 |

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan April (6) Mei (12) Juni ( 8 )
2. Peserta IUD Nova T pada bulan April (2 )Mei meningkat(9) menurun Juni (6)
3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan April (6 ) Mei menurun (1) meningkat Juni ( 5)
4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan April (11 ) Mei meningkat(13) menurun Juni (2)
5. Peserta KB pil kombinasi pada April (27) Mei meningkat (30) menurun Juni (1) karena stok kosong Gudang bkkbn.
6. Peserta KB Kondom pada bulan April (36) Mei meningkat (60) menurun Juni (46)

Analisis

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

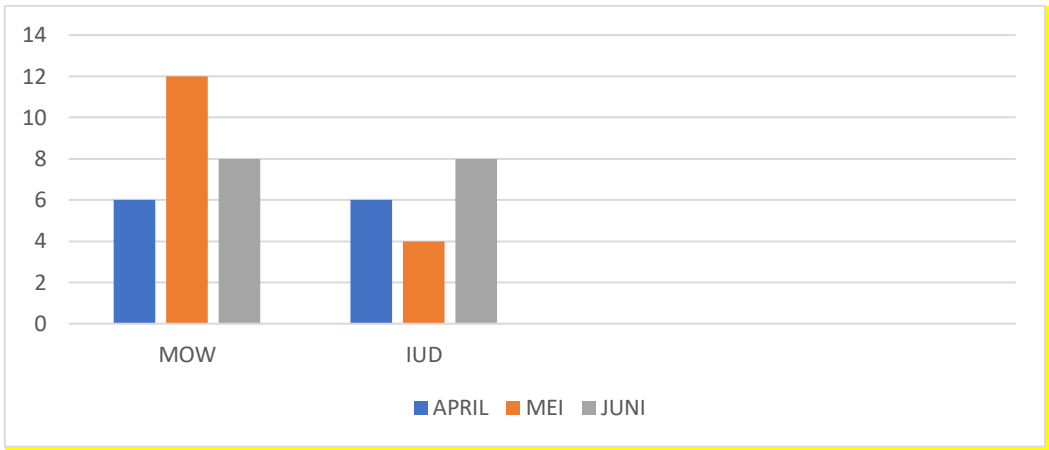
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

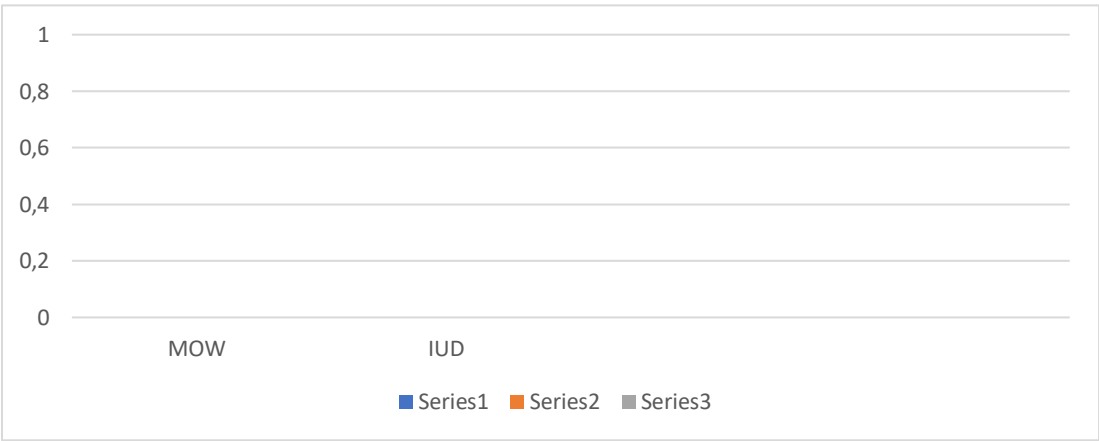
| NO | JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                                  | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | MOW                              | 6                | 12             | 8               |
| 2  | IUD                              | 6                | 4              | 8               |

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



| NO | JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN | JUMLAH PASIEN    |                |                 |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    |                                 | BULAN APRIL 2024 | BULAN MEI 2024 | BULAN JUNI 2024 |
| 1  | MOW                             | 0                | 0              | 0               |
| 2  | IUD                             | 0                | 0              | 0               |

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan April-Mei-Juni meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan April-Mei-Juni menetap

Analisis

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan II Tahun 2024

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2024

| NO. | NAMA            | JENIS KELAMIN /UMUR | DOKTER             | NO. RM | DIAGNOSIS KRS         | TGL MRS    | TGL KRS    | LOS (HARI) | ANTIBIOTIK       | JUMLAH ANTIBIOTIK | DOSIS (GRAM) | TOTAL DOSIS (GRAM) | ATC  | DDD  |
|-----|-----------------|---------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|------|------|
| 1   | Sukartiningsih  | P/79                | dr. Heri, Sp.PD    | 211502 | Vomiting, GERD        | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 8          | Ceftiaxone       | 2                 | 2x1          | 14                 | 2    | 7    |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Asam Pipemidat   |                   | 2x0,4        | 1,6                | 0,8  | 2,5  |
| 2   | Sukanan         | L/66                | dr. Anton, Sp. B   | 211534 | Gangren               | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 5          | Ceftriaxone      | 1                 | 3x1          | 12                 | 2    | 6    |
| 3   | Fitriani        | P/28                | dr. Heri, Sp. B    | 211607 | Febris                | 30/03/2024 | 03/04/2024 | 5          | Ceftriaxone      | 1                 | 2x1          | 9                  | 2    | 4,5  |
| 4   | M Riza abdi     | L/21                | dr. Heri, Sp. B    | 211653 | Volume Depletion      | 02/04/2024 | 06/04/2024 | 5          | Ceftriaxone      | 1                 | 2x1          | 8                  | 2    | 4    |
| 5   | Eris Kurniawan  | L/42                | dr. Heri, Sp.Pd    | 211718 | GERD, Hiponatremi     | 02/04/2024 | 06/04/2024 | 5          | Ceftiaxone       | 2                 | 2x1          | 9                  | 2    | 4,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Azitromycin po   |                   | 1x0,5        | 2,5                | 0,3  | 8,3  |
| 6   | Sucipto H       | L/63                | dr. Pradana, Sp. U | 097743 | Mums Orchitis         | 03/04/2024 | 06/04/2024 | 4          | Gentamycin       | 2                 | 2x0,04       | 0,24               | 0,24 | 1    |
| 7   | Maulana B       | L/35                | dr. Zaki, Sp.B     | 211843 | Appenciditis acute    | 04/05/2024 | 06/05/2024 | 3          | Cefoperazone     | 2                 | 1x2          | 2                  | 4    | 0,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Ceftriaxone      |                   | 2x1          | 5                  | 2    | 2,5  |
| 8   | Djumain         | L/79                | dr. Anton, Sp.B    | 211849 | Necrotizing fasciitis | 04/05/2024 | 06/05/2024 | 3          | Ceftriaxone      | 3                 | 1x1          | 1                  | 2    | 0,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Ceftriaxone      |                   | 3x1          | 7                  | 2    | 3,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Metronidazole po |                   | 3x0,25       | 1,5                | 2    | 7,5  |
| 9   | Murtiningsih    | P/65                | dr. Heri, Sp.Pd    | 212014 | Febris                | 07/04/2024 | 13/04/2024 | 7          | Ceftriaxone      | 3                 | 2x1          | 1                  | 2    | 0,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Levofloxacin po  |                   | 1x0,75       | 3                  | 0,5  | 6    |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Metronidazole po |                   | 3x0,5        | 5,5                | 2    | 2,75 |
| 10  | Ariel Harijaman | L/53                | dr. Yoga, Sp.JP    | 201144 | ADHF                  | 07/04/2024 | 13/04/2024 | 7          | Ceftriaxone      | 2                 | 2x1          | 12                 | 2    | 6    |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Levofloxacin po  |                   | 1x0.5        | 1,5                | 0,5  | 3    |
| 11  | Saropah         | P/47                | dr. Heri, Sp. Pd   | 209882 | DM Hipoglikemi        | 09/04/2024 | 13/04/2024 | 5          | Ceftriaxone      | 2                 | 2x1          | 9                  | 2    | 4,5  |
|     |                 |                     |                    |        |                       |            |            |            | Asam Pepimidat   |                   | 2x0,4        | 3,2                | 0,8  | 4    |

|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   |        |     |     |      |
|----|--------------|------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------------|---|--------|-----|-----|------|
| 12 | Nita Firda M | P/40 | dr. Heri, Sp. Pd       | 112517 | Vomiting                                                   | 09/04/2024 | 13/04/2024 | 5 | Ceftriaxone<br>Asam<br>Pepimidat          | 2 | 2x1    | 9   | 2   | 4,5  |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 2x0,4  | 2,8 | 0,8 | 3,5  |
| 13 | Sumarmi      | P/51 | dr. Anton, Sp.B        | 211764 | Tumor mammae (S)                                           | 12/04/2024 | 14/04/2024 | 3 | Ceftizoxime<br>Ceftriaxone<br>Cefadroxile | 3 | 1x1    | 1   | 4   | 0,25 |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 1x1    | 1   | 2   | 0,5  |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 2x0,5  | 2   | 2   | 1    |
| 14 | Ani Farida   | P/46 |                        | 212181 | DM Hiperglikemi                                            | 13/04/2024 | 17/04/2024 | 5 | Cefriaxone                                | 1 | 2x1    | 9   | 2   | 4,5  |
| 15 | Gisam        | L/72 | dr. Yunita, Sp.P       | 127242 | Dyspnea                                                    | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 5 | Levofloxacin<br>inf                       | 1 | 1x0,75 | 3   | 0,5 | 6    |
| 16 | Lailatul K   | P/21 | dr. Humaira, Sp.<br>OG | 212404 | Single Spontaneous<br>Injury of unspecified<br>body region | 17/04/2024 | 19/04/2024 | 3 | Cefazoline<br>Cefadroxile                 | 2 | 1x2    | 2   | 3   | 0,67 |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 2x0,5  | 2   | 2   | 1    |
| 17 | Ika Elfiya   | P/27 | dr. Oka, Sp. OT        | 212462 |                                                            | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 2 | Cefoperazone                              | 1 | 2x1    | 4   | 4   | 1    |
| 18 | Sunayah      | P/68 | dr. Zaki, Sp.B         | 099848 | AF RVR, CAD                                                | 19/04/2024 | 23/04/2024 | 5 | Ceftriaxone<br>Metronidazole<br>inj       | 2 | 2x1    | 8   | 2   | 4    |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 2x1    | 6   | 1,5 | 4    |
| 19 | Darmini      | P/56 | dr.Heri, Sp.Pd         | 212623 | Other Anemias                                              | 21/04/2024 | 24/04/2024 | 4 | Ceftriaxone<br>Asam<br>Pipemidat          | 2 | 2x1    | 8   | 2   | 4    |
|    |              |      |                        |        |                                                            |            |            |   |                                           |   | 2x0,4  | 1,2 | 0,8 | 1,5  |
| 20 | Alfian Nur H | L/32 | dr. Edi, Sp.U          | 209854 | Scrotal Varices                                            | 28/04/2024 | 30/04/2024 | 3 | Ceftizoxime                               | 1 | 1x2    | 2   | 4   | 0,   |

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2024

| NO. | NAMA             | JENIS KELAMIN /UMUR | DOKTER               | NO. RM | DIAGNOSIS KRS                                | TGL MRS    | TGL KRS    | LOS (HARI) | ANTIBIOTIK       | JUMLAH ANTIBIOTIK | DOSIS (GRAM) | TOTAL DOSIS (GRAM) | ATC | DDD   |
|-----|------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----|-------|
| 1   | RUSWANDI         | L/59                | DR. FARID, SP.S      | 212319 | CVA INFARK                                   | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 8          | Ceftiaxone       | 2                 | 2X1          | 7                  | 2   | 3,5   |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Levofloxacin Po  |                   | 1X0,5        | 1,5                | 0,5 | 3     |
| 2   | SULAKSONO        | L/48                | DR. EDI, SP. U       | 212963 | NEFROLITIASIS BILATERAL                      | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 5          | Ceftizoxime      | 1                 | 1X2          | 2                  | 4   | 0,5   |
| 3   | LASIAMAH         | P/74                | DR. IRA, SP.JP       | 097978 | ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER              | 03/05/2024 | 07/05/2024 | 5          | Ceftiaxone       | 2                 | 2X1          | 4                  | 2   | 2     |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Azitromycin      |                   | 1X0,5        | 1                  | 0,3 | 3,3   |
| 4   | CHOTAMIN         | L/56                | DR. YUNITA, SP.P     | 207671 | COPD                                         | 04/05/2024 | 07/05/2024 | 4          | Levofloxacin Inf | 1                 | 1X0,75       | 3                  | 0,5 | 6     |
| 5   | SUPAAT           | L/68                | DR. YUNITA, SP.P     | 213556 | PNEUMONI SUSP TB                             | 08/05/2024 | 11/05/2024 | 4          | Ceftriaxone      | 3                 | 2X1          | 8                  | 2   | 4     |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Azitromycin Po   |                   | 1X0,5        | 1,5                | 0,3 | 5     |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Levofloxacin Inf |                   | 1X0,5        | 1                  | 0,5 | 2     |
| 6   | SUKRI            | L/93                | DR. MIRYANTI, SP. JP | 213625 | DYSPNEA                                      | 09/05/2024 | 14/05/2024 | 6          | Levofloxacin Inf | 2                 | 1X0,5        | 1,5                | 0,5 | 2     |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Levofloxacin Po  |                   | 1X0.5        | 1,5                | 0,5 | 2     |
| 7   | MUNYATUN         | P/54                | DR. ANDY, SP.P       | 140274 | PNEUMONI, HT                                 | 12/05/2024 | 15/05/2024 | 4          | Ceftriaxone      | 1                 | 2X1          | 8                  | 2   | 4     |
| 8   | ESTER NINGMAWATI | P/58                | DR. ANTON , SP.B     | 194608 | NECROTIZING FACITIS DEXTRA, DM HIPERGLIMKEMI | 13/05/2024 | 15/05/2024 | 3          | Ceftriaxone      | 3                 | 1X1          | 1                  | 2   | 0,5   |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Ceftriaxone      |                   | 2X1          | 5                  | 2   | 2,5   |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Metronidazole Po |                   | 3X0,25       | 2                  | 2   | 1     |
| 9   | RUSLANI          | L/67                | TUMOR SHOULDER       | 064773 | TUMOR SHOULDER (S)                           | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 3          | Cefoperazone     | 2                 | 1X2          | 2                  | 4   | 0,5   |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Ceftriaxone      |                   | 2X1          | 5                  | 2   | 2,5   |
| 10  | RACHMAD RIYADI   | L/47                | DR. ANTON, SP.B      | 213876 | GANGRENE AND NECROSIS OF LUNG                | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 3          | Ceftriaxone      | 2                 | 3X1          | 8                  | 2   | 4     |
|     |                  |                     |                      |        |                                              |            |            |            | Metronidazole Po |                   | 3X0,25       | 1,75               | 2   | 0,875 |
| 11  | ACHMAD SOBIM     | L/49                | DR. OKA, SP.OT       | 213924 | CRUSH INJURY                                 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 2          | Cefoperazone     | 1                 | 2X1          | 4                  | 4   | 1     |

|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   |                 |   |        |     |     |      |
|----|-------------------|------|---------------------|--------|-------------------------------------------|------------|------------|---|-----------------|---|--------|-----|-----|------|
| 12 | ERNI KUSUMAWATI   | P/50 | DR. ANTON, SP.B     | 146928 | GANGLION                                  | 19/01/2024 | 23/01/2024 | 5 | Ceftizoxime     | 2 | 1X1    | 1   | 4   | 0,25 |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Ceftriaxone     |   | 1X1    | 1   | 2   | 0,5  |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Cefadroxile     |   | 2X0,5  | 1,5 | 2   | 0,75 |
| 13 | DIAN PUTRI AMALIA | P/27 | DR. ZORA, SP. PD    | 177321 | VOLUME DEPLETION                          | 16/05/2024 | 18/05/2024 | 3 | Doxycycline     | 1 | 2X0,1  | 0,6 | 0,1 | 6    |
| 14 | MISERI            | L/60 | DR. ANTON, SP.B     | 214064 | CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF TRUNK | 19/05/2024 | 22/05/2024 | 4 | Ceftriaxone     | 2 | 1X1    | 1   | 2   | 0.5  |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Ceftriaxone     |   | 2X1    | 6   | 2   | 3    |
| 15 | KARTIKA           | P/29 | DR. ARDHI, SP.PD    | 214161 | GEA                                       | 20/05/2024 | 23/05/2024 | 4 | Ceftriaxone     | 2 | 2X1    | 8   | 2   | 4    |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Ciprofloxacin   |   | 2X0,5  | 2   | 1   | 2    |
| 16 | WIDARSONO         | L/48 | DR. HERI , SP.PD    | 214179 | ACUTE NASOPHARYNGITIS                     | 20/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | Ceftriaxone     | 3 | 2X1    | 4   | 2   | 0.5  |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Cefadroxile     |   | 3X0,5  | 2,5 | 2   | 1.25 |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Levofloxacin Po |   | 1X0,75 | 1,5 | 0,5 | 3    |
| 17 | MUJIONO           | L/68 | DR. MIRYANTI, SP.JP | 190448 | JAUNDICE                                  | 20/05/2024 | 23/05/2024 | 4 | Ceftriaxone     | 2 | 2X1    | 6   | 2   | 3    |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Asam Pipemidat  |   | 2X0,4  | 1,6 | 0,8 | 2    |
| 18 | KASIYANTO         | L/64 | DR. PRADANA, SP.U   | 113927 | BPH                                       | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 3 | Ceftizoxime     | 1 | 1X2    | 2   | 4   | 0,5  |
| 20 | SENJA AYU         | P/26 | DR. HUMAIRA, SP.OG  | 182583 | PRM                                       | 22/05/2024 | 24/05/2024 | 3 | Cefazoline      | 2 | 1X2    | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Cefadroxile     |   | 2X0,5  | 2   | 2   | 1    |
| 19 | ALIFAH            | P/40 | DR.HERI, SP.PD      | 200272 | DM TYPE 2                                 | 22/05/2024 | 27/05/2024 | 6 | Ceftriaxone     | 2 | 2X1    | 7   | 2   | 3.5  |
|    |                   |      |                     |        |                                           |            |            |   | Cefixime        |   | 2X0,1  | 0,5 | 0,4 | 1,25 |

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2024

| NO. | NAMA            | JENIS KELAMIN /UMUR | DOKTER            | NO. RM | DIAGNOSIS KRS           | TGL MRS    | TGL KRS    | LOS (HARI) | ANTIBIOTIK          | JUMLAH ANTIBIOTIK | DOSIS (GRAM) | TOTAL DOSIS (GRAM) | ATC | DDD  |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 1   | M Furqon B      | L/36                | dr. Nimim, Sp.THT | 214625 | Abses Mandibula         | 29/05/2024 | 01/06/2024 | 4          | Clindamycin po      | 3                 | 3x0,3        | 2,7                | 1,8 | 1,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Ceftriaxone         |                   | 2x1          | 8                  | 2   | 3,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Metronidazole inf   |                   | 3x0,5        | 4,5                | 2   | 2,25 |
| 2   | Jumiati         | P/54                | dr. Ardhi, Sp.PD  | 164052 | Volume Depletion        | 29/05/2024 | 01/06/2024 | 4          | Ceftiaxone          | 2                 | 2x1          | 7                  | 2   | 3,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Asam Pipemidat      |                   | 2x0,4        | 2                  | 0,8 | 2,5  |
| 3   | Abdi Suroyo     | L/43                | dr. Ardhi, Sp.PD  | 203535 | Febris / Fever          | 02/06/2024 | 05/06/2024 | 4          | Ceftiaxone          | 2                 | 2x1          | 5                  | 2   | 2,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Ciprofloxacin po    |                   | 2x0,5        | 2                  | 1   | 2    |
| 4   | Ni'ah           | P/74                | dr. Yoga, Sp.JP   | 214835 | Chest Pain              | 02/06/2024 | 06/06/2024 | 5          | Ceftiaxone          | 2                 | 2x1          | 8                  | 2   | 4    |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Levofloxacin po     |                   | 3x0,5        | 3                  | 0,5 | 6    |
| 5   | Hasanuddin      | L/55                | dr. Ardhi, Sp.PD  | 214904 | Volume Depletion        | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 4          | Ceftiaxone          | 2                 | 2x1          | 7                  | 2   | 3,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Asam Pipemidat      |                   | 2x0,4        | 2                  | 0,8 | 2,5  |
| 6   | Rubakyah        | P/42                | dr. Heri, Sp.PD   | 078562 | Vomiting                | 05/06/2024 | 10/06/2024 | 6          | Ceftiaxone          | 2                 | 2x1          | 9                  | 2   | 4,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Asam Pipemidat      |                   | 2x0,4        | 3,2                | 0,8 | 4    |
| 7   | Rochmayati      | P/47                | dr. Sigit, Sp.BP  | 215130 | Post Repair Soft Tissue | 07/06/2024 | 12/06/2024 | 6          | Ceftiaxone          | 2                 | 1x1          | 1                  | 2   | 0,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Ceftriaxone         |                   | 2x1          | 10                 | 2   | 5    |
| 8   | Dyah Ramadhanty | P/23                | dr. Zaki, Sp.B    | 215147 | Colic Abdomen           | 08/06/2024 | 11/06/2024 | 4          | Cefoperazone sodium | 2                 | 1x2          | 2                  | 4   | 0,5  |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Ceftriaxone         |                   | 2x1          | 6                  | 2   | 3    |
| 9   | Sumartono       | L/38                | dr. Andy, Sp. P   | 215239 | Athsma                  | 09/06/2024 | 12/06/2024 | 4          | Ceftriaxone         | 1                 | 2x1          | 5                  | 2   | 2,5  |
| 10  | Liman Harsono   | L/70                | dr. Edi, Sp. U    | 214658 | Calculus of Ureter      | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 3          | Cefizoxime          | 1                 | 1x2          | 2                  | 4   | 0,5  |
| 11  | Ni'matus S      | P/27                | dr. Aida, Sp.OG   | 104116 | SC                      | 13/06/2024 | 16/06/2024 | 3          | Cefazoline          | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Cefadroxile         |                   | 2x0,5        | 2                  | 2   | 1    |
| 12  | Rubinem         | P/62                | dr. Zaki, Sp.B    | 203990 | Tumor Paru              | 14/06/2024 | 16/06/2024 | 3          | Cefoperazone sodium | 2                 | 1x1          | 1                  | 4   | 0,25 |
|     |                 |                     |                   |        |                         |            |            |            | Ceftiaxone          |                   | 2x1          | 4                  | 2   | 2    |

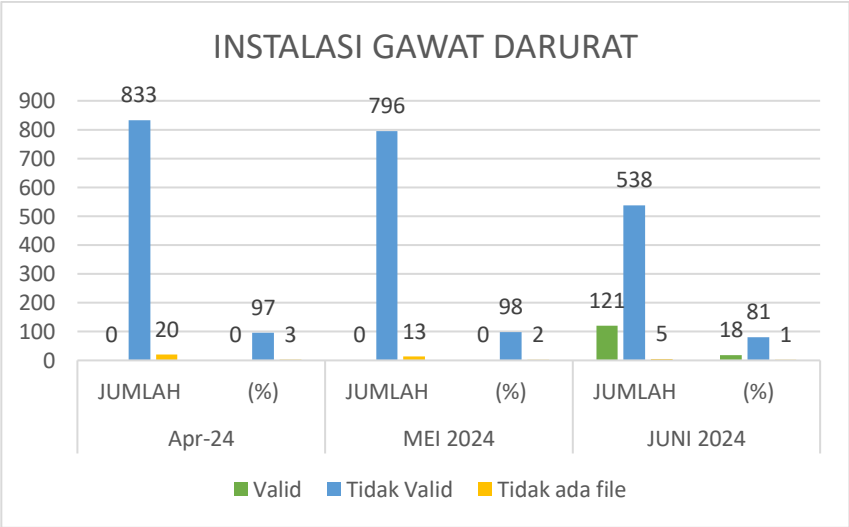
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   |                   |   |        |      |     |      |
|----|-----------------|------|--------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|---|-------------------|---|--------|------|-----|------|
| 13 | Endang Wahyuni  | P/29 | dr. Andy, Sp.P     | 215638 | Febris / Fever              | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 3 | Ceftriaxone       | 2 | 2x1    | 4    | 2   | 2    |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Azitromycin po    |   | 2x0,5  | 2    | 0,3 | 6,67 |
| 14 | Suwandi         | L/53 | dr. Farid, Sp.N    | 210236 | Dyspnea                     | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 5 | Meropenem         | 2 | 3x1    | 15   | 3   | 5    |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Levofloxacin inf  |   | 1x0,75 | 3,75 | 0,5 | 7,5  |
| 15 | Ida Marlinawati | P/49 | dr. Heri, Sp. B    | 100853 | Shock hipovolemik, anemia   | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 5 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1    | 8    | 2   | 4    |
| 16 | Sujiono         | L/59 | dr. Zaki, Sp.B     | 116131 | Colic abdomen               | 23/06/2024 | 27/06/2024 | 5 | Ceftiaxone        | 2 | 2x1    | 7    | 2   | 3,5  |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Metronidazole inf |   | 3x0,5  | 5    | 1,5 | 3,3  |
| 17 | Rochmatul J     | P/24 | dr. Humaira, Sp.OG | 215870 | SC                          | 24/06/2024 | 26/06/2024 | 3 | Cefazoline        | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Cefadroxile       |   | 2x0,5  | 2    | 2   | 1    |
| 18 | Firmansyah      | L/39 | dr. Meyrna, Sp.THT | 215875 | Sinuses                     | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 5 | Ceftiaxone        | 2 | 2x1    | 8    | 2   | 4    |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Metronidazole inf |   | 3x0,5  | 6    | 1,5 | 4    |
| 19 | Ferlyna Vivi    | P/31 | dr. Humaira, Sp.OG | 151815 | Kista                       | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 3 | Ceftriaxone       | 2 | 1x1    | 1    | 2   | 0,5  |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Amoxicilline tab  |   | 2x0,5  | 3    | 1,5 | 2    |
| 20 | Paino           | L/66 | dr. Anton, Sp.B    | 215965 | Necrotizing fasciitis pedis | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 3 | Ceftriaxone       | 3 | 1x1    | 1    | 2   | 0,5  |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Ceftriaxone       |   | 3x1    | 7    | 2   | 3,5  |
|    |                 |      |                    |        |                             |            |            |   | Metronidazole po  |   | 3x0,25 | 4,5  | 2   | 3,5  |

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

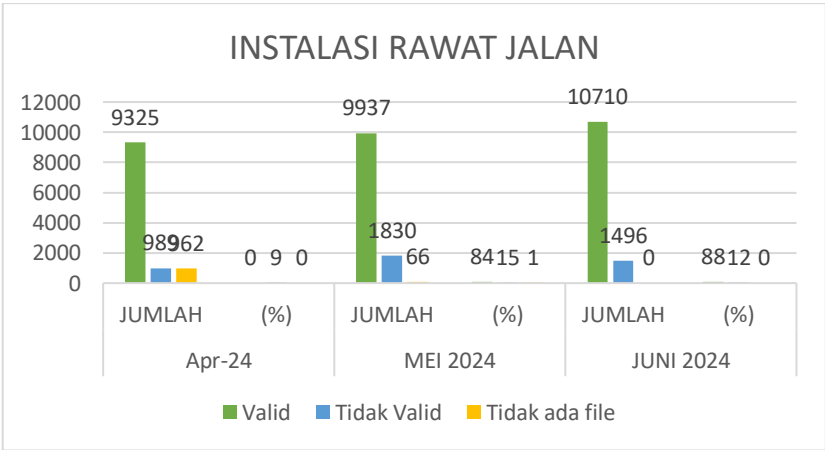
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan April - Juni 2024

| NO    | UNIT      | KUALIFIKASI    | BULAN      |      |          |     |           |     |
|-------|-----------|----------------|------------|------|----------|-----|-----------|-----|
|       |           |                | APRIL 2024 |      | MEI 2024 |     | JUNI 2024 |     |
|       |           |                | JUMLAH     | (%)  | JUMLAH   | (%) | JUMLAH    | (%) |
| 1     | IGD       | Valid          | 0          | 0    | 0        | 0   | 121       | 18  |
|       |           | Tidak Valid    | 833        | 97   | 796      | 98  | 538       | 81  |
|       |           | Tidak ada file | 20         | 3    | 13       | 2   | 5         | 1   |
| Total |           |                | 853        |      | 809      |     | 664       |     |
| 2     | IRJA/POLI | Valid          | 9325       | 82,5 | 9937     | 84  | 10710     | 88  |
|       |           | Tidak Valid    | 989        | 9    | 1830     | 15  | 1496      | 12  |
|       |           | Tidak ada file | 962        | 8,5  | 66       | 1   | 0         |     |
| Total |           |                | 11276      |      | 11833    |     | 12206     |     |

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan April - Juni 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan April - Juni 2024



Analisis :

- 1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 121 Data E-RM dari 0 Data E-RM, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
- 2. Ada 81% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis.
- 3. Terjadi penurunan data tidak valid di IRJA, hal ini juga disebabkan adanya perubahan alur penyetoran casemix/data kunjungan pasien per hari.

Masalah :

- 1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- 2. Ada beberapa tanda tangan pasien belum muncul.
- 3. Pada fitur “keadaan umum” di lembar triage pengkajian awal medis igd muncul di Billing rekam medis, tetapi di Billing IGD tidak muncul.
- 4. Berikut link permasalahan yang ditemui

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ\\_D\\_k/edit#gid=1732600455](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455)

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidakiengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

- 1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

| NO                                               | MASALAH                                                                                                     | TINDAK LANJUT |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A. Permasalahan Dari Unit                        |                                                                                                             |               |                                                                               |
| 1                                                | Kebersihan yang ada di iko harus di jaga,menemukan alat slang suction yang kotor dan kurang enak di pandang | P             | Meningkatkan kepatuhan kebersihan tim IKO                                     |
|                                                  |                                                                                                             | D             | Membuat SOP Kebersihan di IKO Supervisi                                       |
|                                                  |                                                                                                             | S             | Pada saat di supervisi dari pihak manajemen kebersihan iko masih kurang       |
|                                                  |                                                                                                             | A             | Mengingatkan Karu, pelaksana dan CS                                           |
| B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit |                                                                                                             |               |                                                                               |
| 2                                                | Lampu IKO 2 kurang terang                                                                                   | P             | Mengganti atau memperbaiki lampu operasi tersebut                             |
|                                                  |                                                                                                             | D             | Mengajukan ke bagian PT untuk penggantian karena sudah tidak dapat diperbaiki |
|                                                  |                                                                                                             | S             | Ada beberapa dokter dpjp komplain tentang lampu yang ada di IKO 2             |
|                                                  |                                                                                                             | A             | Follow up berkala hingga barang datang                                        |

### 3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

| NO                                               | MASALAH                                                                                                                           | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Permasalahan Dari Unit                        |                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                | Pengambilan BMHP ke farmasi masih belum tepat waktu                                                                               | P             | Meningkatkan kedisiplinan dalam pengambilan BMHP oleh perawat IGD                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                   | D             | Membuat jadwal pengambilan                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                   | S             | Staf perawat/ pj barang selalu lupa mengambil barang di farmasi                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                                   | A             | Meningkatkan komunikasi dengan pj BMHP dan selalu di follow up                                                                                                                                                                     |
| 2                                                | Dokter IGD kesulitan saat pasien IGD membludak dan di ruangan ada emergency (saat shift sore-malam) sehingga menimbulkan complain | P             | Menambah dokter IGD sesuai analisa beban kerja                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                                                                                   | D             | Menambah dokter IGD menjadi 2 dokter dalam 1 shift                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                                                                                                   | S             | Beberapa dokter IGD tidak setuju jika 1 shift dibuat 2 dokter, Solusi dari dokter IGD adalah dibuat jadwal middle namun belum terealisasi karena beberapa dokter tidak focus di PHM dan hanya meminta jadwal sedikit dalam 1 bulan |
|                                                  |                                                                                                                                   | A             | Menambah dokter IGD                                                                                                                                                                                                                |
| B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit |                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                | Dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD                                                                     | P             | Meningkatkan kepatuhan pengisian ERM oleh dokter IGD                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                                   | D             | Menegur dokter IGD untuk dapat melengkapi ERM sebelum pulang                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                                                                                                                                   | S             | Beberapa dokter IGD tidak paham apa yang harus diisi<br>Dokter IGD mengaku tidak sempat mengisi ERM saat pasien banyak                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                   | A             | Memberikan arahan terkait point-point di ERM pada dokter IGD<br>Mengingatkan dokter IGD untuk menyelesaikan ERM sebelum pulang                                                                                                     |

### 3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

| NO | MASALAH                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rekam medis tidak lengkap                                                                                                                                              | P             | Meningkatkan kelengkapan rekam medis                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                        | D             | Melakukan supervisi                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                        | S             | Perawat tidak paham mengenai poin poin yang wajib dilengkapi, DPJP kurang patuh dalam mengisi rekam medis  |
|    |                                                                                                                                                                        | A             | Membuat pelatihan pengisian dan kelengkapan rekam medis                                                    |
| 2  | Sistem input tarif di SIMRS sering bermasalah karena ada inputan tarif yang otomatis tetapi tidak sesuai sehingga mempengaruhi kontrol biaya dan membuat DPJP complain | P             | Meningkatkan kendali mutu kendali biaya                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                        | D             | Menyampaikan sisa plafon dari kontrol biaya di SIMRS pada DPJP                                             |
|    |                                                                                                                                                                        | S             | Terdapat inputan yang tidak sesuai dan muncul secara otomatis sehingga membuat kontrol biaya menjadi rancu |
|    |                                                                                                                                                                        | A             | Memperbaiki system penginputan di SIMRS agar tidak ada kekeliruan dengan cara koordinasi dengan programmer |
| 3  | Isi paket operasi SC tidak lengkap di irna                                                                                                                             | P             | Selalu mengecek barang yang akan di terima dari farmasi                                                    |
|    |                                                                                                                                                                        | D             | Komunikasi dan koordinasi dengan perawat irna dan farmasi                                                  |
|    |                                                                                                                                                                        | S             | Terdapat banyak kasus, paket SC yang tidak lengkap baik dari maternitas dan irna                           |
|    |                                                                                                                                                                        | A             | Memperbaiki sitem serah terima paket sc                                                                    |

### 3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

| NO | MASALAH                                                                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ada obat-obatan yang dokter tidak bisa input karena stok di depo 0 contoh H202 100 ml, sehingga harus menunggu serah terima dari gudang ke depo dulu                                                         | P             | Menghindari terjadinya kekosongan stok di SIMRS agar obat dapat segera diinput                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                              | D             | Koordinasi dengan Kabid Penunjang agar prosedur serah terima dievaluasi kembali, misal meningkatkan jumlah permintaan atau menambah stok minimum di depo |
|    |                                                                                                                                                                                                              | S             | Masih belum terlaksana karena butuh koordinasi lebih lanjut                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                              | A             | Koordinasi lebih lanjut                                                                                                                                  |
| 2  | Poli jantung kewalahan jika treadmill mcu dalam satu hari lebih dari 4, karena dalam satu hari sudah ada jadwal tindakan echo rawat jalan maupun ruangan, sehingga jika terlalu lama potensi pasien komplain | P             | Membatasi jumlah treadmill MCU hanya 4 pasien per hari untuk mencegah komplain                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                              | D             | Koordinasi dengan Humas Marketing untuk menginformasikan pihak eksternal yang berencana treadmill MCU                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                              | S             | Masih ada pasien yang tiba-tiba datang melebihi kuota                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                              | A             | Melakukan penjadwalan ulang dan koordinasi dengan pihak eksternal                                                                                        |

### 3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

| NO | MASALAH                                                                | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual               | P             | Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                        | D             | Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                        | S             | Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                        | A             | Follow up ke Programmer Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Terjadi kekosongan konsinyasi implan sehingga pelayanan tidak maksimal | P             | Proses pemesanan implan dilakukan setiap hari oleh bagian pengadaan PT sesuai dengan permintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                        | D             | Melakukan perubahan alur mulai dari penyerahan LPO dari IKO (maksimal 1x24jam setelah dipakai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                        | S             | Jumlah konsinyasi terbatas dari distributor, sehingga implant tidak tersedia ketika dibutuhkan saat durante operasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                        | A             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan LPO dilakukan setiap hari dari perawat IKO ke Gudang farmasi.</li> <li>2. Pengecekan kesesuaian implan yang tertulis di LPO dengan inputan tagihan dilakukan setiap hari oleh petugas Gudang farmasi.</li> <li>3. Pemesanan implan ke distributor dilakukan setiap hari.</li> <li>4. Koordinasi dengan pengadaan untuk menambah jumlah konsinyasi.</li> </ol> |

|   |                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Selisih stok di Depo, Gudang Farmasi, IKO dan Gudang Retur Farmasi                                                                                                                                      | P | Memperbaiki monitoring stok antara fisik dengan system.                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                         | D | Menegakkan kembali sistem serah terima pada permintaan barang Depo ke Gudang Farmasi, melakukan double check ketika proses serah terima barang antara stok fisik yang telah disiapkan dan jumlah release di sistem. |
|   |                                                                                                                                                                                                         | S | Terjadinya selisih stok secara terus menerus pada depo dan Gudang Farmasi,                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                         | A | Koordinasi dengan Programmer terkait sistem IKO dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO.<br>Return barang IKO yang tidak sesuai jumlah FS ke Gudang Farmasi dilakukan setiap hari.                          |
| 4 | Retur penjualan obat yang tidak diambil pasien, di retur ke Gudang farmasi di fitur penerimaan hibah lainnya namun resep kronis tidak di hapus di apotek online, dan tidak dihapus di penjualan farmasi | P | Memperbaiki alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                         | D | Koordinasi dengan Kabid, Keuangan, Verifikator dan Managemen PT DPM.                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                         | S | Tidak ada laporan tarikan data pasien khusus BPJS kesehatan karena berkaitan dengan data pasien yang akan di hapus datanya di apotek online.                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                         | A | Obat belum direturn ke apotek online beserta racikannya. Hasil keputusan PT racikan di anggap kerugian maka racikan tetap di retur tapi dihapus dari penjualan.                                                     |
| 5 | Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.                                                                                                                        | P | Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                         | D | Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                         | S | Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasein di Poli sampai menunggu di Farmasi.                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                         | A | 1. Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama.<br>2. Resep obat diinput per pasien oleh DPJP.                                                                                                       |

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

| NO | MASALAH                                                                              | TINDAK LANJUT |                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS                                    | P             | Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.               |
|    |                                                                                      | D             | Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.              |
|    |                                                                                      | S             | LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.     |
|    |                                                                                      | A             | Follow up berkala ke Programmer.                                          |
| 2  | Kurangpahamnya petugas melakukan analisa serah terima hasil pemeriksaan laboratorium | P             | Memperbaiki SPO serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien |
|    |                                                                                      | D             | Koordinasi dengan Karu untuk meminimalisir terjadinya                     |

|  |  |   |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   | kesalahan/keterlambatan pemberian hasil pemeriksaan dan membuat kesepakatan alur serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien                                         |
|  |  | S | Memperbaiki alur setelah analisis melakukan sampling, surat pengantar diberikan petugas input dan diberi keterangan “pasien rawat jalan, hasil ditunggu”.                          |
|  |  | A | 1. Petugas input wajib segera menyerahkan hasil kepada pasien setelah selesai input.<br>2. Mendokumentasikan jika petugas sudah memanggil nama pasien tetapi tidak segera diambil. |

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

| NO | MASALAH                                                                             | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketidaksesuaian antara fitur e-rm poli dengan rekam medis                           | P             | Memperbaiki fitur e-rm poli dan rekam medis.                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                     | D             | Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                     | S             | Mencatat temuan permasalahan e-rm dan dilaporkan kepada Programmer.                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                     | A             | Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemukan masalah e-RM.                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Terjadi keterlambatan penginputan hasil di Aplikasi DINKES (PROGNAS HIV, HEPATITIS) | P             | Memperbaiki alur pelaporan.                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                     | D             | 1. Koordinasi dengan PJ PROGNAS dan Unit terkait.<br>2. Sosialisasi alur terbaru.                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                     | S             | Pengumpulan data tidak realtime.                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                     | A             | 1. Melakukan kegiatan sesuai dengan jobdesc.<br>2. Koordinasi dengan pelayanan terkait kelengkapan yang dibutuhkan, supaya membantu petugas dalam penginputan hasil saat hari H pemeriksaan.<br>3. Pengumpulan form hari H setelah pemeriksaan di rekam medis. |

3.7.8 Permasalahan CSSD

| NO | MASALAH                                       | TINDAK LANJUT |                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi. | P             | Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.                                                                 |
|    |                                               | D             | Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.                           |
|    |                                               | S             | Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya. |
|    |                                               | A             | Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan.                         |

3.7.9 Permasalahan Laundry

| NO | MASALAH                                            | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih. | P             | Memperbaiki alur pencucian.                                                                                                                                          |
|    |                                                    | D             | Menerapkan alur baru.                                                                                                                                                |
|    |                                                    | S             | Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.                                                                                                       |
|    |                                                    | A             | 1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia).<br>2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO. |

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

| NO | UNIT                  | PENDIDIKAN                      | TOTAL | JUMLAH | TETAP | TIDAK TETAP | RESIGN |
|----|-----------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| 1  | Direktur              | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 2  | Kabid Pelayanan medik | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 3  | Kabid Penunjang Medik | D3 Kebidanan                    | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 4  | Kabid Umum & Keuangan | Dokter Gigi                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 5  | Kabid Keperawatan     | Profesi Ners                    | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 6  | Dokter IGD            | Dokter Umum                     | 7     | 7      | 0     | 7           | 0      |
| 7  | Dokter Ruangan        | Dokter Umum                     | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 8  | Farmasi               | SMK                             | 41    | 5      | 0     | 5           | 0      |
|    |                       | D3 Farmasi                      |       | 19     | 4     | 15          | 1      |
|    |                       | S1 Apoteker                     |       | 12     | 0     | 12          | 0      |
|    |                       | S1 Farmasi                      |       | 3      | 0     | 3           | 0      |
|    |                       | S1 Analisis Farmasi dan Makanan |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | S1 Ekonomi                      |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 9  | Asuransi Center       | SMA                             | 11    | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                             |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kesehatan                    |       | 3      | 0     | 3           | 0      |
|    |                       | D3 Asuransi Kesehatan           |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 RMIK                         |       | 5      | 0     | 5           | 0      |
| 10 | CSSD                  | SMK                             | 4     | 2      | 1     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Keperawatan                  |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Farmasi                      |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 11 | Fisioterapi           | D3 Fisioterapi                  | 4     | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kesehatan                    |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | S1 Terapi Wicara                |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 12 | Gizi                  | SMP                             | 16    | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                             |       | 6      | 0     | 6           | 0      |
|    |                       | SMA                             |       | 2      | 0     | 2           | 0      |
|    |                       | D3 Gizi                         |       | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D4 Gizi                         |       | 2      | 0     | 2           | 0      |
|    |                       | S1 Gizi                         |       | 2      | 1     | 1           | 0      |
| 13 | Humas &               | S1 Kesehatan                    | 2     | 1      | 0     | 1           | 0      |

|    |                        |                       |    |    |   |    |   |
|----|------------------------|-----------------------|----|----|---|----|---|
|    | Marketing              | Masyarakat            |    |    |   |    |   |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 1  | 0 | 0  | 0 |
| 14 | ICU dan HCU            | D3 Keperawatan        | 12 | 5  | 1 | 4  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 6  | 4 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Kebidanan          |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 15 | IGD                    | D3 Kebidanan          | 28 | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | D4 Kebidanan          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 10 | 0 | 10 | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 7  | 1 | 6  | 0 |
| 16 | IKO                    | D3 Kebidanan          | 12 | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 3  | 1 | 2  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 3 | 5  | 0 |
| 17 | IPCN                   | Profesi Ners          | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 18 | IPSRS                  | D3 TEM                | 7  | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | SKM                   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | D3 Teknik             |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | S1 Teknik             |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | SMA                   |    | 3  | 1 | 2  | 0 |
| 19 | IRJA                   | D3 Kebidanan          | 27 | 5  | 3 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Keperawatan        |    | 13 | 6 | 7  | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan Gigi   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 4 | 4  | 0 |
| 20 | IRNA 2C                | D3 Keperawatan        | 7  | 2  | 0 | 2  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 1 | 4  | 0 |
| 21 | IRNA 6A & 7A & 8A      | D3 Keperawatan        | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 4  | 0 | 4  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 8  | 0 | 8  | 0 |
| 22 | IRNA 3C Anak           | D3 Keperawatan        | 14 | 8  | 0 | 8  | 0 |
|    |                        | D4 Keperawatan        |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 23 | IRNA 3A & 4A           | D3 Keperawatan        | 19 | 14 | 0 | 14 | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 24 | IRNA 5C                | D3 Keperawatan        | 10 | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 5  | 0 | 5  | 0 |
| 25 | Maternitas             | D3 Kebidanan          | 11 | 7  | 7 | 1  | 1 |
|    |                        | D4 Kebidanan          |    | 2  | 1 | 1  | 0 |
|    |                        | Profesi Bidan         |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 26 | Neonatologi            | D3 Keperawatan        | 9  | 5  | 0 | 5  | 0 |
|    |                        | Profesi Ners          |    | 4  | 3 | 1  | 0 |
| 27 | Keuangan dan Akuntansi | SMA                   | 10 | 4  | 1 | 3  | 0 |
|    |                        | S1                    |    | 5  | 3 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Keuangan           |    | 1  | 0 | 1  |   |
| 28 | Laboratorium           | D3 Kesehatan          | 10 | 4  | 0 | 4  | 0 |
|    |                        | D3 Analisis Kesehatan |    | 4  | 1 | 3  | 0 |
|    |                        | D4 Analisis Kesehatan |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 29 | Laundry                | SMA                   | 5  | 5  | 3 | 2  | 0 |
| 30 | Rekam Medis            | D3 RMIK               | 10 | 9  | 3 | 6  | 0 |
|    |                        | D4 RMIK               |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 32 | Pendaftaran            | SMA                   | 15 | 6  | 1 | 5  | 0 |
|    |                        | D3 RMIK               |    | 4  | 2 | 2  | 0 |
|    |                        | D3 Kesehatan          |    | 2  | 0 | 2  | 0 |

|    |                                                    |                                  |    |    |   |    |   |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|---|----|---|
|    |                                                    | S1 Sosial                        |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                                                    | D4 Manajemen                     |    | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 33 | PIPP                                               | Ners                             | 5  | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                                                    | D3 Keperawatan                   |    | 1  | 0 | 1  | 0 |
|    |                                                    | D3 Kebidanan                     |    | 1  | 1 | 0  | 0 |
|    |                                                    | D4 Kebidanan                     |    | 2  | 1 | 1  | 0 |
| 34 | PMKP                                               | Profesi Ners                     | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 35 | Radiologi                                          | D3 Radiodiagnostik & Radioterapi | 7  | 7  | 0 | 7  | 0 |
| 36 | SDM                                                | S1 Psikologi                     | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 37 | Sekretaris                                         | S1 Administrasi Publik           | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 38 | SIMRS & IT                                         | S1 Komunikasi                    | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 39 | Umum Rumah Tangga                                  | S1 Ekonomi                       | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 40 | Cleaning Service                                   | SMP                              | 44 | 3  | 1 | 2  | 0 |
|    |                                                    | SMA                              |    | 41 | 5 | 36 | 0 |
| 41 | Security                                           | SMA                              | 12 | 12 | 6 | 6  | 0 |
| 42 | Driver                                             | SMA                              | 5  | 5  | 1 | 4  | 0 |
| 43 | Gudang Umum                                        | SMA                              | 1  | 1  | 1 | 0  | 0 |
| 44 | Dokter Spesialis Syaraf                            |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 45 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah        |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 46 | Dokter Spesialis Paru                              |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 47 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam                    |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 1 |
| 48 | Dokter Spesialis Anestesi                          |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 49 | Dokter Spesialis Bedah                             |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 50 | Dokter Spesialis Bedah Plastik                     |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 51 | Dokter Spesialis Orthopedi                         |                                  | 3  | 3  |   | 3  | 0 |
| 52 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi                  |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 53 | Dokter Spesialis Patologi Klinis                   |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 54 | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 55 | Dokter Spesialis Mata                              |                                  | 3  | 3  | 0 | 3  | 0 |
| 56 | Dokter Spesialis Urologi                           |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 57 | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                    |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |
| 58 | Dokter Spesialis Obstetry Ginekology               |                                  | 4  | 4  | 0 | 4  | 0 |
| 59 | Dokter Gigi Spesialis Orthodontist                 |                                  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 |
| 60 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin                 |                                  | 2  | 2  | 0 | 2  | 0 |

---

|       |                                     |  |     |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------------|--|-----|---|---|---|---|
| 61    | Dokter Spesialis<br>THT             |  | 2   | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62    | Dokter Spesialis<br>Gigi Periodonti |  | 1   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63    | Dokter Spesialis<br>Radiologi       |  | 2   | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL |                                     |  | 451 |   |   |   |   |

---

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

#### **B. SARAN**

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

---

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan bulan Juni 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Juni 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Juli 2024  
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



**dr. Nur Mazidah**



## LAMPIRAN

| NO | INSTANSI                                            | NAMA PKS                                        | NOMOR RS                            | NOMOR INSTANSI                     | MASA BERLAKU     |                     | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1  | PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia | Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat            | 028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023         | 0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123         | 30/01/2023       | 31/01/2023          | BERLAKU    |
| 2  | PT. Asuransi Allianz Life Indonesia                 | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                  | -                                   | 729/AZLI-LGL/AG/XII/2017           | 12 Desember 2017 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 3  | PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)     | Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan        | -                                   | 640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019        | 26 AGUST 2019    | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 4  | PT. Fullerton Health Indonesia                      | Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan        |                                     | 640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019        | 26 Agustus 2019  | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 5  | PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE                        | Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan |                                     | 3143/PMN-PA/IV/2020                | 13/04/2020       | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 6  | PT. Java Smartindo                                  | Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan         | 364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020         | PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C | 21/08/2020       | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 7  | PT PLN Insurance                                    | Asuransi Pelayanan Kesehatan                    | 612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019          | 300/PKS/TKI/X/2019                 | 30/10/2019       | Perpanjang Otomatis | BERLAKU    |
| 8  | Avrist Assurance                                    | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                  | 951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023 |                                    | 24/08/2023       | 24/08/2025          | BERLAKU    |
| 9  | BPM Inung Indah sari                                | Rujukan Asuhan                                  | 004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022          | -                                  | 10/1/2022        | 1/10/2025           | BERLAKU    |

|    |                                      |                                                   |                                  |                             |             |                     |         |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------|
|    |                                      | Pasien                                            |                                  |                             |             |                     |         |
| 10 | KLINIK TIRTO HUSADA                  | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang                 |                                  |                             | 3/3/2018    | 3/2/2024            | BERLAKU |
| 11 | Klinik Dokter 24 Jam                 | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang                 |                                  |                             | 16/3/2020   | 3/16/2024           | BERLAKU |
| 12 | Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari | Rujukan Asuhan Pasien                             | 107.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2023  | 031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023 | 15/04/2023  | 15/04/2026          | BERLAKU |
| 13 | Klinik Rawat Inap Wijaya Husafa      | Rujukan Asuhan Pasien                             | 001/PKS/15/4/2023                | 113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023  | 15/04/2023  | 15/04/2026          | BERLAKU |
| 14 | Klinik Endisa Husada                 | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang                 | 148.3/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2023 | PK/01/VII/2023-KEH          | 21/07/2023  | 21/07/2026          | BERLAKU |
| 15 | PT. JAYA OBAYASHI                    | Pelayanan Kesehatan                               | 360/DPM/I-PKS/VIII/2020          |                             | 1/7/2020    | 1/7/2025            | BERLAKU |
| 16 | PT. PANCAMAS ELITE                   | Pelayanan Kesehatan                               | 032/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020   |                             | 1/7/2020    | 7/1/2025            | BERLAKU |
| 17 | PT. TIRTA INVESTAMA                  | Pelayanan Kesehatan Karyawan & Keluarga           |                                  |                             | 31/08/2020  | 31/08/2025          | BERLAKU |
| 18 | PT HM Sampoerna Tbk                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan               | -                                | 55/Perj/HMS/IX/2014         | 1 Juni 2014 | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 19 | PT Adonai Manajemen Kesehatan        | Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Medisak Chek Up |                                  | 055/PKS-PF/AMK/VIII/2019    | 26/08/2019  | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 20 | PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                    |                                  |                             | 30/03/2015  | perpanjang otomatis | BERLAKU |

|    |                                         |                                                                                    |                              |                               |            |                     |         |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------|
| 21 | PT. Nestle Indonesia<br>Kejayan Factory | Pelayanan Kesehatan                                                                |                              |                               | 1/4/2013   | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 22 | Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)    | Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit                                      |                              |                               | 22/04/2022 | 22/04/2026          | BERLAKU |
| 23 | RSUD Dr. Saiful Anwar Malang            | Rujukan Asuhan Pasien                                                              | 1562.1/e-pks/dir/xi/2022     | 116/302/2019                  | 1/11/2022  | 1/11/2024           | BERLAKU |
| 24 | RS SITI MIRIAM LAWANG                   | Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah                               | 151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022   | 810/HMS/RSSM/X/2022           | 4/10/2022  | 3/7/2024            | BERLAKU |
| 25 | RS Prima Husada Sukorejo                | Rujukan Asuhan Pasien                                                              | 213/E-PKS/DIR/III/2019       | 126/RSPHS/E-PKS/III 2019      | 21/02/2022 | 2/21/2025           | BERLAKU |
| 26 | RS PANTI NIRMALA                        | Kerjasama Pelayanan Rujukan                                                        | 152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022 | 3740/069/RSPN/X/2022          | 7/10/2022  | 6/10/2025           | BERLAKU |
| 27 | RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)             | Rujukan Pekayanan Penunjang                                                        | 1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022     | 116//102.7/2022               | 1/11/2022  | 1/11/2024           | BERLAKU |
| 28 | RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  | Rujukan Pelayanan Kesehatan                                                        | 220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023   | HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023 | 30/10/2021 | 30/10/2026          | BERLAKU |
| 29 | BPJS KETENAGAKERJAAN                    | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS | 1571/E-PKS/DIR/XII/2022      | PER/60/102022                 | 1/1/2023   | 31/12/2024          | BERLAKU |

|    |                                                  |                                                                                                      |                                                |                               |            |                     |         |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------|
|    |                                                  | Ketenagakerjaan                                                                                      |                                                |                               |            |                     |         |
| 30 | PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) | Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan                                                                 | 015/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2019                  | PKS-0097/XI/2019/MAG-R2       | 28/01/2020 | 27/01/2024          | BERLAKU |
| 31 | PT. Lippo General Insurance                      | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                                                                       | 267/RSPHS/E-<br>PKS/DOR/VI/2019                | 1502/LI-HOSPT/VI/2019         | 18/09/2019 | 18/09/2024          | BERLAKU |
| 32 | PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)   | Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan | 912.1/E-<br>PKS/DIR/VII/2022                   | P/13/SP/2022                  | 4/7/2022   | 4/7/2027            | BERLAKU |
| 33 | PT AIA FINANCIAL                                 | Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan                                                            | 069/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2020                   | 639/AIA-DPM/XI/2020           | 4/11/2020  | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 34 | PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)             | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                                                                       | 150/ PKS-<br>RSPRIMAHUSADA-<br>MAT/DIR/XI/2016 |                               | 28/11/2016 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 35 | PT. ASURANSI JASA INDONESIA                      | Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan                                                            | PKS.031/GHASKES/157-<br>1/2020                 | 053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020   | 28/08/2020 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 36 | PT. Asuransi AA Internasional                    | Pelayanan Kesehatan                                                                                  | -                                              | AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015    | 19/09/2019 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 37 | PT. SUPRIMA MITRA ADIHUSADA                      | Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan                                                            |                                                | 640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019 | 26/08/2019 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 38 | PT. EQUITY LIFE IND-                             | Perjanjian Pelayanan                                                                                 |                                                | 091/ELI/LGL/X/19              | 14/10/2019 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |

|    |                                     |                                                     |                                |                                 |                   |                     |         |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------|
|    | CORPORATE                           | Kesehatan                                           |                                |                                 |                   |                     |         |
| 39 | PT. Axa Services Indonesia          | Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan              | -                              | 067/AGR-Leg/ASI/VII/2013        | 15 Agustus 2013   | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 40 | PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig     | Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan            | -                              | 063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012 | 10/9/2012         | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 41 | PT. Asuransi Jiwa Sinarmas          | Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap | 010/DPM/E-<br>PKS/DIR/IX/2019  | 364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019    | 4/9/2019          | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 42 | PT. Hanwha Life Insurance Indonesia | Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan              | -                              | 0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015     | 16 Maret 2015     | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 43 | PT. EQUITY LIFE IND-CASSLES         | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                      |                                | 090/ELI/LGL/X/19                | 14/10/2019        | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 44 | PT. Asuransi Reliance Indonesia     | Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan            | 490/RSPH/I-<br>IKS/DIR/XI/2016 | 930.01/UM/ARI-RS/XI2016         | 7/9/2020          | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 45 | PT. Asuransi Adira Dinamika         | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                      | PH/E-IKS/171/X/2013            | 499B/AAD-LEG-AGR/X/2013         | 24 Oktober 2013   | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 46 | PT. Prima Sarana Jasa               | Pelayanan Kesehatan                                 | 735/E-PKS/DIR/IX/2018          | 296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018      | 17 September 2018 | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 47 | PT. BNI Life Insurance              | Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan            | 082/RSPH/E-<br>IKS/DIR/II/2016 | 274.PKS.BL.DIR.0716             | 25/07/2019        | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 48 | Administrasi Medika (Admedika)      | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                     | 025/RSPH/E-<br>PKS/DIR/IV/2015 | 141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015        | 28-Apr-15         | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 49 | Asuransi Jiwa Generali              | Perjanjian Pelayanan                                | 070/DPM/E-<br>PKS/DIR/IX/2019  | 109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019      | 10/10/2019        | perpanjang otomatis | BERLAKU |

|    |                                                          |                                                                  |                              |                                           |                 |                     |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|    |                                                          | Kesehatan                                                        |                              |                                           |                 |                     |         |
| 50 | PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)            | Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan                   | PH/IKS/100/II/2015           | 095/LA/MoU/00300/2015                     | 25/02/2015      | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 51 | PT. Asuransi Takaful Keluarga                            | Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan                         | 508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016  | 0642/PKS-RS-01/II/2017                    | 02 Januari 2017 | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 52 | PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia                     | Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu                  | 017/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019   | 045-02/EB-CONT/2020                       | 2 MARET 2020    | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 53 | PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)                           | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                                   | 795/E-ADD/DIR/XI/2019        | DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019                | 29/11/2019      | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 54 | PT. Pan Pacific Insurance                                | Pelayanan Perawatan dan Pengobatan                               | 017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020  | 0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020 | 31/08/2020      | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 55 | PT. Jasindo Health Care                                  | Pelayanan Perawatan dan Pengobatan                               | -                            | -                                         | 1/4/2015        | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 56 | PT. International Services Pacific Cross                 | Asuransi Pelayanan Kesehatan                                     | 150/DPM/E- PKS/DIR/X/2022    | 953/ISPC/PKS/X/2022                       | 3/10/2022       | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 57 | PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)               | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                                   | 103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023 | 358/KBM-DPM/PKS/VI/2023                   | 26/06/2023      | 25/06/2026          | BERLAKU |
| 58 | PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM) | Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang |                              |                                           | 7/2/2023        | 04/072027           | BERLAKU |

|    |                                                    |                                              |                                  |                        |            |                   |         |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|-------------------|---------|
|    |                                                    | Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan          |                                  |                        |            |                   |         |
| 59 | BPM Silvian Wulandari                              | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang            | 031/DPM/E-<br>PKS/DIR/III/2022   |                        | 3/10/2021  | 3/10/2024         | BERLAKU |
| 60 | BPM Suma'iyah                                      | Rujukan Pelayanan Kesehatan                  | 686.1/E-PKS/DIR/VI/2023          |                        | 2/5/2023   | 2/5/2026          | BERLAKU |
| 61 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Pelayanan KB IUD, Umplant, MOW dan MOP       | 630/E-PKS/DOR/IV/2023            | 440/146/35.07.120/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2024        | BERLAKU |
| 62 | BKKBN                                              | pelayanan keluarga berencana iud dan implant | 630/E-PKS/DOR/IV/2023            | 440/146/35.07.120/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2024        | BERLAKU |
| 63 | Klinik Mutiara Sehat                               | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang            | 200.11/DPM/I-<br>PKS/DIR/I/2022  |                        | 5/1/2022   | 5/1/2025          | BERLAKU |
| 64 | Klinik BLKI Singosari                              | Rujukan Asuhan Pasien                        | 108.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2023  | 150/0187B00/IV/23      | 24/04/2023 | 27/04/2026        | BERLAKU |
| 65 | Klinik Husada Asih YPAC                            | Kerja sama Penunjang                         |                                  |                        | 11-Sep-12  | Tanpa Batas Waktu | BERLAKU |
| 66 | Klinik Brawijaya Lawang                            | Rujukan Asuhan Pasien                        | 144.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2023 | PKS/115/VII/2023       | 3/7/2023   | 3/7/2026          | BERLAKU |
| 67 | Klinik Garuda                                      | Pelayanan Kesehatan                          | 131.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/V/2023   | B/25/VI/2023           | 31/05/2023 | 31/05/2023        | BERLAKU |
| 68 | Klinik Idamamuk                                    | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang            | 347/DPM/I-<br>PKS/DIR/VII/2021   | 005/VI/2021            | 16/06/2021 | 16/06/2024        | BERLAKU |

|    |                                       |                                                           |                                   |                              |            |            |         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------|
| 69 | Klinik 24 Jam                         | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang                         | 112.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2022 | 138/MOU/VIII/CSH.2022        | 2/8/2022   | 2/8/2025   | BERLAKU |
| 70 | Laboratorium Panglima Sudirman        | Pelayanan Rujukan Laboratorium                            | 135.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2023   | Q.0150/LKPS.VI/25.2023       | 5/6/2023   | 5/6/2026   | BERLAKU |
| 71 | PT. MALANG INTERMEDIA PERS            | Pelayanan Publikasi dan penerbitan artikel                | 166/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2023   | 423/MOU/PMSRN/JPRM/VIII/2023 | 1/9/2023   | 1/2/2024   | BERLAKU |
| 72 | PT. Bangun Sarana Wreksa              | Pelayanan Kesehatan                                       |                                   |                              |            |            | BERLAKU |
| 73 | PT. Kasoem Hearing                    | Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)           | 339.6/E-<br>PKS/DIR/III/2022      | 002/KHC/KSO-SMAD/III/2022    | 1/3/2022   | 1/3/2024   | BERLAKU |
| 74 | PT. MALANG INTERMEDIA PERS            | Pelayanan Kesehatan                                       | 025/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020    | 103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020 | 1/7/2020   | 1/7/2025   | BERLAKU |
| 75 | PT. TASPEN                            | Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja        | 008/E-PKS/DIR/2023                | JAN-01/DIR/2023              | 1/1/2023   | 31/12/2025 | BERLAKU |
| 76 | PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA | Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Karyawan Dan Keluarga | 004/DPM/E-PKS/III/2020            | 452/YMPI/HI/PKS/III/2020     | 1/6/2020   | 1/6/2025   | BERLAKU |
| 77 | PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera     | Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah                        | 060.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/II/2023   | 176/TSA-MOU/MD/II/2023       | 21/02/2023 | 21/02/2024 | BERLAKU |

|    |                                      |                                                   |                              |                                |            |                     |         |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------|
|    |                                      | Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)           |                              |                                |            |                     |         |
| 78 | PT. KSI                              | Pelayanan Kesehatan                               |                              |                                |            |                     | BERLAKU |
| 79 | PT. Samator                          | Operasional Pasokan Produk                        |                              | DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850 | 1/9/2022   | 1/9/2027            | BERLAKU |
| 80 | Harris Hotel & Conventions Malang    | Rujuka Pelayanan Kesehatan                        | 308/E-PKS/PMS/V/2018         | 001/IKS/HR/V/2018              | 14/10/2019 | Perpanjang Otomatis | BERLAKU |
| 81 | PT. Ajinomoto Sales Indonesia        | Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan      | 008/PERS/RSPH-I/2012         | LEG/ASI/120510-85              | 1/5/2012   | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 82 | PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA | Pelayanan Kesehatan                               | 573/I-PKS/PMS/IV/2019        | 004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019   | 1/9/2019   | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 83 | PT. DUHA MULYA ABADI                 | Penyediaan paket BHP Operasi Katarac              |                              |                                | 1/11/2019  |                     | BERLAKU |
| 84 | PT. Indolakto Pandaan                | Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja ( PPK) |                              |                                | 10/1/2014  | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 85 | PT. KTG (KENCANA TIARA GEMILANG)     | Pelayanan Kesehatan                               | 174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021 | 017/KTG/HRGA.06/XII/2021       | 12/12/2021 | 12/12/2024          | BERLAKU |
| 86 | PT. Sumber Alfaria                   | Pelayanan Kesehatan                               | 142.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023  | 0002/SDM-MLG/VI/2023           | 22/06/2023 | 22/06/2026          | BERLAKU |
| 87 | PT. ETERCON PHARMA                   | Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien       | 132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023  | 039/ETC-CBX/PKS/VII/2023       | 1/6/2023   | 1/6/2024            | BERLAKU |

|    |                                            |                                                                       |                                      |                                            |            |            |         |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---------|
|    |                                            | Maternitas                                                            |                                      |                                            |            |            |         |
| 88 | PT. RENTOKIL                               | Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station       | 173.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/IX/2023      | 003/PT.RI/MLG-<br>37/52400326/IX/2023      | 11/9/2023  | 11/9/2024  | BERLAKU |
| 89 | PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA                | Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang                             | 302/DPM/I-<br>PKS/DIR/VI/2021        | 001/PKS-IU-HRD/VI/2021                     | 8/6/2021   | 8/6/2024   | BERLAKU |
| 90 | PT. TSSA<br>(Teman Sejati Sejahtera Abadi) | Pengelolaan Limbah B3                                                 | 0175/LGL-PK/DPM-<br>TSSA-AMP/II/2023 |                                            | 6/2/2023   | 6/2/2024   | BERLAKU |
| 91 | PT. NAYAKA ERA HUSADA                      | Pelayanan Kesehatan                                                   | 143.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2023     | PKS/106/072023                             | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BERLAKU |
| 92 | PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)           | Layanan Antar Obat Pasien                                             | 138.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2023      | 003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/<br>MLG/23-24 | 15/06/2023 | 15/06/2024 | BERLAKU |
| 93 | PT. Global Trans Jaya Mulia                | Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  | 060.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/II/2023      | 037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023             | 1/4/2023   | 31/03/2024 | BERLAKU |
| 94 | PMI Kabupaten Malang                       | Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya | 768/E-PKS/DIR/V/2023                 | 0                                          | 1/6/2023   | 1/6/2024   | BERLAKU |
| 95 | RS LAVALETTE                               | Rujukan Asuhan                                                        | 155.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2023    | RSL-KONTR-PKS/VII/23.124                   | 10/8/2023  | 10/8/2025  | BERLAKU |

|     |                               |                                                         |                                  |                             |                 |                     |         |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|     |                               | Pasien & Penunjang                                      |                                  |                             |                 |                     |         |
| 96  | RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST) | Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang               | 152.40/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2022  | PKS/173/IX/2022             | 16/09/2022      | 15/09/2024          | BERLAKU |
| 97  | RS SAHABAT                    | Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang                       | 1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2<br>021   |                             | 2 Desember 2016 | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 98  | RSU MUHAMMADIYAH (RSUMM)      | Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi | 159.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2023 | 100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023 | 21/08/2023      | 21/08/2024          | BERLAKU |
| 99  | RS Persada                    | Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog | 152.42/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2022 | 1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022     | 10/10/2022      | 10/10/2027          | BERLAKU |
| 100 | PT. ASURANSI DAYIN MITRA TBK  |                                                         | 003/MKT/HLT/PKS/I/201<br>5       | PH/IKS/269/XII/2014         | 5/1/2015        | perpanjang otomatis | BERLAKU |
| 101 | PT. PILLAR UTAMA CORTINDO     | Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator        | -                                | KS/PUCCSBY-1216/VII/2023    | 1/7/2023        | 30/06/2024          | BERLAKU |
| 102 | Klinik Siaga Medika           | Rujukan Pelayanan Kesehatan                             | 188/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2023     | 14.30/KSM/VII/2023          | 3/10/2023       | 3/10/2026           | BERLAKU |
| 103 | Solaris Hotel                 | Rujukan Pelayanan Kesehatan                             | 222/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2023    | 108/HRD/SHM/X/2023          | 1/11/2023       | 1/11/2026           | BERLAKU |
| 104 | PT. ASURANSI JIWA BCA         | Asuransi Pemberian Pelayanan                            | 149/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2023  | 286/PKS/BCAL-PHMS/2023      | 10/10/2023      | 10/10/2028          | BERLAKU |

|     |                              |                                                                                                      |                              |                         |                 |            |                            |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------|
|     |                              | Kesehatan                                                                                            |                              |                         |                 |            |                            |
| 105 | PT. ARTHAWENA SAKTI GEMILANG | Pelayanan Rujukan kesehatan                                                                          | 138.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023 | -                       | 15/06/2023      | 15/06/2026 | BERLAKU                    |
| 106 | BPJS KESEHATAN               | Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN                                 | 1769/E-PKS/DIR/XII/2022      | 454/KTR/VII-05/1222     | 1/1/2022        | 31/12/2023 | PROSES DISPOSISI DI BPJS   |
| 107 | PMI Kota Malang              | Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya                                | 1164/02.06.28/UDD/PKS/X/2021 |                         | 01 Januari 2022 | 31/12/2023 | PROSES DISPOSISI DI PMI    |
| 108 | RS ISLAM UNISMA MALANG       | Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah                                                 | 1097.1/E-PKS/DIR/VIII/2021   | 57/PKS/RSI-4/X1/2021    | 2/8/2021        | 31/12/2023 | PROSES DISPOSISI DI UNISMA |
| 109 | DINKES Kabupaten Malang      | Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis | 1183/E-PKS/DIR/VII/2023      | 415.4/61/35.07.103/2023 |                 | 31/12/2023 | PROSES PERMOHONAN          |
| 110 | Meditap (PT                  | Asuransi                                                                                             |                              |                         |                 |            | PROSES                     |

|     |                                            |                                                                                               |  |  |  |  |                              |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
|     | TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA)               | Pelayanan Kesehatan                                                                           |  |  |  |  | PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS |
| 111 | PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza) | Perjanjian Pelayanan Kesehatan                                                                |  |  |  |  | PROSES TTD DILUAR            |
| 112 | BPM Yuniarti                               | Rujukan Asuhan Pasien                                                                         |  |  |  |  | PROSES TTD DILUAR            |
| 113 | Asuransi Jiwa Generali                     | PKS Asuransi Kesehatan                                                                        |  |  |  |  | PROSES DISPOSISI SIM         |
| 114 | ASABRI                                     | PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF |  |  |  |  | PROSES DISPOSISI SIM         |
| 115 | Klinik Sim pang Sulfat                     | Rujukan Asuhan Pasien                                                                         |  |  |  |  | PROSES DISPOSISI SIM         |
| 116 | CV. Galaxy Mulia Cahaya                    | PKS Alat Protesa Ortesa                                                                       |  |  |  |  | PROSES DISPOSISI SIM         |